

Sabrina Critzmann

HOY NO ES SIEMPRE



**GUÍA PEDIÁTRICA
PARA UNA CRIANZA
RESPETUOSA**

Índice de contenido

Portadilla

1. El camino antes de este libro

2. Crianza respetuosa: un cambio de paradigma

- El modelo médico hegemónico
- Exterogestación
- Crianza respetuosa
- Opinología
- Criar en tribu
- Las redes sociales
- La multidisciplina

3. Los primeros 1000 días de vida

- ¿Cómo se definen los primeros 1000 días de vida? ¿Por qué son importantes?
- Descubriendo la microbiota
- Bacterias trabajadoras
- Epigenética: los genes proponen, el ambiente dispone
- Prebióticos y probióticos
- Disbiosis: buscando el equilibrio
- ¿Cómo cuidar nuestra microbiota y la de nuestra familia?
- Disruptores endocrinos

4. El nacimiento

- Nacimiento respetado
- Plan de parto
- La primera hora de vida

5. La casa

- La nueva familia y las visitas
- Las mascotas, parte de la familia
- Hay un bebé en mi cama
- Llora todo el día
- “Crisis genital”
- Mi bebé tiene granitos
- La costra láctea
- Los tan temidos cólicos

Bebé “vomitivo”
El baño y el cuidado del cordón umbilical
¿Lo pelamos? ¿Le ponemos aritos?
Limpiar las orejitas
Cortar las uñas
¿Cómo lavamos la ropa?
La caca y los pañales
Mi bebé babea mucho
Pautas de alarma: no al miedo, sí a la información
Baby blues y depresión posparto

6 La Neo

Volver a casa sin panza y sin bebé
Construir vínculos incubadora de por medio
El intervencionismo
Los maravillosos cuidados canguro
¿Cómo seguir?

7. Estudios, pesquisas, controles

No aumenta “x” cantidad de gramos/día
Me sube la bilirrubina
Pesquisa neonatal (PPN)
Pesquisa auditiva
Fondo de ojo
Ecografía de cadera
Suplementos de hierro y vitaminas
Tetanalgesia
Hablemos (un poco) sobre vacunas
Controles pediátricos
Salud bucal

8. La lactancia

Leche materna: tejido vivo
Camino a la lactancia deseada: el embarazo y la información
El nacimiento y la lactancia
Primeras semanas
Brotos de crecimiento
La leche de fórmula
Lactancia y vuelta al trabajo
Medicamentos, procedimientos y lactancia
Lactancia “prolongada”
Destete: nuevas formas de amarnos

Lactancia en duelo
Donar leche materna
Reflexión final

9. La alimentación

El placer, el disfrute y la comida
Redescubriendo la comida real
Hijos de los ultraprocesados
Las publicidades
Microbiota intestinal
La historia de las papillas
#CososMarketineros: el chupete para frutas
La leche materna y los sabores
Baby Led Weaning (BLW), ¿algo nuevo? Alimentación autorregulada
BLW ¿vs.? papillas
Baby Led Introduction to Solids (BLISS)
Arrancando la alimentación complementaria
Ya no sube tanto de peso
Arcadas, toses y ahogos
Alimentación complementaria en niños prematuros
El miedo a las grasas
Los mil nombres del azúcar
Las legumbres y los cereales son amigos, y comida
Los lácteos
Alimentación basada en galletitas
Desayunos y meriendas
Tras la búsqueda del hierro
Alimentación vegetariana y vegana en la infancia
Hablemos de alergias alimentarias
Para tomar: el agua y sus no-amigos
La mamadera
“No come nada”
El mundo real: la casita de Hansel y Gretel
La comida y las enfermedades
Reflexión final: soberanos de los alimentos

10. El sueño

Para dormir como un adulto... hay que ser un adulto
¿Qué podemos hacer para que duerman “mejor”?
Dormirse con la teta y mamar durante la noche (breastsleeping)
Colecho seguro
Pautas para un sueño seguro

“Descolectar”

Mitos sobre el sueño infantil

11. El movimiento y el cuerpo

La construcción de la corporalidad

Movimiento libre

Los pies descalzos

“Sostenedores de bebés”

Los niños y las pantallas

Porteo ergonómico, seguro y respetuoso

Sistemas de retención infantil

12. “Su hijo es valiente”

Mi camino en la crianza respetuosa

El biencriar

Bebés y niños de “alta demanda”

Angustia del octavo mes

Los adultos y el apuro

Los adultos y el cansancio

Berrinches

Control de esfínteres: “dejar” los pañales

Escolaridad

Todo tipo de familias

La lectura

13. Mocos, tos, fiebre, chichones... y otros temas que nos preocupan

Los pies descalzos y las enfermedades

Fiebre

Enfermedades de la vía aérea

Golpes en la cabeza

Diarrea y vómitos

Intoxicaciones

Quemaduras y cortes

El botiquín en casa

¿Cuándo ir a la guardia?

Medicaciones frecuentes

Hoy no es siempre

Guía pediátrica para una crianza respetuosa

Sabrina Critzmann

HOY NO ES SIEMPRE

GUÍA PEDIÁTRICA PARA UNA CRIANZA RESPETUOSA

Critzmann, Sabrina

Hoy no es siempre / Sabrina Critzmann. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Planeta, 2019.

Libro digital.

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-950-49-6837-5

1. Maternidad. 2. Paternidad. I. Título.

CDD 158.24

© 2019, Sabrina Silvia Critzmann

Diseño de interior y cubierta: Álvaro Caldelas

Ilustraciones: Julieta Farfala

Fotografía de Sabrina Critzmann: © Alejandro Guyot

© 2019, Grupo Editorial Planeta S.A.I.C.

Primera edición en formato digital: septiembre de 2019

ISBN edición digital: 978-950-49-6837-5

A Lisandro, Juan Martín y Patricio.

Porque el amor no muere, y la vida va.

El camino
antes de este libro



El camino antes de este libro

Mi nombre es Sabrina. Me formé como médica en la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente, hice mi residencia de Pediatría en el Hospital Elizalde, más conocido como la ex Casa Cuna.

Mi compañero se llama Patricio, también es pediatra y, además, emergentólogo. En casa, la mitad de la mesa está tapada de archivos impresos, libros y revistas científicas. Amamos lo que hacemos. Fuimos y somos docentes. Nos apasiona el estudio y comentar las novedades a la hora de la comida... pero no somos tan aburridos: nos gustan los deportes, otros libros, la cocina y muchas cosas más.

En mi tercer año de residencia, quedé embarazada de Juan Martín, nuestro primer hijo. Su embarazo fue saludable y estaba todo listo para recibir a ese bebé que había hecho tantas guardias con mamá antes de nacer. La ropita estaba lavada a mano, el bolso listo. El 3 de diciembre del 2016, vinieron amigos a casa a festejar su pronta llegada. Comimos *pizza* y nos reímos mucho.

El 4 de diciembre, Juani dejó de moverse tanto como solía hacerlo. Le pedí que se moviera. No pudo. Algo no me gustaba nada. Le avisé a la partera, y me sugirió hacer un monitoreo. Con ya mucho miedo en el corazón, subimos al auto, comiendo cosas asquerosamente dulces para ver si el bebé se despertaba.

Mientras esperaba que me atendieran, Juani me pegó una patada justo abajo del esternón. Se me descongeló un poco el alma, y me alegré de que hubiéramos ido a hacer una consulta innecesaria. Media hora después, volábamos en el auto a la otra sede del hospital donde me atendía. Una hora de monitoreo fetal con taquicardia persistente y sin reactividad no era algo bueno. Apoyé un pie en la guardia de Obstetricia y en menos de veinte minutos estaba en el quirófano.

Hasta hice chistes. Tantas cesáreas había presenciado en mi rotación de Neonatología... No estaba ni un poco feliz por perderme el parto que estaba segurísima que iba a tener... pero quería que Juani naciera ya, lo único que quería era escucharlo llorar.

“Que llore, que llore, que llore, que llore”. Era lo único que pensé durante toda esa cesárea veloz. “Que llore, por favor”, pensé mientras sentía el corte en la piel. “Que llore”, pensé mientras bajaban el campo quirúrgico y me mostraban un hermoso manojito de bebé morado... que no lloró.

A Juani se lo llevaron corriendo y primó el silencio en el quirófano. El resto de los médicos respiraban lento, mientras me cosían y se les escapaban los ojos a la sala de al lado. Pasaban los minutos. Eso no podía ser bueno.

La neonatóloga llegó y me dijo al oído que Juani había nacido con una condición muy grave, que habían tenido que reanimarlo, que estaba con un respirador, que lo estaban trasladando a Neonatología y que iban a iniciar el protocolo de hipotermia. Y en ese momento, con esa última frase, el mundo cambió de eje. La Tierra empezó a

rotar para otro lado, explotaron todos los volcanes y todo se prendió fuego.

Porque la hipotermia es un tratamiento que busca evitar el daño neurológico en los bebés que se asfixian al nacer. ¿Hipotermia? ¿Mi bebé en hipotermia? ¿Mi bebé cerca de la muerte, mi bebé con daño neurológico grave?

Lo llevaron a Neo, me llevaron a la habitación donde esperé horas temblando mientras procesaba la anestesia y me consumía el horror. Pato volvió con la primera foto de Juani, pálido, blandito, perdido entre tanto cable... y perfecto.

Pasaron las horas. Vinieron sus médicas varias veces. Dijeron las palabras “encefalopatía severa”. Lo llamaron por su nombre, y eso creo que me salvó la vida. Fueron las primeras veces que le dijeron “Juani”. “Juani colabora, a todo lo que hacemos responde”, dijo Laura, la neonatóloga. Me agarré a esa frase esa noche y los siguientes siete meses de su vida.

Cuando me dejaron levantarme y lo vi por primera vez en Neo, no sabía qué decirle. ¿Qué se le dice al ser que te habitó nueve meses, que casi muere al nacer y ahí está, frío, pálido y lleno de aparatos, luchando, en vez de estar acurrucado en tu pecho descubriendo la teta? ¿Fuerza? ¿Qué sabe un bebé de dos horas de vida acerca de la fuerza? ¿Escuchaba o era solo un cuerpo esperando mi saludo y mi despedida? Le acaricié una manito húmeda y llena de unto. Claramente era un bebé de 37 semanas.

Nunca descubrí qué se dice. Pero sí sabía que había mucho para decir.

Al día siguiente, le pedí al abuelo que me trajera los libritos que le había comprado antes de nacer, y empezamos a leer.

Y todo empezó.

Descubrieron con las horas que Juan había nacido con una patología rara, congénita, llamada “quilotórax congénito”. Un caso en veintidós mil, y suele descubrirse prenatalmente. Pero este no fue el caso, dado que una ecografía que me hicieron una semana antes de que naciera estaba impecable.

Tuvo sufrimiento fetal, y de eso nunca supimos la razón (yo prefiero pensar que quiso avisar). Se asfixió al nacer porque no pudo respirar y el cerebro no recibió el oxígeno necesario. Tuvo hipertensión pulmonar con requerimiento de óxido nítrico. Falla multiorgánica. Inotrópicos. Hiperglucemia. Transfusiones. Mil palabras médicas más absolutamente horribles. No importó. Nada importó.

La capacidad humana para tolerar el terror es infinita. Lo que fue un golpe engeguecedor pasa a ser, de a poco, la cotidianeidad. Y así es como pasamos treinta y cuatro días en Neonatología, esperando, acariciando a través de la cuna, besando sus piecitos, muriéndonos de amor y de ganas de estar en casa.

12 de diciembre de 2016

Pasó la semana más hermosa y más amarga de nuestra vida.

Juani cumplió 7 días. Nunca vamos a poder agradecerle tanto amor y

tanta fuerza. Tantas ganas de quedarse en este mundo y hacer frente a cosas terribles. Mi bebé tiene 7 días y todavía no conoce el sol a la tardecita en casa, ni las margaritas que lo esperan. Todavía no pudo despertarnos a la noche porque no le gusta la cuna.

Sin embargo, nuestro pollito nos regaló por primera vez un rato a upa de mamá, pura espuma y olor a bebé, acompañado por el ovillo de cables que ocupan su cuerpito y lo ayudan a mejorar. Y ahí no importan los diagnósticos, pronósticos, medicaciones y máquinas. Nuestro bebé estaba ahí y ahora, pegado a nuestro cuerpo, latiendo rosadito y perfecto.

No son los primeros cuentos y canciones que esperábamos, pero un día vamos a poder acordarnos de ellos con risa de dolor curado. Mientras nos sentamos al costado de la cuna con fábulas de marmotas, osos de las tuberías y recuerdos de los Hombres Sensibles de Flores.

Te amamos con un amor que no sabíamos que existía. Te amamos entero, desde la plantita del pie pinchada hasta la punta del pelo gringo. Te amamos hoy y te vamos a amar cuando nos anuncies que decidiste hacerte hippie, ponerte tetas e ir en gorro coya a hacer pulseras al Bolsón. Sos lo más hermoso que nos pasó nunca.

Gracias por quedarte, gracias por pelear, gracias por ser nuestro bebé perfecto. Feliz semana. Falta menos.

Hubo un momento en Neo donde tuve que decidir cerrar los ojos ante todas esas máquinas que me explicaban cosas horrendas, y mirarlo a él. Minúsculo, lleno de tubos y moretones de pinchazos. Sin haber compartido un abrazo todavía. Nos esperábamos. Habíamos compartido nueve intensos meses, ¡y ahora había tanto plástico e incertidumbre entre nosotros!

Pasó de todo. Desde vías perdidas hasta una neurocirugía. Su enfermera, Jimena, arropándolo con amor. Noches en casa pidiendo que ya sea de mañana. Trillones de horas de lactario. Una Navidad y un Año Nuevo con otras familias que son ahora también nuestra familia. El escuchar la historia del otro. Y, para nosotros, el aprender a ser mapadres además de médicos.

Y lo impensado en un primer momento, llegó. El 7 de enero del 2017 nos dieron el alta. La casa estaba desordenada porque no hubo tiempo para acondicionarla y porque

nadie sabía que volvíamos. No hubo cartelito de bienvenida en la puerta ni *souvenirs*. Pero ese paquetito de persona en los brazos, abriendo los ojos grandes ante la luz, bastaba.

No hay palabras para describir la llegada del hijo al hogar. Menos si durante su primer mes creíste que tal vez no llegaría.

No hay palabras para describir la primera vez que acercás a tu bebé a la ventana y le decís: “¿Ves, mi amor? Eso es el amanecer”.

“¿Ves? Eso que ves ahí, rosita, es el cielo, y eso tan, tan amarillo, el sol...”.

Pasaron siete magníficos meses. Cientos de controles, muchos estudios para entender qué había pasado. Un pediatra del bien que se va a reír cuando lea esto, pero que fue y es el indicado para nosotros. Horas de estimulación temprana que disfrutamos muchísimo. Recitales de música para bebés, sábados en la pileta, cientos de libritos, dragones de peluche con alitas tornasoladas. Las hamacas de la plaza. Traer un litro de mi leche en una conservadora cuando volví a hacer 24 horas de guardia. La felicidad plena y la aventura de mapaternar.



Creo que toda madre canta loas de su hijito/a. Yo no voy a ser la excepción y no voy a privarme de decir que Juani era un bebé extraordinario. Manejaba un buen humor visceral que no perdió siquiera en su segunda internación. Era paciente, curioso, agradecido y, esto lo voy a repetir hasta el hartazgo, nunca jamás dejaba de sonreír. Todo era maravilloso para él. Su padre y yo éramos las personas más

increíbles del mundo, para él éramos seguridad, abrigo, alimento y amor; pero nunca le escatimó su sonrisa a cualquiera que pasara cerca.

Un día de julio, de repente, se acabaron las fotos al sol en el balcón. Hay fotos en la penumbra, en una cama de hospital. En un segundo plano brilla la sonrisa de Juan, e innegablemente la nuestra, tratando de creer que esa oscuridad pronto se terminaría.

La primera fiebre de su vida vino a partir de una meningitis y una infección generalizada. Los siguientes días los pasamos en terapia intensiva para control. Creo que Juani nunca se enteró de que no era un juego supergenial donde papá y mamá pasaban todo el día con él. A la mañana siguiente de descompensarse estaba jugando con bloques, hablándole a Juan Del Espejo, escuchando cuentos y tomando teta como si nada. En sus cultivos creció una bacteria espantosa. Sorprendidos todos, nos alegramos y agradecemos haber llegado a tiempo, haber pescado esa meningitis horrenda antes de que causara más daño.

El sábado 29 de julio, yo estaba asustada. Lo veía mal. Estaba molesto, lloraba, me daba la impresión de que algo estaba mal. Por otro lado, claramente le molestaban las encías, y tomaba teta perfectamente. Me lo atribuí a mi cansancio, mi falta de apetito y mis ganas de terminar con todo eso.

Lo revisó dos veces la médica de guardia, Juan le hizo una enorme sonrisa. Me relajé, seguro eran los dientes y una incipiente angustia del octavo mes. Nos dejaron darle de comer a la noche, y, sentadito y feliz, se bajó un plato de puré de pera (parte fue a parar al pelo también). Fue la última foto feliz que le mandé a todo el mundo.

Han pasado meses de lo que sigue, y me gustaría no recordarlo. En resumidas cuentas, doce horas luego de esa pera pringosa en sus manitos, Juan comenzó a tener movimientos oculares compatibles con convulsiones. Mucha medicación para estabilizarlo mediante, le hicieron una tomografía que mostró gran daño vascular cerebral en varias áreas críticas del cerebro, típico de ese germen. Requerió que lo intubaran.

El pronóstico era malo. Recuerdo que me lo tomé con una calma inesperada: ya habíamos pasado por algo así. La tragedia ya había sucedido: ahora había que construir desde lo que teníamos. Se lo dije a todo el mundo amoroso de amigos y familia que se aglutinaba en la sala de espera para obligarnos a comer y a dormir.

Lo charlé con Juan. Le dije que íbamos a hacer todo lo que había que hacer. Le canté, le moví las piernitas rígidas, lo peiné, le leí un cuento de dinosaurios. La madre de la cama de al lado me miraba como si estuviera loca. A la tarde decidieron extubarlo, porque venía respirando solito. Yo estoy segura de que en algún momento me sonrió.

No sé por qué no me quedé a la extubación. Lo dejé a Pato en el hospital y me fui a tomar unos mates con un grupo de amigos. Pato me escribió que la extubación había sido exitosa y que estaba dormidito, respirando solo. Aplaudimos, nos alegramos y hablamos del futuro.

Estaba untando una tostada cuando, de la nada, sentí que se me rompía el corazón.

Miré el celular. Pato me avisaba que estaba desaturando, que no me asustara, que

por ahí quería ir. Crucé la calle que me separaba del hospital corriendo y agarrándome el pecho. Llegué para las palabras claves del médico: “Bueno, necesitamos ventilarlo de nuevo, porque, vos viste, dejó de respirar. Y las pupilas no me gustan tampoco”.

Listo.

Yo lo supe, seguro Pato también.

Una nueva tomografía mostró mayor daño cerebral. Entre muchas otras cosas, el centro respiratorio no recibía flujo sanguíneo.

Nos acercamos a él, le tomamos la mano. Y le pedimos que decida.

31 de julio de 2017

Juan está crítico.

Empeoró el infarto cerebral, y ya no respira solo ni responde.

Hablamos con él y le dijimos

que cualquier decisión que tome,

mamá y papá están acá para apoyarlo.

Que hay raudales de amor en el mundo para él.

Que hay miles de libros y canciones.

Que hay cientos de amigos.

Pero que él decide.

Juani decidió. Nosotros, que habíamos criado un hijo libre, lo dejamos decidir, y lo dejamos ir en paz.

Donar sus órganos no fue tomar una decisión. Fue natural. Fue un deseo.

Siguieron dos días eternos de diagnósticos firmados, espera del INCUCAI, burocracia y vigilia al lado de su cuerpo, empecinados los tres en donar esos pequeños órganos que iban a hacer que otros niños vivieran. Hasta que finalmente, luego de un aplauso enorme que el universo no puede parar de brindarle a Juani, lo acompañamos a quirófano, y le dimos el último beso.

3 de agosto de 2017

Nuestro bebé fue magia, amor, risas, alegrías, canciones, libros, papilla, pecho, abrazos, caricias y aplausos entre millón de otras maravillosas cualidades. Hoy en su despedida de este plano queremos que todos ustedes en sus lugares de laburo, educación, vida cotidiana, le dediquen un mínimo aplauso. A él le gustaba mucho que lo

aplaudieran.

***A las 16 horas entramos a quirófano a seguir dando vida y amor.
Digan Juani y aplaudan.***

***Transformen la energía con la que Juani los alcanzó en una energía
que les cambie el día.***

***No queremos llanto porque Juani nunca fue tristeza.
Los queremos.***

Familia Cascallar Critzmann

Sabemos que hubo varios trasplantes, y nos alegramos profundamente. Y a veces yo pienso en esos niños y niñas, y espero que estén felices, que estén sanos, que no se internen mucho, que tomen su medicación, que jueguen en el pasto, que se abracen mucho a sus mamás, que festejen cumpleaños. Que ojalá a veces se enojen porque no les gusta el brócoli o lloren un poquito porque se acabó la torta. Que hagan renegar a sus abuelas y les roben los anteojos. Que crezcan.

Los días siguen. Los soles salen.

El mundo sigue girando, increíblemente.

Los amigos nos levantaron. Nos consolaron, nos dieron comida, hicieron guardia, no nos dejaron solos. Nunca. Gracias a ellos sobrevivimos.

Volvimos a los hospitales donde trabajábamos. ¿Cómo volver a atender niños?

Como pudimos.

Unos meses después, decidimos casarnos. Merecíamos festejar todo el amor que habíamos vivido, en medio de la oscuridad. Nos casamos en un brillante día de sol de abril. Y fuimos felices un rato, mientras nos abrazábamos con gente amorosa y comíamos rico.

Unos días después, descubrimos que había un pequeño polizone a bordo. Recorrimos paisajes en nuestra luna de miel con un Lisandro minúsculo, latiendo pequeñito. Felices, asustados y agradecidos.

Cuando volvimos, decidí que no iba a hacer el posgrado que tenía planificado, para darle tiempo a mi panza incipiente. Me inscribí en la carrera de Puericultura, en la escuela Panza y Crianza, y también me formé como Consultora de Porteo en la escuela Crianza en Brazos. Conocí ambas formaciones durante la vida de Juani, y me parecieron perfectas para complementar mi labor como pediatra, y sobre todo, para disfrutarlas. Palabras que nunca escuché en mi formación como “apego”, “exterogestación”, “relactador” y otras miles se empezaron a hacer cotidianas.

Para no perder la costumbre de estudiar, me armé una cuenta en Facebook y otra en Instagram sobre pediatría, y empecé a escribir sobre temas pediátricos cotidianos. Pronto, inesperadamente, fuera de toda estrategia, las páginas empezaron a crecer, a recibir miles de mensajes por día. Empecé a dar talleres, charlas, clases en hospitales. Armé mis consultorios. Conocí gente maravillosa. Entendí que además de médica era, de alguna manera, comunicadora. Y también entendí la responsabilidad que eso conlleva.

Mientras se desarrollaban esos proyectos, Lisandro crecía, sano y hermoso, en mi panza. Y en diciembre del 2018, un día de lluvia gris perla, en medio de truenos que hacían vibrar las ventanas del quirófano, un bebé pequeñito era apoyado sobre el pecho de su mamá para no separarse nunca más.

En medio de la vorágine, apareció la propuesta de escribir este libro. Mucha investigación, trabajo, correcciones, tetas, mate, amigos, noches en vela, más tetas, y mucho, mucho estudio: este es el resultado.

Este texto busca dar información a las familias, para que luego puedan decidir libremente la mejor opción para ellas. No busca ser un manual ni tener todas las respuestas. La ciencia es más veloz que los libros, y cambia todo el tiempo: lo que comunico hoy puede ser distinto en unos meses. Y bienvenida sea la ciencia, y bienvenida la necesidad de tragarnos nuestras palabras si eso aporta para que los niños y niñas del mundo estén más sanos y felices.

Espero que lo disfruten. Gracias.



Crianza respetuosa:
un cambio de paradigma



*Mi niño es una persona.
Que a veces tiene días de risa plena,
y otras, está chinchudo.
A veces descubre mil mundos en sus manitos,
y otras, solo quiere upa.
Mi niño
a veces nada en mares de baba,
a veces tiene hipo,
a veces muerde una punta del fular,
a veces reniega de la teta,*

*a veces grita en la butaca del auto,
a veces se olvida de cómo dormir.
Otras, hace prrrfff muchas veces, muy divertido.
Canta con mamá.
Le sonríe al universo.
Va a la plaza con papito.
Mi niño
es una persona, plena, completa.
Con sus vaivenes, con sus bemoles.
Con su infancia llena de abrazos y de alguna tristeza seguramente.
Es una persona
con la que vamos de la mano.
Con respeto, con placer, con belleza, con amor.*

El modelo médico hegemónico

Me formé como pediatra en el Hospital de Niños Pedro de Elizalde, el más antiguo de Sudamérica. No lo cuento porque me genere algún tipo de orgullo en particular, sino porque tiene una historia pintoresca: antes de ser hospital, fue un hogar de niños y niñas abandonados. De allí le quedó el nombre con el que se lo conoce: la Casa Cuna.

Para formarse como pediatra en Argentina, es preciso hacer primero la carrera de médico, y luego la residencia o concurrencia en Pediatría, más un curso superior dictado por una universidad. Un pediatra (y la mayoría de los especialistas de otras disciplinas) tiene, inicialmente, alrededor de 12 años de formación.

La residencia en Argentina es una instancia de formación de posgrado remunerada (la concurrencia es lo mismo, solo que sin remuneración. Sí, generalmente el mismo trabajo pero sin sueldo). Esto suena fantástico, si no fuera porque, al menos en este país, los residentes son la sangre que mantiene vivo al sistema de salud. Independientemente del ámbito (público, privado, obras sociales), el sistema de salud se caracteriza por una enorme densidad de pacientes y tiempos mínimos para atenderlos.

Para atender a TODOS, hay que atender RÁPIDO. Hay que aprender a priorizar, a conocer todos los atajos dentro del hospital, a evolucionar historias clínicas de pie en el ascensor, a conocer de memoria el número de interno del cardiólogo copado que ve a los pacientes en el día. Hay que minimizar los tiempos para comer y para ir al baño, resignar el horario de salida y aceptar que la guardia dura 30 horas porque así se “aprende”.

El proceso es deshumanizante. Suele haber, en muchas residencias, maltrato claro y abiertamente aceptado como ceremonias de “bienvenida” o simplemente como ejercicio de poder de un residente superior a otro inferior. Mucha culpa, muchísima exigencia. Muchas frases del estilo “no se les ocurra embarazarse”. Y, por sobre todo, mucho pensar que “esto siempre fue así, es la manera de formarse y nadie se murió por ello”.

Y entonces aceptamos trabajar de maneras indignas. Pero atendemos personas. Personas que vienen con una historia, con pensamientos alegres y tristes, con un

trabajo que les gusta o no, preocupadas porque no pagaron la luz o porque la bacha de la cocina se tapa. Personas que no nos dicen nada o nos cuentan su vida y obra en una consulta que, según los parámetros de una obra social, debería durar (completa)... ¡12 minutos!

Y peor aún, en esos tiempos atendemos niños, que además, muchas veces están enfermos. En un mundo ideal, los niños son felices, comen todos los días, no se enferman, no sufren ni se mueren. En el mundo real, todo eso sí sucede. ¿Cómo reducir entonces esos tiempos?

Fácil: alejándose de los pacientes. Queriendo saber lo menos posible. Tratando de que la historia no nos llegue en profundidad, porque si lo hace, nos duele y nos la llevamos a casa, y queremos volver a casa cada tanto a continuar con la vida...

Revisamos rápido, no pedimos permiso, levantamos remeras, “mamá este nene tiene que adelgazar, eh”, indicamos medicaciones no tan necesarias porque sabemos que la familia nos va a exigir llevarse “algo”, damos fórmula porque evaluar la lactancia en el consultorio es imposible, escribimos en arameo y listo, nos fuimos.

Esto se suma a que **estamos muy formados para tratar enfermedades, y muy poco para prevenirlas**. Recuerdo perfectamente qué enzima falla en la acidemia glutárica tipo 1, pero aprender acerca del efecto de las golosinas en la salud de un niño me costó más. Nunca escuché durante mi formación acerca de la extergestación, ni de los primeros 1000 días, ni de las necesidades afectivas de un bebé.

Descubrirlo fue un proceso intenso, arrebatador, que inició con mi primer hijo y mi maternidad despuntando en una terapia de Neonatología. **Deshacer el modelo médico hegemónico, el que da órdenes, el que da miedo, el que reta y el que te impone qué hacer, es complejo** y dudo poder desmaderarlo del todo alguna vez. Pero tenemos una voz que se escucha, y se replica. Y no dudo de que eso, de a poco, pueda empezar a cambiar las cosas.

La médica que fui

Doce años estudié para tener ese papelito que dice “Pediatra”. Hice mil guardias. Leí muchos libros. Confeccioné cientos de historias clínicas, tuve a cargo muchas pequeñas vidas.

Y nada me interpeló tanto ni me hizo cuestionar tanto lo que estudiaba y lo que hacía como la maternidad.

Yo obstaculicé lactancias. Indiqué fórmula innecesaria. Sugerí yogur. Dije que la teta “no alimentaba”. Hablé de poner a los bebés boca abajo. Desaconsejé el colecho una y otra vez. Creí que un bebé debía dormir toda la noche. Me horroricé ante berrinches en público. ¡Y

quién sabe qué otras cosas!

Lo cuento porque lo hice con la mejor fe del mundo, creyendo sinceramente en cada una de esas cosas. Sin cuestionarlas, sin ponerme a leer en profundidad, viviendo la vorágine de la carrera ante todo. Lo cuento porque agradezco poder estar construyéndome de otra manera cada día. Lo cuento porque me duele, pero quiero contarlo para mostrar que, todavía con errores, se puede cambiar.

Lo cuento mientras, en mi cama (que es su cama), un bebé pequeñito toma la teta, abrazado a mi cuerpo, tibio y feliz, extero-gestándose con el amor que merece y que ningún profesional debería desconocer.

Exterogestación

El ser humano nace prematuro. Biológicamente, se nos considera una especie altricial. ¿Qué significa eso? Que las crías nacen desvalidas, sin ninguna posibilidad de conseguir cobijo o alimento, y con dependencia absoluta de otro ser.

En algún momento de la evolución, el ser humano se puso de pie. Esta novedad locomotora solo fue posible estrechando la pelvis (si el agujero de la pelvis fuera más grande... se caerían los órganos). Al mismo tiempo, el cerebro se desarrollaba rápidamente, siendo casi la parte del cuerpo más grande de un bebé recién nacido. Pelvis estrecha + cráneo grande: no es una buena combinación para un parto. Entonces, evolutivamente, los seres humanos redujeron su tiempo de gestación, para permitir a las crías pasar por el canal.

El cerebro del ser humano nace poco desarrollado: hay miles de conexiones por formarse aún, y crecerá durante los primeros dos años de vida tanto que alcanzará el 75 % del peso que tendrá de adulto. Esta adaptación biológica es tan perfecta que, para que ese cerebro crezca, el cráneo tiene sus huesos sin soldar, permitiendo la expansión del mismo. Esa es la razón por la que los pediatras medimos la circunferencia craneal: vamos evaluando cómo va aumentando el cerebro de tamaño.

Al reducir ese tiempo de gestación, la cría es más prematura: aunque un bebé humano nazca a término, será totalmente dependiente de sus cuidadores para sobrevivir.

Sabemos que, si se lo permitimos, un bebé recién nacido sano puede reptar sobre su mamá y llegar a la teta solito. Pero no más. No puede abrigarse, no puede defenderse de depredadores, no puede limpiarse. **Faltará mucho tiempo para lograr**

valerse por sí solo. Y cuando decimos mucho tiempo, hablamos de décadas. ¿Nos parece culturalmente que una persona es capaz de valerse sola a los 13 o 14 años? Seguramente no.

Cito, textual, a la psicóloga española Rosa Jové, de su libro *La crianza feliz*:

“... El feto está dentro del útero en un entorno templado protegido de la luz y del ruido; oye los sonidos de la madre y el latido de su corazón. Está muy a gusto. Y así es: cuando nace, el bebé viene de alojarse en el mejor aposento de este mundo: el vientre de su madre. Un lugar en el que no existe el hambre, ni el frío, ni el calor, ni la soledad... Y cuando sale necesita lo mismo, porque, al fin y al cabo, un recién nacido no es nada más que un feto con unos segundos más de vida, y sus necesidades no han cambiado tanto. Requiere un entorno que emule en lo posible la vida intrauterina. A esto se denomina ‘exterogestación’...”

Contrario a lo que la sociedad occidental define que es “necesario” para un bebé (ser independiente, dormir solo, no llorar), la biología viene, implacable, a decirnos lo contrario: **el bebé necesita de un entorno continente, lo más parecido al útero materno, para sobrevivir. Necesita oler a su madre, escuchar su corazón, probar su sabor, dormirse sobre su piel.** El bebé ES la madre, desconoce que son personas diferentes, y tampoco le interesa. Demandará todo lo que necesite, su llanto será la manera de comunicarse durante un tiempo y creará los vínculos que sus cuidadores permitan.

No buscará manipular a nadie, ni tomarle el tiempo, ni ser caprichoso. Simplemente, no puede hacerlo, porque no tiene las conexiones cerebrales necesarias para esos procesos complejos. Llorará porque no sabe expresarse de otra manera para que lo entiendan. Se calmará solamente cuando lo acunen, lo alimenten, lo abracen, le hablen y le cambien el pañal. Imagínense lo peligroso que sería que un bebé se “conformara” y no llorara por nada: ¿cómo sabríamos que necesita algo?

Los bebés necesitan los brazos. Un bebé dejado en el suelo, a la intemperie, en la antigüedad, no hubiera sobrevivido nunca. Las tribus nómadas llevaban a sus bebés en brazos o, a lo sumo, en portabebés para ayudarse. ¿Es agotador? Sí, porque **es imposible criar en soledad, como estamos acostumbradas (y hablo en femenino porque estadísticamente, la que cría es la mujer).** Las tribus se pasarían los bebés de brazo en brazo mientras migraban, se ayudarían a amamantar y un grupo se ocuparía de los bebés más grandes. Hoy vivimos alejadas de nuestra familia, en departamentos solitarios, donde pasamos a veces más de 24 horas solas con nuestras crías, sin ninguna ayuda ni compasión, porque estamos “descansando” para el resto del mundo, sobre todo el laboral, que reclama nuestra presencia.

Este proceso de dependencia absoluta, al que llamamos exterogestación, durará muchos meses. ¿Cuántos? Entre ocho y diez, como mínimo. A los 8 meses aproximadamente, el bebé alcanza un hito madurativo asombroso y aterrador: cae en la cuenta de que él y su madre son personas diferentes, y como tales, al desaparecer su madre, puede quedar solo. En el capítulo “Su hijo es valiente”, hablaremos más profundamente sobre lo que se llama “angustia del octavo mes”.

Crianza respetuosa

La cultura del terror/2

*La extorsión,
el insulto,
la amenaza,
el coscorrón,
la bofetada,
la paliza,
el azote,
el cuarto oscuro,
la ducha helada,
el ayuno obligatorio,
la comida obligatoria,
la prohibición de salir,
la prohibición de decir lo que se piensa,
la prohibición de hacer lo que se siente
y la humillación pública*

son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo (...)

Eduardo Galeano

Existen muchas ideas fantasiosas acerca de lo que es la crianza respetuosa.

Primero, como probablemente repita varias veces en este libro, me parece tremendo tener que aclarar que las relaciones humanas tienen que incluir el respeto. Si hablamos de una crianza respetuosa, tenemos que hablar de que hay crianzas no respetuosas. Y hoy por hoy, las hay. En la Argentina, el 46,4 % de los mapadres reconoce utilizar violencia física para criar o disciplinar a sus hijos, aunque admite que no está bien. Existen muchas más formas de violencia en la crianza además de los castigos físicos: agresiones verbales, amenazas de abandono, adjudicación de culpas al niño por problemas de pareja... y un sinfín más.

Se suele confundir el concepto de “crianza respetuosa” con “crianza con apego”. El apego es la tendencia de los humanos (que también existe en diversas especies de animales) a establecer un vínculo de afecto con al menos un cuidador primario (figura de apego). Los seres humanos somos tan prematuros, tan dependientes, que no puede no existir una figura de apego. ¿Siempre es la mamá? Tal vez idealmente sí, pero no necesariamente. Hay familias homoparentales de varones, familias con abuelos, tíos o amigos como figuras de apego. **El punto es que no existe un ser humano que no desarrolle apego hacia otra persona. Criar sin apego no existe, sí existe criar sin respeto a la otra persona, a los tiempos, al vínculo...**

La crianza respetuosa no se trata de un grupo de reglas que hay que cumplir, ni un itinerario de lo que nos hace “buenos mapadres” si lo cumplimos, y malos si no lo hacemos. Hay tantos modos de crianza como familias. No tiene nada que ver con portear, dar la teta, alimentar al bebé sin papillas o mantener al niño descalzo (todos temas que veremos más adelante en este libro). **La crianza respetuosa no es un mandato, no es un “bebé pegoteado 24 horas”, no es realzar el sacrificio y la abnegación, sino escuchar nuestras propias necesidades, validar nuestro deseo y reconocer en nuestro hijo otra persona a respetar.**

La crianza respetuosa sitúa al niño como persona. Persona completa, única e irrepetible, a quien acompañar en sus amores, descubrimientos y sinsabores. Persona a la cual no le haremos lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Entre otras cosas, no nos gustaría que nos dejen llorando a la noche, no nos gustaría que nos obliguen a comer sin hambre, y no nos gustaría que nos lleven a un médico, ¡y nos desnuden sin explicarnos nada!

Crianza respetuosa también es situarnos en nuestro rol de adultos falibles. En que nunca, jamás, seremos perfectos. Y que eso es bueno, porque es el mejor ejemplo para nuestros hijos: yo, adulta, puedo equivocarme, puedo reconocerlo, puedo llorar de frustración y puedo pedir disculpas.

Nos han criado en un paradigma de adulto todopoderoso, que en todo tiene razón y todo lo sabe. Enormes, sabios, que toleran cualquier emoción sin desmoronarse. Adulto que tiene que “enseñarle” al niño a ser persona, a ser independiente, a ser duro, a no llorar, a no pensar. Paradigma insostenible. Hay un sistema económico que se nutre de esto: hace poco tiempo, una usuaria de Twitter reflexionaba acerca de cómo es una cultura laboral el encerrarse en el baño a llorar. El

tuit tuvo miles de respuestas: la mayoría de las personas hemos sufrido maltrato psicológico en el trabajo y lo hemos naturalizado, como lo contaba al principio del capítulo. ¿Por qué somos violentos? Porque probablemente hayamos sido criados de esa manera y no sepamos relacionarnos de otra forma.

Es momento de mostrar que **probablemente nadie tiene la menor idea de cómo criar (¡nadie! Porque cada niño o niña es único/a)**, que todos tenemos miedo de equivocarnos, que el camino es a veces brillante y divertido, y otras veces es oscuro y obtuso. Es momento de reconocer nuestros propios miedos, de ponerlos en palabras, e incluso charlarlos con nuestros hijos, para mostrarles que no somos perfectos, que estamos aprendiendo a su lado, que en este camino no hay nadie que sepa todo, sino muchas personas creciendo y amándose.

Validar lo que nos pasa es fundamental. La crianza respetuosa busca ser respetuosa de todas las personas que forman ese vínculo, tanto bebés como adultos. Por supuesto, los bebés y los niños dependen absolutamente de nosotros, y ese vínculo es asimétrico: un niño no puede mapaternar a sus padres. Lo cual no quiere decir que las necesidades de esos adultos no deben ser reconocidas y atendidas. Es por eso que es fundamental la “matriz de sostén”, es decir, un entorno que sustente a esa familia. ¿Cómo son las matrices de sostén hoy por hoy? Escasas y difíciles, empezando por las licencias de mapaternidad cortas, sin ningún tipo de coherencia con las necesidades de los bebés o de las familias. La matriz de sostén de la infancia somos todos. La responsabilidad es social, no solo de esa familia.

Hablar de crianza respetuosa sin perspectiva de género tampoco tiene sentido. Las madres trabajan a la par de los padres fuera de la casa, con sueldos menores y a cargo de la mayoría de las cuestiones domésticas y de crianza. La mayor parte de las familias monomarentales están a cargo de una mujer. **Se les exige a las mujeres trabajar como si no criaran, y criar como si no trabajaran.** A nadie se le ocurriría preguntarle a un varón, cuando anuncia que será padre, “Uhh, ¿y qué vas a hacer con el trabajo?”.

Esto es relevante porque cuando hablamos de crianza, hablamos también de tareas de cuidado, que son las tareas y actividades que se llevan a cabo en el hogar y que hacen posible la organización de las familias. Es prometedor ver, cada vez más, a los padres involucrados en las mismas, sobre todo, comprendiendo que no realizan ningún favor ni “ayuda”, sino que la crianza y estas tareas son su responsabilidad como padres.

Es imposible criar sin comprender que somos un ejemplo. Que las relaciones sanas se basan en el respeto y no en el miedo. Que nosotros no somos seres humanos que todo lo saben, sino que cada día, aprendemos un poquito más.

Opinología

“Cómo engordaste este embarazo, eh”.
“Tenés la panza muy grande, ¿no serán dos?”.
“Tenés la panza muy chica, ¿seguro está todo bien?”.
“Era obvio que iba a necesitar fórmula, tenés los pechos muy chicos”.
“Estás muy flaquita, te está consumiendo... ¿le seguís dando la teta?”.
“Este bebé tiene las piernas muy torcidas, ¿se dio cuenta el pediatra?”.
“Qué flaco tu nene, ¿estará sano?”.
“Es muy gordito, tenés que darle menos teta”.
“¿Por qué no lo pelás? Así está más lindo”.
“¿Y aritos no le vas a poner? Va a parecer un varón”.
“Qué lindaaaa la naaaa, siempre tenés que estar linda, ¿sabés?”.
“A vos te parece vestirlo de rosa...”.
“Está más gordita, ¿no? A ver si vamos adelgazando, sino nadie te va a querer”.
“Qué bueno que adelgazaste, ahora estás más linda”.

Cuando aparece un bebé en la vida de una familia, aparecen una multitud de comentarios, muchos de ellos con amor y buenas intenciones, que podrían desequilibrar al ser humano más paciente. Como adultos, sufrimos la mirada sobre nuestro cuerpo. Mirada que no pedimos, que no nos interesa y que no suma. **Los niños, desde su gestación y en conjunto con sus madres, sufren de estas apreciaciones, y al no ser considerados personas a respetar, escuchan estos comentarios en voz alta continuamente.**

Nadie tiene derecho a opinar sobre el cuerpo de otra persona. Nadie. Enseñarles a los niños a conocerse, a amarse y a no emitir juicios sobre otros debería ser uno de los pilares de nuestra crianza, y así, seguramente, tendríamos una sociedad más sana y nos ahorraríamos mucho, mucho dolor.

¿Cómo sobrevivir a la multitud de opiniones? Con la tranquilidad de saber que estamos informados y que la crianza es una aventura absolutamente única para cada familia. Sabiendo que cometer “errores” es parte del proceso, y también disfrutarlos. Como dice mi amiga Natalia Kiako: “El tesoro, el verdadero tesoro... es cavar”.

Criar en tribu

Antiguamente, **la humanidad criaba en tribu**. Cuando una persona estaba agotada, había muchas otras para relevarla y permitirle el descanso, que es tan importante. La

comida se preparaba para todos, las mujeres se asistían entre ellas para amamantar, y los bebés siempre estaban en los brazos de alguien... ¡porque había muchos brazos disponibles!

Pero hoy por hoy, vivimos en ciudades, en departamentos que parecen cajitas de fósforos, donde se materna 24 horas en soledad con un bebé pequeñito. Bebé que tiene necesidad de su mamá (1) sin descanso, que no tiene noción de que es otra persona, que no sabe que su mamá necesita ir al baño, o cocinarse, o dormir. **Mamá que muchas veces recibe, durante el embarazo y posteriormente, mensajes edulcorados acerca de la maternidad, y siente que al no cumplir esos mandatos, está haciendo algo mal.** Tapas de revistas con modelos con figuras perfectas a poco tiempo de dar a luz, imágenes de mamás dando la teta en un ensueño de colores pastel, el hijo del vecino que “duerme toda la noche”... y la vida no suele ser tan así, sino más bien grietas en el pezón, piel flácida en la panza y muy pocas horas de sueño.



Ahí empieza la patologización de la infancia: el bebé tiene un trastorno de sueño, el bebé es muy inquieto, el bebé es caprichoso, el bebé es muy intenso. Cuando, en realidad... el bebé simplemente es bebé.

De ahí viene la importancia de la matriz de sostén que mencioné antes. Personas y un sistema que colaboren en el sostén de las necesidades del bebé y de su mamá. Que se ocupen de preparar comida, de lavar los platos, de cuidar al bebé un ratito para que su mamá se pueda bañar. A veces son parte de la familia: abuelos, tíos, primos, amigos (sin la ayuda de mis amigas, este libro que fue escrito en pleno puerperio, nunca hubiera sido posible). Pero hoy por hoy tomaron fuerza las tribus de mamás, grupos de mujeres y bebés de aproximadamente la misma edad, que se sostienen, se ayudan y crían en conjunto.

Las tribus de mamás se forman en muchos contextos: a veces durante los cursos de parto, y otras, a través de foros de maternidad en la web. Los vínculos, a veces únicamente virtuales, se refuerzan, hay mensajes a la madrugada, apoyo durante las crisis, amistades que se van afianzando.

Conocí a mi tribu de puérperas mientras cursaba la semana 35 del embarazo de Juani. Armamos un grupo de Facebook llamado “Mamás diciembre 2016”. Había mamás de varias partes del país y también de otros países. Me acompañaron en su nacimiento e internación en Neo, y luego empezamos a conocernos fuera del celular. El grupo de WhatsApp no tardó en armarse, y las realidades de cada una, muy distintas, a entrelazarse. Compramos baberos y platitos de oveja al por mayor cuando empezaron a comer. Vinieron al hospital cuando Juani volvió a internarse, me trajeron ropa, sacaleches y chocolate, y hasta vinieron el día de la ablación. Siempre estuvieron. Sé que si las necesito, hoy siguen estando, y que les hablan a sus hijos acerca de Juani. Agradezco haberlas conocido, haber encontrado entre ellas a una enorme amiga, y haber compartido mi maternidad y la vida de mi bebé.

Las redes sociales

En los últimos años, las redes sociales crecieron a niveles insospechados para el común de la población. Tienen aspectos fantásticos: encontramos muchísima información, podemos ver a familiares y amigos lejanos, hacemos tribus, nos inspiran algunas recetas. Vemos también el día a día de personas que no conocemos, e incluso, ¡los pediatras vemos a nuestros pacientes crecer!

En las redes sociales también han proliferado en abundancia los grupos relacionados con la crianza. Grupos que también aportan mucha información y son bienvenidos. Sin embargo, creo pertinente plantear que tenemos que tener una mirada crítica acerca de todo lo que leemos en ellos. **Muchas veces se maneja información errónea a nivel científico, se invoca a “gurús” o se desarrollan contenidos que generan culpa en las familias.** “Si no das la teta, sos menos madre” o “Si querés tener un bebé, mínimo tenés que dejar de trabajar dos años”, son frases comunes que ignoran las diversas realidades que se viven.

Aún peor: en muchos sitios se dan opiniones médicas sobre bebés y niños sin

conocerlos. Esto es peligroso y antiético. **No importa que la página sea administrada por un profesional de la salud: no se puede opinar sobre el desarrollo y los procesos de salud/enfermedad de un niño sin conocerlo**, sin saber su historia clínica, ni estar al tanto de su entorno, sin revisarlo y mucho más, cuestiones que se realizan en una consulta individual. Es la salud de nuestros hijos e hijas, y también es nuestra responsabilidad. No la dejemos en manos de cualquiera.

La multidisciplina

Cuando armamos una red de profesionales respetuosos que charlamos entre todos y nos ponemos de acuerdo, le ganamos a los tiempos acotados del consultorio o del hospital, y somos más personas alrededor de una familia para acompañarla en la crianza.

Trabajar con puericultoras, más allá de estar formándome en esa disciplina, ha sido una experiencia tremendamente satisfactoria a nivel personal y profesional. Más lactancias con placer, bebés llenitos de leche protegidos de enfermedades, lactancias mixtas o exclusivas con fórmula pero apegadas a la fisiología, lactancias en adopción.



Poco de esto es posible sin aprender a trabajar en equipo. Igual me ha sucedido,

por ejemplo, con los/las odontopediatras que atienden a mis pacientitos y con quienes trabajamos codo a codo por la salud bucal.

En un equipo interdisciplinario podemos trabajar con fonoaudiólogas, kinesiólogas, terapistas ocupacionales, obstétricas, doulas, musicoterapeutas, consultoras de porteo, psicólogas, nutricionistas, colegas pediatras, médicos de familia y de otras áreas con quienes armamos este camino de compañerismo, enriqueciendo nuestra práctica día a día. **Los equipos multidisciplinarios no son “derivar a que lo vea otro”, sino mantener un ida y vuelta de ideas, información y capacitación constante, que colabora en los acompañamientos, los tratamientos y el seguimiento de los niños.** Es una especie de grupo de WhatsApp nominal, en el que todos nos comunicamos y tomamos decisiones en conjunto.

Grande fue mi sorpresa cuando me di cuenta de que, al necesitar comunicar, estas redes también se iban a ver enriquecidas por comunicadores sociales, periodistas responsables, chefs, diseñadoras... y tanta gente maravillosa más, que pone su saber y su profesionalismo al servicio de la niñez. ¡Comunicar responsablemente también es salud! Ganas de trabajar juntos, respeto entre nosotros y hacia la familia que acompañamos, ganas de aportar y de escuchar.

-
1. Recordemos que el cuidador principal, la figura de apego, no es siempre la mamá, pero para simplificar el texto, la nombraremos así en este apartado.

Para leer

PARA FAMILIAS

- González, C. *Bésame Mucho*, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2012.
- Grieco, A. y Zampaloni, S. *Crianza para principiantes*, Editorial Grijalbo, Buenos Aires, 2018.
- Jové, R. *La crianza feliz*, Editorial La esfera de los libros, Madrid, 2009.
- Raschkovan, I. *Infancias Respetadas*, Editorial Aique, Buenos Aires, 2019.
- UNICEF. *Crianza sin violencia: Guía práctica para evitar gritos, chirlos y estereotipos*. 2017.

PARA PROFESIONALES

- Schulz, N.; Laskowski, P. y Eliet, V. (2018). Módulos de formación en porteo ergonómico. *Crianza en Brazos Escuela de Porteo*.
- Winnicott, D. *Escritos de pediatría y psicoanálisis*. Editorial Paidós, Barcelona, 2012.
- Winnicott, D. *Los bebés y sus madres*. Editorial Paidós, Buenos Aires, 1987.

Los primeros 1000 días de vida



*Las bacterias nos hacen humanos.
Bailamos un vals infinito corales,
holobiontes, el orgullo aplacado
del Homo sapiens perplejo
al descubrir que no es el fuego, ni la rueda,
lo que le da color a su humanidad,
sino las bacterias, esas a las que
les tiene tanto, pero tanto miedo.*

¿Cómo se definen los primeros 1000 días de vida? ¿Por qué son importantes?

Los 1000 días, que como vemos incluyen la gestación y los primeros dos años del niño, son críticos: las primeras etapas de la vida de una persona son cruciales en su desarrollo y también en su salud de futuro adulto. **Este período importantísimo se considera una “ventana de oportunidad” desde el punto de vista nutricional, emocional y social**, ya que una adecuada alimentación, estimulación y contención afectiva durante esa etapa tiene un impacto enorme en la salud y en el desarrollo físico e intelectual del niño, en su presente y de cara a su futuro.

La Organización Mundial de la Salud los define como:

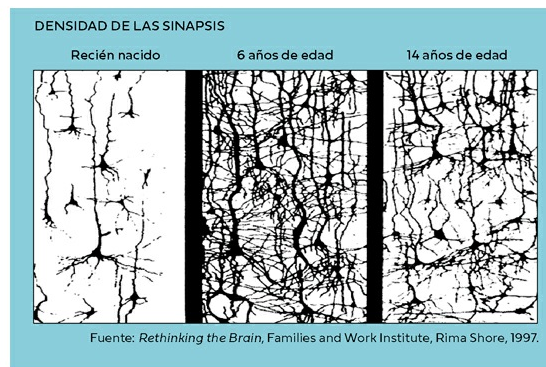
$$\begin{array}{r} 270 \text{ días de gestación} \\ + \\ 365 \text{ días del primer año} \\ + \\ 365 \text{ días del segundo año} \\ = \\ 1000 \text{ días} \end{array}$$

¿Qué sucede en los primeros 1000 días de vida, que hablamos tanto de ellos? Bien, nadie duda de que antes del nacimiento, un bebé ya está desarrollando su cerebro, ¿verdad? Partiendo de una sola célula, se ha formado un ser humano completo. Lo que no solemos tener en cuenta es que **ese cerebro sigue formándose en los siguientes años, y los primeros 1000 días de vida van a tener un rol fundamental sobre el mismo.**

Durante mucho tiempo se dijo que nacíamos con cierta cantidad de neuronas, y

que no se dividían más. Ahora sabemos que esto no es tan así, y que inclusive la leche materna le aporta al bebé células madre con la capacidad de formar neuronas en sus tejidos. Aun con esa información, no es lo que más nos importa. Vamos a hablar de las conexiones de esas neuronas.

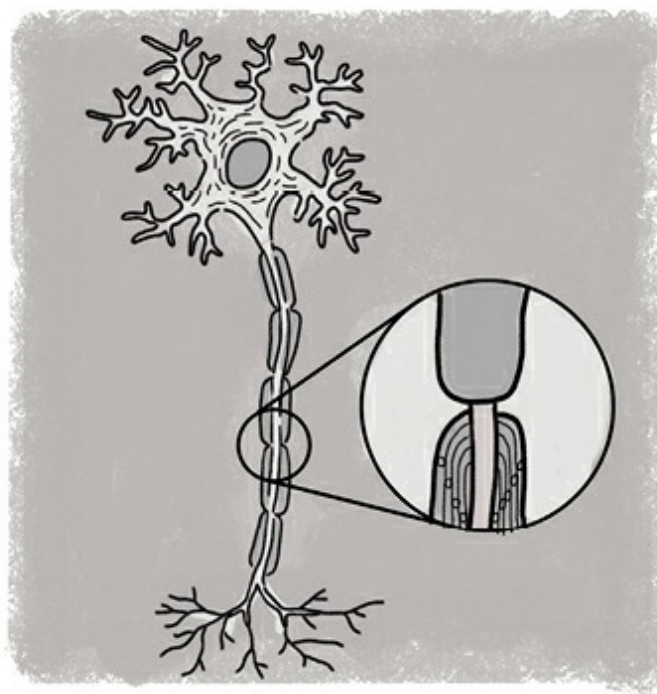
Las podemos ver en estos esquemas, que reproducen las fotos de un trabajo científico de 1997:



Allí lo que vemos es cómo se encuentran las neuronas y sus conexiones a medida que el niño va creciendo. En la primera imagen vemos cómo sería el cerebro de un recién nacido. Poquitas conexiones... hay mucho para desarrollar y aprender.

La segunda imagen representa el cerebro de un niño de 6 años. Se observa una maraña de “pelitos” que conectan neurona con neurona. Esto es porque las neuronas tienen MUCHAS conexiones (axones y dendritas), y muchas de ellas son redundantes. En la tercera imagen, vemos el cerebro de un adolescente de 14 años. Es más limpia. ¿Qué pasó? Nada malo, al contrario. Las neuronas ahora tienen menos conexiones entre ellas, porque HAN REFINADO su señal. No solo se conectan más directo, sino que sus axones ahora tienen algo que se denomina “vaina de mielina”, un recubrimiento formado por grasa (por eso la grasa es tan importante en el desarrollo infantil) que es un “aislante” de la señal que transmiten. De cierta manera, han eliminado la “estática” en la comunicación.

Y esta “poda”, ¿cómo ha sucedido? A través de todo lo que ese niño ha hecho durante esos primeros dos años de vida. Todas las veces que tomó la teta o la mamadera, todas las veces que se llevó la mano a la boca, todas las veces que le cantamos el arrorró, todas las veces que regurgitó. Todo es un aprendizaje y lleva al desarrollo del cerebro, eligiéndose conexiones que “sirven” y eliminándose otras.

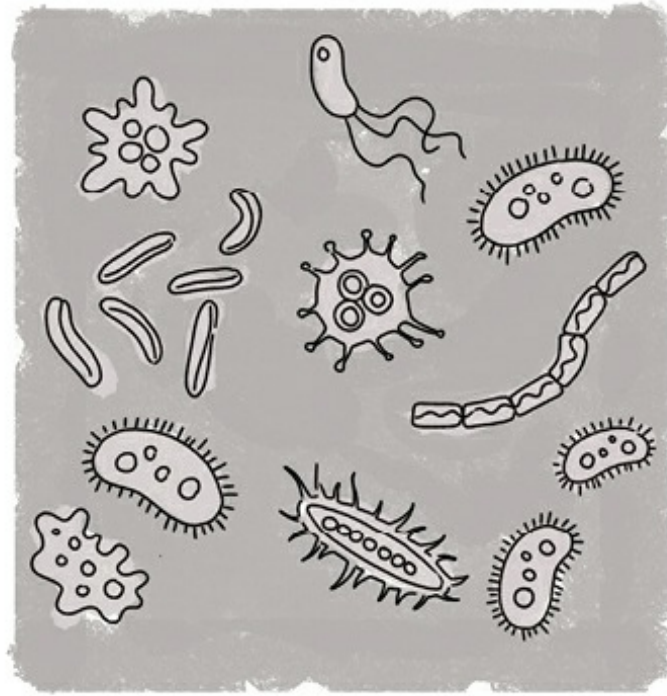


La alimentación de ese niño y su impacto en su microbiota, tanto como su nutrición afectiva, tienen un efecto directo en la formación y refinamiento de esos circuitos cerebrales.

Descubriendo la microbiota

Durante mucho tiempo hablamos de la “flora intestinal”. Bacterias “buenas” que estaban en nuestro intestino, lo hacían funcionar bien. Probablemente también hayamos escuchado que cuando tomamos antibióticos, tenemos diarrea porque matamos a esas bacterias.

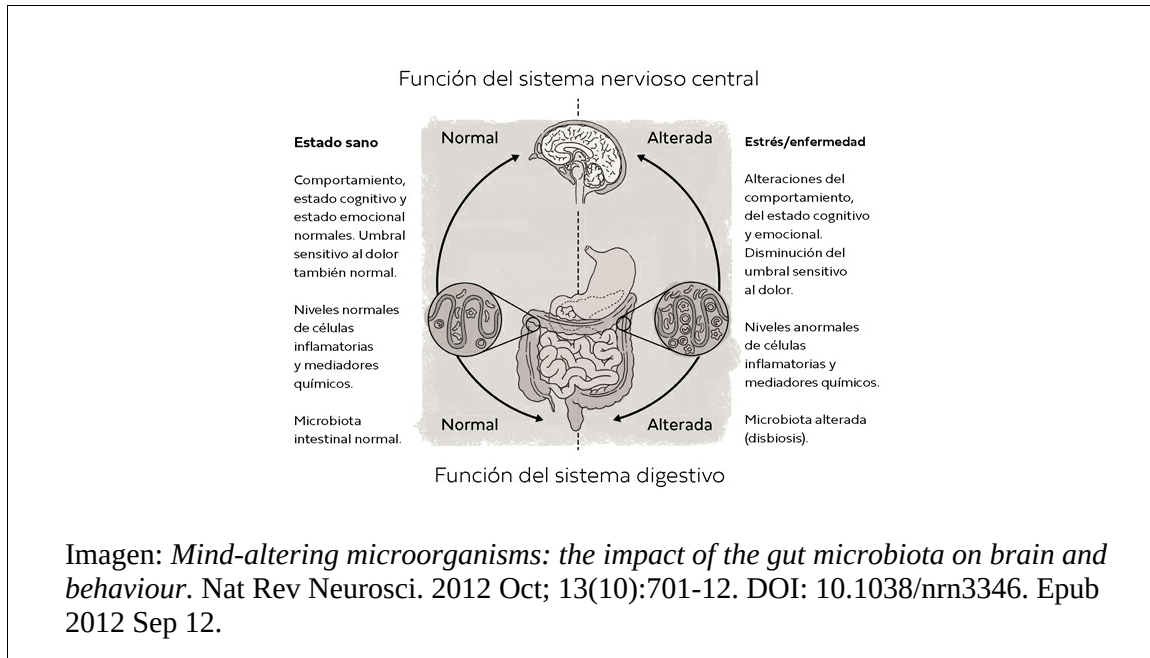
En los últimos años nos enteramos de que la microbiota hacía muchísimo más que “estar ahí”. **En el intestino, hay neuronas, que forman lo que se llama el “segundo cerebro”.** A partir del tipo de microbiota que prolifere en nuestro intestino, ese segundo cerebro forma NEUROTRANSMISORES, directamente relacionados con el neurodesarrollo, el comportamiento, el sueño, el aprendizaje... ¡Una conexión vital entre el intestino y el cerebro!



Además de los neurotransmisores, la microbiota también tiene que ver con la inmunidad. Se sabe que estimula al sistema inmune a ser más “tolerante”, y su mal funcionamiento se relaciona con alergias y enfermedades autoinmunes (asma, alergia a la proteína de la leche de vaca, acné, dermatitis atópica...).

Se cree que la microbiota, en el cuerpo del adulto, pesa alrededor de 2 o 3 kilogramos. Que son trillones de genes. Y que, también, **hay por lo menos 105 enfermedades en las que se identificó su relación con su desbalance (disbiosis).**

La microbiota es tan, pero tan importante que hoy sabemos que sin ella no sobreviviríamos. Entonces, nos plantea una idea tan apasionante como perturbadora: el ser humano no es un organismo aislado, sino que es la conjunción de múltiples organismos. Como dicen por ahí, “las bacterias nos hacen humanos”.



Bacterias trabajadoras

Lejos del paradigma hiperhigiénico en el que toda bacteria es sinónimo de algo “malo”, empezamos a descubrir bacterias y otros microorganismos que son parte de la persona que somos. Se empezó a investigar y a descubrir que, **tal vez, no está tan bueno que todo sea estéril y aséptico**. Y que si bien es muy útil lavarse las manos para no llevar por ahí virus infecciosos, el jabón antibacterial está de más, a menos que estemos trabajando en un quirófano. Es un cambio profundo de mirada, muy importante y en continuo estudio.

Pero ¿qué hacen estas bacterias?

- * Evitan que el intestino se colonice de bacterias que nos enfermarían.
- * “Educan” al sistema inmune y están involucradas en la protección contra futuras alergias.
- * Eliminan toxinas.

- * Estimulan la formación de células intestinales (en continuo recambio).
- * Estimulan la formación de vasos sanguíneos donde son necesarios.
- * Generan vitaminas (K y B).
- * Tienen un efecto regulador en los depósitos de grasa del organismo.
- * Regulan las funciones endocrinológicas.

Y más. Muchas funciones más.

Epigenética: los genes proponen, el ambiente dispone

Cuando se encaró el Proyecto Genoma Humano (un proyecto internacional de investigación científica que se inició en 1990 y finalizó —si es que algo en la ciencia finaliza— en 2016), era prometedor pensar que íbamos a conocer un mapa de todos los genes del ser humano y que con eso se evitarían enfermedades. Resultó que tiene gran utilidad, pero también nos llevó a pensar que tener tal o cual enfermedad era inevitable porque era “genética”. **Hoy por hoy, se sabe que más allá de los genes, hay mecanismos EPIGENÉTICOS que interactúan con ellos y hacen que se expresen de diferente manera.**

¿Qué significa “epi-genético”? Significa literalmente “algo por encima de los genes”. Todas nuestras células tienen los mismos genes: la célula de la piel tiene los mismos genes que las células del corazón. ¿Qué hizo que la piel sea piel y el corazón sea corazón? El ambiente, el medio en el que creció esa célula, en un momento y lugar determinado. Es decir, factores MÁS ALLÁ del genoma por sí mismo. Eso es epigenética.

Y por supuesto... la microbiota tiene que ver. Dentro de sus acciones, genera ciertas proteínas que hacen que algunos genes se expresen y otros no. **Es decir, de acuerdo con las bacterias que tengamos en nuestro cuerpo, se “programa” la expresión de nuestros genes.** Nuestros genes no solo codifican el color de pelo o de ojos, como solemos ilustrar, sino que tienen que ver en cómo reacciona nuestro páncreas a los alimentos, cómo crecen nuestros músculos, cómo reaccionan nuestros glóbulos blancos a las enfermedades...

El ejemplo más ilustrativo es el de las abejas. Todas las abejas tienen los mismos genes, pero una de ellas pasa a ser la reina, quien es de mayor tamaño, pone huevos y puede vivir durante años. Las otras son obreras, más pequeñas, viven semanas y son estériles. ¿Pero no tienen los mismos genes? Sí, pero a la reina se la alimentó con jalea real desde que era una larva. Esa jalea real tiene una proteína llamada “royalactina”, que se cree que actúa sobre su genoma y le da el “fenotipo” de abeja reina.

Entonces, “tener un gen para algo”, es decir, un “genotipo”, o un largo historial de familiares con una enfermedad “x” (alergias, por ejemplo) no es una condena. **Hay mecanismos epigenéticos que trabajarán sobre esos genes. ¿Conocemos todos esos mecanismos? No. ¿Podemos controlarlos? No totalmente, pero podemos empezar a darles una mano.**

Muchas condiciones tales como asma, diabetes, obesidad, autismo, cáncer, alergias y enfermedades inflamatorias intestinales se cree que tienen que ver con la interacción entre la genética y el medio ambiente, teniendo la microbiota un rol fundamental.

En la actualidad, en una extensión del Proyecto Genoma Humano, se encuentra en proceso el Proyecto Microbioma Humano, el cual busca caracterizar las distintas comunidades de microorganismos que habitan las diferentes partes de nuestro cuerpo para evaluar cuáles son sus efectos sobre nuestra salud. Lo más probable, estimado/a lector/a, es que todo esto que está leyendo en este libro, en quince años sea obsoleto y se hayan descubierto muchísimas cosas más interesantes y fascinantes... porque la ciencia avanza sin parar.

¿De dónde sale esta microbiota? ¿Nacemos con ella?

Sí y no. Se sabe que **el útero no es un ambiente completamente estéril, que ciertas bacterias de la mamá podrían pasar al feto a través de la placenta (microbiota placentaria)**. Por eso, la dieta materna, el estilo de vida y el uso de antibióticos que afecte la microbiota de la mamá impactan directamente en la microbiota del bebé. Incluso se habla de los **“cinco trimestres”; el trimestre PREVIO a la gestación, los 3 trimestres de embarazo y el trimestre posterior: son los que van a crear una huella vital en el desarrollo del niño.**

El primer momento de colonización profunda viene durante el nacimiento. Durante este momento, los bebés se colonizan con trillones de bacterias que, entre otras funciones, van a participar en la programación de sus circuitos cerebrales. Increíble, ¿no?

Si el bebé nace por parto vaginal, se colonizará inmediatamente con la flora de la vagina y zona perianal de la mamá. Y si respetamos los protocolos de la hora sagrada, colocarlo sobre su pecho hará que el bebé se colonice con bacterias de la piel. Y si toma la teta, por medio del calostro le pasará un verdadero “trasplante de células”, con

bacterias beneficiosas y células inmunes. Una situación ideal que sabemos que en esta época de epidemia de cesáreas no suele ocurrir, pero muchos profesionales de la salud trabajamos por lograrlo.

Si el bebé nace por cesárea, la colonización es diferente. Va a depender mucho de los protocolos: si es colocado sobre el pecho de la mamá, si se lo van a llevar, si va a Neo... **La microbiota intestinal de los recién nacidos por cesárea parece ser menos diversa y más escasa que la de los niños nacidos por vía vaginal**, especialmente en especies de bifidobacterias. Esto influye, de acuerdo con diferentes estudios, en el desarrollo del sistema inmune, ya que esta microbiota intestinal podría modular la respuesta y el desarrollo de los mecanismos de alergia y tolerancia alimentaria a largo plazo. Además, se ha demostrado que el tiempo para establecerse la microbiota normal puede representar una ventana de riesgo y factor predisponente para la colonización de *Clostridium*, un germen que puede producir diarrea y otros trastornos potencialmente graves.

Hoy en día **se está estudiando una técnica llamada “swabbing”**, que se utiliza en las cesáreas programadas: se coloca una gasa en la vagina de la mamá una hora antes de la cesárea. Luego se retira, y cuando nace el bebé, se le pasa esa gasa por la boca, la cara, las manos y el resto del cuerpo. De esa manera se coloniza con los gérmenes de la mamá, simulando lo que sucede en un parto vaginal. Como dije al principio, es una técnica en estudio.



¿La microbiota solo está definida por el tipo de nacimiento?

No. **El segundo momento de impacto es la alimentación de los primeros días.** La microbiota de un niño que toma fórmula versus un niño que toma leche materna es profundamente diferente. En estudios recientes se ha demostrado también que la microbiota de los lactantes alimentados a pecho está compuesta casi en forma predominante por bifidobacterias y lactobacilos, mientras que en aquellos que recibieron leche de fórmula, estas bacterias existen en menor cantidad, además de la presencia también de bacteroides, enterobacterias y estreptococos. Estas últimas bacterias son poco beneficiosas para el desarrollo de la microbiota.

Si nace un bebé por cesárea y luego toma fórmula, ¿no hay nada que hacer?

Para nada. La mayoría de los adultos de hoy en día fuimos alimentados a fórmula porque “era lo mejor” en ese momento. **Sabemos que esto tiene incidencia, junto con la alimentación con ultraprocesados, en la epidemia actual de obesidad y de ECNT (enfermedades crónicas no transmisibles),** como la hipertensión y la diabetes. Hoy sabemos que nuestros hábitos y nuestra alimentación están directamente ligados a la microbiota. Al final de este capítulo hablaremos de algunas medidas que podemos tomar para cuidar a nuestras bacterias amigas.

Prebióticos y probióticos

Los probióticos son los microbios vivos no patógenos (buenos), que cuando son ingeridos, ejercen una influencia positiva en la salud y en la fisiología del huésped. No es sencillo envasar y vender probióticos: tienen que reunir muchas condiciones. Entre ellas, no tienen que enfermar (recuerden que hablamos de bacterias vivas), se debe haber estudiado que son beneficiosos y tienen que lograr llegar al intestino, y no morir en la boca o el estómago cuando los consumimos. Todo esto con el plus de que cada ser humano tiene su propia microbiota, y lo que viene en una pastillita es igual para todos.

Hoy por hoy, en pediatría se considera que los probióticos podrían prevenir la diarrea por antibióticos y la enterocolitis necrotizante en prematuros (una enfermedad intestinal grave), y se está evaluando su uso para cólicos, alergias, diarreas agudas y enfermedades inflamatorias crónicas.

Los prebióticos son las sustancias que le dan de comer a esas bacterias. Son

ingredientes no digeribles para nosotros, pero que promueven el crecimiento y las actividades de la microbiota intestinal.

La leche materna es un tejido vivo que combina probióticos y prebióticos: aún no se ha encontrado un alimento tan completo. Las bacterias llegan a la leche materna a través del circuito enteromamario, es decir, por una conexión metabólica (no anatómica, ¡no es un cañito!) entre el intestino y la glándula mamaria. La alimentación materna y su estilo de vida tienen un impacto directo con el tipo de bacterias que llegan al bebé. **Se comprobó que las mamás con una alimentación de pobre calidad (basada en ultraprocesados, por ejemplo) tenían bacterias “menos buenas” y factores que promovían la inflamación.**

Se está estudiando qué probióticos y prebióticos son saludables para ingerir por los niños fuera de la leche materna. Los estudios son muy nuevos y aún no hay resultados concluyentes, salvo en situaciones puntuales, como consumo de antibióticos y bebés prematuros. El kéfir y otros alimentos fermentados parecen ser el camino, pero aún no están claras las dosis, ni el mecanismo de preparación para que sean inocuos.

Por lo cual, es más fácil evaluar qué alimentos causan disbiosis (desbalance de la microbiota) y tratar de evitarlos (más adelante lo veremos en detalle). Es decir, el famoso “no necesariamente comas mejor, dejá de comer peor”.

Disbiosis: buscando el equilibrio

La disbiosis es la pérdida de equilibrio con relación a la diversidad bacteriana.

Hay múltiples factores que intervienen en las disbiosis, ya mencionamos varios: el nacimiento por cesárea, la alimentación con fórmula, la alimentación complementaria precoz (antes de los 6 meses), el consumo de alimentos ultraprocesados, las prácticas hiperhigiénicas, el uso indiscriminado de antibióticos y el estrés.

Este tema, como todo lo relacionado con la microbiota, está en constante revisión y estudio, pero **se plantea que la disbiosis puede afectar nuestro día a día debido al aumento de la permeabilidad intestinal.** El intestino tiene células con diferentes tipos de uniones entre ellas. Cuando la microbiota está alterada, estas uniones se vuelven más laxas, **permitiendo el paso de bacterias no tan buenas a otros tejidos, las cuales generan inflamación. Esa inflamación puede incluir al cerebro, y afectar el ánimo y el comportamiento. Y sí, esto ocurre en niños también.**



¿Cómo cuidar nuestra microbiota y la de nuestra familia?

Con relación al día a día

- **Fomentar el contacto de los bebés con su familia.** Abrazos, porteo...
- **Evitar el consumo de antibióticos sin prescripción.** Respetar dosis y días de tratamiento.
- **Evitar el consumo de medicaciones innecesarias.** Solemos abusar de jarabes para la tos, antiinflamatorios, antigripales, digestivos y otros medicamentos que apuntan a tratar el síntoma y no la causa de lo que nos ocurre. Todos ellos impactan directamente en nuestra microbiota.
- **Evitar el uso de jabones antibacteriales.** Con lavarnos las manos con agua y jabón alcanza para prevenir enfermedades.
- **Fomentar el contacto con la naturaleza y los animales** (dejar que los chicos se ensucien, ¡esa tierra que comen es buena!).

- **Evitar la vida sedentaria**, y promover la actividad física; si es al aire libre, mejor.

Con relación al nacimiento

- A menos que sea nuestro deseo, evaluando toda la información posible, o por alguna razón médica por compromiso de nuestra salud y la de nuestros bebés, **evitar las cesáreas programadas.**
- **Pensar el trabajo de parto como algo positivo**, aun cuando no se logre un parto vaginal. Durante el mismo, con la rotura de la bolsa, ascienden bacterias beneficiosas para la colonización del bebé.
- **Priorizar, si es posible, los partos vaginales.**
- Si durante las últimas semanas del embarazo, el hisopado vaginal y perianal dio positivo para estreptococo del grupo B, seguramente se indiquen antibióticos durante el trabajo de parto. ¿Por qué? Para prevenir una infección en el bebé recién nacido, que puede ser muy grave. Es decir, es una práctica beneficiosa. ¿Y la microbiota? **Podemos consumir probióticos basados en *Lactobacillus* y *Bifidobacterium* de origen farmacéutico, indicados por nuestro/a médico/a, además de una alimentación saludable**, para restablecerla.
- **Respetar la hora de oro, el contacto piel con piel, y el inicio y sostenimiento de la lactancia materna.**
- Si el bebé nace en una institución, además de las ropitas, **podemos llevar sabanitas de nuestra casa en lugar de utilizar las del hospital.**

Con relación a la alimentación

- Si estamos planificando un embarazo, además de los controles ginecológicos pertinentes y el consumo de ácido fólico, **podemos repensar nuestros hábitos y nuestra alimentación.** Recordemos que la microbiota presente en el trimestre previo al embarazo influirá directamente en el desarrollo del bebé.
- **Buscar sostén e información para el mantenimiento de la lactancia materna,**

si es nuestro deseo.

- **Iniciar la alimentación complementaria en forma oportuna**, después de los 6 meses, y con alimentos de buena calidad nutricional.
- **Evitar el consumo de alimentos ultraprocesados:**
 - Productos con jarabe de maíz de alta fructosa.
 - Productos con colorantes artificiales.
 - Lácteos en exceso.
 - Imitaciones industriales de la manteca (por ejemplo, margarina).
 - Grasas trans.
 - Leches de “fórmula” después del año.
 - Embutidos.
 - Bebidas alcohólicas.
 - Gaseosas y bebidas industriales.
- **Apuntar al consumo de alimentos reales:**
 - Frutas y verduras. Si tienen certificación orgánica o producción agroecológica, mucho mejor.
 - Carnes de buena calidad, de ganado pastoril.
 - Pescados, evitando los de criadero (por ejemplo, el salmón). Argentina tiene una extensa costa atlántica y tenemos muchos pescados de excelente calidad.
 - Pollo y huevos de campo.
 - Semillas activadas, frutos secos.
 - Legumbres.
 - Fermentados (kéfir, por ejemplo).
 - Aceites vegetales de buena calidad (primera prensada).

Disruptores endocrinos

(por Martín Schneider, endocrinólogo pediatra, M. N. 129.706)

Además de los alimentos, existen múltiples sustancias ambientales que pueden afectar a nuestro organismo. **Están descriptas alrededor de 800 sustancias que pueden generar cambios en el sistema endocrino, actuando por sí mismas, o cambiando el efecto de nuestras hormonas. Son sumamente diversas: plaguicidas, fármacos, plásticos, cosméticos, sustancias que vienen de la quema de residuos, fitoestrógenos. Ingresan a nuestro organismo por la vía respiratoria, por la piel o por su ingesta.**

Sus efectos no son inmediatos (pueden pasar AÑOS o DÉCADAS hasta manifestarse su acción biológica), teniendo una persona múltiples exposiciones a lo largo de la vida antes de manifestar algún problema. Los efectos más frecuentes en la edad pediátrica incluyen ADELANTO O RETRASO DE LA PUBERTAD, aunque hay descripciones de efectos en todos los sistemas corporales y en todas las edades.

Por esto es fundamental prevenir exposiciones a disruptores endocrinos en todo momento, y especialmente a edades tempranas. Estudios en Estados Unidos hallaron casi 300 disruptores endocrinos en sangre de cordón umbilical, por el pasaje de los mismos de la mujer al feto durante el embarazo.

Cuando uno se adentra en el tema, entra en pánico. Internet es una fuente de cáncer, todo es cancerígeno; tan solo prender la computadora para buscar algo nos convence de que vamos a tener una enfermedad grave... por eso es fundamental **NO ENTRAR EN UNA PARANOIA COLECTIVA. Hay exposiciones inevitables, porque no vivimos en una burbuja de cristal: no es necesario usar doble barbijo y lavarse las manos cinco veces para salir de casa. Lo prudente es disminuir las exposiciones que SÍ podemos evitar, protegiendo especialmente a la embarazada, a los niños y las niñas.** Estar informados nos ayuda a tomar las mejores decisiones.

Las fuentes más frecuentes de exposición a disruptores ambientales son algunos pesticidas (DDT), plásticos (bisfenol A, ftalatos, poliestireno, policloruro de vinilo). Los plásticos en particular tienen una clasificación que nos permite identificar cuáles son seguros.

Recomendaciones:

- **LEER TODAS LAS ETIQUETAS y buscar productos que digan “sin bisfenol A/BPA” o “sin ftalatos”.** ESPECIALMENTE EN CHUPETES, BIBERONES Y JUGUETES PARA NIÑOS. Si no conseguimos biberones libres de BPA, la ANMAT recomienda calentar el líquido en otro medio y pasarlo al biberón cuando no esté muy caliente (la temperatura elevada acelera la liberación del BPA).
- **Tras el cambio del pañal, si eligen usar linimento óleo calcáreo, debe aclarar que es “libre de parabenos”.** De otra manera, se pueden utilizar aceites vegetales para limpiar la cola del bebé.
- **Preferir juguetes fabricados con materiales naturales** (por ejemplo, tejidos no sintéticos: algodón, lana).
- **Optar por plásticos seguros (códigos 1, 2, 4 y 5).**

- Evitar los que tengan PVC, poliestireno o ftalatos (códigos 3, 6 y 7 respectivamente).
- Preferir el vidrio para contener y calentar alimentos, antes que plásticos, especialmente al calentar los alimentos con el microondas. El microondas no es el problema: son los plásticos que usamos para calentar las comidas los que pueden ser tóxicos.
- Evitar bolsas vinílicas para cocción.
- Evitar alimentos envasados con *film* de PVC, reducir/evitar las comidas enlatadas por el recubrimiento interno de la lata con bisfenol A.

CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE RESINAS DE PLÁSTICOS

						
PETE PET	HDPE PEAD	PVC V	LDPE PELD	PP	PS	O OTROS
POLIETILENO TEREFTALATO	POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	POLICLORURO DE VINILO	POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD	POLIPROPILENO	POLIESTIRENO	OTROS

PRODUCTOS PLÁSTICOS MÁS SEGUROS 2, 4 Y 5



Las botellas marcadas con el código (1. PET o PETE) se deben utilizar solamente una vez, en sucesivas veces podrían desprender DEHP, un ftalato tóxico.

PLÁSTICOS QUE HAY QUE EVITAR 3, 6 Y 7



PVC o vinilos
pueden contener
ftalatos y bisfenol A



Espuma de
poliestireno



Puede contener
bisfenol A

- **Evitar consumir agua de botellas plásticas que hayan estado expuestas al calor.** Muchas tienen BPA o bisfenol A entre sus componentes, y si las botellas se exponen a temperaturas elevadas, pueden transferirse al agua.

- Preferir verduras orgánicas en el embarazo. **Pelar las frutas y verduras que no sean orgánicas, ya que la mayoría de los plaguicidas se concentran en la cáscara. Evitar el exceso de soja en niñas**, especialmente si se presentó desarrollo mamario precoz. La mayor cantidad de soja la encontramos en los alimentos ultraprocesados.
- **Preferir alimentos de estación y locales**, contienen menos conservantes.

Para leer

PARA FAMILIAS

- <https://www.libresdecontaminanteshormonales.org/>
- *Pequeños cuidados por un mundo saludable. Pequeños cuidados en tu casa.* Recuperado de: <https://pequenioscuidados.org/pequenos-cuidados-en-tu-casa/>
- Barruti, S. *Mala Leche*. Editorial Planeta, Buenos Aires, 2018.
- Oyarzo Salazar, M. *Cocina Biomédica*. Editorial Planeta, Buenos Aires, 2018.
- Raele, F. D. *Nutrición Holística*. Editorial Planeta, Buenos Aires, 2017.
- Troncoso, L. *Los primeros 1000 días de tu hijo*. Editorial Planeta, Buenos Aires, 2019.
- Yong, E. *Yo contengo multitudes*. Penguin Random House, Buenos Aires, 2017.

PARA PROFESIONALES

- Álvarez Calatayud, G.; Marcos, A. y Margolies, A. *Probióticos, Prebióticos y Salud: Evidencia científica*. Sociedad Española de Probióticos y Prebióticos. Editorial Ergon, Madrid, 2016.
- VI CURSO LATINOAMERICANO VIRTUAL DE NUTRICIÓN INFANTIL, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, 2017. MÓDULO 5: MICROBIOTA INTESTINAL, Dra. María del Carmen Toca.
- *Empleo de probióticos en pediatría*, Intramed, 2018. Recuperado de: <https://www.intramed.net/contenido.asp?contenido=91944>
- Espín Jaime, B. *Probióticos: luces y sombras*. AEPap (ed.). Curso de Actualización Pediatría 2018. Madrid, Lúa Ediciones 3.0; 2018. p. 191-200. Recuperado de: https://www.aepap.org/sites/default/files/191-200_probioticos_luces_y_sombras.pdf.
- *Importancia de la microbiota gastrointestinal en pediatría*. Acta pediatr. Méx vol.38 no.1 México ene./feb. 2017. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.18233/apm1no1pp49-621323>.
- Lynch, S. V. y Pedersen, O. *The human intestinal microbiome in health and disease*, NEJM (New England Journal of Medicine), 2016; 2369-2377. DOI: 10.1056/NEJMr1600266.
- National Institutes of Health: <https://commonfund.nih.gov/hmp>
- Neu, J.; Koletzko, B.; Pindexter, B.; Uauy, R. *The developing intestinal microbiome: Probiotics and prebiotics, in nutritional care of preterm infants*. 2014. Vol 110; 167-176. DOI: 10.1159/000358465.
- PRONAP. Programa Nacional de Actualización Pediátrica 2016, Módulo 1, “La primera hora de vida”, Dra. Norma Rossato.

- PRONAP. Programa Nacional de Actualización Pediátrica 2017, Módulo 1, “El microbioma del lactante”, Dr. Miguel Larguía.
- PRONAP. Programa Nacional de Actualización Pediátrica 2018, Módulo 1, “Intestino: segundo cerebro y trastornos gastrointestinales funcionales”, Dr. Víctor Eduardo Grinblat.
- *Mind-altering microorganisms: the impact of the gut microbiota on brain and behaviour*. Nat Rev Neurosci. 2012 Oct; 13 (10):701-12. Epub 2012 Sep 12. DOI: 10.1038/nrn3346.
- Román Riechmann, E. y Álvarez Calatayud, G. (2013). *Empleo de probióticos y prebióticos en pediatría*. Nutrición Hospitalaria, 28 (Supl. 1), 42-45. Recuperado en 10 de junio de 2019, de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112013000700010&lng=es&tlng=es
- *The human gut microbiota in perinatology and neonatology. Seminars in fetal and neonatal medicine*. 2016, 21; 367-422. DOI: doi: 10.1016/j.siny.2016.06.004.

El nacimiento



**“Para cambiar el mundo primero hay
que cambiar la forma de nacer”.**

Michel Odent

Nacimiento respetado

El nacimiento es un evento crucial, único e irrepetible. Nuestros hijos nacen una sola vez, a veces por parto vaginal y a veces por cesárea. Ambas formas de nacer deberían ser amorosas y con la adecuada contención del equipo de salud, siendo parte de esa contención también dar el espacio de intimidad que requiere una familia.

En la Argentina contamos con la **Ley 25.929 de Parto Respetado** (el nombre de por sí es un poco triste: ¿hay que aclarar que un nacimiento se debe RESPETAR?). Sabemos que no se cumple en muchísimos lugares, pero conocerla nos da información y fuerzas para exigir que las cosas cambien. Entre muchas otras cuestiones, habla del derecho de la madre a estar informada de todo lo que se realizará, a elegir acompañante, a no sufrir intervenciones innecesarias, a —si no hay ninguna razón de salud que lo impida— estar con el recién nacido ininterrumpidamente, y más.

La vía de nacimiento ideal sería el parto vaginal. Poco se habla de la importancia de la preparación física y psicológica para el parto. En los videos que muestran partos, se ve el cuello del útero dilatándose y el bebé deslizándose plácidamente, pero no es visible lo que pasa en los huesos de la pelvis, no se muestran músculos, no se muestran pelos ni líquidos ni nada que pueda llegar a ser desagradable.

De esta manera, junto con la romantización novelesca en la que la heroína rompe bolsa dramáticamente en el *shopping* y a la media hora tiene un bebé a upa (los bebés de las novelas suelen tener como 8 meses cuando nacen...), se banaliza un evento profundamente personal, intenso siempre, que puede durar horas o días. **El intervencionismo sobre el parto (no permitir el libre movimiento, los tactos repetidos, la episiotomía de rutina) impide muchas veces una experiencia que es natural y parte de nuestra sexualidad.**

El trabajo de parto es importante, porque le avisa al cuerpo de la madre y al bebé que ya están listos para separarse (¡un poquito!). A veces me encuentro con madres que me dicen que se lamentan de haber tenido trabajo de parto, porque terminó en cesárea y “no tuvo sentido”. Al contrario: **el trabajo de parto desencadena muchísimos procesos** que ayudan al bebé a respirar cuando nace, favorecen la

lactancia, mejoran el vínculo afectivo, generan una mejor recuperación después del nacimiento...

¿Y la cesárea? La cesárea es una vía de nacimiento que en ocasiones tiene que ver con un deseo personal, pero generalmente es debido a alguna complicación materna o fetal... o lamentablemente, con un deseo del equipo obstétrico en cuestión. **Existe una epidemia de cesáreas a nivel mundial**, que tiene que ver con “me voy de vacaciones, si querés te hago una cesárea antes” y otras frases desafortunadas.

La cesárea no es “la vía fácil” como se suele creer: es una cirugía abdominal que tiene su complejidad y un postoperatorio donde, además, la mamá está a cargo de una vida nueva mientras se cicatrizan los puntos. La cesárea no es “abren, sacan y listo”, sino que, muchas veces, se hace en situaciones de urgencia inesperadas y tiene una alta carga de angustia. La anestesia que se utiliza bloquea el dolor, pero no los tirones, la sensación de corte y, mucho menos, a veces, la sensación de vacío que queda cuando se termina, sobre todo si no se ha pasado por trabajo de parto. Además, la misma anestesia no tiene una recuperación exactamente igual en todas las mujeres: muchas veces, posterior al nacimiento, hay temblores, náuseas, aturdimiento, prurito (picazón)... Todos estos síntomas suelen resolverse pronto, pero mientras suceden, asustan, sobre todo si no sabemos que son consecuencias esperables.

Asimismo, existe una presión de parte de la sociedad, con la que muchas mujeres que pasaron por una cesárea sienten que son señaladas como “menos madres” porque “eso no es parir” (y lo he leído en varios grupos de crianza...). También se plantea que el niño nacido por cesárea tiene una herida irreparable en su psiquis y que todo lo malo que le pase en su desarrollo tiene que ver con eso. Estos dos conceptos no solo no tienen ninguna base psicobiológica, sino que tienen que ver con una concepción patriarcal ligada a la culpa y al dolor, siempre poniendo el peso en el cuerpo de la madre.

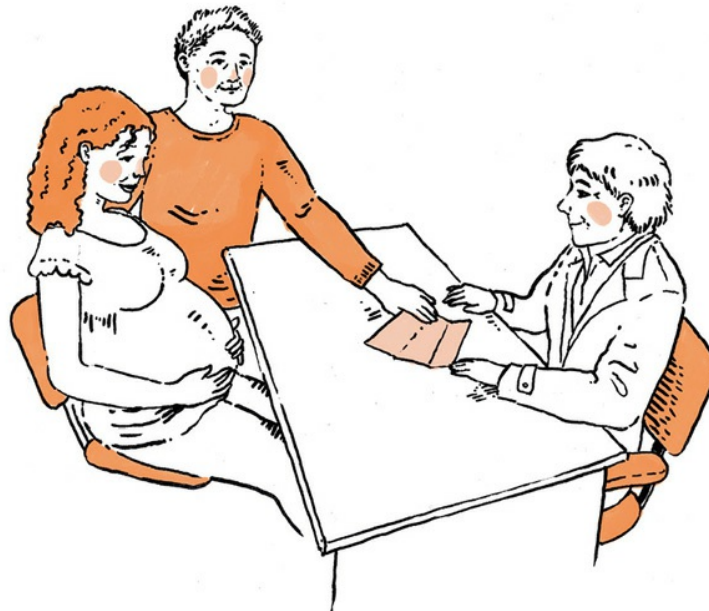
Me encanta el término que se está utilizando últimamente para definir a los nacimientos: encuentro. Me lo dijeron muchas madres de mis pacientes mientras los saludaba por última vez con panza antes de que naciera mi hijo Lisandro. “Que tengan un hermoso encuentro”, me deseaban todas esas mujeres que me confiaban la salud de sus hijos. Y yo me imaginaba automáticamente ese momento en que sostendría a mi bebé en brazos, iluminado por todo ese amor de muchas madres. Algo que felizmente sucedió, inclusive dentro de la asepsia de una cesárea, gracias a mi paciente y comprensiva obstetra, mi doula y mi compañero fiel.

El nacimiento respetado es diferente para cada familia. No hay una receta mágica ni una que sirva para todos. Lo importante es tener en cuenta los deseos, las posibilidades, la cultura y la voluntad de propiciar un encuentro amable y amoroso.

Plan de parto

El plan de parto (PP) es un **documento que se le presenta a la institución donde nacerá el bebé y expresa la voluntad de la familia**, principalmente de la madre, en relación con las distintas etapas del nacimiento. Se presenta al servicio de Obstetricia y al de Neonatología de la institución, previo al nacimiento (generalmente entre la semana 20 y 30 de gestación) y debe ser sellado y firmado por los jefes de dichos servicios y la familia. El mismo **está enmarcado dentro de la Ley Nacional 26.529 de Derechos del Paciente bajo la figura “Directivas Anticipadas” (art. 11)** y busca garantizar la participación activa de la persona gestante, así como el pleno acceso a sus derechos.

En dicho documento se dejan en claro y **se ponen en común deseos y realidades**. Algunos sanatorios tienen un plan de parto para descargar y modificarlo a gusto. El plan de parto puede incluir consideraciones alrededor de la llegada al hospital (acompañamiento, necesidades particulares por cultura o idioma); del trabajo de parto (solicitar evitar ayunos, libre movimiento, opciones para el manejo del dolor); de las intervenciones a la mamá y al recién nacido; y también acerca del nacimiento y el puerperio. **Si el nacimiento será por cesárea, ¡también se puede presentar un plan de parto!**



El recién nacido pierde su casa. Pierde su mundo tibio y anfibio, el suave mecer del agua, la luz tan tenue que ni hay que usar los párpados.

Pierde la comida que viene sola y continua por el pupo, pierde la señal infalible de los latidos de su madre que indican que todos estamos vivos y felices.

Pierde su casa, y está solo, y está desnudo, y aparece el hambre, y hay que cerrar los ojos, y el vacío es profundo y no hay unas paredes firmes que lo abracen y le indiquen quién es y dónde está.

Pierde todo, y el desconsuelo es absoluto, cuando no hay brazos suaves que lo acunen y leche tibia que lo llene. Cuando no hay voces cantarinas y golpecitos de corazón.

Pierde todo, a menos que, de a poco, le mostremos que en este mundo nada se pierde, y que, en un abrazo amoroso, se encuentra el calor, el aroma y la vibración del amor.

“Los bebés no se acostumbran a los brazos, los necesitan”.

La primera hora de vida

Hasta hace no tanto tiempo, la primera hora de vida del recién nacido sano en instituciones era un momento sumamente intervenido. Sondas, pinchazos, peso, talla y otras **cuestiones que, científicamente, tienen poco apuro** y se hacían sobre su cuerpito recién nacido.

De a poco, la ciencia fue demostrando que **lo más importante para un recién nacido sano es estar en contacto con su madre**. Que la mejor manera de regular la temperatura, de adaptarse al medio ambiente y de iniciar sus respiraciones autónomas es estar sobre la piel de su mamá.

A este tiempo de adaptación lo llamamos **“hora de oro”**, si bien no es una hora exacta por reloj. Es un tiempo único, de reconocimiento entre mamá y bebé, de interpretación de señales, olores, el mundo nuevo y fascinante de este vínculo fuera de la panza.

Durante el trabajo de parto se producen hormonas de estrés, las catecolaminas (adrenalina, por ejemplo) que pasan la placenta y llegan al bebé. De esta manera, el bebé nace y luego de su primera respiración, si está todo bien, entra en un estado de alerta tranquilo. **Si se lo permitimos, es capaz de reptar por encima del abdomen de su mamá y llegar a la teta**. Los pezones se oscurecen durante el embarazo por efecto de las hormonas, y de esa manera, son más fáciles de ubicar por sus ojitos que ven poco. Alrededor de los pezones están las glándulas de Montgomery, que son unas glándulas chiquitas que secretan pequeñas cantidades de un líquido que tiene un aroma similar al líquido amniótico y le generan una sensación de “algo conocido” al

bebé. Este aroma lo atrae hacia el pecho, donde, si se lo permitimos, hará un “reconocimiento” del mismo olfateando, lamiendo y probando, hasta iniciar solito su primera mamada.

Claro está que todos los partos, inclusive los domiciliarios, suelen ser algo intervenidos, y no es común que esto suceda espontáneamente. Es interesante tener esta información en cuenta como parte de nuestra vida mamífera, para **considerar al bebé sujeto activo de su nacimiento y de las primeras horas de vida.**

¿Puede pasar todo esto en una cesárea sin trabajo de parto? Sí, puede pasar. Se puede poner al bebé sobre el pecho de la mamá, se puede acercarlo a la teta. Tuve la suerte de que, luego de desear mucho un parto después de cesárea y que no se diera, se respetara mi cesárea y fuera un hermoso encuentro para los tres. **Un nacimiento hermoso no siempre se trata de un parto vaginal, sino de respetar a la persona que llega al mundo y a su familia.**

Después del nacimiento del bebé, **se sugiere esperar de uno a tres minutos para cortar el cordón umbilical**, tiempo en el que generalmente deja de latir. Esta es una manera de **asegurarse de que la sangre del bebé que se encuentra en la placenta retorne al mismo, y así prevenir la anemia.** Es una estrategia sencilla, sin costo e importantísima para la salud pública.

Muchos bebés nacen embadurnados por una especie de pasta blanquecina y grasosa. Esta sustancia se llama “vérnix caseosa”, y es más pronunciada mientras más pequeño sea el bebé de edad gestacional. **No hace falta lavarla:** le permite regular la temperatura y protege su piel. Se va absorbiendo y retirándose solita.

A partir del momento en que el bebé sale del útero, los profesionales de la salud observamos su vitalidad: si respira enseguida, si reacciona rápido, cómo es su tono muscular... Con estos datos hacemos algo que se llama “puntaje APGAR”, que evalúa Aspecto (color: los bebés suelen ponerse rosados al nacer, aunque a veces tardan en ponerse rosadas las manos y los pies), Pulso (frecuencia cardíaca), Irritabilidad refleja (*grimace*, en inglés: cómo responde el bebé a un estímulo), Actividad (el tono muscular) y Respiración. Va del 0 al 10 y se hace dos veces, la primera en el momento del nacimiento. ¿Para qué nos sirve? Para evaluar rápidamente el estado de salud del recién nacido.

También hacemos otro test llamado “de Capurro”, que nos sirve para estimar su edad gestacional. Miramos las orejitas, las glándulas mamarias, la formación del pezón del bebé, la textura de la piel y los pliegues de la planta del pie (cuanto más arrugadito, más “viejito” es el bebé). Se hace una cuenta con un cierto puntaje y se define la edad gestacional, sobre todo en embarazos no controlados o en bebés prematuros.

Con el nacimiento, comienza la exterogestación del bebé. Parte del inicio del vínculo mamá y bebé se da con la primera preñida a la teta, en ese mundo nuevo que implica que haya “otro”, que da el primer puntapié a la construcción de la identidad y que genera deseo, placer y seguridad.

Hablemos de algunas intervenciones:

- **¿Hace falta bañar al bebé cuando nace?** La respuesta es rotunda: no, **no hace falta y, de hecho, puede ser perjudicial**. El bebé que nace por parto vaginal se impregna de las bacterias de la vagina, la zona perineal y la piel de su mamá. El que nace por cesárea, si le permiten ser apoyado en el pecho materno, con las bacterias de su piel. Estas bacterias son importantísimas, porque definirán su microbiota. Vimos esto en profundidad en el capítulo 3.
- **¿Pesarlo, medirlo, medirle la cabeza...?** Ninguna de estas tres cosas es de urgencia en un recién nacido sano. Existe consenso en pesar al recién nacido inmediatamente después de su nacimiento, y de hecho, el “¿cuánto pesó?” suele ser una pregunta muy común al anunciarlo. La realidad es que se está pensando en **cambiar el momento del primer peso a las 24 h del nacimiento, cuando el bebé ya perdió líquidos “de más” que se puedan haber pasado a la mamá durante el trabajo de parto o cesárea**. Lo que es seguro es que, por un lado, el bebé está flexionado, hecho un bollito, igual que en el útero, y si pasó por un parto vaginal, probablemente con la cabecita algo deformada (los huesos del cráneo no están pegados en los bebés precisamente para eso: para que puedan adaptarse al canal de parto). Las mediciones de largo y de circunferencia craneana serán... ¡muy inexactas!
- **Los pinchazos:** al nacer, el bebé recibe dos inyecciones, una en cada muslito. Se dan en esos lugares porque es donde hay más músculo (¡tanta patadita en la panza los ha desarrollado!). Una de ellas es la vitamina K. Esta vitamina pasa muy poco por la placenta y la forman las bacterias del intestino, esa famosa microbiota que mencioné antes (además de, posteriormente, ser incorporada en la dieta). El bebé recién acaba de empezar a recibir esas bacterias, así que no tiene en su cuerpo manera efectiva de tener vitamina K. ¿Y para qué sirve esta vitamina? Para evitar hemorragias, porque **la vitamina K actúa en la coagulación de la sangre**. Sin ella, pueden sangrar órganos clave como el cerebro o el intestino. ¿Hay otras maneras de dar vitamina K? Sí, **se puede administrar por vía oral, pero son varias dosis** y es importante cumplirlas a todas sin falta, sino el bebé continúa en riesgo. **La otra inyección por protocolo es la vacuna contra el virus de la hepatitis B**, su primera dosis, que no necesariamente debe ser administrada al nacer, sino que puede darse dentro de las primeras 12 horas de vida. ¿Hay alguna forma amable de dar estas inyecciones? Sí, **pueden ser administradas con el bebé sobre el pecho de la mamá, tomando la teta**. De esta manera se minimiza el dolor y se aporta consuelo. Algunos bebés, como mi Lisandro, de hecho, ni siquiera lloran, ocupados como están con succionar y descubrir a mamá.

- **“A todos los bebés les meten una sonda por la boca y luego por el ano”.** Esto era real hasta hace algunos años, pero **es una práctica desaconsejada hoy en día.** En pocos lugares (desactualizados) se sigue realizando. Se hacía para comprobar que no hubiera ninguna malformación que ocluyera el tubo digestivo. Hoy nos limitamos a observar al bebé; si come bien y hace caca, claramente el tubo digestivo está permeable y no necesitamos ninguna sonda para evaluarlo.
- **“Solo le pude dar un besito, y cuando me lo trajeron, ya estaba vestido”.** Esto es muy común y muy triste. **El bebé y su mamá necesitan estar piel con piel por lo menos durante la primera hora de vida.** Les hace bien a ambos, los relaja, favorece la bajada de la leche y el vínculo de amor. **Piel con piel es eso: no se necesita ni el pañal.** Es el calor de la mamá entibiando al cachorro. Ya llegará el tiempo de vestirse: hay toda una vida para hacerlo.
- **“Del pecho no sale nada”.** El estómago del recién nacido está lleno aún del líquido amniótico que tragó adentro del útero (sí, los bebés “entrenan” su deglución adentro de la panza). Es común que tenga algunas náuseas las primeras horas, y hasta algunos vómitos. Esto no quiere decir que no haya que ponerlo al pecho, al contrario. **La primera leche se llama “calostro”, y son apenas unas gotas que bastan y sobran.** Tiene un color amarillento transparente y es riquísimo en proteínas, muchas de ellas anticuerpos que le aportan inmunidad al bebé. A veces no se ve, porque el bebé lo toma cuando succiona, o se cree que es “poco”. El tamaño de ese pequeño estómago es de no más de 5 ml, y **la leche materna se digiere en una hora** aproximadamente, así que no es raro que, en su primer mes, el bebé esté la mayor parte del día pidiendo teta, y tomando teta. Y esto es... ¡sano y bueno! **La primera hora del recién nacido es el momento ideal para iniciar la lactancia.** Se comprobó que los bebés que toman la teta antes de salir de la sala de parto/quirófano tienen tasas de lactancia mucho mayores a los que no.
- **“¿Y si no pasó nada de eso en el nacimiento de mi bebé? Si no nos respetaron la hora de oro, ¿puede generarle algún problema? Si no inició la lactancia en la sala de partos... ¿lograré una lactancia exclusiva?”.** Antes que nada, reconfortarse. Muchas veces no tenemos la información; otras, la tenemos pero no nos respetan. **Siempre queremos lo mejor para nuestro bebé, y esa es la premisa donde tenemos que apoyarnos.** El vínculo no se define por un hecho, se construye día a día, con amor. La lactancia tiene mil aristas: una de ellas es la paciencia y otra la ayuda externa, y esto va mucho más allá de la primera hora de vida.

Para leer

PARA FAMILIAS

- Marcote, V. *Nosotras parimos. Guía para un parto respetado*. Editorial Paidós, Buenos Aires, 2017.
- Odent, M. *El bebé es un mamífero*. Editorial Madreselva, Buenos Aires, 2011.

PARA PROFESIONALES

- Dirección Nacional de Maternidad, Infancia y Adolescencia (DiNaMIA), Ministerio de Salud de la Nación. *Curso básico de lactancia materna*, Plataforma SUMAR. 2018.
- Rossatto, N. *PRONAP, Programa Nacional de Actualización Pediátrica 2016*, Módulo 1, pág. 15-46.
- Moore E. R.; Bergman, N.; Anderson, G. C.; Medley, N. *Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants*. Cochrane Database Syst Rev. 2016; (11):CD003519. DOI: 10.1002/14651858.CD003519.pub4.
- Smith, E.; Hurt, L.; Chowdhury, R.; Sihna, B.; Fawzi, W.; Edmond, K. *Delayed breastfeeding initiation and infant survival: a systematic review and meta-analysis*. Plos One. 2017. Recuperado de: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180722>
- Fallon, A.; Van der Putten, D.; Dring, C.; Moylett, E. H.; Fealy, G.; Devane, D. *Baby-led compared with scheduled (or mixed) breastfeeding for successful breastfeeding*. Cochrane Database Syst Rev. 2016; (9):CD009067. DOI: 10.1002/14651858.CD009067.pub3.

La casa



Todo esto lo imaginamos mientras acariciábamos la panza. Tenemos la cuna lista, la pila de medias lavada, hay un vinilo con un león simpático pegado en la pared de su habitación. Nos han dado el alta de la clínica con control en 48 horas. Dijeron algo de la bilirrubina, unas palabras sobre el cordón. Cruzamos la puerta de la habitación del sanatorio y nos llevamos el cuadrito colgado. ¿Cómo se pone el huevito? ¿Por qué no lo practicamos antes? Miralo, parece perdido ahí adentro... ¿No se le estará yendo la cabeza muy para adelante? Sostenelo, sostenelo bien, cuidado con la cabeza. Bueno, Pedro, esta es tu casa. Bienvenido.

¿¿¿Y ahora???

Los recién nacidos son criaturas inigualables: tan bellos como aterradores. Podríamos pasar horas mirándole los pies a nuestro bebé, y otras tantas preocupados por si está respirando o no. Este capítulo, como el de primeros auxilios que veremos más adelante, apunta a poner un poco de paz para promover el disfrute familiar y la adaptación a nuestro bebé en esos primeros días llenos de emociones (¡de todo tipo!).

La nueva familia y las visitas

Hay pocos momentos tan hermosos como visitar por primera vez a un recién nacido. Sin embargo, es conveniente buscar que nuestro amor por esos niños y las ganas de verlos también se vean traducidos en **visitas respetuosas para ellos y sus familias, dejando de lado nuestros deseos y ansiedades, y poniéndonos en su lugar**. Por lo tanto, aquí algunas recomendaciones para esas primeras visitas a la nueva familia que acaba de formarse:

- Pedí permiso para ir al hospital o al hogar. Los primeros días no son fáciles, es un proceso de adaptación a la nueva situación de vida para todos los integrantes de la familia, no solo para el recién nacido, y tal vez sea mejor dilatar la visita un tiempito más.
- Si el bebé está siendo amamantado, tratá de darle intimidad a esa dupla que se está conociendo afuera de la panza.

- Sería saludable evitar comentarios sobre el cuerpo de la mamá, acerca de cómo amamanta, cuánta leche tiene, cuánta caca hace el bebé...
- No tomes en brazos al recién nacido si no te lo ofrecen. Tu amor por él va más allá de tenerlo a upa en sus primeras horas. El bebé no conoce a nadie más que a su mamá, y necesita de ella en plenitud, sentir su corazón, su calor, su olor. Habrá mucho tiempo para conocerse y hacer burbujitas juntos.
- No saques fotos ni las publiques en redes sociales sin permiso. Conocí casos de mamás que antes de ver a su bebé, por diversas razones, vieron una foto en las redes subida sin su consentimiento. No es respetuoso ni para la familia ni para el bebé. Ellos decidirán si desean posteriormente esta exposición.

¿Qué cosas sí podemos hacer?

- Llevarles comida a los nuevos mapadres.
- Ayudar con los hermanitos si los hubiera.
- Ofrecerse a hacer las compras o limpiar alguna parte de la casa.
- Mantener una higiene estricta al visitar niños pequeños: lavado de manos con jabón y alcohol en gel.
- Tratar de usar el celular lo menos posible si vamos a tocar a un bebé (los celulares son un fuerte foco de microorganismos infectantes).
- Evitar darle besos en las manos o en la boca, para no pasarle gérmenes que pueden dañarlo. Inclusive, a un recién nacido, sería prudente no besarle la carita o las manos si no somos sus mapadres.
- Suspender la visita si estamos con mocos, tos, o cualquier signo de infección. Avisar a los mapadres. Un pequeño resfrío para nosotros puede ser una internación para un bebé pequeño.
- A veces, contener nuestras ganas, ¡es la forma de amor más grande!

Cada familia es un universo. ¡A algunas familias les encanta tener mucha gente en la casa! Lo importante es contar con toda la información posible para poder decidir, y poder expresar nuestros deseos reales en ese momento.

Las mascotas, parte de la familia

Pocas cosas superan el cariño por una mascota y la importancia de su compañía. ¿Qué hacemos cuando tenemos mascotas y, de pronto, llegamos a casa del hospital con un bebé?

Lo importante, según los veterinarios y entrenadores caninos, es permitir que la mascota (generalmente perro o gato) **reconozca al bebé, sin mostrarle miedo**. Se puede dejar al bebé en una manta o colchoneta en el piso y permitir que las mascotas lo olfateen y lo reconozcan. ¡Los bebés tienen el olor a su mamá! Nuestros animalitos reconocerán ese aroma como parte de la familia.

Para aquellos que se horroricen al leer esto, pensando en un perrito lamiendo a un recién nacido, paso a contarles que **el recién nacido no es un ser estéril**. Está conformando su microbiota, y ese animal va a ser parte de su entorno.

Las mascotas **deben estar vacunadas, desparasitadas y, en lo posible, bañadas**. Ayuda mucho hacer un control cercano a la llegada del bebé, para charlar con el veterinario acerca de esta situación y escuchar sus consejos.

También es relevante el explicarles a las mascotas qué objetos son de ellos y cuáles del bebé. Ponerse firme en los espacios que les permitimos: por ejemplo, no autorizar que duerman en la cuna.

Se ha escrito mucho acerca de los beneficios del contacto con perros y gatos con relación a diversas enfermedades. **Se plantea que convivir con estas mascotas sería un factor protector para el asma, la dermatitis atópica y otras enfermedades relacionadas con los alérgenos.**

Mientras esperábamos a Lisandro, con el papá disfrutábamos a Godzilla, nuestro perro salchicha. Dueño de un carácter salchichístico y una intensidad sin igual, se pasó casi todo el embarazo durmiendo con su cabeza apoyada en mi panza. Unos días antes del nacimiento, empezó a dormir con su padre humano. Preocupados por su amor extremo a mi persona y con miedo a que le hiciera daño al bebé, hablamos con un adiestrador, que nos dio los consejos que reproduce más arriba con su permiso.

El día que llegamos de la clínica, dejamos a Lisandro en el piso y Godzilla lo husmeó, lo olisqueó y le lamió los pies. Después de eso, nunca más le presté demasiada atención, ¡salvo cuando tiene arranques de besuqueo intensivo! Esperamos que sean buenos amigos más adelante.

Las mascotas son parte de nuestra familia. No es necesario echarlas ni evitar

el contacto. Simplemente mantener normas básicas de higiene sin caer en la paranoia, y promover el vínculo afectivo entre nuestros bebés y nuestros masco-hijos. Enseñarles a los chicos a no lastimarlos, a no tironearles la cola, explicarles que son seres con carácter y que se pueden asustar o enojar si los tratamos mal. Invitarlos, más adelante, a participar en su cuidado: ponerles la comida, limpiar la caca o sacarlos a pasear. Todos podemos convivir con amor y puede ser una hermosa experiencia.

Hay un bebé en mi cama

Es conveniente que los bebés, durante su primer mes de vida, se alimenten mínimo cada 3 horas. Es decir, aunque duerman toda la noche, solo durante ese mes (y por supuesto, generalizando) **habría que despertarlos para comer si no lo hacen solos, para prevenir la hipoglucemia (niveles bajos de azúcar en sangre).**

Posteriormente, si aumentan correctamente de peso, no hay necesidad de despertarlos... aunque, generalmente, ¡se despiertan solos!

Ya hablaremos del sueño infantil en el capítulo correspondiente, como así también hablaremos de colecho y sueño seguro.

Y sí. Ir cada 5 minutos a ver “si respira”, ¡es normal! Lo hacemos todos.

Llora todo el día

Los bebés lloran. Es su única herramienta de comunicación. **Es una señal que comunica necesidades.** Y esas necesidades no siempre son hambre o frío. Puede ser la necesidad, por ejemplo, de escuchar una voz que conozca o de estar en brazos. También puede ser que les moleste alguna etiqueta de la ropa, que el pañal esté mojado, que los estemos sosteniendo en una posición incómoda. Y también, cómo no, pueden ser los temidos cólicos.

El llanto de un bebé, sobre todo si es nuestro primer hijo, o se suma a un hermanito más grande y con algo de celos, puede ser agobiante y desgarrador. Si sentimos que nos excede, tratemos de pedir ayuda a familiares, amigos, e incluso a profesionales de la salud perinatal: nosotros también estamos aprendiendo de ellos.

El llanto acerca al adulto al bebé: lo raro sería que los bebés no pidieran por nosotros. Necesitan nuestro abrazo porque en él se sienten seguros. ¿No es hermoso? ¿Cuándo nos querrán de nuevo con tanta sinceridad?

*No son “mañosos”.
No son “manipuladores”.
No te “toman el tiempo”.*



Sí, quieren estar a upa siempre. No se duermen en la cuna. Gritan en forma desesperada cuando los apoyamos en el cochecito para ir al baño.

Quieren teta, siempre. ¡Un recién nacido puede estar 20 horas al día en la teta! Y aparecen los comentarios innecesarios de “no se llena”, “debe tener hambre”, “tu leche es mala”. ¿Cuándo nos convencieron de que esas 20 horas no son normales? ¿Cuándo nos hicieron dudar de que la mayoría de los bebés solo se duermen a upa?

Y ese bebé, simplemente, quiere tu olor. Tu sabor, tu piel tibiecita. La inundación de oxitocina que siente cuando lo acariciás. Quiere sentirse protegido y amado, como cualquier persona. No termina de entender este mundo, después de haber vivido 9 meses de nado feliz. Necesita abrazos, mimos, teta (aunque tome mamadera, siempre estará para apoyar la cabecita y sentir el corazón debajo).

Que nuestro agotamiento no nos haga patologizar la infancia. Que no tengamos que pensar que nuestro hijo es “caprichoso” porque no nos deja “hacer nada”. La humanidad crío siempre en tribu, porque los brazos son exclusivos para el bebé que los necesita y no para que una

mamá se tenga que estar preocupando de otras cosas (que suele ser lo que más agobia). Es difícil, en este mundo de soledad y departamentos de ciudad, pero con empoderamiento e información, podemos empezar a buscar compañía y ayuda.

Buscan nuestro abrazo cansado porque nos aman. Llegará el día que el consuelo esté en otro lado y recordaremos esas manitas calentitas con nostalgia. Hoy no es siempre.

“Crisis genital”

En los primeros días después del nacimiento, los bebés, tanto niños como niñas, pueden tener manifestaciones en sus genitales que nos llamen la atención. Esto es debido a las hormonas de la mamá que pasaron a su cuerpo durante el embarazo, el parto y la lactancia. **Son totalmente normales y transitorias.** Se le llama “crisis genital”.

Las niñas pueden tener:

- Hinchazón de las mamas, e inclusive secretar un poco de líquido. Se suele denominar popularmente “leche de brujas”.
- Flujo vaginal blanquecino o transparente.
- Un pequeño sangrado vaginal, como si fuera una menstruación.
- Vulva “hinchada” y más oscura.

Los varones pueden tener:

- También, agrandamiento de las glándulas mamarias (se palpa una “bolita” por debajo de las tetillas).
- Escroto “hinchado” y más oscuro.

No hay que apretar ni hacer ninguna maniobra con las glándulas mamarias de los bebés. Irán reduciéndose de tamaño y pronto se normalizarán.

Mi bebé tiene granitos

Pocos días después de nacer, los bebés pueden presentar granitos en todo el cuerpo, generalmente de base roja, como si fueran picaduras. Esto es muy común, se llama “eritema tóxico” (un nombre un poco desafortunado, no es tóxico ni anormal). Dura alrededor de una semana y se cree que está producido por un tipo de células que se llaman “eosinófilos”, pero aún no se sabe muy bien por qué sucede. **Se van solos.**

También, en la cara de los bebés podemos ver, recurrentemente, puntitos blancos. Estos se denominan “millium facial” y son absolutamente normales. Simplemente, es que su piel es inmadura. No hay que apretarlos, se pueden infectar, y se resuelven espontáneamente.

Por último, a veces nuestro bebé parece que se vuelve un adolescente y se le llena la cara de granitos parecidos al acné. Esto precisamente se llama “acné neonatal”, y se produce por el *shock* de hormonas que se produjo entre el nacimiento y la teta. Da un poco de impresión a veces, pero tampoco se hace nada.

Por supuesto, todas estas cuestiones de la piel tienen que ser diagnosticadas por el ojo entrenado de un profesional. ¡Pero sepamos que son normales!

La costra láctea

La costra láctea es la forma de llamar a la dermatitis seborreica que se puede observar en el cuero cabelludo del recién nacido. Son costras amarillentas, a veces gruesas (inclusive, se denominan también “gorra de cuna”). Las podemos encontrar también en las cejas, la frente, detrás de las orejas y hasta en la zona del pañal. No pican ni duelen. Generalmente se van solas hacia los 7 meses de vida, pero pueden persistir más tiempo (¡hasta los 2 años!).

No hace falta sacarlas, si lo hacemos, es solo por estética. Se suele sugerir pasar aceite de almendras un rato antes del baño para que las escamas de la cabecita se aflojen, y luego pasar un peine con mucho cuidado para no lastimar al bebé. Pero reitero: no hace falta hacerlo, y de hecho, no lo sugiero.

Los tan temidos cólicos

¿Cómo se definen los cólicos? Médicamente, como episodios de llanto intenso y vigoroso al menos **tres horas al día, tres días a la semana, durante al menos tres semanas** en un bebé sano y bien alimentado.

¡Momento! ¿Entonces no se podría decir que un bebé menor de tres semanas tiene cólicos? Por definición, no. ¿El dolor de pancita es un cólico? Cada vez estamos más lejos de asociar una cosa con otra. **El recién nacido está aprendiendo qué le pasa en su tracto digestivo.** Antes, el alimento llegaba por el cordón umbilical. Ahora, hay tiempos y espacios, la leche entra por la boca con mucho esfuerzo, se digiere, hace borbotones, hay que hacer fuerza para sacar lo que sobra del cuerpo. Todo esto es nuevo y extraño, y puede producir malestar. ¿Es esto un cólico? No.

Existe una condición llamada “disquecia del lactante”, que tiene que ver con esta adaptación digestiva (“pujos”, bebé coloradito al hacer caca pero que no está estreñido). El bebé aún no entiende que tiene que abrir su esfínter anal externo para hacer caca, entonces hace fuerza y se siente molesto. Esto va mejorando a medida que va adquiriendo mayor conciencia de sus esfínteres.

El cólico, se cree, tiene más que ver con la adaptación del bebé al mundo exterior. El pico es entre las 3 y 8 semanas, y sobre todo, a partir de las 18-19 h, la llamada “hora de brujas”... cuando TODOS, bebés y mapadres, estamos cansados y agobiados. Fuimos acumulando estímulos y tensión durante todo el día, ¡y todos queremos llorar!

Entonces... ¿qué podemos hacer cuando el bebé llora? ¿Y cuando tiene cólicos?

Las intervenciones que se comprobó que tienen efectividad ante el llanto “excesivo” de los bebés son:

- * Responder pronto al llanto.
- * Tomar en brazos.
- * Alimentar a demanda.
- * Conocer el patrón normal de llanto.
- * Si la situación nos agobia, pedir ayuda.
- * Tener una red de contención (tribu) que nos dé soporte.
- * Mantener la calma y comprender que, a pesar de nuestro agotamiento, *hoy no es siempre.*

Las intervenciones que se comprobó que NO tienen efecto o que

eran similares al placebo:

- * Antiespasmódicos como el famoso Factor AG: no se comprobó que tuviera ningún efecto. Es una medicación y, como tal, no está exenta de riesgos.
- * "Dejarlo llorar": de esta manera, el bebé solo aprenderá que no puede contar con nosotros.
- * Disminuir tomas de leche/sustituir o complementar la lactancia materna con fórmula/leche baja en lactosa/hidrolizado/leche de soja: error grave y de desconocimiento profundo de parte de los profesionales. A menos que el niño tenga un diagnóstico puntual, en los estudios no se encuentra NADA que avale estas prácticas intrusivas y peligrosas para la lactancia.
- * Infusiones de "yuyos" como la manzanilla, el paico, el anís estrellado: sumamente tóxicas para los bebés, pueden causar diarreas graves y convulsiones.
- * Excluir lácteos de la dieta materna: esto, en niños con sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca, puede ser útil. Sin embargo, requerimos evaluarlo detalladamente para poder hacerlo en forma correcta como indicación. No es lo mismo el consejo de consumir lácteos "deslactosados", esto no tiene ningún fundamento.

¿Y el masaje? ¿Y los probióticos? ¿Y la bicicleta con las piernitas?

- Siempre, SIEMPRE, no importa cómo se haga, el contacto piel con piel mejora los cólicos, pues le aporta seguridad y placer al bebé. Por eso, también sugiero el porteo ergonómico, seguro y respetuoso. Dijimos que el cólico es la respuesta a la adaptación al mundo... y nada mejor que hacerlo pegadito a alguien a quien amás. El movimiento en "bicicleta" es parte de ese contacto y atención que siempre colabora.
- Los probióticos envasados no se venden en Argentina pero se traen de afuera. Aún no hay estudios que avalen su uso, salvo en bebés prematuros internados en Neonatología. En bebés sanos de término no se observó que su uso mejorara los cólicos. ¿Pero saben qué alimento tiene probióticos y prebióticos en abundancia? ¡Sí, la leche materna!

Lo más importante con relación al tema de los cólicos es mantener la calma, saber que

los bebés lloran pero no siempre por dolor de panza o hambre, y que esto, por más duro que parezca... también pasará.

Bebé “vomitito”

La gran mayoría de los bebés vomitan o regurgitan. **El reflujo gastroesofágico es definido como el pasaje del contenido del estómago hacia el esófago, llegando incluso hasta la boca.**

En los bebés, esto es sumamente COMÚN, y se pueden definir dos situaciones:

- * **Reflujo gastroesofágico fisiológico:** son los llamados “vomitadores felices”. Estos bebés suelen regurgitar o vomitar varias veces al día, no ocurriendo esto durante el sueño. Los vómitos no se asocian a otros síntomas, son bebés que crecen bien, aumentan de peso y están de buen humor aunque recién hayan vomitado. Esto habla de un reflujo fisiológico por inmadurez intestinal, que suele resolverse solo entre los 6 y 18 meses. No necesitan medicación ni ningún tratamiento específico.
- * **Reflujo gastroesofágico patológico, o enfermedad por reflujo gastroesofágico:** Estos bebés también tiene reflujo, pero se encuentran otros síntomas asociados. Entre ellos, pérdida o escasa ganancia de peso, broncoespasmos a repetición, estridor laríngeo, arqueamiento hacia atrás constante (también llamado “síndrome de Sandifer”), episodios de apneas y anemia.

Ante la sospecha de un reflujo gastroesofágico patológico, el pediatra debe evaluar si, según los síntomas (que como vemos, son variados), corresponden estudios como la seriada esofagogastroduodenal (SEGD) o la pHmetría. En algunos casos con síntomas claros se evalúa también comenzar un tratamiento farmacológico empírico y observar la evolución. En otros casos, se requiere la derivación con gastroenterología.

Antes, o junto con el tratamiento farmacológico, se indican medidas higiénico-posturales para bebés con reflujo: por ejemplo, no acostarlo enseguida después de haber tomado la leche, elevar la cabecera de la cama y evaluar qué volumen de leche se le está aportando, si este se alimenta solo con fórmula.

Si se sospecha o se diagnostica un reflujo patológico, CADA CASO ES PARTICULAR y debe ser evaluado por el pediatra. Es importante no autodiagnosticarse, y ante la duda, consultar al pediatra de cabecera.

La lactancia materna siempre es un factor protector, es la leche que mejor se

digiere y no se debería interferir con la libre demanda, cualquiera sea el tratamiento. Si el profesional que los acompaña diagnostica un bebé vomitador feliz... ¡solo queda usar muchos trapitos y resignarse a tener la ropa vomitada!

El baño y el cuidado del cordón umbilical

Cuando hablamos del nacimiento, dijimos que **no es necesario bañar al recién nacido en sus primeras horas, ni en sus primeros días**. La vernix caseosa va a ir desapareciendo, si es que la tiene, y el olor a líquido amniótico dará paso al famoso “olor a bebé” que tanto nos enamora.

No hay un consenso acerca de cuándo bañar por primera vez al bebé. Lo que sí podemos decir es que no es necesaria la caída del cordón umbilical para el primer baño. Mientras mantengamos la zona bien seca posteriormente, no hay problema con mojarlo.

¿Con qué bañar al bebé? Con agua tibia y algún jabón hipoalergénico. No es necesario ni recomendable usar champú ni acondicionador. **Mientras menos químicos, por lo menos hasta el año de vida, mejor.**

¿Cuántas veces por semana bañar al bebé? Se puede bañar todos los días si lo deseamos. No hay una indicación precisa.

Luego del baño, ¿ponemos talco o fécula de maíz? **No, no es necesario**. El talco tapa los poros y no permite que la piel respire, y puede generar irritación. Además, las partículas vuelan y pueden irritar la vía aérea. Ninguno de estos productos se recomienda para un bebé.

El cordón umbilical es una estructura fascinante que comunica al feto con la placenta, un órgano creado por el cuerpo específicamente para el embarazo. La placenta está formada por células fetales y maternas, y, por suerte, **cada vez tenemos más conciencia de ella**. Cuando un parto o una cesárea no tienen complicaciones, la placenta va a la basura. Podemos pedirle para llevárnosla si lo deseamos: para mirarla, para hacer una impresión en una hoja (son muy bellas), para enterrarla, para alquimizarla... lo que deseemos. Otras veces se envía al área de Anatomía patológica para ser estudiada (por ejemplo, ante infecciones en el bebé o en la mamá, bebés de bajo peso y otras condiciones).

El cordón umbilical tiene dos arterias y una vena, y no tiene nervios, por lo que no duele. Se corta en el momento del nacimiento, esperando a que deje de latir (1 a 3 minutos) **para que la sangre de la placenta pase al bebé. Esto es un factor protector ante la anemia**. Se le coloca un brochecito (*clamp*) y se cae entre los 5 y 20 días de vida (a veces más, a veces menos).

Acerca de “limpiar” el cordón, mucho se ha dicho. Se ha recomendado alcohol,

clorhexidina y otros químicos. Las últimas actualizaciones dicen que simplemente **hay que mantenerlo limpio y seco, y que no hace falta pasarle ninguna solución en particular** (aunque, de hacerlo, no sería perjudicial). No hay que tener miedo en limpiar la unión entre la piel y el cordón, incluso si sangra un poquito: al no tener nervios el cordón, no duele.

Durante el desarrollo embrionario-fetal, alrededor de la semana 10 de gestación, los intestinos crecen muy rápido, más que el abdomen, y por un corto período de tiempo, se alojan en el cordón umbilical, para después volver a la cavidad abdominal (es rarísimo y fascinante).

A veces, la pared abdominal no se termina de cerrar del todo antes del nacimiento, y cuando se cae el cordón o antes, empezamos a ver un bultito en la pancita del bebé, que va y viene. Esto se llama “hernia umbilical”: como esa pared no está cerrada del todo, un pedacito de intestino cubierto por piel se “escapa” cada vez que el bebé llora, hace fuerza, hace caca... y entonces aparece ese bultito que tanto preocupa. **Es muy común: un bebé de cada diez la presenta.**

¿Es grave? Para nada. ¿Duele? No, no duele. ¿Cuándo se va? Las hernias umbilicales se “van” solas, porque **cuando el bebé se va verticalizando, se van fortaleciendo los músculos abdominales y se cierra ese agujerito.** Esto puede tardar incluso 3 o 4 años y seguir siendo absolutamente normal.

¿Hay que hacer algo? No. No hay que poner fajas, botones, monedas ni nada que “haga peso” u oprima. Colocar estos objetos puede irritar la piel y lastimar. Solo hay que tener paciencia y continuar los controles con el pediatra. En algunos casos, muy pocos, se requiere cierre quirúrgico.

¿Lo pelamos? ¿Le ponemos aritos?

Dos preguntas que los mapadres nos hacemos... o nos hacen: ¿Lo van a pelar? ¿Le van a poner aritos? Estos dos procedimientos quedan a criterio de la familia, y **es importante reconocer que solo se realizan por una cuestión estética y cultural.**

Pelar al bebé no hará que el pelo crezca más fuerte ni más lindo. El pelo de la cabeza ayuda a los bebés a regular su temperatura (la cabeza es la parte más extensa del bebé, y por donde más calor pierde, por eso, en las primeras horas de vida se le coloca un gorrito), **pelarlo le quita esa protección.** Si se decide esa práctica, es importante elegir a una persona idónea y respetuosa para realizarla.

Poner aritos a las niñas también es una cuestión cultural. Si se decide realizar, utilizar materiales hipoalergénicos, en condiciones de esterilidad. Se puede dar la teta durante el procedimiento para aminorar el dolor (sí, les duele. No es cierto que “mejor ahora que es chiquita y no lo siente”). No deja de ser **una perforación y una posible**

vía de entrada de gérmenes en un bebé muy pequeño, así que hay que estar muy atentos a cualquier signo de infección.

Limpiar las orejitas

El conducto auditivo externo (el agujerito del oído que conduce al interior del mismo) produce cerumen (cera). Esta sustancia es amarillenta-anaranjada y su función es PROTEGER esa zona. Es decir que la cera del oído, **¡no hace falta limpiarla! ¡Nos protege!**

No hacen falta hisopos, y mucho menos palillos, escarbadientes, hebillas y otros elementos que son peligrosos, pues pueden lastimar, irritar, producir más cera e incluso perforar el tímpano. Si la cera se escapa un poquito para afuera del oído y queremos limpiarla, podemos pasar simplemente un trapito y listo.

Si entra un poco de agua durante el baño, no pasa nada tampoco en la mayoría de los niños. Con secar levemente las orejitas al salir está bien.

La otitis media aguda, esa que nos lleva a la guardia por fiebre o dolor, no se produce por el baño, sino por virus y bacterias. Generalmente arranca con un resfrío, y las bacterias aprovechan y lastiman el oído. Debe diagnosticarla un médico con un elemento que mira el oído medio, llamado “otoscopio”.

Cortar las uñas

Hay bebés que nacen con las uñas largas. Otros que no, pero que juntan mugrecita y pelusas como si anduvieran haciendo jardinería. Muchas veces se arañan la carita o rasguñan el cuello de la mamá. Esto genera que se sugiera poner mitones o guantecitos al recién nacido. Esto no está aconsejado, porque no le permitimos explorar el mundo con sus manitos. **Los bebés necesitan tener las manos libres.**

¿Entonces? Durante el primer mes, las uñas suelen ser finas y quebradizas, y estar más “pegaditas” a la piel de los dedos, lo cual hace muy difícil el cortarlas en forma segura. Por lo tanto, los pediatras solemos sugerir que se limen con una lima de uñas para bebés, suave, solamente para pulir los bordes irregulares.

Después del primer mes, se puede usar una tijera con bordes redondeados. **Es recomendable cortar la uña en forma recta y no redondeada, para evitar que se encarne.** El mejor momento es después del baño, cuando están más blanditas (aunque

no siempre se puede). Está bueno dejar un margen de seguridad al cortar, no hacerlo muy al ras del dedo, sino lo suficiente para que no se arañe.

Cortar 20 uñitas es un deporte de riesgo que tendrá, probablemente, muchas pruebas y errores, y algún dedito lastimado (todos, alguna vez, sin querer, cortamos de más y nos sentimos las peores mapadres del mundo por hacerlo). Cada bebé tendrá su método: a algunos les gusta el ritual de cortarse las uñas, otros usan una canción, a otros los fastidia, otros eligen cortárselas dormidos. Cada familia, al ir conociendo a su bebé, elegirá la mejor opción. No hay fórmulas mágicas.

¿Cómo lavamos la ropa?

La piel del bebé es delicada. Durante las primeras semanas de vida, es aconsejable **usar ropita de algodón, hipoalergénica**. Se puede usar cualquier color, pero antes es importante verificar con qué están teñidas. Algunos colorantes, sobre todo de la ropa de colores muy vivos, pueden irritar.

Toda la ropita se debe lavar antes de ser probada en el bebé: no sabemos dónde estuvo guardada. Los jabones habituales para lavar nuestra ropa pueden no ser adecuados, por lo tanto, **durante el primer mes de vida, conviene lavarla a mano con jabón blanco, o en el lavarropas con jabón blanco rallado** (hay algunas marcas que hacen jabón blanco líquido). Es conveniente lavar el lavarropas previamente haciendo un programa con vinagre blanco, para quitar restos de jabón pegado.

Posteriormente, va a depender de la piel del bebé. Un bebé con la piel muy sensible necesitará que su ropa se lave sola y con jabón blanco (por ejemplo, en algunos casos de dermatitis atópica). Si esto no sucede, se puede agregar la ropita al lavado familiar.

Centrifugar la ropa no da cólicos, como dice un viejo mito. Tampoco es necesario planchar toda la ropa, eso no la desinfecta. Y si le cae el rocío encima... no pasa nada, ¡solo hay que secarla de nuevo!

La caca y los pañales

Una de las consultas más frecuentes que recibimos los pediatras es acerca del color, la consistencia y la frecuencia de la caca del bebé. Aquí va un pequeño “manual”:

- **Meconio:** es el nombre que reciben las primeras deposiciones del bebé. A veces, incluso, expulsan meconio dentro del útero (es un signo de que algo no anda bien, y recién se va a ver cuando se rompa la bolsa amniótica). Son cacas similares a la brea, negras y pegajosas.
- **Cacas de transición:** un poco negras, un poco amarillas. El intestino del bebé se está librando del meconio y a la vez produciendo nueva caca. La leche materna tiene efecto laxante y ayuda a este proceso.
- **Cacas color mostaza, doradas:** son las cacas esperables de un bebé alimentado a pecho y de la mayoría de los que toman fórmula. Pueden ser grumosas, pastosas, incluso algo líquidas. Todas son normales.
- **Cacas verdes:** no son por frío, ni por estar descalzos. Las cacas verdes tienen varios significados. Si son verde claro, puede que el bebé esté tomando solamente la primera parte de la mamada, con mayor contenido de lactosa, y poco de la parte grasa. Se soluciona dejándolo más tiempo en la teta. Si son verde oscuro, puede ser por el suplemento de hierro. Si el bebé toma fórmula, como la misma contiene hierro, puede tener cacas normales de dicho color.
- **Cacas negras:** si el bebé comenzó a tomar hierro y las cacas se volvieron negras concomitantemente, es probable que sea el hierro el que les da ese color. La sangre digerida puede también tener color negro, consultar al pediatra si hay dudas.
- **Caca con sangre:** las cacas con sangre son motivo de pronta consulta. Pueden tener varios orígenes: bebé que mama de un pezón lastimado y traga un poquito de sangre, alergia a la proteína de leche de vaca, infección por rotavirus... Es precisa una evaluación completa para definir y tratar su causa. Nunca son normales.
- **Caca blanca:** la caca blanca tampoco es normal. Generalmente habla de afectación hepática, y requiere una consulta urgente.



¿Con qué limpiar la cola? Se recomienda **usar óleo calcáreo**, que crea una película oleosa entre la piel y el pañal, y la protege. Hay muchas marcas en el mercado, sugiero utilizar alguna sin parabenos, o comprar el preparado magistral en la farmacia. Si no deseamos utilizar ese producto, podemos lavar con agua y jabón, y utilizar aceite, puede ser de cocina (oliva, coco...). Las toallitas comerciales no están sugeridas para el día a día porque tienen gran cantidad de químicos y suelen irritar las colitas, pero se pueden usar cada tanto o en situaciones puntuales, por ejemplo, cuando salimos de casa.

¿Cómo limpiar el área del pañal? En niñas, de adelante hacia atrás. También es conveniente limpiar entre los labios de la vulva, para que no queden restos de materia fecal que puedan propiciar una infección urinaria. En varones, es muy común que tengan el agujerito del prepucio muy pequeño. Esto se llama “fimosis”, y es absolutamente normal, en la mayoría de los varones se va ensanchando el orificio con el tiempo. No hay que tironear ni empujar hacia atrás el prepucio: eso solo haría que se lastime y cree adherencias que pueden terminar en cirugía. Un pequeño número de niños requerirá efectivamente cirugía para tratar la fimosis.

¿Qué pañales usar? Cada familia decidirá qué marca de pañales le conviene: hay mucha diversidad en el mercado sin demasiada diferencia de calidad. Hoy en día se encuentran en auge los pañales de tela: una excelente opción. Las telas utilizadas son mucho más sofisticadas que las de los antiguos pañales de tela, y se lavan fácilmente en el lavarropas. Algunos niños con dermatitis recurrente por los químicos de los pañales descartables mejoran notablemente con los pañales de tela. Hay varios “sistemas” (planos, todo en dos, todo en uno, de bolsillo, etc.) de estos pañales, y es cuestión de animarse y probar.

¿Cuántas cacas por día? El recién nacido puede hacer caca cada vez que se alimenta. Esto se llama “reflejo gastrocólico”: la ingesta de leche estimula el funcionamiento intestinal y el bebé hace caca. A partir del segundo-tercer mes, esto se va regulando. Cada bebé hace una cantidad de caca diferente, y cada familia va a ir aprendiendo a conocerlo. Algunos bebés hacen caca una sola vez al día, y otros cada dos o tres días. Durante los primeros seis meses es importante no dar agua, ni jugo de ciruela, ni ningún alimento que no sea leche cuando presumimos que el bebé está constipado: debemos consultar al pediatra.

Mi bebé babea mucho

Una pregunta muy común en la consulta: ¿es normal que mi bebé babeo mucho? ¿Le estarán saliendo los dientes?

Alrededor de los dos meses (a veces antes, a veces después), algunos bebés empiezan a babear más que antes. Esto lleva muchas veces a cuellitos húmedos, ropa imposible de secar y familias preocupadas. ¿Será normal? La respuesta es SÍ.

Las glándulas salivales se están desarrollando, pero los bebés aún no saben manejar ese volumen de saliva. Esto va mejorando los meses siguientes, cuando coordinan mejor la deglución. Generalmente coincide con un período donde se chupan insistentemente las manitos, por lo cual parece que hay dientes en camino.

Si bien hay bebés que cortan los dientitos tempranamente, lo usual es que se trate de un proceso de autodescubrimiento + baba, que es ideal que acompañemos en forma respetuosa.

Conclusión: la baba en bebés es normal, sana y esperable, y también pasará. ¡A cambiar baberos y ropitas nomás!

Pautas de alarma: no al miedo, sí a la información

Los recién nacidos tienen un **sistema inmune muy inmaduro y susceptible a infecciones**. No hay que tener miedo: simplemente hay que estar informados. Ante la presencia de algún signo de los siguientes enumerados, concurrir a la guardia de neonatología (generalmente en el hospital donde el bebé nació):

- 1. Fiebre (38 grados o más): la fiebre, incluso un solo registro, es un motivo de consulta en un bebé menor de dos meses.**
- 2. Bebé que no hace pis o hace mucho menos que de costumbre.**
- 3. Bebé que no quiere alimentarse o succiona débilmente.**
- 4. Bebé aletargado, “flojito” o muy irritable.**
- 5. Zona del cordón roja, dolorosa o con mal olor.**

Baby blues y depresión posparto

Podemos hablar horas acerca del enamoramiento de una mamá por su bebé. Hablamos tanto a veces, que cuando no sucede de esa manera, nos invade la angustia. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no sentimos ese amor arrollador de golpe por ese gurrumín gruñón? ¿Estaremos mal? ¿Por qué llora tanto? ¿No duerme porque no se siente seguro conmigo?

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, **del 30 al 75 % de las mujeres puérperas atraviesan, tres o cuatro días después del nacimiento, los *baby blues*: sentimientos de angustia, irritabilidad, llanto posparto**. Duran alrededor de una semana y mejoran con el tiempo. En cambio, la depresión posparto y la psicosis puerperal son cuadros más complejos, prolongados en el tiempo, que requieren rápida detección y un trabajo multidisciplinario para preservar la salud, y a veces hasta la vida, de la mamá y su bebé.

Si tus pensamientos son avasallantes, con mucha angustia; si sentís que no podés más realmente o pensaste en lastimarte a vos o a tu bebé, por favor, pedí ayuda profesional. Podés comunicárselo a tu obstetra o a tu pediatra para que puedan guiarte.

Algunos mitos...

- * **“No le des la teta tan seguido, porque el estómago trabaja mucho y hace más cólicos/se mezcla la leche nueva y la vieja/no va a tener horarios/se le va a arruinar el estómago”**. Esto habla de un profundo desconocimiento alrededor de la fisiología del recién nacido y la leche materna. El recién nacido puede estar alrededor de 20/22 horas pegado a la teta por día, no solo para comer, sino para regularse ante el mundo nuevo. La digestión de la leche materna se puede dar en: ¡una hora! Es decir, siempre está trabajando... y es lo que tiene que hacer. Alimentar al bebé a demanda mejora los cólicos.
- * **“Los cólicos son gases acumulados”**. Ya vimos que no asociamos el cólico tanto con lo gastrointestinal, sino con la adaptación al mundo nuevo. El bebé tiene gases y no sabe aún abrir el esfínter anal voluntariamente para eliminarlos. Eso, puntualmente, no es un cólico, es disquécia del lactante. Y nadie, NADIE, acumula gases hasta elevarse como un globo. Tranquilos, ya se irán.
- * **“Tu leche es mala/agria/tiene mucha lactosa. Vamos a cambiarla por formula/fórmula sin lactosa/hidrolizado/etc.”**. La leche materna es perfecta para cada bebé a menos que encontremos alguna enfermedad puntual (por ejemplo, la galactosemia, algo muy, muy raro). Nunca es agria, nunca tiene “cosas de más”. La lactosa que contiene es azúcar BUENA y NECESARIA para el desarrollo de la microbiota intestinal. La intolerancia a la lactosa en bebés (NO es lo mismo que

alergia a la proteína de leche de vaca) puede ser algo transitorio postgastroenteritis que se resuelve espontáneamente. Se hicieron estudios con leches bajas en lactosa y se comprobó que no tienen ningún efecto beneficioso.

- * **”Tiene cólicos porque comiste papa/chocolate, tomaste gaseosa, etc.”.** Una alimentación saludable de la mamá se traduce en una mejora en su microbiota y en la del bebé. ¡Pero el gas de la gaseosa no pasa a la leche! La alimentación saludable tiene que ser algo constante y a largo plazo para mejorar la salud de todos. Y se puede comer chocolate, picante, cítricos o lo que se desee: no “pasan” por la teta y ese día le generan cólicos al bebé. Si bien durante la lactancia se puede consumir café o bebidas con cafeína, se recomienda que no sea mucha cantidad pues eso sí puede estimular al bebé y ponerlo irritable (en www.e-lactancia.org pueden encontrar las dosis adecuadas).
- * **”Hay que acostarlo boca abajo y ahí mejora el cólico”.** Acostar a los bebés boca abajo generalmente los hace sentir más contenidos y los regula. De hecho, a los prematuros pequeños, cuando están en Neonatología, se los coloca boca abajo para “organizarlos” en el espacio (recordemos que están monitorizados continuamente). Sin embargo, no se recomienda dormir a los bebés boca abajo pues aumenta el riesgo de muerte súbita. Los bebés, en casa, no tienen un monitor constante que nos avisa si respiran o no. Sí podemos tenerlos a upa con la pancita contra nuestro brazo, posición que les gusta a muchos bebés. Recordemos que los cólicos son una etapa de maduración de nuestros bebés. ¡Fuerza! Esto también pasará.
- * **“Siempre tiene que hacer provecho”.** El provecho no es más que un eructo que elimina cierta cantidad de aire que está en el estómago. ¿Siempre eructamos después de comer? No. Los bebés tampoco. No enloquezcamos con el provechito: a veces lo hará y a veces no, y no hacerlo no significa que habrá cólicos posteriormente.

Para leer

- Capurro, H. *Cuidado tópico del cordón umbilical en el nacimiento. Comentario de la BSR* (última revisión: 30 de septiembre de 2004). La Biblioteca de Salud Reproductiva de la OMS; Ginebra: Organización Mundial de la Salud.
- Castro S, F.; Castro, A. F.; Raby, B. T. (2010). *Fimosis y Circuncisión*. Revista chilena de pediatría, 81(2), 160-165. Recuperado de: <https://dx.doi.org/10.4067/S0370-41062010000200009>
- *Lactancia Materna: guía para profesionales*. Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría (2004).
- Maternal Mental Health & Child Health and Development. *Literature review of risk factors and interventions on Postpartum Depression*, Organización Mundial de la Salud, 2008.

La Neo



Te pedimos que te quedaras con nosotros. Que abrieras los ojos, que respiraras solo, que toleraras la leche, que dejes de producir líquido en las pleuras, que no necesites la dopamina. Te pedimos que succiones, que trabajes con tus piernitas, que tomes la teta.

(...)

Te amamos con un amor que no sabíamos que existía. Te amamos entero, desde la plantita del pie pinchada hasta la punta del pelo gringo. Te amamos hoy y te vamos a amar cuando nos anuncies que decidiste dejar la facultad e

irte a vivir de mochilero al Bolsón. Sos lo más hermoso que nos pasó nunca. Gracias por quedarte, gracias por pelear, gracias por ser nuestro bebé perfecto. Feliz semana. Falta menos.

Volver a casa sin panza y sin bebé

La internación en Neonatología siempre es un golpe al deseo y a la felicidad. Aun cuando existe un diagnóstico prenatal y sea algo esperable, también hay un puchito de esperanza. Y cuando es absolutamente inesperado, la sorpresa enmudece y aturde.

La Neo es un duelo. Es el sueño truncado del cartelito de bienvenida color pastel con una cunita colgando en la puerta de una habitación. Es una marca que atraviesa a miles de familias, que duele, que, en el fondo, no se supera nunca.

La Neo salva las vidas de miles de bebés por día. Y por eso, las familias permanecen firmes, a veces calladas, al lado de todas esas cunitas transparentes. Esperando. El día en Neonatología no tiene veinticuatro horas. Tiene tres o cincuenta y ocho. Se oscila entre el entusiasmo y la desesperación. La vida de los mapadres de Neo está ligada a los tiempos, los esfuerzos y las vidas chiquitas que están ahí adentro.

Pero también hay momentos de gloria. Recuerdo que durante la primera semana de vida de Juani, Pato se volcó un café entero sobre una chomba blanca y anduvo así todo el día, con un mapa de café sobre el pecho. Me reí tanto cuando lo vi que me retó un poco: estaba sentada al lado de nuestro bebé, que estaba muy grave. No le hice caso: yo no sabía cuánto iba a vivir mi hijo y quería que experimentara las cosas lindas de la vida, como la risa.

En Neo hay respiradores que se sacan, hay primeros baños, hay estudios que salen bien. Hay pronósticos sombríos que se desarmen con la primera teta tomada. Hay brazos que se acalambran por sostener jeringuitas con leche pasada por sonda, y hay primeros conjuntos de ropa estrenados. Hay una pasión arrolladora por vivir y, también, sabias despedidas.

“Volver a casa sin panza y sin bebé” es una de las frases más tristes del mundo, pero sucede. **Y visibilizarlo, tal vez, nos hace sentir que no estamos solos.**

Construir vínculos incubadora de por medio

¿Cómo abrazar a un bebé adentro de una cunita de plástico? ¿Qué pasa con el contacto piel con piel? ¿Cómo moverse sin tropezar con cables y mangueritas? ¿Escucha? ¿Ve? ¿Siente? Hace tan poco estaba en la panza...

Con palabras o sin palabras, todos los que pasamos por una Neo hemos pensado esto. Las máquinas entorpecen nuestras caricias y, a la vez, mantienen a los bebés con vida. **¿Qué hacer para continuar el vínculo, para estar más cerca de ellos?**

Esta lista es absolutamente personal, pero la comparto porque de la Neo se habla poco, y puede servir a otros mapadres que estén pasando por situaciones parecidas a las que vivimos junto a Juani.

- **Acariciar cada vez que se pueda.** Despacito, tal vez sea un piecito por vez nada más. Pero tocarlos. Mucho. Contenerlos con las manos, como cuando estaban en la panza. Como si estuvieran abrazados.
- **Charlar con las enfermeras y médicos a cargo.** Y aprender los recaudos: este cable no hay que moverlo, pero este se puede correr. Hay que lavarse mucho las manos, y si algo se cae al piso, no se vuelve a levantar. Estas indicaciones parecen miles los primeros días, pero luego son parte de la vida cotidiana.
- **Aprovechar cada vez que podamos tenerlos a upa.** En lo posible haciendo contacto piel con piel.
- **Hablarles.** Y si no podemos hablarles, cantarles. Y si no podemos cantarles, leerles cuentos, poesías, el diario. No importa. Escuchar la voz de su mamá o su papá es el estímulo perfecto para el bebé.
- **Si podemos, si lo deseamos, trabajar en la lactancia.** No importa juntar muy poquito en las extracciones con el sacaleches: 5 o 10 ml son oro, un *shot* de anticuerpos y bacterias buenas que SIEMPRE les hacen bien.
- **Tratar de comer y descansar.** Sí, es casi imposible. Pero eso no hace que no sea importante. Cada minuto de descanso es algo bueno para tu bebé.
- **Permitirse reír, llorar, estar enojado, estar triste, estar feliz, o no saber qué sentir.** No hace falta pelear con los sentimientos, si los podemos dejar fluir, pasan más rápido...

- **Todas las Neo deberían contar con apoyo en salud mental para las familias que las atraviesan.** No siempre es así, o no siempre congeniamos con el profesional que nos toca. Contar con ayuda profesional es un pilar importantísimo en esos momentos.

Todo parece complejo y gigante los primeros días, y luego, como todo, termina siendo parte de la vida cotidiana. Si somos familia o amigos, ¿cómo podemos acompañar? Veamos algunas ideas:

- **Comida.** Llevarle comida a la familia es algo que parece pequeño pero no lo es. Mantenerles la heladera y la alacena con provisiones: alguna tarta, una tortilla, algo sano (se suele comer muy mal durante las internaciones). Volver a la noche a casa a dormir sin el bebé es desgarrador, muchas veces no hay ganas de cocinar y se necesita combustible para seguir.
- **El mundo, aunque parezca imposible, sigue girando.** Vence el alquiler, las cuentas de la casa, el pasto crece. Preguntarle a los mapadres qué podemos ir a pagarles o qué trámite necesitan es de gran ayuda.
- **Ocuparse del resto de la familia.** Mantenerles la casa limpia, cuidar a los hermanitos del bebé internado (que también la están pasando mal) y a las mascotas es una ayuda enorme.
- **Regalos.** Los bebés en Neo muchas veces no pueden vestirse por la gravedad de su estado, ni tener juguetes. ¿Qué les regalamos? Podemos, por ejemplo, llevarles cuentos y poesías para leerles junto a la cuna.
- **Acompañar sin exigir.** A veces vamos a hacer una visita y la familia está con el bebé. La visita no pasará de un abrazo o un saludo, y eso es muy valioso. No podemos exigirle a esos mapadres sentarse a tomar mate: la prioridad siempre es el bebé.
- **Respetar los tiempos y los silencios.** A veces no hay ganas de responder mensajes ni de charlar. Pero se puede acompañar igual, respetando los momentos de cada familia. Cuando el bebé esté de alta, respetar los tiempos de la familia: necesitan, de a poquito, adaptarse al hogar, y no siempre podremos visitarlo enseguida.
- **Evitar comparaciones.** Cada bebé es un mundo y tiene sus tiempos.

El intervencionismo

Un bebé internado en Neonatología seguramente sufra de numerosos procedimientos. Vías, oxígeno, sondas. Todo nos parecerá muy invasivo al principio y luego nos acostumbraremos, sin dejar de sufrir ante cada vía que se pierde o extracción de sangre que hay que hacer.

Todo ese intervencionismo es para que los bebés sobrevivan y tengan la mejor calidad de vida posible, pero nos duele. **¿Qué hacer? Estamos en nuestro derecho de estar presentes durante los procedimientos** y, cuando se pueda, de sostener a nuestro bebé, abrazarlo, cantarle o incluso darle la teta durante los mismos.

La presencia de los mapadres durante estas acciones no solo está descrita como positiva para la familia, sino que **debe estar contemplada en los cuidados del bebé**, así como también si prefieren no estar. Inclusive se plantea la importancia de que la familia esté presente, si lo desea, durante la reanimación de un niño o bebé en paro cardiorrespiratorio.

Los maravillosos cuidados canguro

El método “madre canguro” surge en Colombia, como alternativa a los cuidados en incubadora, inadecuados e insuficientes, dispensados a recién nacidos prematuros que habían superado dificultades iniciales y que se encontraban internados para alimentarse y crecer.

Con el tiempo, se estudió que dicho método **era beneficioso para todos los recién nacidos internados**, que crecían mejor, tenían menos complicaciones, repercutía favorablemente en la lactancia materna, mejoraba el control de la temperatura y colaboraba con el desarrollo del vínculo afectivo con sus mapadres.

El método “madre canguro” básicamente consiste en **apoyar a los bebés, con la menor ropa posible, sobre el pecho desnudo de su madre u otro cuidador presente, sostenido por una faja de tela contenedora**. Es sumamente importante el contacto piel con piel, y no ropa con ropa, como suele suceder. La temperatura del cuidador se adapta a la del bebé y lo ayuda a regularse.

Es una estrategia muy económica y **con excelentes resultados en todos los sentidos**. Lamentablemente, no se realiza de rutina en todas las Neo, probablemente por falta de personal. Es complejo mover a un bebé con respirador, sondas y vías, y requeriría la atención de una enfermera en relación uno a uno, lo cual en nuestro sistema de salud es casi utópico.



Ojalá tomáramos conciencia de la importancia de esta intervención sencilla que mejoraría la calidad de vida de muchos bebés durante la internación y a futuro. Por eso es importante difundirlo, capacitarnos y trabajar en su implementación global.

¿Cómo seguir?

Pasar por la internación neonatológica es también pasar por **un duelo: el del bebé esperado versus el bebé que llegó**, que necesitó cuidados diferentes a los que imaginábamos. El alta es un momento de felicidad inigualable, pero también de desconcierto. ¿Y si le pasa algo? ¿Cómo le doy la medicación? ¿Qué pasa si tiene una apnea y no nos damos cuenta, dado que no tiene más el sensor de oxígeno?

Es importante sacarse todas las dudas posibles acerca de los cuidados y del seguimiento antes de salir de la internación. No importa si las preguntas parecen “tontas”: es posible que muchos profesionales de la salud hayan trabajado con nuestro bebé y que todos tengan algo para contarnos: enfermeras, médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos.

Adaptarse al hogar puede ser complejo, los miedos pueden abrumar. Toda la familia puede querer venir corriendo a conocer a ese bebé que no conocieron al nacer. **Pongamos límites**, animémonos a evitar visitas que no nos suman o, peor, personas resfriadas o con alguna enfermedad contagiosa. Y no desestimar el apoyo psicológico: es fundamental. Puede llevar mucho tiempo “superar” la Neo.

Algunos mitos...

- * **“Los bebés de Neo son más pacientes/son más irritables”**. Los bebés que pasaron por una internación neonatológica son bebés como cualquier otro. Tendrán diferentes temperamentos, y no hay duda de que pasaron por una situación estresante cercana a su nacimiento. Pero con mucho amor y contención, la internación solo será un recuerdo.
- * **“Siempre le van a tener miedo a los médicos”**. Eso va a depender, en realidad, de la actitud que vean en nosotros durante las consultas. Darles medidas anticipadas, explicarles adónde vamos y qué va a suceder es muy importante, como a cualquier niño.

Para leer

- *Método madre canguro*. Guía práctica. OMS.

Estudios, pesquisas, controles



*Y me gusta creer
Que la leche te susurra secretos
De canciones de cuna
De gorgoritos danzantes
De las buenas lunas
Y del buen amor.*

*Si pudiera poner mi cuerpo
Otra vez
No habría dudas, hijo.*

*Si mis venas sirvieran
Si pudiera cargar de nuevo
Con los vaivenes del cuidado
No habría dudas, mi amor.*

*Y me consuela pensar
Que en mis brazos hay tibieza
De nanas de madre
De aroma de leche
De aguas en calma
Y del buen querer.*

En Argentina, el sistema de salud se encuentra fragmentado en tres partes: público, privado y obras sociales. Cualquiera sea la cobertura bajo la cual nace un bebé, **existe una serie de controles preestablecidos que son de suma importancia para preservar su salud. Estas pesquisas son un derecho y el Estado debe asegurarlas para todos los niños.**

Además, de acuerdo con las características de cada bebé (si fue prematuro, si nació con bajo peso, o hubo algún problema en el nacimiento, o hay algún antecedente familiar de importancia...), su pediatra podrá indicarle otros estudios de seguimiento. Lo importante es consultar la razón de estos para quedarnos tranquilos y para estar informados.

No aumenta “x” cantidad de gramos/día

Los primeros días extraútero son un vaivén de números que muchas veces puede ser confuso y angustioso para los mapadres. En las primeras horas de vida, el bebé suele bajar de peso. ¿Por qué? Generalmente, porque los nacimientos son institucionalizados y la mamá recibió hidratación por vena durante el trabajo de parto o la cesárea. Es decir, los bebés tienen más peso al nacer porque reciben ese excedente de líquido de la madre. **Se observan entonces de una manera casi universal pérdidas importantes de peso los primeros días, más en bebés nacidos por cesárea (alrededor de un 10-12 % en las primeras 24 horas) que en bebés nacidos por parto vaginal (8-10 %).** Esto también nos lleva a plantearnos, nuevamente, la importancia de evitar intervenciones innecesarias durante el trabajo de parto, en el parto y la cesárea, salvo que estén estrictamente justificadas a nivel médico.

Este descenso de peso del bebé puede llevar a una innecesaria indicación de complemento con leche de fórmula. **El peso es un número, importante, sí, pero no es lo único que los pediatras observamos para determinar la salud de un bebé.** Son importantísimos: el examen físico (signos de deshidratación como la boca muy

seca o la fontanela —también llamada mollera— hundida), la vitalidad del bebé, su estado general, cuánto pis hace (por eso preguntamos la cantidad de pañales que cambia la familia en un día), si su piel tiene color amarillento, si hace caca, cuánta teta pide, si le agregaron fórmula, si está usando chupete...

Puede haber una meseta los primeros días, en la cual el bebé no aumente de peso y luego comience a incrementar. **¡Tenemos por lo menos 21 días para recuperar el peso del nacimiento!**

No tiene sentido pesar al bebé todo el tiempo. El bebé no va a aumentar de peso porque lo pesemos más: va a aumentar si toma el pecho correcta y continuamente. Es normal que un recién nacido haga un mínimo de 12 tomas diarias, y también es normal que esté 20 horas colgado de la teta de su mamá. La teta es el reemplazo del cordón umbilical: recordemos que hasta hace unos días tenía alimento las 24 horas, los 7 días de la semana, y que ahora depende de su boquita para sobrevivir. **Las tomas nocturnas son importantes**, y al menos durante las primeras semanas mientras esperamos que empiece a ganar peso, no se sugiere que el bebé pase más de 3 horas sin tomar la teta.

¿Qué pasa si no sube de peso como se espera? La solución no es la fórmula en mamadera “de una”. En una primera instancia, si lo desea la madre, hay que evaluar la lactancia: el acople, la succión, la deglución, cómo se están colocando la mamá y el bebé, si hay dolor (si lo hay, es porque existe algún problema en la posición o la prendida: **dar de mamar no debe doler**), si el bebé se duerme... Lamentablemente, este seguimiento para un pediatra en consultorio es muy complejo en los tiempos que ofrecen las obras sociales y el sistema público. Evaluar la lactancia en un recién nacido no lleva menos de 30-40 minutos, y no es lo mismo lo que sucede en un consultorio médico frente a un profesional de guardapolvo blanco que lo que sucede en casa. ¿Entonces? Entonces, lo ideal es trabajar en forma multidisciplinaria y recurrir a profesionales expertas en lactancia: las puericultoras.

Las puericultoras suelen hacer una evaluación en el domicilio de la familia o en su propio espacio, aportar ideas y pautas, y hacer una devolución al pediatra, y de esa manera, poder acompañar a todos en forma coherente y adaptada a cada familia. Como médicos, también hay que evaluar ciertas cuestiones en el bebé, como la posibilidad de infección urinaria (en ocasiones su única manifestación es el mal progreso de peso, sin fiebre ni ningún otro signo) o de alguna alteración en su desarrollo. También es importante conocer la historia clínica de la madre: si tiene cirugías mamarias, si tiene hipotiroidismo, si toma algún medicamento... Todos factores que pueden afectar la producción de leche.

Por último, no menor es el tema de la complementación con leche de fórmula: algunas familias lo deciden por una cuestión de agotamiento, por deseo o por presión del entorno. Por supuesto, la decisión es de cada familia y nosotros como pediatras debemos acompañar respetuosamente, pero es importante recalcar que **la mamadera no es la mejor opción para introducir la fórmula, porque genera confusión tetina-pezón**, es decir, la manera en que el bebé coloca la boca y la lengua no es igual

cuando toma teta que cuando toma mamadera, y “aprender” a tomar mamadera puede interferir con la lactancia.

Si necesitamos complementar, podemos hacerlo con la leche de la misma mamá, si se extrae con el sacaleche. Si no es así y requerimos complementar con fórmula, **podemos hacerlo utilizando un relactador** (ver capítulo 8, “La lactancia”) para que el bebé siga estimulando el pecho, o con un vasito, o con el método dedo-jeringa (también explicado en ese capítulo).

Me sube la bilirrubina

La bilirrubina es un pigmento producto de la degradación de la hemoglobina, una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y que transporta el oxígeno a los tejidos. Los glóbulos se están produciendo todo el tiempo en la médula ósea y, a la vez, rompiéndose porque terminó su vida útil. Cuando se degrada la hemoglobina, se convierte en bilirrubina, y el hígado se ocupa de metabolizarla y eliminarla por la materia fecal. ¡Nuestra caca es marrón porque está teñida por la bilirrubina!

Los bebés al nacer tienen un hígado inmaduro, por lo cual no logran siempre metabolizar rápidamente la bilirrubina. Y como dije antes, la misma es un pigmento, que busca otras vías para eliminarse: una de ellas es la piel. La bilirrubina tiñe la piel, y se vale de la luz para degradarse y terminar de irse del cuerpo. Esta coloración amarilla que puede tomar el recién nacido se llama “ictericia”. ¿A todos los bebés les pasa? No a todos, pero sí a la mayoría. Algunos tienen más factores de riesgo, como haber tenido alguna complicación en el nacimiento, ser prematuros o haber tenido algún hermano con ictericia. **La ictericia aparece a partir de las 24 horas de vida: si aparece antes, no es fisiológica y hay que estudiarla.**

Cuando los valores de bilirrubina son muy altos, no solo se deposita en la piel, sino que puede llegar al cerebro, donde se acumula y puede causar daños irreparables. Esto se denomina “*kernicterus*”, y puede ocasionar retraso mental, sordera, ceguera y otras manifestaciones totalmente evitables.

¿Cómo se mide la bilirrubina? Antes, con menos tecnología, se miraba al bebé y se calculaba hasta “dónde” estaba amarillo, a ojo, y con eso se calculaban porcentajes. Claramente era muy variable y poco específico. Ahora tenemos dos herramientas. La primera es el BiliCheck: se apoya un aparatito en el pecho o en la frente del bebé y se mide la bilirrubina transcutánea, es decir, en la piel. Esto es muy útil si el aparato arroja valores bajos, pero a partir de cierto valor deja de ser confiable. Y ahí, sí o sí, tenemos que sacar sangre para evaluar. Podemos darle la teta (¡tetanalgesia! Lo desarrollo más adelante en este capítulo) al bebé mientras le sacan sangre (generalmente sacan de la manito o del pliegue del codo): eso le atenuará el dolor.

¿Cómo se elimina la bilirrubina del cuerpo? Tomando teta. El bebé nace con meconio (la primera caca) en el intestino, que contiene mucha bilirrubina en su composición (una de las razones por la cual es tan oscuro). Una ingesta pobre de leche materna, la cual también actúa como laxante, retrasa la eliminación de meconio y aumenta la absorción de la bilirrubina a través del intestino. Entonces, **mientras más teta, más caca hace el bebé, menos bilirrubina circulando, menos amarillo, menos posibilidades de tener que hacer otro tipo de tratamientos.**

¿Qué pasa si el valor en sangre es muy alto? El tratamiento para la hiperbilirrubinemia no es un remedio ni un pinchazo: son rayos ultravioletas, también llamados fototerapia. ¿Se interna? Sí, los bebés se internan en Neonatología si la mamá ya está dada de alta: de otra manera, se puede llevar el equipo a la habitación de la mamá. Se coloca el bebé desnudo, solo con pañal, en una cuna debajo de una lámpara especial, y se le pone una especie de antifaz para protegerle los ojitos de la luz ultravioleta que suele ser muy molesta (pero no los lastima). Es cuestión de horas: a veces son 24, a veces son 72 o más. Se va midiendo la bilirrubina en sangre para ver si va bajando, y una vez que se observa esto, se da el alta. Es importante que durante este tratamiento se trabaje a nivel equipo de salud en el mantenimiento de la lactancia, se promueva el ingreso irrestricto a la unidad de Neonatología y se permita a los mapadres acariciar y mantener el contacto con el bebé. En algunos centros privados cuentan con unas “mantas de rayos UV” fabulosas, las cuales se colocan en la cama de la habitación de la madre y se puede realizar la fototerapia con el bebé sobre el cuerpo, a upa. Ojalá se pueda extender esta tecnología a todos los centros de salud en el futuro.

Poner al bebé al sol a través de la ventana, como se decía antes, no sirve y puede ser peligroso al causar daños en la piel del bebé.

Pesquisa neonatal (PPN)

La pesquisa neonatal (PPN) es un estudio que POR LEY se debe realizar gratuitamente a todos los recién nacidos antes de salir de la maternidad, generalmente entre las 48 y 72 horas de vida, tanto en establecimientos públicos como privados. La pesquisa se popularizó con el nombre de “FEI” porque en un inicio, la Fundación Endocrinológica Infantil (FEI) era el único centro que la realizaba.

Si el bebé nació en un parto domiciliario, se puede concurrir a realizar el estudio a un centro de salud. La realización de la PPN es un derecho de todos los niños de nuestro país, amparado por la Ley 26.279, que establece “un régimen para la detección y posterior tratamiento de determinadas patologías en el recién nacido”.

Este estudio consiste en pinchar el taloncito del bebé para obtener una muestra de sangre, aunque si hay que sacarle sangre para otra cosa (estudios de bilirrubina, por ejemplo), se puede usar esa misma extracción, que suele ser en la manito o pliegue del codo como dijimos. Este procedimiento también se puede hacer con tetanalgesia (lo explico un poco más adelante en este capítulo).

La PPN sirve para detectar precozmente enfermedades inaparentes, es decir, que no dan signos ni síntomas en un inicio, e instaurar un rápido tratamiento para evitar efectos y secuelas de las mismas. Estas enfermedades son: hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, fibrosis quística, galactosemia, déficit de biotinidasa e hiperplasia suprarrenal congénita. Todas tienen tratamiento que mejora radicalmente la calidad de vida y evita sus secuelas (por ejemplo, una de las secuelas del hipotiroidismo se llama “cretinismo” e incluye el retraso mental profundo).

Es importante cerciorarse de que se realizó este estudio e IR A BUSCARLO, ya que **suele estar listo aproximadamente en un mes** (depende de la maternidad y el laboratorio).

En bebés prematuros, se puede necesitar repetir este estudio varias veces de acuerdo con la edad gestacional, dado que el metabolismo va madurando y es preciso reevaluarlo por los neonatólogos a cargo.

¿Qué pasa si algún resultado da alterado y el bebé no tiene ningún signo o síntoma? Habitualmente, el laboratorio que lo realiza debe comunicarse con la familia, pero como esto es plausible de fallas (puede haber errores en la toma de datos, por ejemplo), es importante llevar el resultado al/a la pediatra lo más pronto posible, pues precisamente estas patologías son inaparentes. Se evaluará al bebé y seguramente se repita la muestra o se hagan otros estudios para confirmar. No desesperar: es posible que haya falsos positivos, como en cualquier estudio.

La pesquisa no busca solo detectar patologías, sino que está inserta dentro de un programa de prevención, confirmación de resultados, comunicación a la familia, tratamiento y contención.

Pesquisa auditiva

Los primeros meses de vida son claves para el desarrollo del sentido de la audición. La presencia del estímulo constante de la voz de sus seres queridos será muy importante para la formación de vías neuronales que escuchan, interpretan y pueden devolver sonidos que cobran sentido, desarrollando el lenguaje.

Es por esto que la detección temprana de trastornos de la audición es muy relevante; que cuanto antes los pesquisemos, antes los podemos tratar.

La Ley 25.415 de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia establece

el derecho de todo recién nacido a que se le estudie su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en forma oportuna si lo necesita.

¿Cómo se realiza esta detección? **En un inicio, se realiza un estudio denominado “otoemisiones acústicas”.** Suele realizarse antes del alta de la maternidad. El estudio es sencillo: es una especie de auricular (en realidad es un micrófono) que se coloca en el oído del bebé mientras duerme, que censa la percepción del sonido de una estructura clave en el oído, la cóclea.

Muchas veces, el estudio “no pasa”. ¿Por qué? Porque suele quedar líquido amniótico en los oídos, o hay interferencia con el ruido del ambiente, o el bebé se despierta. ¿Y qué hacemos? Repetimos el estudio preferentemente antes del mes de vida.

¿Y si otra vez no pasa? Cuando sucede esto, es imprescindible solicitar estudios más complejos, como los potenciales evocados auditivos, la timpanometría y la impedanciometría. Estos estudios buscan evaluar cómo funciona el nervio auditivo, la membrana timpánica, los huesecillos del oído... Junto con los estudios, el bebé debe ser evaluado por un otorrinolaringólogo, médico que se ocupa de la nariz, la garganta y el oído.

Si todo da bien, ¿significa que el bebé no tendrá ningún problema auditivo? No, no lo sabemos. Por eso pesquisamos en los controles pediátricos ciertas señales que nos interesan: si el bebé balbucea, si llama a su mamá, si se da vuelta ante los sonidos...

Si dan mal todos los estudios, ¿qué hago? En estos casos es probable que nos encontremos frente a una hipoacusia. Con un diagnóstico, podemos definir un tratamiento.

¿Y si se me paso del mes en el que se recomienda hacer el primer estudio? No importa: hay que hacerlo igual, lo antes posible. Mientras más temprano sepamos si hay alguna patología, más rápido podemos actuar.

¿Qué pasa en los bebés prematuros o con factores de riesgo? Estos bebés tienen o vivieron alguna condición que hace necesario el control continuado y estricto de su audición. Entre ellas, el haber estado en respirador más de 5 días, el haber recibido antibióticos en Neo (suelen ser tóxicos para el oído), los antecedentes familiares de hipoacusia, haber padecido meningitis, el bajo peso, y varios factores más. Estos bebés tendrán un seguimiento estricto por el equipo de fonoaudiología, generalmente cada tres meses hasta el alta.

Si un niño llega a necesitar tratamiento y el consecuente seguimiento, el Estado debe cubrirlo plenamente. Es uno de los puntos de la ley.

Fondo de ojo

Al día de la fecha, el fondo de ojo no es obligatorio por ley en todos los recién nacidos. Sin embargo, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil abogan porque este control se convierta en tal, como parte de la importancia de la visión en la infancia. Por el momento, **se sugiere al menos un fondo de ojo en el recién nacido de a término sin factores de riesgo, con seguimiento definido por el oftalmólogo tratante.** En el caso de bebés prematuros o con factores de riesgo, es diferente: el seguimiento se encuentra más estandarizado. Es preciso observar regularmente la retina para evaluar cómo se van desarrollando los vasos sanguíneos y prevenir, entre otras cosas, la retinopatía del prematuro. La prevención de esta patología se encuentra contemplada en la Ley 26.279.

El ojo es una estructura formada por muchas capas. La parte de color se llama “iris”, y en el centro del iris hay un “agujerito” negro que se llama “pupila”. La pupila se agranda y se achica según la luz del ambiente. Adentro del ojo encontramos dos sustancias que se llaman “humor acuoso” y “humor vítreo”, y un “lente” que se llama “cristalino”. Como bien dicen sus nombres, son todos transparentes. Eso nos permite “espiar” adentro del ojo a través de esa ventana al exterior que es la pupila.

¿Y qué miramos adentro del ojo? Podemos ver los vasos sanguíneos y la retina. La retina es la capa del ojo que contiene neuronas y que capta las imágenes. A través del nervio óptico, las envía al cerebro. También podemos ver el comienzo del nervio óptico.

Claro que, si las sustancias de adentro del ojo no están transparentes por alguna patología, no vamos a ver todo eso. Por ese motivo, al bebé recién nacido se le hace un análisis por “inspección” antes del alta: el o la neonatólogo/a, con un aparato llamado “oftalmoscopio” (o con un otoscopio) observa a cierta distancia los ojitos del bebé. Esto se llama “reflejo rojo”: lo que vemos es precisamente una coloración rojiza en la pupila. Si nos cuesta verlo, es que hay algo que evaluar urgentemente.

Las cámaras de fotos con *flash* sacan fotos con ojos rojos. ¿Por qué? Porque precisamente reflejan el fondo del ojo con vasos sanguíneos. **¡A veces descubrimos patologías en el ojo a través de una foto! Si en alguna foto de tu bebé sale un ojito rojo y el otro no, no dudes en consultar a su pediatra.**

En la consulta pediátrica repetimos el reflejo rojo, observamos la fijación de la mirada, cómo el bebé sigue un objeto y cómo se relaciona con sus mapadres. La visión es inmadura en las primeras semanas de vida, aunque durante los primeros días, el bebé es capaz de fijar la mirada en una cara cercana (su mamá, generalmente. ¡Es la distancia perfecta a la teta!). A las 6-8 semanas comienzan a seguir objetos, y cada vez la visión se agudizará más. **A los 7-8 meses pueden definir detalles de las caras... ¡y darse cuenta de que no todos son su mamá! (ver “Angustia del octavo mes” en el capítulo 12, “Su hijo es valiente”).**

Ecografía de cadera

El objetivo de las ecografías o radiografías de cadera es pesquisar una condición denominada “displasia congénita de cadera”.

La cadera de todos los bebés es inmadura y sus ligamentos son muy laxos. Esto les permite adoptar la posición que tienen en el útero y pasar por el canal de parto. A veces, esa laxitud genera que la cadera sea inestable y que se luxe (se salga de lugar). Si no lo pesquizamos a tiempo, la articulación en formación empieza a desgastarse y puede ser discapacitante en la vida adulta. En el capítulo 11, “El movimiento y el cuerpo” podés encontrar más información acerca de la displasia de cadera.

La ecografía se solicita entre la semana 6 y 8 de vida, dado que antes es muy imprecisa. ¿Se les solicita a todos los bebés? No, esta pesquisa no es universal. Se les solicita a todos los bebés con factores de riesgo y a aquellos con hallazgos en el examen físico.

¿Y cuáles son los factores de riesgo? Bebés en pelviana (“sentados”) durante la gestación, historia familiar de displasia de cadera, tortícolis o malformaciones en los pies y oligoamnios (poco líquido amniótico). Todo esto sumado a dos factores que se repiten mucho en esta patología: ser nena y ser primera hija.

Lo más importante para la detección de la displasia de cadera es el examen físico del pediatra, no la ecografía. En los controles hacemos varias maniobras, conocidas como Ortolani y Barlow, que evalúan la cadera. Si alguna de estas maniobras nos parece patológica, o si observamos una franca asimetría entre una pierna y la otra, o diferencias de movilidad, solicitamos el estudio de imágenes.

A partir de los 4 meses se puede solicitar una radiografía de las caderas que debe ser evaluada en conjunto con el traumatólogo infantil.

¿Tiene tratamiento? Sí, generalmente el tratamiento es el arnés de Pavlik, un sistema de correas que coloca al bebé en posición “ranita” y genera de esa manera una posición saludable para el desarrollo de su cadera. Este tratamiento puede evitar una intervención quirúrgica.

Suplementos de hierro y vitaminas

Hierro

Para hablar de hierro, primero tenemos que entender su importancia en el

organismo. El hierro forma parte de la hemoglobina, el componente de los glóbulos rojos que lleva el oxígeno a los diferentes tejidos. El hierro también forma parte como cofactor de diversos procesos, por ejemplo, de la mielinización del sistema nervioso. ¿Qué es eso? Un proceso por el cual las conexiones neuronales se hacen más específicas y efectivas.

Es decir, ¡el hierro participa del desarrollo neurológico y de la oxigenación de los tejidos! Una vez dicho esto, ahora sí, vamos con el gran dilema. **¿Por qué en pediatría se suele indicar hierro como suplemento? Porque se comprobó que la mayoría de los niños de 6 a 24 meses en nuestro país tienen anemia (del 35 % al 60 % según la región), es decir, menos hemoglobina en sangre y menos depósitos de hierro para usar, y su causa suele ser el faltante de hierro para formarla.**

¿Y por qué tienen anemia? Hay varias razones: la malnutrición materna, el corte temprano del cordón umbilical, las bajas tasas de lactancia materna y el uso indiscriminado de fórmula, y la malnutrición infantil a base de productos ultraprocesados, mayormente lácteos y carbohidratos simples.

El feto acumula hierro en su cuerpo durante la gestación, que pasa a través de la placenta. Estas reservas de hierro se agotan muy rápidamente en la formación de nuevos tejidos en el período de mayor crecimiento de una persona: los primeros 6 meses de vida. **Mientras menos tiempo haya estado este bebé gestándose, menos cantidad de hierro acumuló: un bebé que nace a las 40 semanas tiene mayores depósitos de hierro que uno que nace a las 36.**

Para paliar esta situación, que puede llevar a un déficit en la maduración neuronal, las políticas públicas han propuesto varias estrategias: propiciar el corte tardío del cordón umbilical, fortificar los alimentos con hierro (los cereales, por ejemplo) y dar suplementos de hierro a ciertos sectores infantiles, además de promover la lactancia materna y la alimentación saludable... materia troncal en la cual nos falta mucho, claramente.

¿A qué niños sí o sí, según la Sociedad Argentina de Pediatría en su actualización 2017, suplementaremos?

- Prematuros.
- Gemelares.
- Niños con bajo peso de nacimiento.
- Niños que sufrieron hemorragias en el período perinatal.
- Niños de término alimentados con leche de vaca sin fortificación.
- Niños de término alimentados a pecho que reciben alimentación complementaria inadecuada con bajo contenido de hierro.
- Patologías que impliquen malabsorción o pérdida crónica de hierro.
- Adolescentes con pérdidas menstruales excesivas.
- Adolescentes embarazadas.

”¡Pero mi hijo no tiene nada de esto y le dieron hierro igual!”.

Si bien estas son las indicaciones básicas para la suplementación, hay otras razones que tienen que ver con los antecedentes y el contexto, por ejemplo, familias con dietas vegetarianas o veganas, niños con otras patologías, hijos de mamás muy anémicas durante el embarazo, etc. **Requiere un cuidadoso análisis y no se puede decir “a quién sí y a quién no” ni cuándo sin una consulta individual.** La Sociedad Argentina de Pediatría desaconseja el suplemento de hierro en los niños de término, con adecuada progresión de peso y talla, alimentados con fórmulas en forma regular, dado que estas ya contienen sulfato ferroso en su composición.

El hierro con mayor biodisponibilidad es el que viene en la leche materna, es decir, es el que mejor se absorbe. Si complementamos la lactancia materna con alimentación complementaria oportuna, adecuada y con alimentos ricos en hierro, no será necesaria su suplementación.

No hay que quedarse con dudas: si el pediatra indicó el suplemento, hay que irse tranquilo sabiendo el porqué.

“Le indicaron hierro pero no le hicieron estudios antes”.

Cuando indicamos el suplemento, no es necesario un análisis de sangre previo. ¿Por qué? Porque queremos PREVENIR. El estudio de sangre, idealmente, va a venir bien, y de cualquier manera indicaremos el hierro porque está dentro de los grupos de riesgo. Si pincho a un bebé para evaluar si necesita hierro, es porque como pediatra quiero hacer un TRATAMIENTO, no una PREVENCIÓN, o quiero evaluar, después del año, si esa prevención funcionó.

Es importante detenerse en la cuestión nutricional. La introducción temprana de leche de vaca, sobre todo si la misma no está diluida correctamente para la edad, y la introducción temprana de alimentos antes de los 6 meses, generan menor absorción del hierro presente en la dieta o en la misma leche. Asimismo, en niños más grandes, el consumo excesivo de lácteos y de azúcares (golosinas, galletitas, etc.) puede generar una baja en la absorción del hierro y podemos tener niños con sobrepeso u obesidad, y también anemia.

“¿Hace mal el suplemento de hierro?”.

En algunos casos se ve intolerancia digestiva, con aumento de gases. Si esto ocurre, hay que hablarlo con el pediatra para que considere qué es lo mejor para el bebé. Existen dos formas de suplementos: el sulfato ferroso y el hierro polimaltosato, así que si está indicado uno, también podemos probar con la otra forma.

El hierro que no se absorbe porque no se necesita se va por la caca, por lo que es común ver cacas negras. La lactancia materna ayuda a eliminar todo hierro “de más” a

través de uno de sus componentes que se denomina “lactoferrina”. Las dosis indicadas son muy pequeñas como para generar toxicidad, y recordemos que si se indica, es porque se necesita.

Y algo importante: mancha la ropa (y cuesta sacarlo), así que cuidado. ¡Se lo podemos dar a la hora del baño!

Vitaminas

La leche materna contiene pilas y pilas de vitaminas. Vitamina A, E, C, D, minerales, células vivas... La leche de fórmula también está compuesta por todas las vitaminas que al día de hoy la ciencia nos informa que requiere un bebé para crecer.

Entonces, ¿por qué indicamos un suplemento de vitamina D? O, más aún, ¿por qué en Argentina la formulación es un compendio de vitaminas A, C y D?

La vitamina D se obtiene de un trabajo en conjunto entre la piel, el riñón y el intestino. **El primer paso ocurre en la piel y se produce gracias a la exposición al sol. El problema es que cada vez estamos menos expuestos al sol:** el vivir en las grandes ciudades, el trabajar en lugares cerrados y el llenarnos de actividades que no son aire libre no colabora.

La vitamina D trabaja en el mantenimiento de los niveles de calcio en el organismo, ayudando al intestino a absorber el calcio de la dieta y a fijarlo en los huesos. El hueso no es un tejido estático: está todo el tiempo construyéndose y degradándose. ¿Por qué? Porque es un reservorio de calcio, y lo va “guardando” y “soltando” a medida que el cuerpo lo necesita. El calcio en el organismo funciona en múltiples niveles, por ejemplo, en la contracción de los músculos. Además de todo esto, se está estudiando que la vitamina D tiene funciones a nivel cerebral, tejido adiposo, aparato respiratorio...

La deficiencia de vitamina D en niños puede ser peligrosa: como todo su cuerpo, el esqueleto está en plena formación. Sin la adecuada cantidad de vitamina D se puede producir una enfermedad denominada “raquitismo”.

¿Pero la leche materna no tiene suficiente vitamina D? Los estudios de hoy en día, a nivel internacional, no solo en nuestro país, dicen que no. Un niño necesitaría 400 UI (Unidades Internacionales, que es una unidad de medida) para crecer correctamente, y la leche materna no proveería más que 20 UI. ¿Error de la naturaleza? No lo creo: la naturaleza no sabía que nos íbamos a encerrar en oficinas.

Es por esta razón que la American Breastfeeding Association sugiere complementar, desde el nacimiento, con 400 UI de vitamina D vía oral hasta el año de vida. Hay estudios que hablan de la posibilidad de complementar a las mujeres lactantes y no a los bebés. Otros, de indicar una dosis alta semanal en vez de un poquito todos los días. Ninguno de estos estudios aún es concluyente.

¿Todos los bebés necesitan la vitamina D vía oral? Esto tampoco es 100 % claro. En los nacidos en invierno, cuando claramente hay menos luz solar durante el día y usan prendas de abrigo de manga larga, que cubren la mayor parte del cuerpo, seguramente sea necesaria. Para los bebés prematuros o con alguna condición de salud también. Pero los bebés sanos, que se exponen al sol indirectamente por lo menos 15 minutos 3 veces por semana, podrían no requerirla. Los bebés que toman fórmula exclusiva no necesitan complementos ni de hierro ni de vitaminas, porque esos “complementos” están agregados en la leche de fórmula.

¿Hace mal el suplemento de vitaminas? No, no hace mal. Las dosis son pequeñas y bien asimiladas por el cuerpo. Sin embargo, una de las formulaciones actuales contiene esencia de dulce de leche, por lo que no es apta para niños con alergia a la proteína de leche de vaca.

¿Por qué viene en formulación vitamina A + vitamina C + vitamina D? No tengo una respuesta para esto. La vitamina A y la C están contenidas en dosis adecuadas en la leche materna y en la de fórmula. Es una cuestión de mercado que, personalmente, me resuena mucho y no he podido resolver.

Tetanalgesia

Un bebé o un niño no debe sentir dolor si como profesionales podemos evitarlo, y si no podemos, es nuestro deber hacer que esté lo más cómodo y confortable posible.

La “tetanalgesia” es una práctica recomendada por la Organización Mundial de la Salud, en la cual el bebé toma la teta, o succiona el chupete, o se abraza a un ser querido mientras se le realizan procedimientos. Se ha visto que la succión les genera liberación de hormonas que hacen que sufran mucho menos dolor. No tiene ninguna contraindicación, no genera reflujo ni ahogos. Es un derecho de los niños que los agentes de salud veamos por su mayor confort posible, en contacto o presencia de una figura de apego, para evitar el miedo y la angustia, y minimizar el dolor.

La tetanalgesia minimiza el estrés del bebé (y de la familia) ante procedimientos necesarios. Se puede realizar durante la vacunación, y esto es importante, NO interfiere con la respuesta a vacunas orales (Sabin, rotavirus). Los prospectos de las mismas sugieren ayuno antes y después para evitar vómitos, pero la leche no interfiere con su función. Es decir, no hay problema en dar la teta inmediatamente antes o después de estas vacunas.

Recordemos que no es solo “la teta”: es permitir al bebé/niño estar en los brazos de sus mapadres, permitir a la familia acompañarlo, dejar que use el chupete, explicarle lo que le van a hacer y respetar su cuerpo. Inclusive, en estos casos, la OMS propone, en niños más grandes, mostrar algún dibujo animado que les guste, y adhiero

a la sugerencia.



Las medidas anticipatorias, aun en bebés pequeños, son muy importantes. Explicarles que vamos a ir a un vacunatorio, que les van a pinchar la piernita o el bracito, que esa vacuna los va a proteger de enfermedades, que puede sentir dolor (sí, es sumamente relevante ponerle palabras a ese dolor y no minimizarlo ni esconderlo) y que vamos a estar allí con ellos para acompañarlos, es una enseñanza profunda. Inclusive es transitar nuestro propio miedo y angustia, imposibles de no sentir (¡a mí también me pasa!) al “llevarlos a pinchar”.

Hablemos (un poco) sobre vacunas

En 1998, un gastroenterólogo británico llamado Andrew Wakefield publicó un trabajo asociando una vacuna (la MMR: antisarampión, rubeola y paperas) con el autismo. Utilizó datos fraudulentos, y sometió a niños con autismo a procedimientos innecesarios de investigación sin aprobación de un comité de ética. Wakefield buscaba que se diera de baja la vacuna actual para que ingresara en el mercado la que producía otra empresa (la cual trabajaba con él, claro está). En 2004, el trabajo fue retirado y todos sus autores se retractaron. A Wakefield se le quitó la licencia médica. Pero el daño estaba hecho.

Cuando me consultan acerca de mi postura sobre las vacunas, mi respuesta es: son necesarias y agradezco que existan para proteger a mi hijo y a mis pacientes.

¿Pueden tener efectos adversos? Sí, como cualquier sustancia. Pero son mucho menores que la enfermedad de la cual protegen. Los más comunes son fiebre y dolor en el lugar de aplicación. Si llega a haber algún otro tipo de manifestación, se comunica inmediatamente a una entidad llamada Sistema de Vigilancia y se estudia qué sucedió.

¿Todos tenemos que vacunarnos? Hay personas que no pueden vacunarse. Bebés muy pequeños para algunas vacunas, niños en tratamientos oncológicos, pacientes inmunosuprimidos (receptores de trasplantes, por ejemplo) y otros. Es por ellos también que es nuestra responsabilidad como sociedad vacunarnos.

¿Por qué vacunamos para enfermedades que no existen? Aquí tengo dos respuestas: la primera, son enfermedades que no se ven frecuentemente porque precisamente nos vacunamos para que no sucedan más. Hace unos 60 años, la epidemia de poliomielitis era atroz y muchos niños fallecieron o quedaron con graves secuelas. Que hoy no veamos casos de poliomielitis habla del éxito de la vacunación. La segunda es que cuando estamos fuera del sistema de salud, tenemos un sesgo. Como residente de pediatría, vi numerosos casos de tos convulsa (para la cual protegen las vacuna pentavalente, séxtuple y triple acelular) y de meningitis tuberculosa (para la cual protege la vacuna BCG, que se da antes del alta en la maternidad), enfermedades de las que poco se habla en los medios de comunicación y pueden ser muy graves. Existen, están. Si dejamos de vacunarnos, volverán.

¿No es mejor que tenga la enfermedad? Varicela, sarampión... Todos crecimos un poco con la idea de que tener varicela es algo que incluye helado, tele, reposo y rascarse ampollitas. Eso es en la mayoría de los casos, e incluso, antes se sugería a las familias que era mejor poner a los niños en contacto para contagiarlos y que “ya tuvieran” la enfermedad. Esta recomendación cambió: preferimos que, directamente, nadie tenga varicela, o si sucede (porque las vacunas no protegen 100 % de contraer la enfermedad, sino que probablemente expresemos formas más leves de la misma), que no haya complicaciones. ¿La varicela tiene complicaciones? Sí, es un virus que además de ampollitas puede generar encefalitis, varicela hemorrágica y neumonía; predisponer a sobreinfección por bacterias; e incluso, si una mujer embarazada no tuvo varicela y se contagia durante el embarazo o cerca del parto, puede causar gravísimas consecuencias en el bebé.

***Un Día del Niño, embarazada de mi primer hijo, estaba de guardia.
Era domingo y era el Día del Niño, el hospital estaba lleno de payasos.***

En una de las habitaciones, el corazón de una nena galopaba, los pulmones claudicaban. Su cuerpito peleaba contra una infección que había comenzado como una varicela común. Queríamos pelear con ella, queríamos darle las herramientas para pelear. Sus padres la abrazaban, su mamá estaba embarazada igual que yo. Los payasos entraban entre brillantinas y porras, les pedíamos por favor que se fueran, los antibióticos no alcanzaban, la fiebre subía. A mí se me ponía dura la panza y se me estrujaba el corazón. Finalmente, el cuadro fue tan grave que pasó a Terapia intensiva y unas semanas después falleció.

No quiero, nunca más, ver una varicela.

Nunca más.

¿Por qué aquí tenemos ciertas vacunas y en otros países otras?

Porque el calendario de vacunación se define entre expertos de acuerdo con la epidemiología del país. ¿Qué significa eso? Que para todas las enfermedades hay un sistema de “conteo”. De esta manera, sabemos aproximadamente cuántos casos de bronquiolitis por virus sincicial respiratorio hay por año, y en qué semana del año hay más; o qué cepa del meningococo —un germen que produce meningitis y otras manifestaciones— es la más común. A partir de ello, se decide qué vacunas incorporar y cuáles no.

¿Es peligroso que un niño vacunado esté en contacto con niños no

vacunados? Lamentablemente, sí. Porque no podemos saber la respuesta inmune de cada persona a cada vacuna. Habría que medir los anticuerpos en sangre después de determinado tiempo, y nadie quiere pinchar a un niño (más veces). Una persona puede ser portadora de una bacteria o un virus y no desarrollar enfermedad, y contagiar a otra. La única manera de que todos estemos seguros es que todos estemos vacunados.

¿Si cuido mucho a mi hijo y lo alimento sanamente, puedo no

vacunarlo? La vacunación es un derecho de los niños y una obligación en nuestro país. Que un niño sea sano y viva en un ambiente cuidado no lo exime de poder enfermarse gravemente.

¿Es verdad que hay vacunas “experimentales”? Para lanzar una vacuna al mercado tiene que haber pasado por procesos rigurosos de control durante años. No se pueden indicar vacunas experimentales.

¡Me da miedo que le duelan los pinchazos! Lo ideal es que el bebé pueda estar aupa de un ser querido, y si está tomando la teta o con el chupete mientras se las dan... ¡mejor! La succión genera sustancias que inhiben los circuitos del dolor, la famosa tetanalgesia de la que hablamos antes. También podemos tener en cuenta que si el niño se enferma, las intervenciones probablemente puedan ser más invasivas que el pinchazo de la vacuna.

¿Por qué se dan tantas vacunas juntas los primeros meses? La mamá le pasa, a través de la placenta, anticuerpos al bebé, de un tipo llamado inmunoglobulina G. También se los pasa a través de la teta, pero predominan otros anticuerpos con diferente composición, la inmunoglobulina A. Los que el bebé recibió durante la gestación son más “efectivos” contra las enfermedades. Esos anticuerpos que recibió de la madre se mantienen en su cuerpo hasta alrededor de los 6 meses de vida. Es decir, tiene 6 meses para producir anticuerpos propios contra diversas patologías. Es por eso que buscamos generar esta respuesta inmune antes de esa edad, y es por eso que incorporamos la mayor parte de las vacunas durante esos meses.

¿Qué pasa si quiero espaciar las vacunas? Si espaciamos las vacunas, el niño estará más tiempo desprotegido.

¿Y el mercurio? El mercurio se utiliza como conservante de algunas vacunas, para evitar que crezcan hongos y bacterias dentro de las mismas. Existen varias formas de mercurio: el metilmercurio, un contaminante de origen industrial que se acumula en algunos pescados; y el etilmercurio, que los *millennials* recordaremos como pintadas rojas en nuestras raspaduras de la infancia, dado que formaba parte del conocido antiséptico Merthiolate (estimado/a lector/a, si no entendiste esto, consultalo con alguien de 30 años para arriba, ¡seguro lo recordará!). El etilmercurio es lo que se utiliza en las vacunas: el cuerpo lo metaboliza fácilmente y no se acumula en ningún lado.

¿Y si me atraso hay que empezar de nuevo? No, se continúan los esquemas, no importa el tiempo que haya pasado.

¿Necesito ir al médico o tener una receta para que a mi hijo/a le den las vacunas? NO. En Argentina son un derecho y son gratuitas. Si bien sugiero la consulta con el/la pediatra para evacuar dudas, no hace falta ver al médico primero para colocar las vacunas si corresponden en ese momento. Para los vacunatorios públicos, basta con presentar el carnet de vacunación.

¿Los adultos nos damos vacunas? ¡Sí! La vacuna triple bacteriana acelular, por ejemplo, que nos protege del tétanos pero también del *Corynebacterium diphtheriae* y la *Bordetella pertussis*. ¿Y esos? Son las bacterias que causan el llamado “crup” y la tos convulsa. ¿Los adultos podemos tener tos convulsa? Sí, pero en realidad, el motivo de esta vacuna es que nosotros no tengamos esas bacterias y no contagiemos a los chiquitos. Esta vacuna nos la damos a los 11 años, y también se aplica en cada embarazo desde la semana 20 de gestación. También es importante evaluar si tenemos todo nuestro calendario de vacunación completo y, sobre todo, dos dosis de la vacuna triple viral (la que protege del sarampión, rubeola y paperas) y la vacunación completa para hepatitis B. En adultos mayores se sugieren las vacunas antigripal y antineumocócica. Si no sabemos si tenemos el calendario completo, simplemente concurramos a un centro de vacunación o a un médico clínico o de familia, quienes nos van a saber orientar.

Tengo dudas, ¿qué hago? Vacunar porque “corresponde” o porque “siempre se hizo así” no sirve si tenés dudas. Sentate con tu pediatra, pedile que te explique una a una las vacunas. Si es necesario, se dedica una consulta entera a charlar la composición de cada una y de por qué se da a esa edad y no antes o después.

Controles pediátricos

Cada niño es un mundo, y cada familia también. **Orientativamente, se puede decir que hasta el año de vida las consultas suelen ser una vez por mes** para evaluar el crecimiento del bebé, ver el calendario de vacunas, charlar pautas de alimentación saludable, prevención de accidentes, cuestiones de lactancia, de la vuelta al trabajo y de crianza. También observamos el vínculo entre los niños y sus cuidadores, evaluamos la motricidad, la comunicación, el lenguaje... ¡Y nos gusta recibir dibujitos!

Como podés ver, los controles no son solo pesar, medir y anotar. Deberían ser mucho más integrales. Lamentablemente, muchos centros pediátricos, en general dependientes de obras sociales y prepagas, no otorgan al profesional y a la familia más de 15 minutos por paciente, lo cual genera que el abordaje holístico sea realmente muy complejo de lograr.

Después del año, los controles suelen espaciarse, generalmente vemos a los chicos cada 2 o 3 meses. A partir de los 2 años, si está todo bien, muchas veces pasamos a controles cada 6 meses, y después de los 3, una vez por año. Esa “vez por año” generalmente se da en la época del ingreso escolar, cuando se solicita el

famoso “certificado médico”. Esta consulta no es “una firmita y nada más”, sino que es sumamente útil para ver si hay que renovar algún control (los niños sanos no suelen necesitar estudios de “rutina”) o charlar acerca de algún hábito. Estos son los famosos “controles de niño sano”, a los cuales se suman las diversas consultas que una familia puede hacer por algunas cuestiones puntuales, como enfermedades o temas de crianza.

¿En todos los chicos es así? No, esto es un paneo general. Depende del embarazo, del nacimiento, de la familia, del crecimiento y del desarrollo.

¿Tu pediatra propone controles más seguidos o más espaciados?
¡Seguramente esté muy bien! No dudes en preguntar lo que te genere dudas.

¿Cómo hacer más llevadera la visita al pediatra? A veces visitamos al pediatra en el consultorio, y otras veces en la guardia. Ir al médico puede dar miedo, estar asociado con el malestar y las esperas largas, y traer recuerdos feos de otras ocasiones.

¿Podemos hacer algo para que sea más llevadero? ¡Claro que sí!

- Explicarle al niño adónde vamos a ir y qué va a ocurrir. Anticiparle la sala de espera, el consultorio, que lo vamos a revisar con su consentimiento y el de su familia. No traerlo “engañado”.
- Tratar de evitar en la vida cotidiana la situación médica como una amenaza. “Si te portás mal, te llevo al doctor”, “No hagas enojar a la doctora porque te va a pinchar”.
- Ponerle ropa cómoda y fácil de sacar y poner. Explicarle que, con su permiso, es posible que haya que sacar al menos algunas prendas para revisarlo.
- Si el/la pediatra son conocidos y se da la posibilidad, podemos contarles que vamos a ver a Sabrina y no a “la doctora”. Somos todos personas. También pueden preparar un dibujito para traer.
- Jugar al doctor en casa, ir familiarizándose con los objetos que usamos en la consulta (estetoscopio, otoscopio, bajalenguas).
- Explicarles que los acompañaremos en todo momento y no se hará nada sin su

consentimiento.

- Permitirle que traiga un objeto que lo haga sentirse bien (osito, muñeco, mantita, patas de rana... lo que desee).
- Respetar sus decisiones. Si no es de vida o muerte pesarlo en esa consulta y resulta imposible, no se realiza y lo hacemos la próxima.

De toda esta listita, destaco el: POR FAVOR, NO AMENAZAR. Eso, por más que parezca habitual, también es una forma de violencia que solo provoca miedo y desconfianza.

¡Por más visitas al pediatra felices!

Salud bucal

La prevención de los problemas de salud bucal del bebé comienza en la panza de su mamá: el embarazo es un excelente momento para controles odontológicos y pautas de prevención. Sí, se pueden realizar procedimientos odontológicos (con el aval del obstetra) y el mejor momento es el segundo trimestre. Luego del nacimiento, estos controles continúan con la evaluación del bebé: la boca, la succión, el frenillo y otras cuestiones que involucran al equipo pediatra-odontopediatra-puericultora (¡#dreamteam!).

¿Se puede ir al odontopediatra si aún no tiene dientes? ¡Sí! Nos ayudará a prevenir y nos dará información acerca del inicio de la higiene bucal.

Molestias en la erupción dental

Los dientes de leche suelen empezar a aparecer entre los 6 y 13 meses. A algunos bebés les salen antes, y a otros después, y también es normal. Incluso hay bebés que, ¡nacen con dientes!

A los dientes de leche hay que cuidarlos tanto como a los permanentes. Si se enferman, DUELEN. Tienen raíz. Y son importantes para el desarrollo saludable de la boca y el rostro: les guardan el lugar a los permanentes.

Es por eso que les vamos a dar la importancia que merecen desde que empiezan a aparecer. No es claro si la erupción dentaria “duele”. Si uno le pregunta a un niño de

5-6 años que está en recambio dental si le duelen los dientes que le están saliendo... dice que no. **Sin embargo, no hay duda de que ante la salida de los dientes, los bebés se ponen “incómodos”.** Muerden todo, babean más, hasta pueden estar irritables. ¿Dan fiebre los dientes? No, pero como dice el pediatra español Carlos González, la dentición aparece durante un montón de tiempo, meses, ¡AÑOS!, y seguramente coincida con algún proceso viral y diversas enfermedades que se les atribuyen a los pobres dientes.

¿Qué podemos hacer si molesta la salida de los dientes? Primero, calma. Es un proceso natural. Hoy no es siempre, y esto también pasará. Acompañemos a nuestros bebés sin desesperar nosotros, es parte de su crecimiento y aquí estamos para brindarles seguridad. Segundo, objetos fríos. Ofrecerles mordillos (siempre verificar que sea plástico apto para bebés, que no se pueda romper y que no sea tóxico) o pedazos grandes, que no se puedan partir, de alimentos fríos. Otra buena idea es masajear las encías con un cepillito de goma o el cepillito de dientes tipo dedal.

Los geles tópicos anestésicos (son de venta libre, sabor frutilla, con nombre de diente) —muy comunes cuando yo era chica— no se recomiendan más. ¿Por qué? Porque se comprobó que tenían mucho riesgo de toxicidad. Pueden producir metahemoglobinemia, patología que genera menor aporte de oxígeno a los tejidos; y también produce insensibilidad local: los chicos no perciben su propia saliva y eso puede generarles tos y ahogos.

Helados de leche

Vengo a proponerles esta idea más vieja que el mundo: helados de leche materna, o de fórmula. Se coloca la leche en recipientes (pueden ser moldes para helados o cubeteras), se deja un ratito y cuando ya está semicongelada, se coloca algo para agarrar fácil según la edad del niño: puede ser un chupete, un palito de helado, una cuchara... Se deja congelar... ¡y listo! Como son de leche y probablemente gran parte terminará en la ropa del niño, no hay un “límite” de heladitos por día. Cuando la encía moleste y se necesiten... ¡adelante! Para niños más grandes, podemos hacer los helados de jugo de fruta exprimida, o de leche + fruta. Y repito, ¡paciencia! Esta etapa también pasará.

El collar de ámbar

Este producto, últimamente muy difundido, se vende como la panacea para las molestias de la dentición en los bebés. Se supone que son de ámbar, que en contacto con la piel del bebé, libera ácido succínico, y que esa sustancia es “analgésica y antiinflamatoria”.

Sin embargo, la mayoría de los pediatras consideramos a esta tendencia sumamente peligrosa. ¿Por qué? Porque colocar un collar, portachupete, cadenita, cinta o lo que sea alrededor del cuello de un bebé, genera riesgo de ahorcamiento y asfixia. Si bien algunos de estos collares se amparan en que son irrompibles y cada cuenta se anuda por separado, basta con que UNA cuenta se suelte e impacte en las vías respiratorias de un niño para causar mucho daño.

No hay ninguna evidencia de que el collar tenga algún efecto beneficioso, y de hecho:

- El ácido succínico que promueven no es una sustancia analgésica utilizada en pediatría.
- La mayoría de los collares no son de ámbar, son de plástico. Sí, me consta que muchos tienen un “certificado de autenticidad”. Pero ¿quién nos asegura que eso no es plástico, y que ese plástico no es tóxico?
- La absorción de la mayoría de las sustancias a través de la piel es mínima, y depende de la edad y del peso del niño.

“Pero a mí me funcionó”. Pocas cosas son más desesperantes para nosotros como mapadres que ver a nuestros hijos pasarla mal. A veces, que nos planteen que hay “algo más” para hacer, además de tener paciencia, nos ayuda a bajar la ansiedad, esto se transmite al niño e impresiona que ese “algo más” funcionó por sí mismo.

Si este accesorio no fuera posiblemente dañino, sería buenísimo, pero dado que hay casos reportados de niños asfixiados por usar collares, es un riesgo que uno debe estar consciente de que corre.

“De todos modos, quiero probarlo”. Como pediatras, como siempre planteo, estamos para informar y no para prohibir o imponer. Si deseás utilizar el collar con tu bebé, podés seguir ciertas normas de seguridad:

- Que nunca esté solo mientras lo tiene puesto.
- Sacárselo para dormir, ya sea a la noche o las siestas.
- No ponérselo en el cuello, sino en el tobillo o la muñeca.

- Verificar que esté anudado “cuenta por cuenta” y que el broche de cierre sea seguro.
- Verificar reacciones alérgicas al potencial plástico del que pueden estar hechos.
- Y, reitero, están registrados casos de asfixia con este objeto. Podemos prevenir los accidentes evitando los riesgos.

¿Cómo prevenir la caries?

Antes de que salga el primer diente, es conveniente higienizar las encías del bebé al menos dos veces por día con una gasa húmeda o un dedal de silicona, sobre todo si consume leche de fórmula o ya inició la alimentación complementaria. Esto alivia y estimula las encías y va generando el hábito de la limpieza.

Una vez aparecido el primer dientito, podemos comenzar a cepillarlo con un cepillo pequeño y pasta dental con flúor, en cantidad similar a lo que sería medio grano de arroz. No hace falta que el bebé sepa escupir: sirve simplemente para topicar los dientes y protegerlos. ¿Con qué pasta? Hay que mirar la composición en la caja de cada pasta. La cantidad correcta de flúor es de 1000-1100 ppm y la cantidad sobre el cepillo se regula a medida que el niño va creciendo. **Se sugiere cepillar con pasta dos veces por día, y luego cepillar solo con agua las veces que deseen. El cepillado nocturno es el más importante.**



Si la pasta no tiene flúor, es un placebo, no tiene objeto usarla. Se ha visto que el flúor, en cantidades adecuadas, colabora con la mineralización de las piezas dentales y es protector ante la caries.

De 4 a 6 meses después de dicho brote, es importante pedir una consulta con el/la odontopediatra para que vaya evaluando la higiene y la salida de los dientes.

Es conveniente mantener una alimentación baja en azúcares refinados y productos industrializados, y lavar los dientes inmediatamente después de haberlos consumido. Evitar los jugos en general también es aconsejable. Jugos, gaseosas, “leches” de soja y demás, tienen muchííííísimas azúcar, la cual además de proveer calorías no nutritivas, aumenta el riesgo de caries.

Se sugiere evitar que los chicos se duerman con la mamadera en la boca, dado que aumenta el riesgo de otitis, y como las leches de fórmula tienen alto contenido de azúcar, puede derivar en lo que se denomina “caries del biberón”.

Por otro lado, no hay nada más fisiológico que la lactancia materna. Esta genera que los músculos de la cara y la mandíbula se desarrollen en forma armónica y saludable, y no se ha comprobado correlación directa con la aparición de caries. Si el niño consume una dieta baja en alimentos cariogénicos, las tomas nocturnas no revestirán mayor problema. **¡El problema es el azúcar, no la teta!**

Las bacterias que causan caries (*S. mutans*) se adquieren de la boca de los adultos. Hay que tratar de evitar las prácticas que generan esta transmisión, por ejemplo, “limpiar” el chupete poniéndolo en la boca del adulto o dándoles besos en la

boca a los niños.

Se recomienda, cuando ya hay dos dientes pegaditos y se puede acumular comida entre ellos, el uso de hilo dental. Hay unos implementos llamados “*easy flossers*”, que son unos palitos de plástico con el hilo ya tensado, que pueden ser mejor aceptados en niños. De todos modos, ellos pueden jugar, pero el cuidador tendrá que hacer el “pasaje final” del hilo dental.

Hasta los 8 años, los cuidadores deben seguir ayudando a lavarse los dientes a los niños, pues no tienen la coordinación motriz para hacerlo efectivamente por sí mismos. ¿Cumplen 8 años y están listos? No: las pautas motrices que deben haber alcanzado son atarse los cordones solos y/o escribir con letra cursiva. En ese momento, ya van a tener la capacidad de llegar a todos los recovecos de la boca con el cepillo por su cuenta.

El cepillado puede ser un momento de juego y de disfrute para toda la familia. Podemos poner música, cepillar al muñeco, jugar al dentista. No hay duda de que esto suena muy lindo, pero a veces también es un campo de batalla. Paciencia. Somos responsables de la salud de nuestros hijos, y su boca también es salud. ¡A seguir intentando sin darnos por vencidos!

Los controles odontológicos varían de niño en niño, aunque generalmente, si está todo bien, son cada 6 meses/1 año. Al igual que con el/la pediatra: no fomentemos el mito y el miedo alrededor de los profesionales de la salud, tratemos de no amenazar ni generar angustias que son muy difíciles de abordar posteriormente. Los odontopediatras suelen tener toneladas de paciencia e incluso, muchos de ellos, la puerta del Ratón Pérez en el consultorio...

Para leer

PARA FAMILIAS

- Asociación Americana de Pediatría. *La dentición en los niños*. Recuperado de: <https://kidshealth.org/es/parents/teething-esp.html>
- González, C. *En defensa de las vacunas*, Editorial Planeta, Madrid, 2011.
- Organización Mundial de la Salud, *Preguntas y respuestas sobre inmunización y seguridad de las vacunas*. Abril de 2018. Recuperado de: <https://www.who.int/features/qa/84/es/>
- Instituto Internacional de Displasia de Cadera: www.displasiadecadera.org
- *Deficiencia de hierro y anemia ferropénica. Guía para su prevención, diagnóstico y tratamiento*. Arch Argent Pediatr 2017; 115 Supl 4: s68-s82 / s68. Recuperado de: <https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2017/v115n4a32s.pdf>
- *Curso básico de Lactancia Materna 2018*, Plataforma SUMAR, Ministerio de Salud de la República Argentina.

PARA PROFESIONALES

- Setton, D. y González, M. *Nutrición en pediatría*, Editorial Panamericana, Buenos Aires, 2014.
- Taylor, S. N. y The Academy of Breastfeeding Medicine. *ABM Clinical Protocol #29: Iron, Zinc, and Vitamin D Supplementation During Breastfeeding*. BREASTFEEDING MEDICINE Volume 13, Number 6, 2018, Mary Ann Liebert, Inc. DOI: 10.1089/bfm.2018.29095.snt.
- Cediél, G.; Pacheco-Acosta, J.; Castillo-Durán, C. *Deficiencia de vitamina D en la práctica clínica pediátrica*. Arch Argent Pediatr 2018; 116(1):e75-e81. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.5546/aap.2018.e75>
- Mansur, J. L. *Vitamina D en pediatría, embarazo y lactancia*. Arch Argent Pediatr 2018; 116(4):286-290. DOI: 10.5546/aap.2018.286.
- Ministerio de Salud de la República Argentina. *Normativa y tutorial para la Vigilancia de los eventos vinculados a la Pesquisa Neonatal Endócrino-Metabólica a través del Sistema Nacional de Vigilancia por Laboratorios del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SIVILA-SNVS)* 2016.
- Ministerio de Salud. *Pesquisa Neonatal Auditiva*. 2014.
- Comité de Estudios Fetoneonatales (CEFEN). *Recomendaciones para la pesquisa de retinopatía del prematuro*.
- Programa Nacional de Actualización Pediátrica 2016, Módulo 3, *Preguntas frecuentes en ortopedia infantil*.
- Asociación Latinoamericana de Odontopediatría, *Guía de Salud Bucal Infantil*

para Pediatras.

- Programa Nacional de Actualización Pediátrica 2018, Módulo 2, Responden los expertos.
- Ruiz, Del Castillo, Delgado. *Ortopedia Infantil. Práctica para pediatras*, Editorial Panamericana, Madrid, 2017.

La lactancia



La lactancia es una responsabilidad social

Las acciones para acompañarla y sostenerla, si es deseada y posible, no pueden recaer solo sobre las mujeres. La lactancia es responsabilidad de toda la familia, de todo el sistema de salud, de los compañeros/as de trabajo. La lactancia no vende, la lactancia molesta. La lactancia tiene olor a leche y transpiración. Pinta lamparones acartonados en las remeras. La lactancia no es coqueta ni prolija. La lactancia deseada es un derecho que está en todos garantizar.

Leche materna: tejido vivo

Tu leche es agua... y mucho más

Hoy por hoy, año 2019, no sabemos exactamente la composición de la leche materna. Tenemos un aproximado que nos sirve, industrialmente, para intentar construir leche de fórmula similar. ¿Por qué no sabemos qué tiene la leche materna? Por un lado, **porque la leche de cada mujer es diferente, y varía su composición todo el tiempo**. La leche que toma el bebé a las 11 de la mañana no tiene lo mismo que la que toma a las 7 de la tarde. No es igual la leche que vamos a producir si nuestro bebé tiene mocos que la que producimos cuando es verano y hace calor. La leche se adapta, fluye, se acomoda a tiempos, espacios, temperaturas y edades.

Históricamente se ha dicho que la leche tiene “dos partes”: la del “principio” de la toma, que tiene más agua, y la del “final” de la toma, que tiene más grasa. Me hicieron falta dos años de estudio de puericultura, y grandes maestras, para poder transmitir hoy que no es así. **La grasa de la leche se mantiene estable durante toda la toma**: simplemente, al principio de la misma, está más “diluida”. Pero es igual de calórica que la leche del “final”. Si dejamos que el bebé mame libremente, **a demanda**, recibirá la grasa necesaria.

Te cuento algunos componentes que tiene la leche:

- **Agua**. Toda la cantidad de agua que necesita un bebé hasta por lo menos los 6 meses. Hasta esa edad, no necesitan ningún otro líquido ni alimento.
- **Anticuerpos** contra patógenos (bacterias, virus, etc.), que el cuerpo de la mamá produce y le pasa al bebé. Se llaman inmunoglobulinas.
- **Células de la inmunidad**, que ayudan al bebé a protegerse de infecciones.
- **Lactosa**, que le da energía y promueve la absorción del calcio.
- **Bacterias probióticas**, que generarán una flora intestinal saludable en el bebé.

- **Proteínas** como la lactoferrina, que evita el sobrecrecimiento bacteriano; la lipasa, que ayuda a digerir las grasas al bebé; o la haptocorrina, que transporta la vitamina B12 y ayuda a absorberla.
- **Todos los aminoácidos, y en especial los esenciales.** Los aminoácidos son los “ladrillos” que componen las proteínas, y las proteínas son los “ladrillos” de tejidos, hormonas, transportadores, mensajeros... El cuerpo no produce todos los aminoácidos y los tenemos que sacar de la diversidad de alimentos cuando crecemos. Mientras tanto, la leche materna los tiene TODOS.
- **Oligosacáridos**, que son prebióticos, es decir, ¡sustancias que le dan de comer a las bacterias buenas del intestino!
- **Gran cantidad de minerales**, en especial de calcio, magnesio, hierro, cobre y zinc. El hierro de la leche materna es el que mejor se absorbe.
- **Vitamina A** (que depende de lo que ingiere la mamá), **vitamina D** (ídem) y **vitaminas C y E**, estas últimas en mayor proporción que la leche de vaca. Tiene **vitamina B12** en baja proporción pero que se absorbe fácilmente (las mamás veganas tendrán que suplementarse) y todas las **vitaminas del grupo B** (B1, B2, B6, B12).
- **Hormonas maternas**, cuyo papel en los bebés aún no es del todo claro.
- **Factores de crecimiento**, que son proteínas que ayudan al crecimiento del bebé, sobre todo a la maduración de su intestino. Previenen patologías intestinales (sobre todo en prematuros) y no existen actualmente en las leches de fórmula.

Y no tenemos que olvidar todo el esfuerzo y amor que tiene esa leche. Haya sido un día solo en la Neo o tres años de lactancia, amamantar es poner el cuerpo en alimentar, es llorar al lado del sacaleches, es preocuparse por la vuelta al trabajo, e incluso es decidir no hacerlo pues no sería sano a diferentes niveles para el binomio.

Muchas veces me preguntan cuánta leche humana “sirve”, cuánto hay que darle a un bebé para que disfrute sus propiedades. **Cualquier cantidad sirve, hasta un mililitro sirve.** Si las empresas pudieran envasar algo mínimamente parecido a la leche humana y vendérselo a todo el mundo, no lo dudarían.

Existe en el cuerpo de las mujeres que amamantan un circuito que se denomina “sistema bronco-entero-mamario”. Todos los patógenos (microorganismos y partículas que pueden enfermar) que ingresan al cuerpo de la mamá producen que esta genere anticuerpos para defender su cuerpo. Esos anticuerpos viajan por el torrente sanguíneo y se van a excretar por la leche materna, colonizando y protegiendo el cuerpecito del bebé cuando toma su leche.

También hay células de la inmunidad maternas, que protegen al bebé de infecciones y que se multiplican cuando el bebé está enfermo. Inclusive existen teorías que plantean que la saliva del bebé, al entrar en contacto con la teta, condicionaría la composición de la leche.

Cuando una madre besa a su bebé, toma con la boca patógenos de la piel del

mismo, produce en su cuerpo defensas contra ellos y se las entrega a ese bebé a través de la leche. ¿No es fantástico?

Tu leche es agua, sí. Y mil cosas más. Nunca deja de nutrir y de proteger.

Leche materna y microbiota intestinal

Hablamos en los primeros capítulos acerca de la microbiota, ese contingente de microorganismos que son parte del ser que somos y que reside en nuestro intestino, piel, vagina, tracto respiratorio y más. Hablamos también de que tenemos un montón de genes y que se expresan de diferentes maneras.

La biología ha demostrado que el feto y la persona gestante intercambian células, y que estas células se anidan en tejidos de la otra persona. Este proceso increíble se llama “microquimerismo” y es único, dado que es realmente muy extraño que un cuerpo permita células que no son propias y no las ataque.

Estas células son células madre (también llamadas “*stem cells*”) que pueden formar muchos tipos de células... ¡y la leche humana también las tiene! Sí, en serio.

Los estudios han mostrado que por la leche podemos pasar células que van a los tejidos del bebé y pueden formar neuronas, células hepáticas, células pancreáticas, células que forman hueso...

Además de eso, la leche humana no es estéril: tiene millones de bacterias beneficiosas que van a poblar el intestino del bebé. Son los famosos “probióticos”.

Los bebés van a recibir probióticos (bacterias) y prebióticos (las sustancias que le dan de comer a las bacterias) directamente en la leche. Mientras mejor sea la dieta de la mamá, con menor cantidad de productos ultraprocesados y harina refinada, y mayor cantidad de alimentos reales, su microbiota será más beneficiosa y lo protegerá de múltiples enfermedades.

A veces me preguntan si sirven los probióticos embotellados (hay uno importado, carísimo, muy popular) para los cólicos. Esos probióticos no tienen sentido en bebés amamantados, porque la leche materna trae muchísimos más que los que puedan meter en un frasco a nivel industrial. Y con respecto a los bebés que toman fórmula, cada vez más marcas los incluyen en la composición de las mismas.

Camino a la lactancia deseada: el embarazo y la información

Lactancia desde el deseo

Como ya vimos antes, ningún científico o agente de salud podría dudar o contradecir que la leche materna es el mejor alimento para un bebé. Pero en la lactancia hay mínimo dos personas: mamá y bebé (o bebés, o mamás, pues mujeres no gestantes pueden amamantar también). **La soberanía sobre el propio cuerpo es primordial: si no deseás amamantar, ¿quién puede obligarte? ¿Cómo puede ser la lactancia algo positivo si es una imposición?**

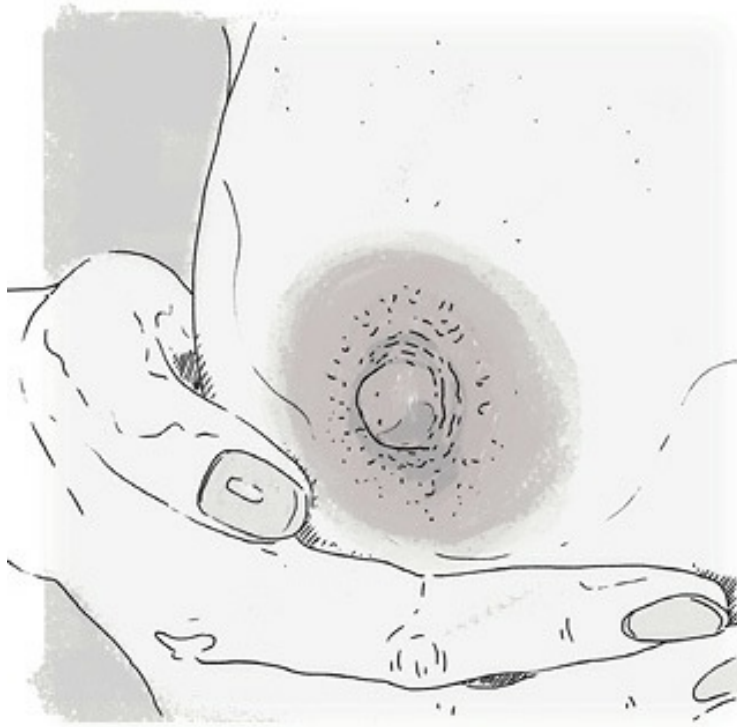
Si tenés toda la información y el soporte adecuado, y de todos modos no deseás amamantar, siempre debe respetarse tu decisión, sin cuestionar ni juzgar, acompañando el crecimiento y desarrollo de tu bebé.

Si tu deseo es amamantar, la información es tu aliada. **Concurrir a charlas prenatales de lactancia y tener el contacto de una puericultora a mano para los primeros días debería ser tan importante como ir a los controles obstétricos.**

“Preparar los pezones”

“¿Tengo que preparar los pezones de alguna manera durante el embarazo?” es una pregunta muy, muy común, sobre todo por la cantidad de mitos que existen alrededor de ello. Por eso, la mejor manera de prepararse para amamantar es INFORMARSE, y también saber que habrá muchos mitos rondando alrededor.

El bebé no toma la teta con el pezón: abarca lo que se llama el “complejo pezón-areola”, es decir, el pezón más la parte “oscura” de la teta. Por lo cual **hay que sacar la atención de los pezones puntualmente y pensar la teta como algo global.**



Aun en el caso de pezones planos o invertidos, no se recomiendan ejercicios previos, sino ayuda profesional para posicionar al bebé.

Algunas “sugerencias” que suelen darse y que NO son ciertas

- **Raspar los pezones con cepillo para uñas/piedra pómez/virulana/esponja vegetal** (¡seguramente la persona que inició este mito no tiene pezones ni amamanta!) para hacerlos “más duros” y que no se lastimen por la prendida del bebé. La única manera de que la succión del bebé no genere heridas, es que tenga una correcta posición.
- **Colocarse casquillos.** En ocasiones, los casquillos o aireadores que existen en el mercado pueden servir precisamente para “airear” los pezones en los primeros días y evitar el roce con la ropa. También pueden servir para recoger la leche que gotea de la otra teta cuando amamantamos, por el reflejo de eyección. Pero NO son algo “necesario” para formar los pezones, ni antes ni después del embarazo. No hace falta comprarlos antes del nacimiento para “tenerlos” ni llevarlos a la clínica.
- **Que la pareja de la mujer succione los pezones para formarlos.** Háganlo si les gusta, no por una indicación.
- **Si no hay calostro durante el embarazo, no habrá leche.** La presencia o no de calostro durante el embarazo no tiene nada que ver con la lactancia posterior.
- **“Ejercicios” para formar pezones.** Hace no tantos años, se indicaban los ejercicios de Hoffman, en los cuales se estiraba y estimulaba el pezón para

“formarse”. Se hicieron estudios donde se llegó a la conclusión de que era lo mismo hacerlos que no hacerlos: el bebé se va a ocupar de darle al complejo areola-pezones la forma de su boca.

La lactancia deseada es mucho más que un pezón. Es abrazo, es calor, es el sonido del corazón, la vibración de la voz, el olor de mamá. **¡SOMOS MUCHO MÁS QUE UN PEZÓN PARA NUESTROS BEBÉS!**

Calostro durante el embarazo

Alrededor de la semana 16 del embarazo, las mamas empiezan a producir un líquido pegajoso que se denomina “calostro”, muy parecido al que producirán los primeros días después del nacimiento. En algunas mujeres, incluso, el calostro saldrá al exterior y los pechos pueden gotear.

No todas las mujeres tienen calostro durante el embarazo. De las que sí, algunas lo perciben desde las primeras semanas y otras en el último tramo del embarazo. Lo que es importante saber es que NO tiene nada que ver con la cantidad de leche posterior al nacimiento. **Una persona gestante puede no haber tenido calostro durante el embarazo y amamantar perfectamente.** Lo que hace producir la leche es el estímulo del bebé.

Tampoco se acaba. Madres muy asustadas me han escrito porque les goteaban los pechos y tenían miedo de no tener calostro después para el bebé. No se preocupen: si dejamos que el bebé succione a demanda, tendrá todo lo que necesita.

Lactancia en tándem

¿Se puede amamantar a dos hermanos de diferente edad? Sí, se puede. ¿Se puede amamantar durante el embarazo? Si el embarazo es de bajo riesgo, saludable... sí, se puede.

¿La lactancia durante el embarazo genera contracciones? Durante la lactancia se genera oxitocina, que lleva a la eyección de la leche. Durante los primeros meses hay pocos receptores de oxitocina en el útero, así que no sería riesgoso. El útero genera contracciones continuas y fisiológicamente, por ejemplo, durante el orgasmo. Si no nos prohíben las relaciones sexuales durante esos meses, tampoco deberían desaconsejarnos la lactancia.

Mientras amamantamos en forma exclusiva, antes del inicio de la alimentación complementaria, en bebés pequeños, GENERALMENTE no ovulamos ni

menstruamos. Inclusive se considera a la lactancia como un método anticonceptivo (muy, muy, muy inseguro, porque no sabemos cuándo volveremos a ovular). La naturaleza es sabia y busca espaciar las concepciones y nacimientos el mayor tiempo posible. Sin embargo, cada mujer tiene un cuerpo distinto y un ciclo menstrual distinto, influido por su historia, sus deseos, su entorno, su alimentación, sus hábitos y mucho más.

¿Cómo será la leche? Durante la primera parte del embarazo, la leche que le llegará a el/la hermano/a mayor será la misma de siempre, tal vez con algunos cambios de sabor, pero en el último trimestre, hará la transición a calostro esperando al recién nacido.

¿Y la mamá no se desnutrirá? Gestar, amamantar y criar es un trabajo de tiempo completo, agotador, desgastante muchas veces. Si la madre consume todos los nutrientes que precisa, no, no tendrá carencias nutricionales. Pero en nuestro medio, esto es bastante complejo. Lo ideal sería trabajar en forma multidisciplinaria con un equipo de nutrición especializado en embarazo.

Conocer a nuestra puericultora

No me canso de sugerir la consulta con la puericultora previa al nacimiento. El posparto es un mundo de revolución donde es muy complejo buscar información confiable o una profesional que nos pueda acompañar rápidamente. **Muchas veces, la presencia de la puericultora es el salvavidas antes de incorporar fórmula innecesaria, o soluciona muchas cuestiones de dolor y posturas incómodas.** Las puericultoras, en general, van a domicilio, entonces pueden conocer el ámbito donde se está llevando a cabo esa lactancia y dar consejos, siempre respetando los deseos y la cultura de la familia, para hacer el momento más llevadero.

Podés encontrar puericultoras por zona en www.uniondepuericultoras.org.ar, la web de la Unión de Puericultoras Argentinas (UPA). También podés consultar en las escuelas de puericultura Panza y Crianza, y ACADP (Asociación Civil de Puericultoras), que cuentan con consultas gratuitas. En FUNDALAM y en La Liga de la Leche también podés encontrar ayuda. Y si en tu zona no hay puericultoras, la consulta *online*, si bien no es lo mismo que la consulta presencial, puede ser una gran ayuda, disipando dudas y calmando ansiedades.

El nacimiento y la lactancia

La hora de oro

Desde que el mundo es mundo, los bebés han nacido y, para asegurar su supervivencia, han sido inmediatamente abrazados, contenidos y alimentados por sus madres. Nacer y ser bañado, secado, vestido y separado de su madre es simplemente parte de la medicalización de la fisiología humana, y en un bebé sano, solo son intervenciones que entorpecen el vínculo y la lactancia.

El trabajo de parto es un proceso que puede llevar horas o días. Durante el mismo, se generan múltiples hormonas que llevan a que **el bebé y su madre estén en un estado de alerta tranquila posterior al nacimiento, y que sea un momento propicio para iniciar la lactancia.**

Sin embargo, cuando no sucede el trabajo de parto (cesáreas programadas, cesáreas de urgencia, etc.), es igual o más importante establecer el contacto piel con piel desde el momento inmediato del nacimiento.

Se ha comprobado que si se coloca a los recién nacidos nada más nacer en contacto piel con piel (ni camisones, ni pañales, ni ropitas) entre los pechos de sus mamás, se preserva su desgaste de energía, regulan mejor su temperatura (también se vio que inmediatamente posparto, el pecho de las mujeres aumenta uno a dos grados su temperatura, para darle calor a la cría), lloran menos, se sienten más tranquilos porque el sonido del corazón de su mamá los tranquiliza, se colonizan con gérmenes propios de la piel de su mamá y, si los dejamos, buscarán y se prenderán solos al pecho. Todo este proceso puede alterarse si separamos al recién nacido de su mamá, aunque sean solo unos minutos.

Se ha estudiado también que los bebés suelen estar despiertos y alertas durante las primeras 2-4 horas después del nacimiento, para pasar posteriormente a un estado de somnolencia que puede durar hasta 12 horas. Es por esto que es imprescindible aprovechar esas primeras horas y no retrasar la prenda al pecho.

Este tiempo de arraigo, de bienvenida al mundo exterior, de reconocimiento mutuo, se llama “hora de oro”. Hora que no es “hora”, simplemente son momentos, es olor a bebé con líquido amniótico, es necesidad de abrazar, lamer, besar, atraer a la cría al pecho. Otras veces es la perplejidad de ese bebé minúsculo y arrugado en nuestros brazos, y el preguntarse cómo conocerlo y cómo amarlo. Es el primer escalón de ese proceso que acaba de comenzar, el puerperio.

Llegar a la habitación

Después de todo el ajetreo del trabajo de parto, o la preparación de la cesárea, o ambos; luego del nacimiento, la recuperación, el alumbramiento, el corte del cordón,

el abrazo, la expectativa, el llanto, la transpiración, el estrés, la felicidad, la angustia... llega la habitación.

La habitación que, o está vacía y la habitamos nosotros, o la compartimos con otras familias. Pero no deja de ser un lugar de calma después de la tormenta. El lugar donde, finalmente, comenzamos a ejercer nuestra mapaternidad.

Lo ideal sería que la habitación sea lo más similar a nuestra casa. Que podamos tener objetos u aromas que nos produzcan placer y comodidad. En algunos sanatorios, inclusive, se propicia que el parto sea en esa misma habitación, para no tener que andar trasladando a las familias de un lado a otro. También sería ideal que los controles de salud a la mamá y al recién nacido fueran en horarios que no alteren su sueño y su comodidad. Sabemos que esto depende de la cantidad de pacientes y del personal médico y de enfermería, y que generalmente es complejo de articular. No pierdo la confianza de que se logre algún día.

En la habitación, muchas veces —si no sucedió ya en la sala de partos— se da inicio a la lactancia. Es importante dejar que el bebé coma cuando quiera, sin horarios rígidos. También es importante, los primeros días, preservar la intimidad, si es que la familia lo desea, y limitar las visitas. **La presencia de muchas personas genera un ambiente muy estresante para un bebé, al que le cuesta manejar ese grado de estímulo.** Muchas veces, la única manera de “regularse” es dormirse profundamente. Eso puede hacer que se pierdan momentos de lactancia y se interfiera con la misma.

Calostro y leche de transición

La lactancia también es un mundo de mitos y de no saber qué esperar. Entre esas fantasías se encuentra el color y la cantidad de leche: las que hemos deseado amamantar en algún momento creímos que seríamos vacas lecheras, con leche a chorros saliendo de las tetas. Y no, al menos no al principio.

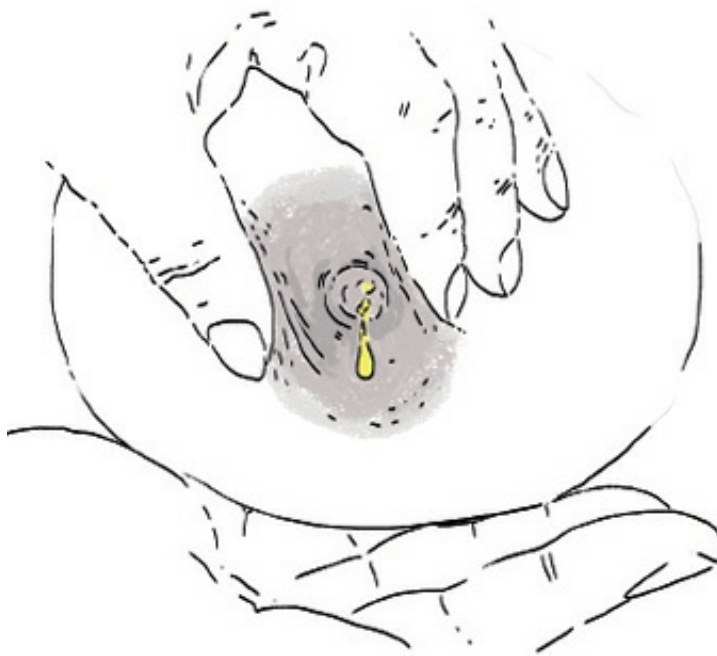
El calostro es la PRIMERA LECHE. Y uso mayúsculas porque hay una creencia popular de que “no me salió leche, solo calostro”, o que el calostro es algo sin importancia. Es leche, y por algo es así. No es blanco y no son chorros: son más bien gotitas que tal vez vimos también durante el embarazo, de color dorado o anaranjado, espesas y pegajosas. **El calostro es así porque está compuesto en su mayor parte por proteínas.** Esas proteínas no son ni más ni menos que anticuerpos, es decir, defensas que le estás pasando a tu bebé. Además tiene células y bacterias buenas, y su color es así por los betacarotenos, que le dan un efecto antioxidante.

¿Pero con esas gotitas no se va a morir de hambre el bebé? No, el bebé recién está aprendiendo a coordinar la serie de movimientos “respirar-succionar-tragar”, y si el cuerpo produjera mayor volumen, no podría manejarlo. Además, su estómago tiene un tamaño pequeño como una uva: no necesita grandes cantidades para “llenarse”.

El calostro es IMPORTANTÍSIMO. Hace que el intestino del bebé se pueble con bacterias beneficiosas y que se empiecen a sellar las uniones entre células intestinales, muy inmaduras aún. Tiene un efecto laxante, hace que el meconio se elimine más rápidamente y eso genera menor hiperbilirrubinemia (cuando sube la bilirrubina y se ponen amarillitos).

A medida que el bebé se pone más canchero con el asunto de respirar-succionar-tragar, **el cuerpo empieza a producir la leche que va a reemplazar al calostro, que se llama “leche de transición”.** Esta leche ya es más blanquecina y se produce en mayor cantidad, coincidiendo con un bebé más despierto, con más ganas de comer y con un estomaguito más grande.

En estos momentos, los bebés suelen estar muchas, muchas, MUCHAS horas tomando teta. Cuando digo “muchas”, digo alrededor de 20 por día, a veces. ¿Por qué? Porque le están explicando a la teta que tiene que producir leche para alimentarlos. **Si cortamos ese estímulo introduciendo fórmula o un chupete, podemos interferir negativamente en la lactancia.**



El calostro es tan importante para el establecimiento de la lactancia y del vínculo, que existen evidencias de pueblos de guerreros que les impedían a los bebés tomar el calostro de sus madres, creyendo que esto los haría más independientes y agresivos.

La bajada de la leche

Mi hijo Juan Martín nació muy enfermo. Durante sus primeros días de internación en Neonatología, lo podíamos tocar poco para no estimularlo y no empeorar su hipertensión pulmonar. Yo me empecé a sacar leche casi 24 horas después de su nacimiento, cuando me lo ofrecieron. Decidí que no me iban a quitar eso también.

A las 72 horas desde la cesárea, me empecé a sentir mal, como engripada. Me dolía el cuerpo, temblaba, y no entendía si era por alguna complicación médica o por el estrés y la angustia. Llamé a la enfermera: vino, me tomó la temperatura, la presión, y me dijo que no era nada. Sentí que estaba exagerando, pero realmente me sentía muy mal y tenía miedo de tener algo infeccioso que contagiara a mi bebé ya muy grave.

Era la bajada de la leche.

Yo, casi pediatra, madre primeriza, no lo sabía. La enfermera de Obstetricia, agente de salud, lo ignoró.

Con el alumbramiento de la placenta, se empiezan a producir hormonas que inician el proceso de lactancia. La hermosa placenta, que se aseguró la nutrición y el confort de ese bebé durante la gestación, termina su función desencadenando la producción de alimento.

La bajada de la leche se produce entre el tercer y sexto día después del nacimiento. Se trata de un aumento “de golpe” de la producción de leche. Las tetas suelen verse más grandes, puede aumentar la temperatura y la turgencia de los pechos, y se puede sentir todo lo que conté en mi relato: dolor muscular, estado gripal e incluso fiebre. O nada de eso. Mi segundo bebé, Lisandro, estaba tantas horas pegado a la teta que la bajada de la leche pasó medio desapercibida.

Este es el momento en que los opinólogos dicen: “Ah, al fin tenés leche”. Pero ya sabemos: **el calostro y la leche de transición, ¡TAMBIÉN son leche!, y son sumamente importantes para el bebé.**

¿Qué podemos hacer para ayudar en la bajada de leche?

- **Los pechos a veces se ponen tan turgentes que al bebé le cuesta acoplarse.** Cuando sucede esto, se sugiere extraer suavemente leche para que el tejido de la areola esté más complaciente y elástico, y sea más fácil de agarrar por la boquita.
- **Los pechos pueden estar muy calientes y algo dolorosos:** sirve ponerse frío

local indirecto. Por ejemplo, hojas de repollo salidas del *freezer*, un poco “rotas”, para que tengan más humedad. ¿Por qué repollo? Porque son cóncavas... ¡y se adaptan a la forma de la teta!

- **Contar con un ambiente tranquilo y contenedor.**
- **Alimentarse saludablemente.** No hace falta “tomar ‘x’ cantidad de litros de agua”. Por tomar más agua, no vamos a tener más leche. Sí es importante estar hidratadas, cuando tenemos sed es porque ya hace rato necesitábamos agua. También evitar alimentos que provoquen inflamación a nivel general —como las grasas trans o los azúcares refinados— siempre nos hará sentir mejor.

El reflejo de eyección

Nuestras tetas, en su composición, cuentan con unas unidades llamadas “alveolos mamarios”. Allí se produce la leche, que luego sale por el pezón a través de conductillos.

La salida de la leche se da a través del reflejo de eyección: un proceso donde participa la hormona oxitocina, “exprimiendo” los alveolos mamarios. La oxitocina actúa con la succión, pero también actúa gracias a las emociones, de hecho, se la llama la “hormona del amor”.

La teta es una fábrica, no un almacén. La leche no se acaba nunca. En las primeras semanas, la leche sale rápido y a montones, pero a medida que van pasando los días, hay que esperar al reflejo de eyección para ver “el montón” de leche. Y eso es lo que nos pasa cuando usamos el sacaleches. Muchas veces creemos que nos sacamos poquito, y en realidad es porque no esperamos el reflejo de eyección.

Para estimular este reflejo, pensar en nuestro bebé, olerlo, acariciar su ropita, ver videos cuando no lo tenemos cerca, puede ayudar porque convoca a la oxitocina. ¡El reflejo de eyección es el que hace que nos salga leche de las tetas cuando escuchamos a un bebé llorar! (Y el que nos mancha la ropa del lado contrario al que estamos dando la teta).

¿Una teta o las dos? ¿Cuánto tiempo?

NO HAY una determinada cantidad de minutos que tenga que estar un bebé en el pecho para “tomar la leche grasosa”. A medida que el bebé toma, la **cantidad** de leche se va reduciendo (pero no se acaba) y es por eso que está más concentrada. Lo que

importa para el aumento de peso es el volumen de leche total que consumió a lo largo del día. Hay bebés que maman todo el alimento que necesitan en pocos minutos y otros que necesitan una hora.

Hay que empezar a mirar menos el reloj y más a los bebés. La diferencia entre una succión alimenticia y una afectiva es evidente cuando empezamos a mirar con atención. La succión afectiva es irregular, suavecita, sin “ruido de tragar”. Esa es la indicación para ofrecerle al bebé el otro pecho.

Lactancia en la Neo

Los bebés internados tienen el derecho (y más necesidad que los no hospitalizados) de recibir leche materna como alimento. Es un trabajo para el obstetra, el neonatólogo y el resto del equipo que acompaña a las familias crear una matriz de sostén adecuada para las mamás con bebés internados que deseen amamantar. Sería ideal que un equipo de apoyo acompañe a todas las familias en esas situaciones complejas y brinde contención.

A veces, el primer contacto con la lactancia es con un sacaleches, y sigue siendo así durante un largo tiempo. A veces, la única manera de suministrar esa leche es a través de una sonda sostenida por un brazo acalambrado. A veces, el primer grupo de mamás con bebés que te acompaña son tus compañeras de Neo, y las charlas no son sobre ropitas y pañales, sino sobre oxígeno, gramos aumentados, respiradores, infecciones y cirugías.

No forzar nada y no exigirse de más es importante en ese camino. Si hoy salieron 5 mililitros porque fue un día difícil, mañana saldrán 6. Si estás muy cansada y el esfuerzo es excesivo, serán más importantes tus caricias y tu voz que cualquier leche.

Primeras semanas

Descenso y aumento de peso

Hemos hablado acerca del descenso fisiológico de peso de los bebés en el capítulo anterior, “Estudios, pesquisas, controles”. Cuanto más intervenido sea el nacimiento, probablemente mayor sea el descenso de peso en los primeros días, y también

recalcamos que lo importante no es la balanza, sino cómo está el bebé: si moja 7 o más pañales, si se lo ve vigoroso, si toma la teta... Es decir, mirar más al bebé que a la balanza.

Existen tablas y pesos “estipulados” por etapa de crecimiento. Por ejemplo, se supone que un bebé aumentaría alrededor de 25 g/día durante sus primeros 3 meses. Pero esto es engañoso: tal vez un bebé aumenta 100 g en 2 días, al siguiente no aumenta más, el próximo día baja 10 gramos y el siguiente aumenta 50. Es por eso que pesarlos muy, muy seguido, no tiene objeto.

Si el bebé no aumenta de peso, indicar fórmula no es la primera opción. Hay que descartar patologías, y para eso, por ejemplo, tenemos que evaluar la pesquiza neonatal (conocida también como FEI). O podemos evaluar la toma de un urocultivo, ya que en ocasiones la infección urinaria tiene como única manifestación el escaso aumento de peso. También podemos buscar causas que puedan afectar la producción de leche como, por ejemplo, un hipotiroidismo no tratado en la mamá.

El uso del chupete, que se suele aconsejar por su papel preventivo en el síndrome de muerte súbita, no es recomendable hasta que esté establecida la lactancia. ¿Cuándo está establecida? Cuando la mamá no sienta molestias y el bebé aumente de peso en al menos dos o tres controles.

En paralelo, necesitamos como pediatras trabajar con una profesional de la lactancia. Podemos evaluar en el consultorio cuestiones como el vínculo, la prendida, los mitos de lactancia que giran alrededor de esa familia, los miedos, las presiones del entorno. Pero es de buena práctica trabajar, además, con una puericultora que evalúe a esa familia y que posteriormente nos brinde una devolución.



SEÑALES TEMPRANAS.
Tengo hambre.



SEÑALES INTERMEDIAS.
Tengo mucha hambre.

Lactancia A DEMANDA

- * "Diez minutos de cada teta".
- * "Cada tres horas".
- * "Cuando te pida llorando".
- * "Si le das muy seguido, le creás dependencia/lo sobrealimentás/lo cansás/le generás cólicos/ETC., ETC.".

Todas estas recomendaciones son MITOS. Nunca voy a cansarme de escribir que **la lactancia materna es A DEMANDA: las veces que el bebé pida, el tiempo y la cantidad que el bebé tome.**

La leche materna se digiere rápidamente, en alrededor de una hora. El concepto de "cada tres horas" es algo de la fórmula (antigua), ¡extrapolado a la leche materna! Las leches de fórmula también se han sofisticado y ahora son más digeribles, por lo que

también se puede hablar de “fórmula a demanda” utilizando lo que llamamos “método Kassing” (una técnica para dar la mamadera que busca reproducir las condiciones que el bebé experimenta cuando toma la teta, hay mucha información en la web).

¿Cómo nos damos cuenta de que un bebé quiere comer? Por diversas señales que va mostrando, ¡antes de llorar! Sacan la lengua, hacen movimientos buscando la teta, succionan en el aire... Cada bebé es un mundo y cada familia va aprendiendo a decodificar las señales del nuevo integrante. Repito: **confíen en su intuición. Nadie conoce a su bebé más que ustedes.**

Cuando un bebé ya está llorando porque tiene hambre, probablemente haya que consolarlo primero y luego ofrecerle el pecho, dado que es posible que lo rechace por estar muy enojado y desregulado. No es que no quiere la teta, es que primero tiene que bajar su frustración. Recordemos que hasta hace poquito, no tenía que esforzarse para comer, ¡todo venía por el cordón umbilical!



SEÑALES TARDÍAS.
Calmame, luego dame de comer.

Habría que tirar el reloj a la basura cuando iniciamos la lactancia. Calcular el tiempo de la mamada tampoco tiene objeto y cambiarlos de teta “porque pasaron diez minutos”, menos. El bebé tomará todo lo que necesite (hay bebés chiquitos y dormilones que puede ser necesario estimularlos) y luego soltará la teta. Ahí podemos

ofrecerle la otra, pero no necesariamente va a tomar las dos tetas en cada toma.

La parte más calórica de la leche requiere un ratito de succión, y si sacamos la teta antes de tiempo, no llegarán a tomarla, no aumentarán de peso, se introducirá fórmula, muchas veces... El típico círculo que perjudica la lactancia.

El primer mes de Lisandro (11/01/19)

En pocos días, Lisandro cumple un mes. Un mes fantástico, lleno de upa, mimos, pañales, salud y teta, con el corazón pleno.

Quiero hacer una mini #HistoriaDeLactancia con respecto a la fluidez de la lactancia durante este mes: todo tuvo que ver con respetar los tiempos, los espacios y sobre todo con el dar TETA A DEMANDA.

Con Liso salimos del quirófano estando él prendido a la teta, gracias al protocolo de respeto a la hora de oro del sanatorio donde nació, inclusive habiendo sido una cesárea. En las siguientes horas a su nacimiento, solo dejó de estar a upa mía unos 10 minutos, en los cuales lo pesaron... y pasó a estar a upa de su papá. Después de eso, siempre pegadito al pecho de mamá. No lo bañaron, no lo vistieron, no lo midieron. Todo eso esperó, como debería ser siempre.

Estar informada es la única forma de estar tranquila. En los talleres de Cuidado del Recién Nacido, solemos decir que es normal que un neonato esté prendido 20 h por día a la teta. ¡Y así fue! De esa manera, con naturalidad, pasamos de un primer calostro a la bajada de la leche, después de las 72 h de la cesárea. Bajó un poquito de peso y lo empezó a recuperar enseguida.

Hay que ponerle el cuerpo y el alma a amamantar el 90 % del día. Y es duro. Sobre todo, tiene que haber una red que cuide a la mamá. Yo tengo un compañero fantástico que nos cuidó en nuestro nido, en la cama abrazados a la teta.

A demanda es no mirar el reloj. No tengo la menor idea cada cuánto toma, ni cuánto tiempo duran las tomas. Él pide, yo le doy. No siempre toma de las dos tetas. A veces toma un poco y se pone a mirarme y nada más, porque solo tiene sed. Y ambos somos felices.

En uno de los controles por la ictericia de los primeros días (algo muy común que se soluciona con... teta), una médica me sugirió “ordenarlo”. ¡Un bebé no es un ropero!

Ni cada 3 horas, ni por 10 minutos. Todo lo que quieran, todo el tiempo que quieran. Mucha info antes del nacimiento, dejar fluir y cuidar a la mamá. Muchas lactancias podrían ser más felices y sencillas así.

Abrazos de leche.

¿Duele? Posturas y consejos

¿Existe dar la teta “mal”? NO. No lo creo de ninguna manera. Toda intención de amamantar debe ser sostenida, abrazada y valorada. Pero tampoco creo que la lactancia sea un proceso idílico, natural, ni siquiera sencillo: necesitamos una matriz de sostén.

Antiguamente, antes de que existiera la fórmula y la publicidad bombardeando nuestra vida y diciéndonos que la leche artificial es “mejor” que la leche materna, el amamantar era un saber que se transmitía de mujer a mujer. La crianza en tribu sostenía estas prácticas y no había dudas de que sabíamos parir, amamantar y criar con muchas menos intervenciones.

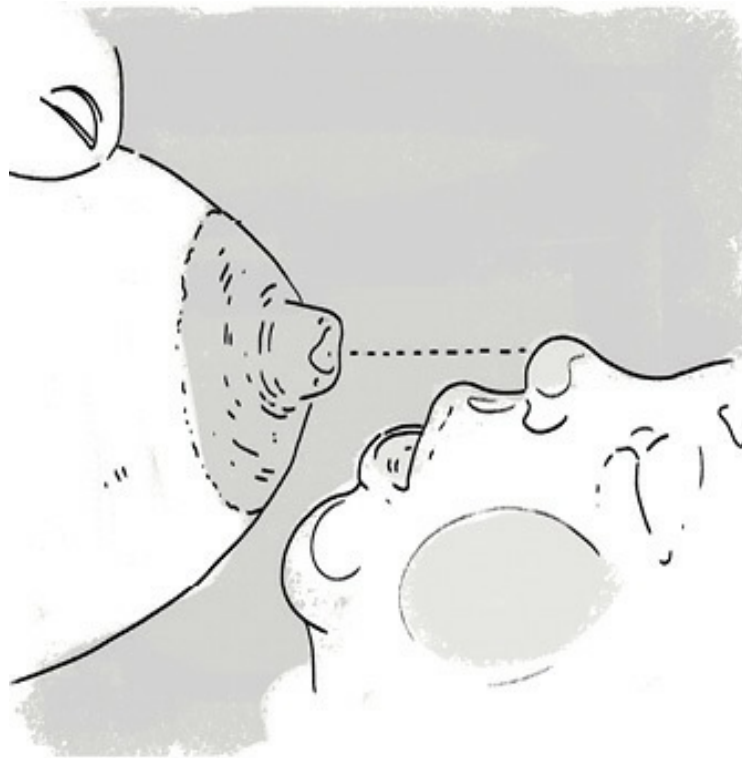
Ya hace varias generaciones (desde nuestras abuelas, aproximadamente) que el paternalismo médico se ha apropiado de nuestras tradiciones y decisiones, y nos ha querido indicar en qué posición tener a nuestros hijos, a qué hora, cuántos minutos darle de cada pecho, cómo tenemos que sentir nuestros pechos... y puedo seguir.

Se ha visto en gorilas criadas en cautiverio que no saben qué hacer cuando nace su cría. Como nunca vieron a otra hembra amamantar, desconocen cómo alimentarlas. En un zoológico de Ohio, tuvieron que pedirle ayuda a La Liga de La Leche: concurren mujeres a dar la teta delante de la gorila, la ayudaron a posicionar al bebé gorilita y de esa manera pudo alimentarlo.

El empoderamiento de las mujeres en los últimos tiempos lleva a recuperar esos saberes y esas tradiciones, y a volver a estrechar lazos en tribu. Es por eso que surgen las figuras de la doula y de la puericultora, aún sin regulación estatal como profesiones.

La lactancia no debe doler. A veces, en los primeros meses, hay una sensación de hormigueo o pinchazos al iniciar la mamada, que se cree que es por el llenado de los conductillos que van al pezón. **Pero dolor, DOLOR, no debe haber. Si lo hay, es porque la prendida del bebé a la teta se puede mejorar.**

El bebé no succiona el pezón: mete parte del tejido de la areola dentro de su boca además del mismo. Si succionara solo el pezón, no estimularía la teta con su rostro y boca (¡sí, los movimientos de su carita también estimulan la producción de leche!) y lastimaría los pezones. Es por eso que insistimos en la “boquita de pescado”: los labios del bebé evertidos (como si los diéramos vuelta suavemente hacia arriba y hacia abajo respectivamente, dejando ver la parte rosada) y parte de la areola dentro de la boca.



La prendida es asimétrica: el mentón toca primero el pecho, antes que la boca, y cuando la abre completamente, es el momento de introducir el complejo areola-pezones en la boquita. Hay maniobras de “achicamiento” de la teta que nos ayudan a lograr esta prendida asimétrica. Además, no todos los bebés abren la boca completamente desde el inicio, y tienden a tomar solo el pezón: ¡aquí viene la ayuda de la experta en lactancia! Que nos puede dar pautas y técnicas para evitar lastimarnos.

Cuando el bebé está mamando en forma efectiva, se escucha cómo traga. Hace pausas mientras su boca se llena de leche y masajea la teta con su lengua para “exprimirla”. No te preocupes: esto no se siente. De hecho, si la prendida es saludable, solo se sentirá una suave succión. Si duele, reitero, hay que evaluar la posición.

Existen múltiples posiciones para dar la teta. Depende de la diada mamá y bebé (o bebés), probar y decidir. Los “almohadones de lactancia” pueden ayudar a evitar contracturas y lograr una posición más cómoda.



Posición acostada.



Posición pelota de rugby.



Posición biológica.



Posición cuna.

¿Es necesaria la mamadera? Confusión tetina-pezón

No. **La mamadera no es un elemento necesario. ¿Es útil? Sí, pero no imprescindible.** Veamos: para tomar el pecho, el bebé coloca la lengua por debajo del complejo areola-pezón, usando algo que se denomina “reflejo de extrusión”. La lengua empuja el tejido de la teta hacia atrás, succionando la leche.

En cambio, en la mamadera, la leche sale sola, por lo que la lengua empuja hacia adelante. Esto haría que la mamadera se salga de la boca, pero para evitar esto, todas las mamaderas tienen una parte ancha en la punta y angosta justo después, para poder cerrar la boca atrás de la parte angosta y que no se salga.

Como el movimiento es distinto, para algunos bebés puede ser difícil alternar entre la mamadera y la teta. Otros nunca aceptan la mamadera, pero en la mayoría de los casos, lo que sucede es que los bebés sí terminan prefiriéndola y evitando la teta. **Por eso, antes de darle una mamadera a un recién nacido, deberíamos agotar otras posibilidades, si la mamá está de acuerdo.** Evitaríamos, seguramente, muchas lactancias coartadas.

Grietas, relactadores, pezoneras

Las **grietas** son heridas en la zona del pezón-areola producidas durante la lactancia, generalmente consecuencia de una prendida que se puede mejorar. No tienen que ver con “no haber preparado los pezones” ni con el tipo de piel de la mamá. Una vez que se produjeron las grietas, **la única manera de que no se vuelvan a repetir y de que cese el dolor es logrando que el bebé posicione su boca y su cuerpo de tal forma que la succión sea efectiva e indolora.**

Múltiples tratamientos se han propuesto para las grietas, como siempre, buscando soluciones un tanto mágicas. No hay ninguna pastilla (aunque se puede tomar algún analgésico) ni crema 100 % resolutive. Algunas mamás usan crema de caléndula o cremas realizadas con componentes de su placenta, pero no es la indicación formal. Lo que se sugiere es la sigla **ALAS**:

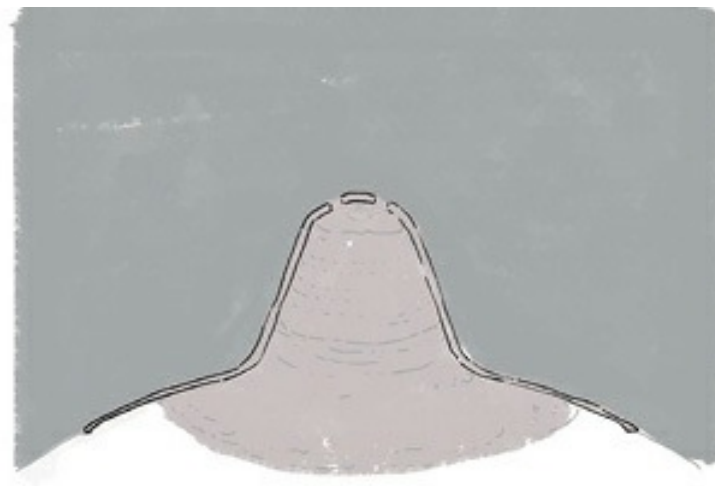
AIRE: dejar los pezones al aire el mayor tiempo posible.

LECHE: colocar la propia leche como bálsamo.

AGUA: lavar solamente con agua cuando toque bañarse, sin necesidad de lavar entre mamadas. Los jabones pueden irritar la piel y quitarle la capa grasa tan necesaria para que el bebé reconozca el olor a la mamá y para que se regenere la piel.

SOL: ídem punto “aire”.

Para “soltar” al bebé de la teta no hay que tironear del pezón, eso nos puede lastimar. Hay que romper el vacío que hace el bebé entre su boca y la teta; introduciendo un dedo en la comisura de su boquita sentiremos cómo se “suelta” y de esa manera evitaremos daños.



La **pezonera** es un elemento de silicona que se coloca por encima del pezón. ¿Para

qué? En los mejores casos, para solucionar alguna disfunción oral de los bebés. Hay bebés que por haber sufrido intervenciones tempranamente, muchas veces muy necesarias (respiradores, sondas), no logran un acople efectivo, y **la pezonera puede ayudar. Pero no es para TODO.** De hecho, las grietas no son una indicación de uso de pezoneras. La única manera de curar las grietas y que no se vuelvan a producir es mejorar la prendida.

Actualmente hay una sobreindicación de pezoneras, e incluso se le sugiere a las mamás que las lleven en el bolso para ir al hospital. Las pezoneras vienen por talles, para bebés de término se priorizan talles más grandes (que no suelen ser los que se venden popularmente). Además, no es solo ponerlas por encima del pezón: el complejo pezón-areola tiene que quedar contenido en las mismas, adentro del “conito”. Es decir: **tienen indicaciones y técnicas, y su uso debe ser sugerido por una profesional de la lactancia materna.** ¿Qué pasa si usamos pezoneras y no son de nuestro talle, o están mal puestas? Puede haber menor succión efectiva y menor producción de leche.

Los **relactadores** son dispositivos, generalmente caseros en nuestro país, que colaboran en el mantenimiento, la relactación y la inducción de la lactancia. Suelen estar constituidos por un recipiente (en general, una mamadera) y una sonda muy fina.



Si tenemos que suplementar a un bebé con más leche de la que produce su mamá (en el caso de alguna condición como el hipotiroidismo materno no tratado) o en niños que necesitamos que recuperen peso rápidamente (por ejemplo, previo a cirugías),

podemos, antes que usar una mamadera, usar un relactador. En el recipiente se coloca la leche que se va suplementar. Un extremo de la sonda va adentro de esa leche y otro se coloca en la comisura de la boca del bebé una vez que está prendido al pecho. De esta manera, ingresa más volumen. Si es posible, lo ideal sería, en un primer momento, complementar con leche materna, pero si tenemos que indicar fórmula, esta es una muy buena opción porque no se pierde el estímulo al pecho.

“No comas brócoli que le da gases al bebé”

“Lo que yo como, ¿afecta al bebé si le doy la teta? Si tomo gaseosa, ¿le da más gases? ¿Puedo consumir mate, naranja, chocolate, repollo, remolacha...?”. Y la lista de preguntas continúa.

La respuesta a esto es: se puede comer de todo, y ninguna de estas sustancias le genera al bebé gases o cólicos directamente. El gas de la gaseosa no pasa a leche, y los gases que producen algunas legumbres y vegetales en el intestino de la mamá tampoco pasan a la leche ni le generan gases al bebé.

Durante la lactancia se puede consumir cualquier alimento, excepto alcohol (sí, sabemos que hay tablas y cosas por el estilo con respecto al alcohol, pero ningún profesional de la salud puede sugerir una sustancia que puede poner en riesgo tanto a la mamá como al bebé).

¿Por qué los bebés tienen tantos gases? Porque tienen un intestino en continua maduración, y por eso, a veces, les resulta “raro” lo que les ocurre y les genera llanto e incertidumbre. Pero eso no quiere decir que tengan más o menos gases que el resto de la humanidad, simplemente, están aprendiendo a percibirlos y a manejarlos.

¿Pasa el sabor de algunos alimentos? ¡Sí!, e inclusive algunos colores (por ejemplo, leche verdosa por haber consumido muchas hojas verdes). Esto generalmente es BUENO, **porque mientras más variado haya comido la mamá, más sabores “probó” el bebé a través de la teta y más aceptación tiene de los mismos cuando inicia la alimentación complementaria.** Se cree que los sabores inclusive... ¡llegan al líquido amniótico!

Entonces... ¿rienda libre a cualquier alimento? ¡Momento! **Mientras más saludable se alimente la mamá y mientras menos ultraprocesados consuma (gaseosas y jugos, por ejemplo), más sana será su microbiota intestinal.** ¿Y adivinen cómo forma el bebé su propia microbiota? ¡Sí! Entre otros factores, a través de la leche materna pasan bacterias “buenas” y alimento para dichas bacterias (los famosos probióticos y prebióticos), que colonizan el intestino del bebé haciéndolo más sano, y reduciendo los gases y los cólicos.

La leche materna siempre será nutritiva y siempre será lo mejor para ese bebé,

incluso si su mamá está desnutrida, como suele suceder en las grandes catástrofes. Sin embargo, se vio que **una alimentación saludable, basada en alimentos, no en productos industrializados, mejora los niveles de nutrientes en la leche materna.** Un ejemplo importante es el de la vitamina D: si los niveles de vitamina D de la mamá están bajos, estarán bajos en la leche materna.

Es decir, una buena alimentación desde el embarazo mejorará la calidad de vida y la salud tanto de la mamá como del bebé. La llegada de un nuevo integrante a la familia siempre es una excelente forma de empezar a pensar en cambios positivos en nuestra manera de alimentarnos.

“¿Qué puedo consumir para tener más leche?”

Mucho se dice acerca de “cosas” para tener más leche: levadura de cerveza, atoles, diversas infusiones, cerveza propiamente dicha... **La realidad es que no existe NINGUNA comida o bebida que nos haga generar más leche. Lo único que genera más leche es MÁS SUCCIÓN: a más succión, más producción, así de simple.** Es por eso que hay gemelos que crecen con lactancia materna exclusiva sin problemas: el pecho de su mamá está estimulado doblemente.

Existen algunos medicamentos como la metoclopramida (Reliverán®) o la domperidona, que en conjunto con mucha estimulación, pueden ayudar en situaciones especiales (por ejemplo, mamás adoptivas que desean amamantar o bebés en Neo). Solos, sin el estímulo, no hacen nada. TIENEN QUE SER INDICADOS POR UN/A MÉDICO/A. ¡Si son mal tomados, pueden tener efectos adversos serios! También es bueno tener cuidado con las infusiones (anís estrellado, hinojo, etc.) que nos sugieren: algunas pasan a leche materna y son tóxicas. La manera de asegurarnos es buscarlas en www.e-lactancia.org

La única manera de mantener la producción, cuando volvemos a trabajar, por ejemplo, es que no pase mucho tiempo sin sacarnos leche. Si la teta está llena mucho tiempo, interpreta que el bebé toma menos y no tiene que producir tanto.

“¿Puedo tomar mate durante el embarazo y la lactancia?”

El mate es más que una bebida tradicional. Es compañía, es un lugar conocido, es un pedacito del hogar que llevamos por el mundo. Una pregunta muy común es si **en el embarazo y la lactancia se puede tomar mate (o café, o té). La respuesta es SÍ, se puede.**

La yerba mate contiene xantinas, al igual que el café o el té, que son estimulantes

del sistema nervioso central. Por esa razón, se sugiere un consumo moderado (¡no te tomes tres pavas!). Una persona promedio consume de 100 a 200 mg de cafeína al día a través del mate, siendo 300 mg el tope que se recomienda (es decir, ¡estamos bien!).

No le provoca cólicos al bebé ni cambia la calidad nutricional de la leche. No le da acidez, ni tampoco aumenta la cantidad de leche. Se puede consumir en el embarazo también (si lo tolerás, ¡durante el primer embarazo yo no pude acercarme a un mate por la acidez y durante el segundo tomé todo el tiempo!).

Como toda xantina, disminuye la absorción del hierro, así que se recomienda ingerirlo lejos de las comidas. Los chicos pueden “probar” cada tanto, pero no les aporta nutrientes, es una cuestión cultural.

La cantidad aproximada de cafeína en diferentes infusiones es:

– Café de filtro (150 ml)	60-180 mg de cafeína.
– Café instantáneo (150 ml)	30-120 mg de cafeína.
– Café descafeinado (150 ml)	2-5 mg de cafeína.
– Té (150 ml)	20-90 mg de cafeína.
– Yerba mate (50 g)	300 mg de cafeína.
– Chocolate (barra de 40 g)	2-23 mg de cafeína.
– Cacao en polvo (10 g)	0,05 mg de cafeína.
– Leche chocolatada (vaso de 220 g)	2-7 mg de cafeína.
– Bebidas cola (vaso de 200 ml)	16 mg de cafeína.

Brotes de crecimiento

Expertos en la teta: “crisis de lactancia”

Las redes sociales tienen una parte maravillosa: el poder reunirnos desde todos los confines del mundo para compartir experiencias. También nos llevan a aprender cosas nuevas y a darnos tranquilidad sobre nuestra intuición acerca de otras.

Sin embargo, una cuestión que me preocupa un poco es el tema de las “crisis” de los bebés, que podemos encontrar por doquier en las redes sociales. Leo mucho acerca de que cada cosa que le pasa a un bebé, es una “crisis”. La “crisis de los 15 días”, la “crisis de los 3 meses”, la “crisis de sueño de los 4 meses”, la “crisis de los 8 meses”... Y así, vivimos en un universo de tragedia.

Los bebés tienen un desarrollo fascinante día a día. Viven en un mundo que no podemos comprender pero que seguramente sea algo lisérgico, lleno de sensaciones nuevas. Es claro que todo eso puede ser divertido pero también es agotador. Aprender

a reaccionar y procesar todos esos estímulos debe ser muy difícil.

Es por eso que no me gusta hablar de crisis de lactancia, sino de “momentos en los que el bebé le exige más a la teta, y por eso toma más seguido y se pelea con ella” (¡qué largo, Sabrina!), resumido como “brotes de crecimiento”.

Entonces, para aclarar un poco la idea: habrá momentos en los que el bebé va a tomar como un recién nacido. Es clave lo que suele ocurrir a los 3 meses, cuando se regula el mecanismo de producción de leche y tarda un poquito más en salir, generando muchas veces enojo y pataleo en los bebitos. Existirán también otros momentos, que considero que varían muchísimo de bebé a bebé, y tienen que ver también con cómo se lo toma su entorno.

Un bebé peleando con la teta puede ser interpretado como que la rechaza, o que no le gusta la leche, o que se queda con hambre y por eso toma más veces. Nada de esto es cierto. **Simplemente le está “diciendo” a la teta que necesita más leche, y la teta le está respondiendo: más succión, más producción.** Si ante ese reclamo bebé-teta introducimos una mamadera de fórmula por miedo a que se quede con hambre, habrá menos producción realmente, porque habrá menos succión.

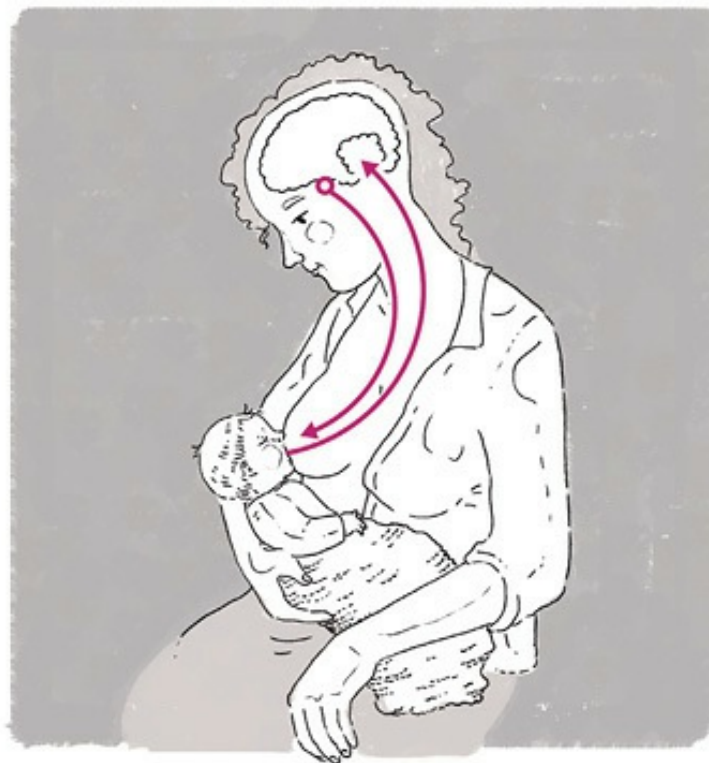
Los brotes de crecimiento duran alrededor de 1 semana a 10 días, aunque esto es generalizar, e incluso, hay díadas mamá-bebé que no los notan.

Tetas blandas: las que más producen

“Tengo los pechos blandos... ¿me estoy quedando sin leche?”. Si tuvieras la heladera hasta reventar... ¿cocinarías más comida? Probablemente no. Eso es lo que le pasaría al cuerpo si la teta estuviera siempre “llena”, como un almacén. Interpretaría que no tiene que producir más y, efectivamente, no lo haría.

Eso es lo que pasa cuando no nos podemos sacar leche durante muchas horas (por ejemplo, en el trabajo); el cuerpo dice: “Nadie toma, está lleno... me guardo la energía y no produzco más”. Lo hace a través de una proteína que se llama **“factor inhibidor de la lactancia” (FIL) que contiene la leche. Si la leche queda en el pecho sin ser extraída durante horas, ese factor empieza a funcionar y se inhibe la producción.**

Durante los primeros meses, suele acumularse leche en la teta, a veces incluso hasta desbordar. **Alrededor del tercer mes, la producción se regula** y ahí es cuando las mamás sienten los pechos “blandos”. Esto coincide con el brote de crecimiento de los 3 meses del bebé, donde, precisamente por este nuevo mecanismo de regulación (la leche no se guarda, sino que se produce mientras toma), se “enoja” con la teta, toma, suelta, llora, vuelve a tomar, toma sin parar muchas horas, pide cada 5 minutos...



Teta blanda + bebé enojado pueden confundir a mamás y (lamentablemente) a profesionales de la salud, planteando que hay “poca leche” y agregando fórmula. Si agregamos fórmula, el bebé toma menos, la teta produce menos y, efectivamente, a la larga habrá menos producción, por una intervención innecesaria.

¿Cómo pasar los brotes de crecimiento?

- ¡Empoderarse! La leche es perfecta, los cuerpos saben qué hacer, y LAS TETAS BLANDAS SON TETAS QUE PRODUCEN MUCHA LECHE (¡lo pongo en mayúsculas, imagínenme gritándolo!).
- Upa, mimos y paciencia. El porteo puede ayudar.
- Tribu, red de sostén. Gente que se ocupe de la casa, amigos que saquen a pasear a los hermanitos mayores, compañeras/os que hagan mate a la madrugada.
- Profesionales con conocimiento en lactancia que nos acompañen.
- Saber que hoy no es siempre, y que esto, como todo, también pasará.

La leche de fórmula

A quien corresponda:

Te pido disculpas, mamá (ni siquiera recuerdo tu nombre) de esa bebé pequeña, alimentada con tu pecho, que no aumentaba lo que yo quería de peso. Te pido disculpas porque te dije que tu leche era muy buena, sí, sí, pero que le íbamos a dar una ayudita con fórmula, para hacerla crecer más rápido. Te pido disculpas porque a la semana siguiente le aumenté la cantidad de leche cuando vos me dijiste que te parecía que se quedaba con hambre. Te pido disculpas porque yo no sabía, y solamente quería que tu bebé creciera como me habían enseñado que crecía un bebé sano.

Te pido disculpas, mamá de ese bebé de 15 meses, por haberte dicho que tu leche ya no lo nutría, que no comía lo suficiente porque tomaba teta, y que usaba la teta de chupete.

Te pido disculpas, mamá de ese bebé recién nacido que no paraba de llorar en la habitación a las 3 de la mañana, al que, en mi obnubilación de 30 horas de guardia, le indiqué fórmula para acallar necesidades que yo no sabía interpretar.

Te pido disculpas, mamá de esa bebé que aumentaba “demasiado” de peso, entonces se te sugirió “espaciar” las tomas, lo que te generó mastitis, entonces te sugerimos destetar...

Les pido disculpas porque yo, en ese momento, creí saber de lactancia. “La teta es lo mejor”, repetimos los médicos como un mantra, y luego hacemos unos cálculos alquímicos cuya conclusión casi siempre termina en una lata comprada con polvo blanco.

Así nos han formado en la universidad y los postgrados. Puedo nombrar proteínas microscópicas que causan enfermedades rarísimas en niños, puedo recitar sus métodos de diagnóstico y sus tratamientos. Puedo leer libros contundentes en unas horas, recitarlos y hacer como que los entendí. Puedo mencionar cuántas calorías tiene la leche de fórmula por mililitro. Sé llenar historias clínicas a la hora en que todos brindan en Año Nuevo.

Pero poco y nada, mientras me formé, supe sobre lo que necesita un bebé.

Por eso, aprovecho este espacio, pido disculpas y prometo trabajar para que no vuelva a suceder.

Antiguamente, en el mundo occidental, cuando una madre no podía amamantar por enfermedades, muerte (recordemos que la mortalidad puerperal era enorme), estatus social (era “mal visto” que las mujeres ricas o nobles amamantaran) u otras razones, los bebés eran alimentados por otras mujeres llamadas “nodrizas”.

El “nodrizaje” probablemente sea en realidad el empleo más antiguo del mundo.

¿Cuántas horas trabajaba una nodriza por día? Las horas en las que un bebé necesitaba ser amamantado, es decir... 24 horas. Esto generaba que realmente muy pocas familias pudieran permitirse económicamente la presencia de estas mujeres. Y aún así, la mortalidad de los niños alimentados por nodrizas era muy alta debido a las condiciones de higiene y salud, sin contar a los propios bebés amamantados de estas nodrizas que eran descuidados muchas veces.

Es por eso que se comenzaron a buscar alternativas: la leche de animales parecía ser la solución. Pero en esas épocas no se conocía la pasteurización, y la mayor parte de los niños alimentados con esas leches no sobrevivían. En el hospicio de Rouen, Francia, en el siglo XVIII, la sobrevida de los lactantes con alimentación artificial era de solo un 4 %, y en los hospicios de Nueva York, la mortalidad era cercana al 100 %.

Irrumpió así en la historia la Revolución Industrial: las familias se mudaron del campo a las grandes ciudades para trabajar en las fábricas. Vivían hacinados, apretados, con poco descanso y poco aire libre, respirando el aire contaminado por las empresas. Las enfermedades se diseminaban y el agua era de dudosa potabilidad. Todos trabajaban en las fábricas: hombres, niños y niñas, mujeres recién paridas. No existían licencias por maternidad ni por enfermedad. Y los bebés no tenían a su mamá para tomar la teta todo el día: eran cuidados por alguien que no podía trabajar en las fábricas, posiblemente alguna persona enferma o sus hermanos menores.

¿Cómo sobrevivían esos bebés? Se les daba leche de animales en mamaderas rudimentarias, algunas de las cuales tenían tetinas hechas con vejigas de animales. No se sabía aún de esterilización ni de higiene de estos elementos, y la mayoría de esos niños moría. Se necesitaba algo nuevo, algo que “reemplace” a la madre para que pueda continuar trabajando. Para que no se pierdan días de producción, y para que el bebé sea menos “dependiente”.

Y apareció un señor llamado Henri Nestlé, quien utilizando algunas investigaciones que había hecho otro señor llamado Justus von Liebig, junto con técnicas de pasteurización, mezcló harina, azúcar y agua, y creó algo llamado “harina láctea”: la primera leche de fórmula que se comercializa en forma masiva. ¿Y los bebés sobrevivieron? Algunos sí, lo cual ya era una diferencia abismal con relación a los métodos anteriores.

Como podemos ver, **el surgimiento de la leche de fórmula no ocurre para ayudar a los bebés prematuros a sobrevivir o porque las mujeres no tenían leche: surge como una necesidad del mercado de separar a los bebés de sus madres para que ellas pudieran trabajar más.**

Pero Nestlé no solo creó la leche de fórmula, sino algo mucho más poderoso: el *marketing* en el consultorio, mediante los visitantes médicos. Y ahí comenzó algo tremendo: se convenció a los médicos de que la leche de fórmula y la “maternidad científica” era mucho mejor que la lactancia. Los pediatras se empezaron a inmiscuir en la alimentación de los bebés, antes plácidamente amamantados, y empezaron a indicar horarios, tiempos y mililitros, convencidos (y convenciendo) de que los cuerpos de las mujeres no producían el alimento necesario para sus bebés.

Esto perdura hasta nuestros días: los congresos médicos pediátricos están auspiciados por empresas de leches de fórmula que regalan lapiceras y muñecos de dinosaurios en coloridos *stands*...

El ser humano es el único animal que cambió su forma de alimentación natural por leche modificada de una especie distinta. Hoy por hoy sabemos mucho más acerca de la composición y los beneficios de la lactancia materna. También estamos más atentos a los despliegues del mercado y a la publicidad alrededor de nosotros.

Estamos preocupados por las consecuencias de este cambio experimental: observamos cifras estrambóticas de alergias alimentarias, enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, hipertensión, cáncer), obesidad infantil y más. Entonces, de alguna manera, **tenemos que empezar a hablar de los riesgos que genera la alimentación con fórmula cuando no tiene indicación.**

También conocemos otros beneficios de la lactancia materna:

- Las madres que dan pecho tienen menos hemorragias posparto, menos cáncer de mama y ovario, y es un factor protector para la osteoporosis.
- Los lactantes que toman pecho tienen menor tendencia a la obesidad, menos infecciones agudas (otitis, diarreas, infecciones urinarias, infecciones respiratorias, etc.) y menos enfermedades crónicas (diabetes, alergias, enfermedades intestinales crónicas, algunos tipos de cáncer en la infancia...).
- Económicamente es beneficiosa tanto a nivel familiar como social: los niños amamantados se enfermarán menos y generarán menor gasto en salud a corto y largo plazo.

Cualquiera sea la “cantidad” de leche materna que un niño reciba en su vida, ya sea un día o tres años, es beneficiosa. Siempre.

¿Incorporar fórmula?

CUANDO LA TETA NO ES UNA OPCIÓN

Porque la mamá no lo elige.

Por enfermedad del bebé.

Por enfermedad de la mamá.

Por dificultades en la dinámica y organización familiar.

Por problemas no tratados a tiempo y desinformación.

Por falta de apoyo.

Porque no hay mamá, ni donantes de leche.

Los motivos médicos para abandonar la lactancia son realmente pocos,

pero nuestra vida no está solo explicada desde la medicina, nos pasan cosas, tenemos complicaciones y no siempre amamantar es una posibilidad. Quizás lo fue anteriormente y ya no lo es por diversos motivos, quizás nunca lo fue. En cualquier caso, maternar es mucho más que dar la teta.

Cuando toma mamadera, el bebé también necesita:

Miradas: el bebé se nutre de miradas. El contacto visual durante la alimentación le da continuidad al niño, que “se mira” en los ojos de quien lo alimenta.

Contacto piel con piel: al dar la mamadera, el contacto piel con piel fortalece el vínculo con el bebé y el apego seguro. Estar cerquita, en contacto, y mirarse a los ojos, favorece la producción de oxitocina, la hormona del amor.

Libre demanda: alimentar a libre demanda significa no regirse por horarios preestablecidos, sino por el ritmo del bebé. Significa ofrecer la mamadera si tiene hambre, aunque haya tomado hace “menos de 2 h”.

El momento de la alimentación es de contacto y amor, ¡ojalá siempre podamos disfrutarlo!

Clara Baffa (doula y musicoterapeuta)

Ya sea por elección personal, vuelta al trabajo, enfermedades u otras razones, la leche de fórmula es utilizada como complemento de la alimentación infantil.

Hace años, la industria nos bombardea con *marketing* oficial y no oficial, gran parte del mismo sostenido por profesionales que violan el Código de Sucedáneos, diciéndonos que la leche de fórmula es “mejor o igual” que la materna.

El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna fue adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en 1981. Es un documento que desarrolla estrategias que buscan proteger a todas las madres y a sus bebés de las prácticas inapropiadas de comercialización. Prohíbe toda promoción de los sucedáneos de la leche materna (fórmula), mamaderas y tetinas, y busca asegurar que las madres reciban información adecuada por parte del personal de salud. Un sucedáneo de la leche materna es todo alimento comercializado o presentado como sustitutivo parcial o total de la leche materna, sea o no adecuado para ese fin.

El Código de Sucedáneos, entre otras cosas, deja muy claro que los

profesionales de la salud NO DEBEMOS entregar muestras, usar folletería o participar en campañas de difusión de leches de fórmula, y que somos responsables de la promoción y protección de la lactancia materna. Como todos sabemos, esto no sucede: hay más de un colega en los medios y en diversas campañas que promocionan fórmula y productos de esa índole. También hay leche de fórmula dentro de los *kits* de bienvenida de algunas obras sociales. Estas son claras violaciones al código.

La leche de fórmula es leche de vaca modificada de tal manera que el organismo de un bebé menor de 1 año puede tolerarla. Entonces, en niños no amamantados o con lactancia mixta, la primera elección es leche de fórmula (que varía según la edad, de 0 a 6 meses y de 6 meses a 1 año) **y no se sugiere la leche de vaca hasta cumplido el año de vida.**

Esta leche está diseñada de tal manera que las proporciones de sodio, potasio, fósforo, calcio y otros minerales se parecen a las de la leche materna, y no causan daño por carencia o exceso según la edad.

Es por esto que **DEBEN PREPARARSE COMO INDICA EL ENVASE.** No rebajarlas, no agregarles “leches vegetales” ni otras infusiones. Esto causaría un desequilibrio de los electrolitos (sodio, potasio...), que podría generar daños en el bebé (hipernatremia, diarrea, deshidratación, etc.).

El agua para prepararlas debe ser potable. Si dudamos del agua de la canilla, podemos hervirla y dejarla enfriar o potabilizarla con unas gotas de lavandina (ver en el envase de la lavandina que sea apta para el consumo humano y cuántas gotas sugiere por litro, suelen ser entre 3 y 5). Si es segura, podemos usar el agua que consumimos habitualmente.

¿En polvo o líquida?

En su composición, la leche de fórmula líquida y la que viene en polvo son iguales, si esta última está bien reconstituida. **La única diferencia es que no podemos asegurar que la lata de leche en polvo no se contamine con bacterias patógenas.** Durante la fabricación, la leche de fórmula en polvo puede contaminarse con bacterias nocivas como la *Enterobacter sakazakii* y la *Salmonella enterica*.

Si utilizamos leche de fórmula en polvo, ¿cómo evitar riesgos?

Para reconstituir la leche de fórmula, se sugiere hervir agua, luego dejarla enfriar unos 30 segundos y en ese momento echar el polvo como indique la caja. El agua caliente a

más de 70° inactiva las bacterias que mencioné anteriormente. Luego, se deja enfriar hasta la temperatura que suele preferir el bebé (se puede poner la mamadera cerrada bajo el chorro de agua fría de la canilla).

Lo ideal es prepararlas en el momento que se van a utilizar, aunque se puede guardar y transportar fórmula reconstituida previamente. Nunca se sugiere calentar ni leche materna ni leche de fórmula en el microondas: se calienta en forma despareja, algunas zonas se calientan mucho y otras quedan frías, y eso puede quemar al bebé.

La lata abierta dura lo que dice el envase. Pasado ese tiempo, el proveedor no puede garantizar que sea inocua.

¿Qué mamadera? ¿La esterilizo?

Todas las mamaderas son más o menos iguales. Elijan la que prefieran como familia. No gasten fortunas: la mejor no es la más cara. Y hay bebés que nunca aceptan mamadera, aunque venga el mismísimo Roberto Mamadera y les traiga mil dólares en plástico.

Con respecto a esterilizar tetinas, mamaderas y chupetes, se sugiere realizarlo hasta los 3 meses. Después, si desean seguir haciéndolo, es también según la preferencia familiar.

¿Cómo ofrecer?

Lo ideal es que la leche de fórmula se ofrezca a demanda del bebé. Sin embargo, al digerirse más lentamente, es bastante común la sugerencia inicial de “cada 3 horas”. Es importante tener en cuenta que esto varía de bebé a bebé. No siempre van a querer tomar lo mismo, depende de su hambre, de su sed, de lo que desee ese día. Validar la autorregulación de los bebés es muy importante.

La fórmula debe ser indicada por el pediatra, en la dosis adecuada, y modificarla si es preciso en los próximos controles con relación al crecimiento y desarrollo.

Estamos acostumbrados a que la fórmula “caiga” en la boca del bebé, y que este simplemente la trague. **La leche en biberón se puede dar de maneras más fisiológicas**, con la mamadera más horizontal y el niño más sentado, para que tenga que traer hacia sí la leche. Esto, sumado a la observación atenta de la toma y al contacto afectivo, apunta a hacer de la lactancia mixta o con fórmula un momento de placer y de autorregulación de la cantidad de leche que el bebé toma. Sugiero buscar

información sobre el método Kassing, que mencioné en apartados anteriores.

Leches de fórmula después del año de vida

Es importante aclarar la diferencia entre las leches de fórmula hasta el año de vida y las de “seguimiento” (leches 3-4). Acerca de estas últimas, veremos en el capítulo de “La alimentación complementaria” que **son absolutamente innecesarias, ya que se componen de leche de vaca común con alto contenido de azúcar**. Son diferentes a las leches de fórmula hasta el año.

La fórmula se puede administrar con vasito, mamadera, cuchara, relactador... hay muchas opciones. Lo más importante es no perder el vínculo, el disfrute, las miradas y el respeto hacia el bebé.

Los que trabajamos y promovemos la lactancia materna lejos estamos de tratar de producir culpas, miedos o angustias, o de demonizar las leches de fórmula. Buscamos que las familias tengan toda la información y las herramientas posibles, y así, poder elegir libremente.

¿Qué pasa con la leche de vaca? ¿Se puede ofrecer antes del año de vida?

La leche de vaca fue históricamente utilizada como “complemento” o “reemplazo” de la leche materna. De hecho, la leche de fórmula es leche de vaca modificada. ¿Qué diferencia hay entonces entre la leche de fórmula y la leche de vaca?

La leche de fórmula está modificada para hacerla tolerable para el organismo de un bebé. Se toma la leche de vaca, se le cambia la relación entre sus proteínas y el contenido de electrolitos, y se le adicionan ciertos minerales y otros compuestos (por ejemplo, hierro y vitaminas). De esta manera, el intestino y los riñones de los lactantes pueden absorber y filtrar sus nutrientes, y los tejidos aprovecharlos. Esto se realiza porque **la leche de vaca, pura, sin diluir, aunque esté pasteurizada y libre de peligro biológico, no es apta para el consumo de un bebé menor de 1 año.**

¿QUÉ SIGNIFICA HIDROELECTROLÍTICO?

En el cuerpo hay una gran cantidad de agua que se encuentra dentro de las células y también entremedio de las mismas. En ambos espacios también encontramos los llamados electrolitos (sodio, potasio, cloro, calcio...), que se mantienen en concentraciones muy específicas,

regulados por los distintos órganos. Es por eso que hablamos de “equilibrio hidro (por el agua) electrolítico”. Pequeñas variaciones pueden causar grandes problemas en los niños. Por ejemplo, cuando pierden mucho líquido por el calor o la diarrea, se altera ese equilibrio y debemos actuar.

- La concentración de proteínas en la leche de vaca es mucho mayor que en la leche materna, lo que genera sobrecarga de los riñones aún inmaduros.
- La presencia de cloro, potasio y sodio es tres veces mayor en la leche de vaca que en la materna, lo cual puede generar trastornos hidroelectrolíticos.
- La leche de vaca contiene hierro en mayor proporción que la materna, pero en una forma que es mucho menos absorbible. La leche materna, además, tiene una proteína llamada “lactoferrina”, que hace que el hierro se absorba más eficientemente.
- Asimismo, la leche de vaca produce microhemorragias intestinales que también propician la anemia.
- La relación entre las proteínas caseína/seroproteína en la leche humana es de 40/60, y en la leche de vaca de 82/12. Como podemos observar, esta relación es prácticamente inversa y de difícil digestión.
- La lactosa es el principal carbohidrato presente en la leche materna y se sintetiza en la glándula mamaria a partir de glucosa. Aporta, junto con la grasa, la energía necesaria para el normal crecimiento y desarrollo del bebé, favorece la implantación de una flora intestinal adecuada y promueve la absorción del calcio. La leche de vaca cuenta con un menor contenido de lactosa que la humana.
- La leche materna es rica en ácidos grasos poliinsaturados, que contribuyen al desarrollo cerebral. La leche de vaca carece de los mismos.
- La leche humana normalmente es rica en vitamina C y su concentración media es mayor que la de vaca.

Y los postrecitos, yogures, quesos... ¿no se pueden ofrecer antes del año? Si bien al cocinar la leche de vaca cambia su conformación, no se recomiendan. Siempre es mejor usar leche materna o de fórmula para realizar preparaciones para los bebés. El yogur es un alimento muy popular en menores de 1 año, lamentablemente. Además de contar con diversos conservantes, endulzantes y colorantes, y de ser muchas veces

dudosa la conservación de la cadena de frío, la sobrecarga proteica que tienen los yogures es innecesaria para el riñón del lactante.

¿Se puede usar la leche de vaca si mi bebé no es amamantado y no consigo o no puedo comprar leche de fórmula? Se puede bajo ciertas condiciones. Es necesario diluirla en concentraciones adecuadas para la edad del bebé. Eso tiene que ser indicado por el pediatra (¡¡¡importante!!!), y es la última opción entre las leches.



Lactancia y vuelta al trabajo

La responsabilidad social

¿Comerías en un baño público? ¿Te harías la ensalada en la bache donde todos se lavan las manos después de ir al baño? ¿Te tomarías un café con la puerta cerrada, después de que la persona anterior haya dejado aromas humanos varios? Seguro que no, te daría asco. Entonces, **¿por qué nos parece normal que las madres se saquen leche en el baño y que los bebés tengan que consumir esa leche?**

El baño suele ser el lugar más común para la extracción de leche de las mamás trabajadoras. Suciedad, mal olor, gente tocando y tratando de abrir la puerta, falta de condiciones básicas de higiene, empleadores y compañeros “apurando” porque hay que producir y trabajar. Es muy fácil decir que la lactancia materna es lo mejor para un bebé, que debería mantenerse como exclusiva por lo menos 6 meses, y luego lidiar con estas condiciones...

La lactancia es una responsabilidad social. ¿Pensaste si hay lactario en tu trabajo? ¿Pensaste en que esos minutos “perdidos” por tu compañera probablemente repercutirán positivamente en la salud de su bebé, y ella y su entorno tengan que faltar menos veces por enfermedades? Aunque no tengas planificado tener hijos nunca, aunque seas varón, aunque tengas hijos grandes... preocúpate. Exigí un lactario digno. Protegé la salud de esos bebés.

Banco de leche

* **Almacenamiento y conservación de la leche materna**

Existen diversas técnicas de extracción de leche materna para cuando armamos nuestro banco para la vuelta al trabajo, para alguna salida, para nuestro bebé en la Neo, para donar, para cuando nos sacamos en el trabajo... La extracción puede ser manual o con sacaleches, ya sea mecánico o eléctrico. Cada mujer evaluará lo que le es más cómodo y posible.

Pero ¿dónde almacenamos esa leche? **La leche materna se puede almacenar en recipientes de plástico aptos para alimentos, recipientes de vidrio o bolsitas almacenadoras que se venden específicamente para ese fin.** Si es posible elegir, se prefieren los recipientes rígidos, pues las bolsitas, si bien son muy prácticas para almacenar, se pueden dañar durante su transporte (aunque son muy cómodas cuando pasamos mucho tiempo alejadas de nuestros bebés, como por ejemplo, ¡las mamás médicas que hacemos guardias de 24 horas!).

Los recipientes de vidrio pueden ser los de yogur con tapa de plástico, o de café pequeños, también con tapa plástica. Hay muchas marcas que venden recipientes de plástico aptos. Se sugiere evitar las tapas de metal, pues pueden oxidarse o saltarse la pintura.

Los frascos para análisis de orina no están recomendados, ya que están esterilizados de tal manera que pueden resultar tóxicos (con óxido de etileno). Se usan en muchas Neo, pero dichos frasquitos se esterilizan de diferente manera (con vapor de agua) y sí son aptos.

¿Hay que esterilizar siempre los frascos? A menos que el bebé esté internado, no es necesario. Se lavan con agua y detergente, enjuagando cuidadosamente todos los restos del mismo y secando por escurrimiento, sin refregar con telas para evitar pelusas. Si no contamos con jabón, como nos puede pasar en el trabajo, lavar con agua hirviendo también es válido.

¿Cuánto pongo en cada frasquito? **Se recomienda guardar en el freezer de a poco, de entre 60 y 120 ml por frasco.** ¡Es preferible descongelar varios frasquitos a desperdiciar leche!

¿Puedo sumar varias extracciones en un frasco? Sí, siempre que estén a la misma temperatura. Por ejemplo, si me saco 20 ml y los pongo en la heladera, y a las dos horas me saco otros 20 ml, debo dejar que estos últimos tomen la temperatura de los que ya están en la heladera para sumarlos. La leche materna tiene bacterias, tanto de la piel como las que están en la leche. Al enfriar la leche, pausamos la actividad de esas bacterias y evitamos que esa leche se degrade por estar guardada. Es por esto que tenemos que juntar todas las leches a la misma temperatura, para que todas estas bacterias estén “en pausa”.

* **“¡Mi leche tiene sabor/olor feo!”**

La primera vez que descongelé leche, casi me muero. Además de que la parte grasa flotaba, lo cual no la hacía visualmente atractiva, tenía un olor y un sabor extraños, entre jabón y algo echado a perder....

En ese momento, no tenía idea de que eso es totalmente normal y que a la mayoría de los bebés no les molesta (de hecho, mis hijos tomaron siempre esa leche como si nada). La leche materna es TAN GENIAL que no solo tiene los nutrientes necesarios para cada bebé, sino que también lleva las “máquinas” (a las que llamaremos “enzimas”) para que sus intestinos inmaduros puedan procesar esos nutrientes. Es así como la leche de algunas mujeres tiene alto contenido en lipasa, una enzima que ayuda a procesar las grasas.

Todo esto está muy bien cuando va directo a la panza de un bebé, pero **cuando se guarda en un frasco, la lipasa también actúa y genera que esas grasas se degraden con ese característico olor rancio/a jabón.**

Si el bebé acepta esa leche, no hacemos nada. ¡El tema es cuando no le gusta! Tenemos dos opciones:

- **Opción “enfriar”:** una vez que terminamos la extracción, cerramos el frasco, rotulamos y enseguida lo ponemos en un recipiente con hielo unos minutos, hasta que se enfríe. Luego la pasamos rápido al *freezer*. Cuando lo descongelemos, veremos si este método funcionó.
- **Opción “escaldar” (lo que más suele funcionar):** colocamos la leche recién extraída en un recipiente limpio, que en lo posible usaremos solo para esto, y al fuego. Cuando alcance los 60°, si tenemos termómetro de cocina, o cuando aparecen burbujitas a los costados del recipiente, apagamos. Enfriamos en un recipiente con hielo y a congelar.

¿Tiene las mismas propiedades la leche escaldada que la que no sufrió este proceso? No, es cierto que pierde algunas propiedades, pero sigue siendo mucho mejor que la leche de fórmula. ¡No hace falta tirar un *stock* de leche por este olor! Si tu bebé la rechaza en el biberón, se puede usar para cocinar.

* “¿Cuánta leche materna debe tomar un bebé por toma?”

Cuando hablamos de vuelta al trabajo, una de las preguntas con más angustia es: **“¿Cuánta leche me tengo que sacar para dejarle por toma?”. Es importante saber que NO HAY FÓRMULAS matemáticas válidas para definir eso.**

En algunos textos se habla de 30 ml x kg de peso. Un bebé de 3 meses puede pesar 5 kg o puede pesar 9 kg... por lo tanto, oscilaría entre 150 ml y ¡270 ml por toma! Lo cual no tiene sentido y solo provoca angustia en esa mamá que “solamente” saca 20, o 50, o 100 ml en cada extracción en el trabajo.

Hay que charlarlo con el pediatra para evaluar cada bebé individualmente. **NO hay un “mínimo” ni un “máximo” generalizado cuando hablamos de leche MATERNA. Algunos bebés tomarán muy poco en ausencia de su mamá y luego se prenderán a la teta muchas horas. Otros tendrán sed y solicitarán muchas**

tomas “cortitas”. Mientras el bebé se desarrolle normalmente, haga pis como siempre, juegue y aumente de peso, la cantidad de mililitros es algo accesorio. Tenemos que confiar en la capacidad de autorregulación del bebé. ¿Cómo?

- Haciendo que el adulto que ofrece el alimento lo haga de forma pausada, respetando los tiempos del bebé, en diálogo con el mismo.
- Evitar dar la mamadera con el bebé “acostado”. Lo mejor es mantenerlo lo más recto posible, para evitar que la leche “caiga fácil”.
- Utilizando tetinas con “agujeritos” pequeños (la tetina cero o de bajo flujo) para que el bebé tenga que trabajar, igual que con la teta.
- Si el bebé no acepta la mamadera, no obligarlo. Probar, por ejemplo, con vasito.
- Cuando la mamá vuelve del trabajo, le ofrece la teta todo el tiempo que ambos deseen.

La leche materna y la de fórmula SE PUEDEN MEZCLAR si es necesario.

Siempre es mejor aportar primero la leche materna y luego la de fórmula, para que, si no llega a tomar todo, no se desperdicie la leche materna. Pero como poder mezclar, se puede.

Para mantener la producción de leche, lo ideal es que las mamás se extraigan en el trabajo máximo cada 3 horas. Los trabajos formales no están hechos para respetar los tiempos fisiológicos de la crianza y el puerperio. Nos exigen que criemos como si no trabajáramos y que trabajemos como si no criáramos. Y esto es parte de un paradigma adultocéntrico, que todos deberíamos tratar de cambiar.

¿Cómo sacarnos leche en el trabajo?

Lo ideal sería la presencia de un lactario. **Un lactario laboral no es más que un cuarto acondicionado para que las madres puedan extraerse leche con las condiciones de higiene y tranquilidad necesarias.** Un lugar para higienizarse las manos, una silla o sillón y una heladera exclusiva para la leche serían los componentes básicos. Lo ideal sería evitar que esté en “el medio de todo”, o que se toque la puerta repetidamente, o que se use para otras actividades (me han contado de lugares en los cuales los lactarios se usan como lugar... ¡PARA FUMAR!).

El baño no es un lugar para preparar comida. El baño no es un lugar para sacarse leche. Haber pasado por esta experiencia me da mil ímpetus para dedicar mis energías a trabajar en el tema y —les prometo— algún día lograr cambiarlo. Mientras tanto, incito a todas las personas a que revisen sus lugares de trabajo, tengan hijos o no. Y si no tienen lactarios, que insistan en poner uno, POR LA SALUD DE LOS NIÑOS, a corto y largo plazo.

Mientras tanto, ¿cómo usar esos lugares?

- Lavarnos siempre las manos antes de empezar.
- Si contamos con toallitas antibacteriales, pasarlas por la superficie donde apoyaremos las cosas.
- No es necesario esterilizar el sacaleches cada vez que lo usamos: con lavarlo con agua y jabón o con agua hirviendo alcanza. No hace falta secarlo, si quedan gotitas de agua adentro no pasa nada.
- No hace falta limpiarse los pezones antes de comenzar.
- Llevar una ropita con olor a bebé o ver fotos nos puede ayudar.
- No desesperar. Tenerse paciencia. La leche suele empezar a salir de a poquitas gotas, y luego, cuando aparece el reflejo de eyección, que a veces puede tardar unos cuantos minutos, sale en mayor cantidad. Sabemos que “hay que volver al trabajo” y que eso provoca estrés, lo cual retrasa este reflejo. Tengamos esta información e intentemos estar lo más tranquilas posible...
- No buscar sacarnos leche “por tiempo” ni “por cantidad”. Lo ideal sería sacarnos de un pecho, y cuando la cantidad de leche que vemos salir se va reduciendo, cambiar al otro. Luego volver al primero, veremos que podemos sacar un poquito más.
- Lo que nos extraemos en el trabajo NO ES lo que extrae el bebé cuando toma. Calma. Sacarse poquito no significa estar quedándose sin leche.
- Lo ideal es no pasar más de 3 horas sin extraerse. La leche acumulada en la mama hace que se inhiba la producción y, ahí sí, pueda empezar a bajar la misma.

“No agarra la mamadera”

Uno de los mayores miedos al volver al trabajo es que el bebé no acepte la mamadera. Sin embargo, **existen diferentes técnicas para administrar suplementos a un bebé amamantado, o para que un bebé que se separará de su mamá varias horas pueda alimentarse en su ausencia.**

No siempre es la mamadera la mejor manera. Hay bebés que la rechazan y otros que, siendo un suplemento transitorio (por un tema de peso, tal vez), sería conveniente que no la recibieran para evitar confusiones tetina-pezón y menoscabar la lactancia. Lo importante es comprender que la mamadera no tiene por qué ser NECESARIA, y que un bebé que no la acepta puede ser alimentado de otras maneras.

Es importante recibir la información adecuada y practicarlo con algún profesional idóneo (por ejemplo, una puericultora) antes de hacerlo solos en el hogar, para sacarnos dudas y miedos.

El método elegido dependerá de la familia y del bebé; si es un bebé inquieto o plácido, si duerme mucho o poco, cuánto volumen tenemos que darle...

Algunas opciones son:

- * **Taza o vasito:** se usa un pequeño vasito, pocillo, tapa de mamadera o vasito medidor. El bebé va semisentado, lo más vertical posible. Se le sostienen la espalda y la cabecita (no acostado). Se coloca el vasito sobre el labio inferior evertido y se inclina para que la leche lo toque. La leche NO CAE en la boca, los bebés la lamen, la succionan o la sorben. Cuando el bebé ha tomado suficiente leche, cerrará la boca y no tomará más.
- * **Cucharita:** muy útil los primeros días de vida, por ejemplo, para administrar el calostro a un bebé plácido y dormilón. Se recoge el calostro directamente del pecho con una cucharita, se la apoya en el labio inferior y se permite que el bebé pueda lamerla.
- * **Dedo-jeringa:** muy útil para evitar la confusión pezón-tetina y poder suplementar si tenemos problemas de peso, ya sea con fórmula o con más leche de la mamá. Sirve también para trabajar problemas de succión. Se introduce un dedo limpio en la boca del bebé apoyando la yema en el paladar, con los labios evertidos. Cuando empieza a succionar, se le coloca una jeringa pequeña en la comisura labial y se acompaña la succión. No se le da leche mientras no succiona. Este método también se puede realizar enrollando una pequeña sonda en nuestro dedo, con el otro extremo en el recipiente con leche.

Reitero que es importante tener una consulta con un profesional para que nos ayude a encontrar las posiciones más cómodas para todos, y la confianza de hallar un método que nos deje tranquilos.

Medicamentos, procedimientos y lactancia

“¿Puedo hacerme tatuajes amamantando?”.

“¿Puedo teñirme?”.

“¿Puedo arreglarme una caries?”.

“¿Puedo tomar “x” antibiótico que me indicaron?”.

Sobre esto último, muchas veces se asesora mal desde la parte médica, se indica destetar o “no darle la teta unos días”. Para ayudarnos con esto tenemos una herramienta FANTÁSTICA que ya mencioné en otros capítulos: **es www.e-lactancia.org. El buscador no solo está muy actualizado, sino que ofrece la bibliografía que lo avala.** Sirve tanto para medicamentos como para procedimientos. Podemos buscar acerca de la realización de estudios médicos, tatuajes, tratamientos de estética...

Sirve para familias y profesionales. Lo responsable a nivel profesional sería consultar si realmente ese medicamento no es compatible con la lactancia y si es así (son muy pocos los que realmente no lo son), buscar otras opciones si es posible. **Si www.e-lactancia.org dice que algún medicamento o procedimiento se puede... ¡se puede! Y si nos genera dudas, podemos leer la bibliografía.**

Lactancia “prolongada”

Estamos en un mundo tan extraño que nos parece extraño un niño de 2 años tomando teta y no uno tomando Coca-Cola.

Aunque en diversas culturas es normal, cotidiano y alentado, la lactancia materna por encima del año de vida está “mal vista” en la sociedad occidental. **Si bien la “norma de oro” promovida por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF es “Lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y lactancia materna continuada hasta los 2 años o más”,** siendo el destete una decisión que solo concierne a la díada mamá-bebé, la sociedad y los profesionales de la salud parecen estar siempre muy preocupados por el tema.

“Tu leche es agua”. “Le das teta solo como mimo”. “Sacale la teta así come más”. “Qué vergüenza, un nene tan grande tomando teta”. “Qué asco”. “Le estás creando una dependencia y un trauma” (a la gente le encanta hablar de traumas). Y miles de otras frases desafortunadas pueblan los oídos de las madres....

A lo largo de los siglos, y en prácticamente todos los lugares del mundo, la lactancia materna ha sido la norma hasta los 2-3 años de edad. No es sino hasta comienzos del siglo XX en los países industrializados cuando, a raíz de la aparición y extensión del uso de los sucedáneos de leche materna y los cambios sociales, se generaliza el destete prematuro de los bebés.

Desde el punto de vista evolutivo, la lactancia materna es una clave fundamental en el desarrollo de nuestra especie. Su interrelación con la fertilidad de las mujeres y con la supervivencia de los niños hace de la lactancia un elemento de estudio primordial en la historia del género humano. Diversos trabajos en paleofisiología y antropología establecen que la edad del destete espontáneo en Homo sapiens sapiens ocurre entre los 2,5 y los 7 años.

Asociación Española de Pediatría

La leche materna no pierde sus propiedades con el paso del tiempo. A partir del primer año de lactancia, la cantidad de grasa en la leche aumenta con respecto a los primeros meses, lo que da como resultado un alimento completo y nutritivo para un lactante mayor, y de más calidad que la leche de fórmula o de vaca. Entre el año y los 2 años, por ejemplo, aporta un tercio de las calorías diarias que necesita un niño (¡y un niño de 1 año hace muchas cosas y necesita muchas calorías!).

No se han constatado riesgos físicos ni psicológicos en niños que toman pecho por encima de los 2-3 años de edad. No se ha evidenciado la relación entre la lactancia materna prolongada y la malnutrición en países en desarrollo, ni tampoco está demostrada su relación con la caries infantil, si está garantizada la higiene bucal.

“Agitación por amamantamiento”

Este concepto describe sentimientos de rechazo que aparecen de repente en la madre lactante hacia su hijo. Generalmente suceden durante las tomas, en lactancias en tándem y/o durante el embarazo, o de niños mayores.

Esto les sucede a muchas mujeres. Es importante mostrarlo para no pensar que somos madres horribles y que no amamos a nuestros hijos. **La “agitación por amamantamiento” es normal, y a veces va y viene.** De alguna manera sentimos que debemos “apartar” al bebé/niño.

Transitar esta situación tiene múltiples resoluciones según cada mujer. Podemos pensar en iniciar un destete o atravesar el sentimiento. Podemos tratar de reducir algunas tomas. Todo es válido si es respetuoso y amoroso. Y esto, les juro... también pasará.

Destete: nuevas formas de amarnos

La principales asociaciones científicas nacionales e internacionales recomiendan que la lactancia materna sea el único aporte de alimento hasta los 6 meses de edad, y después complementarla con otros alimentos, al menos hasta los 12-24 meses de edad, pudiendo mantenerla todo el tiempo que madre e hijo/a deseen.

No hay establecido un límite superior para finalizar la lactancia. La decisión de destetar es propia de cada díada, y como profesionales nos limitaremos a acompañar.

El destete puede ser espontáneo o dirigido. **Espontáneo es cuando el bebé decide**

destetarse por su cuenta, y generalmente, no quiere más teta de un día para el otro. Hay que tener cuidado de no confundirlo con los brotes de crecimiento. Es raro que un bebé menor de 1 año se destete espontáneamente, pero puede ser posible. ¿Por qué sucede? Porque tal vez le interesa más la comida; o se enfermó, le dolía la garganta y ya no quiere más; o pasó algo como una mudanza o un evento familiar. Tal vez nunca lo sepamos y tengamos cierta sensación de vacío. Es importante hablar y trabajar los sentimientos.

El destete dirigido es mucho más llevadero si se da de forma gradual. Si destetamos de golpe, de un día para otro, podemos sufrir taponamientos o mastitis. Ponerse cosas amargas en la teta (limón, ricino), pintarlas con betún o pintura roja para simular sangre o “algo feo”, es bastante poco respetuoso con el niño. Nunca entenderá por qué fue destetado. Por eso, es recomendable:

- Hablarlo con el bebé o niño, no importa qué edad tenga.
- Contarles que mamá está muy cansada, que las tetas también, y que, de a poco, buscaremos otras formas para pasarla lindo juntos.
- Existen cuentos que nos pueden acompañar: por ejemplo, ¡TETA MAMÁ!, de Carolina Mora, o *La teta cansada*, de Montserrat Reverte.
- Es útil identificar qué teta será la más complicada de reemplazar. ¿La de la noche? ¿La de la vuelta del jardín? Y dejarla para el final del destete.
- Buscar otras maneras de relacionarse. Si la teta era la que calmaba ante un golpecito, podemos plantear abrazos o un “sana, sana”.
- Si el niño/a tiene más de 1 año, no hace falta que introduzcamos mamadera si nunca la usó antes. Los niños no “tienen” que usar mamadera, pueden pasar directamente al vasito si ya saben usarlo.
- Contárselo al entorno, pedirles por favor que eviten las burlas y las referencias, por ejemplo, a su edad. Que nos acompañen respetuosamente en el proceso.
- Consultar a una puericultora que nos guíe en el proceso.

Lactancia en duelo

Yo no tenía dudas.

Entre los dos íbamos a parir y en cuanto nacieras, te ibas a prender a la teta.

El dolor de la cesárea y el miedo de tu nacimiento difícil me dejó una sola premisa de esperanza en pie: la teta.

Nadie hubiera aventurado un pronóstico neurológico que incluyera succión en ese momento.

No importó.

La primera vez que me acerqué al sacaleches, Juan tenía 12 horas y se estaba muriendo. Por 5 segundos me pregunté si me iba a sacar leche para un bebé que no iba a vivir. Sacudí la cabeza y me propuse no pensarlo más, y confiar en que no nos iban a robar eso también.

Unos días después, cuando tu intestino sanó lo suficiente como para alimentarte, uno de los médicos me dijo que no te podían dar mi leche. Que por la patología con la que habías nacido, necesitabas una leche artificial con grasas modificadas. La estructura frágil con la que se soportaban los días casi se me rompe.

Después dijo las palabras mágicas: “Por el momento”.

Seguí pegada al sacaleches.

El lactario de la Neo merece un capítulo aparte en los libros de medicina y en la historia de cada niño que haya pasado por ahí.

En la Neo se llora poco. Diría que casi no se llora. No hay tiempo ni energía para llorar.

Las que ya están hace tiempo te ven llegar con un camisón nuevo que compraste y lavaste para abrazar a tu bebé. Te ven llegar recién parida, cortada, caminando desde la caja de acrílico donde está tu hijo, al que no podés alzar porque está grave. Te ven y te ayudan, te explican dónde está el fibrón para marcar los tarritos, te cuentan qué les sirvió a ellas: agua, levadura de cerveza, Reliverán. Con los días y las horas, las catarsis empiezan. Se arman alianzas, se festeja cada gota de ese oro blanco que debería, en un mundo justo, verterse en la boquita de esos bebés.

Ahí somos todas iguales. Todas queremos agarrar a la cría, salir corriendo por la puerta y que nunca más requiera atención médica.

Pero como no queda otra que esperar, nos exprimimos hasta la última gota, rogando que esos seres minúsculos estén listos, pronto, para succionar.

De día respetás las tres horas sagradas para no reventar. De noche,

cuando tratás de dormir en tu casa mientras ese cuerpito te espera en el hospital al cuidado de quién sabe quién, te despertás con las tetas explotadas, chorreando, con la cama húmeda y acartonada. El cuerpo reclama a la cría, que debería estar toda la noche mamando. Falta el bebé al lado. Y el dolor se hace líquido tibio, y una se levanta a usar el bendito sacaleches que menos-mal-que-compré.

Acumulé litros y litros de leche en las heladeras de la Neo. Cuando me dieron los tarritos para llevarme a casa, llenamos tres conservadoras grandes. Nos reímos mucho con las otras madres, que proponían asaltarme cuando saliéramos por la puerta del hospital.

Juan tenía 23 días cuando pudimos probar succión. Me pusieron un almohadón en la cintura, que se agarraba con velcro atrás. Tenía puesto un gorrito verde con púas de dinosaurio. Habíamos practicado ejercicios de estimulación todo el día anterior.

Y tomaste.

Contento, abriste la boca, buscaste la teta y fui tu alimento.

Fuimos uno otra vez, y lo seguimos siendo hasta tu último día.

Mantuvimos la teta contra viento y marea. Nos negamos a la fórmula siempre, hasta cuando salimos de la Neo y eras un bebito diminuto y esmirriado, y no engordabas los gramos/día suficientes para conformar a las tablas de la OMS. Usamos el relactador hasta conformar a tu pediatra. Mantuvimos la teta hasta cuando volví a trabajar y me tenía que sacar la leche parada en un baño sucio, mientras me contaban los minutos que no estaba atendiendo; y cuando volví a hacer guardia y volvía con una conservadora con un litro de leche para dejarte para la próxima ausencia. Disfrutamos cada segundo de teta, de madrugada, de tarde, de noche. Las horas se diluían en tu respiración acompasada, en tu boquita anhelante, en tu cuerpo tibio pegado a mí.

A la noche te despertabas y te traía a mi cama. Al romper el invierno, a veces se te enfriaban las manitos y los pies. Ponías tus piecitos contra mi panza, tu carita famélica buscaba el pezón y seguíamos durmiendo.

No me había equivocado con eso. No iba a permitir que nada nos robara la lactancia.

Pasaron siete magníficos meses.

Cuando volvimos a internarnos, ni la sepsis, ni el dolor, ni la neurocirugía mermaron tu interés por la teta. Tomaste feliz, agarrándote un pie. Tomaste hasta que vi que tus ojos se perdían, y que algo andaba mal. Aún con lo que estaba pasando en tu cabecita, tomaste la teta.

Juan tomó teta hasta minutos antes que lo ventilaran para ya no

volver. Me quedo con que su último acto consciente fue abrazarse a mí y a mi amor.

Poco se habla de las pérdidas gestacionales. Poco se habla de la muerte en general, menos de niños. Poco se habla del duelo de tener un bebé en Neo. Y aún menos se habla de qué hacer con un duelo en pleno puerperio. Las mujeres no cortamos el puerperio de golpe, así como tampoco la leche se va de repente.

Cuando un bebé fallece y era amamantado, es importante acompañar a la mamá para que, además de su dolor, no sufra mastitis ni otras complicaciones. El acompañamiento, por un lado, debería ser médico: hay ciertas medicaciones que pueden ayudar a inhibir la lactancia. El fajarse los pechos no se sugiere desde lo médico: al apretar, se corta la circulación sanguínea y puede producirse mastitis. La falta de estímulo hará que progresivamente se genere menos leche. Pero lo más importante es el acompañamiento psicológico, validar la tristeza, el dolor y otros sentimientos que vayan apareciendo.

Donar leche materna

Para los bebés internados en Neonatología, la leche materna sería el alimento ideal. Sobre todo para los bebés prematuros, en los que se ha estudiado profundamente el papel de la leche materna en la prevención de patologías como la enterocolitis necrotizante (el intestino de estos bebés es muy inmaduro y puede sufrir graves infecciones). Las internaciones pueden ser largas y estresantes, y no siempre sus mamás pueden (o desean) extraerse toda la leche que estos bebés necesitan. Es por esto que los bancos de leche materna son una estrategia fundamental para el desarrollo y la supervivencia de estos bebés.

Los bancos de leche materna reciben, controlan, pasteurizan y distribuyen leche humana donada en forma solidaria y altruista. Conservan por un lado la leche que se sacan las mamás que tienen los bebés internados en esas unidades de atención, y por otro, reciben leche de otras mujeres que alimentan a sus bebés con lactancia materna exclusiva y desean donar.

¿Qué requisitos generales necesitan cumplir las mujeres donantes? Ser sanas, tener exámenes de sangre negativos para HIV, Hepatitis B y C, VDRL, Chagas y toxoplasmosis; no tomar alcohol, fumar, ni consumir drogas; alimentar a sus bebés con leche materna de forma exclusiva y tener algún exceso en la producción de leche. **Cualquier cantidad de leche sirve, no importa si son 10 mililitros. Los bebés internados, sobre todo los prematuros, inician la alimentación con muy poquito volumen,** por ejemplo, uno o dos mililitros. Así que 10 son... ¡un montón!

Por dar un ejemplo, la maternidad Sardá, en Capital Federal, tiene un programa por el cual se entregan los frascos estériles a las mamás, se les explica el procedimiento y se va a buscar la leche a sus casas para evitar que tengan que viajar con un bebé pequeño.

- En la ciudad de **Buenos Aires y el área cercana**, las mamás que deseen donar pueden dirigirse al Servicio de Alimentación del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, Esteban de Luca 2155 (Parque Patricios) o comunicarse por teléfono al 4943 5580/5028, interno 7154. También pueden contactarse por *mail* a blhsada@yahoo.com.ar
- En la ciudad de **Mendoza**, se puede acudir al Banco de Leche Humana del Hospital Lagomaggiore, calle Timoteo Gordillo 100, o comunicarse al teléfono (0261) 413 4751/2, de lunes a viernes de 8.00 a 17.30.
Mail: blh@bancodelechেমendoza.com.ar
Página web: www.bancodelechেমendoza.com.ar
- En **La Plata, provincia de Buenos Aires**: Banco de Leche de La Plata, calle 69 entre 115 y 116. Teléfono: 0221 4251717, interno 386.
Mail: bancodelechelap-ta@gmail.com
- En **Resistencia, Chaco**: Banco de Leche Humana del Hospital Perrando, en 9 de julio 1100.
- En la ciudad de **Córdoba**: Banco del Leche del Hospital Materno Neonatal Dr. Ramón Carrillo, Av. Cardenosa 2900.
Mail: bancodelechecordoba@hotmail.com
- En **Neuquén**: Banco de Leche del Hospital Cutral Có-Plaza Huincul, Las Lengas y Av. Juan Schreiber, Cutral- Có.

Reflexión final

Empecé a estudiar puericultura al poco tiempo de quedar embarazada de mi hijo menor, y de decidir no hacer un posgrado en una especialidad que me gustaba mucho, pero me exigía demasiado tiempo sin remuneración. Casi al mismo tiempo, empecé a divulgar en redes algunas cosas de pediatría. Pronto, ante mis ojos asombrados, empecé a ver que mis textos se compartían y de repente tenía como estandarte los pies descalzos, las galletitas de avena y la teta para todos y todas. No tengo idea cómo pasó, pero pasó.

En medio de todo eso me encontré también con una avalancha impensada de críticas, mensajes privados llenos de odio y hasta un *mail* de una abuela donde sentí toda la furia de *Caps Lock* (me escribió todo en mayúsculas, para que se entienda)

acerca del horror que sentía por la falta de medias. Creo que a nadie le puede gustar que le digan cosas feas. Es estresante y se invierte una gran cantidad de tiempo, así que, sugerencia: si no les gusta algo de lo que leen en las redes, ¡pasen de largo y listo!

Algo que me llamó poderosamente la atención fueron las quejas hacia las publicaciones de lactancia. Mujeres que me decían que sentían mucha culpa al leer mis posteos, o que las hacía sentir menos madres, o que la fórmula era lo mismo que la teta y yo estaba desinformando.

La maternidad está plagada de culpas. Que si diste la teta o si no la diste, cuánto tiempo la diste, cómo es la forma de tu teta, cómo es el color de tu areola, cuán largo es tu pezón, cuánto engordó o no tu hijo/a, cuán caprichoso es, cuánto pelo tiene. Todo es una mirada crítica, buscando el error (todo es error), buscando la patología (hace poco a una mamá de un paciente le preguntaron en el jardín qué problema tenía su bebé en la deglución, porque no aceptaba la mamadera), o simplemente no colaborando.

La leche materna es lo mejor para un bebé. Sí, de eso no hay dudas. Ya expuse multitud de razones científicas, médicas y hasta económicas para afirmarlo. La leche de fórmula, no importa qué marca y no importa qué precio, tiene sus riesgos y no debería venderse en supermercados, sino ser recetada.

Pero ¿la lactancia es lo mejor para esa mamá y ese bebé? ¿Buscamos imponer una actividad que, así como algunas mujeres disfrutaban, otras no e incluso les provoca incomodidad? No. Nunca. Ni yo ni otros agentes de la salud estamos para decirle a la gente lo que tiene que hacer, menos con sus tetas. Estamos para dar información, para apoyar, sostener y acompañar cuando las decisiones son informadas. En el consultorio, acompaño a muchas familias que deciden dar fórmula total o parcialmente. Y son niños y niñas amados/as y felices.

Así que, **cualquiera sea tu lactancia, yo te felicito profundamente.** Porque, de seguro, hiciste lo que creías mejor para tu bebé en ese momento. Porque todo salió desde el amor. Y eso es lo único que importa.



Para leer

PARA FAMILIAS

- De los Santos, P. *#YoDoyLaTeta*. Editorial Grijalbo, Buenos Aires, 2018.
- González, C. *Un regalo para toda la vida. Guía de la lactancia materna*. Editorial Temas de Hoy, Barcelona , 2015.
- La Liga de La Leche Internacional. *El arte femenino de amamantar*. Editorial Pax, 2001.
- Padró, A. *Somos la leche*. Editorial Grijalbo, 2017.
- Troncoso, L. *Los primeros 1000 días de tu hijo*. Editorial Planeta, Buenos Aires, 2019.
- Vázquez, V. *Dar la teta*. Editorial Del Nuevo Extremo, Buenos Aires, 2014.
- E-lactancia: www.e-lactancia.org

PARA PROFESIONALES

- Asociación Española de Pediatría. *Lactancia materna en niños mayores o “prolongada”*. Recuperado de: <https://www.aeped.es/comite-lactancia-materna/documentos/lactancia-materna-en-ninos-mayores-o-prolongada>
- Comité de Lactancia Materna de la Asociación Española de Pediatría. *Lactancia Materna: guía para profesionales*. Monografías de la AEP n.º 5, Madrid: Ergón, 2004.
- PRONAP. Programa Nacional de Actualización Pediátrica, Módulo 2, 2017. Miguel Larguía [et ál]; dirigido por María Luisa Ageitos. Primera edición. CABA, Sociedad Argentina de Pediatría, 2017.
- PRONAP. Programa Nacional de Actualización en Pediatría, Módulo 1, 2018, Sociedad Argentina de Pediatría, *Métodos para la administración de leche extraída o leche de fórmula*, Dra. Roxana Conti.
- Organización Mundial de la Salud. *La alimentación del lactante y del niño pequeño*, 2010.
- Secretaría de Salud de la República Argentina, plataforma SUMAR. *Curso básico de Lactancia Materna*, 2018.
- Organización Mundial de la Salud en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. *Preparación, almacenamiento y manipulación en condiciones higiénicas de preparaciones en polvo para lactantes*. Directrices. 2007.
- *Manual de lactancia materna*, Ministerio de Salud de Chile, 2010.

La alimentación complementaria



Yo lo veo ahí, sentadito a mi lado, atento. Con los ojos enormes cuando suena la procesadora. En silencio, ¿qué pensará? ¿Que soy una persona muy interesante que hace multitud de cosas raras? ¿Que todo muy lindo, pero para cuándo la teta? ¿Que él también quisiera meter mano?

Lo veo ahí sentado, y veo en su cara generaciones de bebitos colgados de las piernas de sus mapadres mientras hacían la comida. Veo algo primal, veo fascinación ante el alimento transformado por magia, seguro que por magia, qué otra cosa haría funcionar ese coso que

hace tanto ruido.

Veo su sonrisa cada vez que mi mirada encuentra la suya. Y canto, para que no se aburra, para terminar de batir los huevos. Y le hablo de las gallinas, y hacemos ruido de gallinas.

No siempre funciona la distracción vocal: a veces se enoja porque el zapallo bobo me hace demorar demasiado y, vamos mamá, no es tan divertido. Y ahí empieza el juego ancestral: no existe nada más versátil que un utensilio de cocina, que se puede morder, tirar, siempre hace ruido y es muy interesante revolearlo y ver dónde cae.

Eso también es cocinar. Eso también es comer. A veces termina en aburrimiento, llanto y teta, y no almorzamos ni él ni yo. Pero quién nos quita lo que vivimos, y quién nos quita lo cocinado.

El placer, el disfrute y la comida

El primer acto social que realiza el ser humano, después de llorar, es alimentarse. Ya hemos descripto cómo un bebé sano recién nacido es capaz de reptar sobre el vientre de su madre y llegar al pezón. **La comida nos convoca, nos reencuentra; a través de la comida celebramos la vida y sus eventos.**

En la cultura argentina, comida feliz es igual a MUCHA comida. Tiene que ver con las raíces de nuestra población, en la cual muchos de nuestros antepasados sufrieron condiciones de vida complejas que incluyeron hambre. El tener alimento se convirtió en un acto de festejo.

Y esto estuvo bien mientras cocinamos con alimentos reales, comidas tradicionales y llenas de historia. Pero luego, vinieron los alimentos hiperindustrializados, de escasa calidad, que desplazaron al guiso de la abuela por tener paquetes brillantes y sabores excitantes que no pudimos parar de comer.

De la mano de esos paquetes brillantes, aumentaron las enfermedades: hipertensión, diabetes, dislipemias, obesidad, cáncer. Y en algún momento, dejamos de pensar en comer rico, para pensar en calorías y en “comer sano”. En envases de etiqueta verde. En cosas magras. En rutinas para perder peso.

Nos hizo mal, nos hizo muy mal. **Actualmente, la malnutrición es una epidemia mundial, y nos vemos forzados a buscar estrategias para cambiar esto.**

Traer de nuevo el guiso de la abuela a la mesa parece ser el camino.

Redescubriendo la comida real

Los productos ultraprocesados

En 2017, la Organización Panamericana de la Salud presentó un informe llamado “Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas”. En ese informe, analiza un fenómeno preocupante que nos reúne a nivel mundial: el aumento sostenido de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el cáncer, las cuales provocan mala calidad de vida y muertes prematuras. Dentro de los factores de riesgo para esas enfermedades, encontramos el consumo de tabaco y de alcohol, la escasa actividad física y, como un factor transversal, la alimentación deficiente.

La mayor parte de las personas está malnutrida. **Malnutrido no quiere decir desnutrido: se puede ser obeso y estar malnutrido. Tiene que ver con un conjunto de reacciones metabólicas a los alimentos que consumimos constantemente, alimentos de mala calidad en su mayoría, denominados “ultraprocesados”.**

¿Qué son los productos ultraprocesados? Son formulaciones industriales elaboradas a través de sustancias derivadas de alimentos u otras fuentes. Como su nombre lo indica, **no son alimentos, son productos comestibles**. Su formulación suele ser una caja de Pandora de aditivos, y lo podemos ver al echarle un ojo a la etiqueta. ¿Para qué tienen tantas cosas? Para durar mucho en la góndola sin perder “frescura” y no generar pérdidas al mercado, y para hacerlos extremadamente sabrosos e hiperexcitantes para los sentidos: no podemos comer UNA papa frita, NECESITAMOS terminar el paquete.

Los productos ultraprocesados imitan a los alimentos reales, promocionándose incluso como “mejores”, porque recitan una larga lista de vitaminas, minerales, cosas. Un ejemplo perfecto es el de las leches de “continuación”, que se venden para bebés mayores de 1 año.

Las leches de “continuación” (Bebé 3, Bebé 4) son una mezcla de leche descremada, leche entera, agua, aceites varios y, sobre todo, mucha, MUCHA azúcar. Prometen beneficios improbables en sus eslóganes, como “impulsa el desarrollo mental” (?). Tienen dibujitos divertidos y su valor es elevado, alrededor de tres veces lo que sale un litro de leche entera común.

No solo no son necesarias, sino que:

- * Favorecen el desarrollo de caries.
- * Estimulan el paladar selectivo hacia los dulces, llevando al consumo de más azúcar.
- * Están relacionadas con los altos niveles de obesidad infantil.
- * Llevan al consumo de gran cantidad de leche en detrimento del consumo de otros

alimentos.

Me consta que muchas familias compren estas leches porque tienen una publicidad pegadiza e insistente (tan solo preguntémonos: “¿Qué tiene tal leche Bebé 3?”). ¿Ustedes también escuchan la música en sus cabezas?), y porque anuncia tener vitaminas, minerales, proteínas y la mar en coche. Todas sustancias que no deberían salir puntualmente de la leche, sino de una alimentación variada.

Los productos ultraprocesados tienen otro “gancho”: suelen venir listos para usar. Son “rápidos” y “fáciles”. Evitan la cocina. Y esto también es un problema. Los ultraprocesados son iguales para todos, no hablan de tradiciones, ni de formas de preparar. Desplazan a las construcciones culturales, y, al ser producidos en fábricas y comercializados generalmente por grandes cadenas, tienen un impacto negativo en las economías locales.

Esto no quiere decir que muchas de nuestras comidas actuales, seguramente basadas en estos productos, no se hagan con mucho amor y con mucho cuidado hacia nuestros seres queridos. Simplemente, cuando uno empieza a informarse, aparece un mundo de autocrítica constructiva hacia nuestros propios hábitos alimentarios y la pregunta acerca de qué queremos transmitirles a nuestros hijos.

Las guías NOVA

Fuera de la tradicional pirámide alimentaria y el más novedoso “plato alimentario” que se propone para clasificar alimentos (carne, cereales, frutas y verduras, etc.), hace pocos años se creó en Brasil **un nuevo sistema de clasificación que tiene como pilar el grado de procesamiento de los alimentos**. No plantea que los alimentos sean saludables o no por estar procesados: casi todos los alimentos tienen algún grado de procesamiento. A la manzana hay que sacarla del árbol, empaquetarla y llevarla al negocio. A la vaca hay que matarla y procesar su carne, cuero, grasa, etc. Todos esos son procesos. Sin embargo, es claro que hay procesamientos beneficiosos para nuestra salud y otros que no.

¿Cómo clasifica los alimentos el sistema NOVA?

- **Alimentos sin procesar o mínimamente procesados:** frutas, verduras, carnes, pollo, pescado, cerdo, otras carnes, frutos secos, granos, leguminosas, cereales, huevos, leche pasteurizada.
- **Ingredientes culinarios procesados:** grasas, aceites, sal y azúcares.

- **Alimentos procesados:** panes y quesos sencillos, pescados, mariscos y carnes salados y curados; frutas, legumbres y verduras en conserva.
- **Productos ultraprocesados:** gaseosas, jugos artificiales, margarina, galletitas, cereales para bebés, papas fritas de bolsa, patitas de pollo congeladas, sopas de sobre, margarina, salchichas, hamburguesas, gelatinas.

Los alimentos sin procesar o mínimamente procesados, combinados con los ingredientes culinarios y algún que otro alimento procesado, junto con nuestro gusto personal, y la gente con la que compartimos la mesa, dan lugar a los platos caseros y la comida tradicional. Esto —está estudiado— tiene un impacto positivo en la salud y el bienestar.

Evitar lo más posible los productos ultraprocesados tendrá un impacto profundamente positivo en nuestra salud. Son difíciles de sacar de nuestra comida diaria: están diseñados para eso, para que dependamos de ellos. Por eso, no sirve ir por el lado de la prohibición, al revés. La propuesta es empezar a incorporar alimentos y preparaciones con alimentos reales. Cuando empiezan a poblar nuestra vida, nuestros tiempos, nuestra cocina y nuestra familia, paulatinamente nos vamos a dar cuenta de que van a desplazar a los ultraprocesados. Y que nuestra salud nos mostrará que estamos en lo cierto.

El inicio de la alimentación complementaria de un bebé es muchas veces un momento de profunda reflexión y cambios en la alimentación de una familia. ¡Aprovechémoslo!

La comida real no viene en paquetes

La comida real no viene en paquetes. La comida real no es toda igual, porque depende de quién la cultivó, dónde, cuánto la regó, si el hijo de esa persona le rompió unas hojitas mientras aprendía a caminar...

La comida real tiene pocos ingredientes y no sabe pronunciar “metabisulfito de sodio” (un antioxidante que lleva, por ejemplo, el puré en escamas). Se pudre, se marchita porque las bacterias y hongos gustan de ella. Tiene manchitas en la cáscara y a veces brilla poco.

La comida real no es más cara, ni inaccesible, ni requiere profundos conocimientos de cocina macrobiótica. Es que la comida nos convoque y nos dé placer. Una comida libre de pensamientos tortuosos acerca de “gustitos” o “porciones”, sino una comida que nos sacie, que nos alegre, y, sobre todo, que no nos enferme.

Las etiquetas

Un buen ejercicio es leer los ingredientes de los productos que compramos. Los ingredientes vienen de mayor a menor, según la cantidad que esté incluida en ese producto. Descubriremos cosas muy interesantes, como varios tipos de azúcares y numerosos colorantes.

En otros países de Latinoamérica, iniciando por Chile, existe legislación que obliga a poner sellos en el frente de los productos, aclarando que los mismos son altos en azúcares, grasas, sodio y otros elementos poco saludables. Asimismo, obligan a sacar a los animalitos y otros personajes de los alimentos promocionados para niños (por ejemplo, los famosos copos de maíz vienen sin el tigre y la chocolatada sin el conejo), y no permiten que esos productos se vendan con juguetitos.

Argentina no está yendo actualmente por ese camino: la resistencia de quienes venden esos productos aún es feroz. Queda seguir leyendo las etiquetas, y transformar nuestra cocina y nuestros hábitos en bastiones de salud.

Hijos de los ultraprocesados

Somos hijos de los ultraprocesados.

Los que crecimos en los 90 lo recordaremos: moles de cemento azules que crecían en el medio de las ciudades, aplastando con su novedad los almacenes de barrio. Los supermercados brotaban, todo se podía adquirir en el mismo lugar, y hasta podías almorzar. El combo completo.

Los alimentos empezaron a venir en paquete. Ya no más la galletita suelta en el tarro de lata: ahora venían en empaques brillantes de seis tubos, con figuritas. Góndolas y góndolas de colores brillantes, cajas seductoras, pilas de mandarinas naranja fuego en islas donde te las podías autoservir en bolsitas.

La comida, la mejor comida, venía en paquete. Y es así como yo no supe, hasta mucho después, que el puré de papas se hacía con... papas. Por muchos años, no cuestioné que viniera en escamas para preparar con agua, en una bolsita verde.

Sopas instantáneas, gelatinas, postrecitos, galletitas, ensalada jardinera en lata, milanesas de soja, salchichas, carne en bandejas de un plástico extraño. Todo cómodo, rápido, “bueno”.

En esa época, lo “mejor” se compraba en un supermercado, estaba dentro de una lata de leche de fórmula y, sobre todo, permitía “ahorrar” tiempo. Cocinar era algo aburrido a evitar, que quitaba momentos de relax y productividad.

Era la época también de los supermodelos larguísimas, la dieta de la luna y cualquier otro plan para no caer en las garras de la condena social por tener kilos de más.

La salud era un detalle: lo importante era estar flaco. Primero tuvieron la culpa las grasas y todo empezó a ser “light”, con una etiqueta verde.

Somos hijos de los ultraprocesados, tanto que nos cuesta considerar a la fruta comida, y en las redes, las cuentas de cocina explotan como novedad imparable.

Somos hijos de los ultraprocesados, enfermos ya, buscando respuestas en la farmacia.

Somos hijos de los ultraprocesados, pero de a poco, empezamos a entender que lo único que va a cortar ese camino que busca la industria es empezar a consumir alimentos y no productos.

Hoy, mientras cocinaba, pensaba que quiero para mis hijos una alimentación consciente y soberana; que lejos de enfermarnos, nos una en tradiciones, ingredientes y sabor.

Las publicidades

¿Qué sabe una pediatra de publicidades? ¿Qué tienen que ver las publicidades con lo que comemos y nuestra salud?

Bien, lo dejo a su criterio. Aquí, datos textuales de mayo de 2018 de la Fundación Interamericana del Corazón – Argentina:

- * Casi 9 de cada 10 alimentos que se publicitan durante los programas infantiles de TV tienen bajo valor nutritivo.
- * Los postres (23,3 %), los lácteos (16,2 %), las bebidas azucaradas (13,2 %), las cadenas de comidas rápidas (12,5 %) y los **snacks** salados (7,9 %) son las 5 categorías de alimentos más publicitados.
- * 1 de cada 3 publicidades usa regalos o premios para incentivar la compra.
- * 1 de cada 4 utiliza personajes o famosos.
- * Se estima que los niños y las niñas argentinos están expuestos a más de 60 publicidades televisivas de comida chatarra por semana.
- * El sobrepeso en adolescentes de 13 a 15 años aumentó del 24,5 % al 28,6 % entre 2007 y 2012 según el Ministerio de Salud de la Nación. Si bien la publicidad de alimentos no saludables no es la única causa del sobrepeso y obesidad, abordar la restricción de este tipo de publicidad se considera como una parte fundamental de cualquier estrategia que intenta abordar el problema.

Las publicidades, muchas de ellas avaladas por colegas con matrícula y pocos escrúpulos, están en todos lados, y los *jingles* que hablan de energía interminable o de productos para que los chicos crezcan más y mejor pueblan nuestros oídos día a día. Y trabajar en cambiar eso también es partir de trabajar en salud pública.

Microbiota intestinal

Somos humanos gracias a las bacterias. Las bacterias nos ayudan a digerir, a pensar, a aprender, a comportarnos, a oler, a elegir pareja, a respirar. Todavía estamos en pleno estudio, pero lo que sí sabemos es que **la microbiota intestinal, además de estar condicionada por la forma de nacimiento, tiene que ver con los alimentos que consumimos.**

Una persona sana tiene muchas bacterias diferentes dentro de su microbiota

intestinal, lo cual la protege contra agentes dañinos. Multitud de patologías están asociadas a la disbiosis, es decir, el desbalance de la microbiota. Y es muy importante tener en cuenta que gran parte de esto se juega en nuestra alimentación, como hemos hablado en el tercer capítulo de este libro (“Los primeros 1000 días de vida”).

La historia de las papillas

Antes de que la pediatría apareciera y se empezara a “instruir” a las familias acerca de cuántos gramos de proteína debía consumir un niño por semana, la alimentación complementaria no era algo tan complejo.

Yo calculo que mis antepasados se morirían de risa ante este capítulo que estoy escribiendo y el devaneo mental de su descendiente ante el teclado. La gente miraba más o menos cuándo el bebé estiraba la mano para agarrar comida, le preparaba alguna cosa blandita o pisaba un poco lo que ya había cocinado. Le ponía un repasador en el cuello y listo. Ni procesadora, ni plato especial.

Pero esta fluidez familiar alimentaria se empezó a desmoronar cuando la gente dejó las zonas rurales, donde producía su propio alimento y decidía sobre él, y migró a las ciudades, donde empiezan a surgir las fábricas. Se comenzó a trabajar en peores condiciones, muchísimas horas por día, sin horarios fijos de comida. Las mujeres también empezaron a trabajar en las fábricas, no había licencias de maternidad ni horarios de lactancia. Había que hacer algo para que los bebés sobrevivieran, “independientes” de sus madres. Y se creó la leche de fórmula.

La leche de fórmula entonces, como vimos en el capítulo correspondiente, no se inventó por una necesidad médica ni por una necesidad de las mujeres, sino para permitir que las mujeres pasaran más horas trabajando, lejos de los bebés. El tema fue que esas leches de fórmula distaban muchísimo de ser parecidas a la leche materna, y muchos bebés continuaron muriendo por las mismas. La falta de agua potable, el hacinamiento, las epidemias y el uso de biberones de dudosa higiene no ayudaron en nada...

Entonces, si la leche de fórmula no nutría correctamente, ¿qué hacer? ¿Dar licencias de maternidad y promover que las madres estuvieran con sus bebés? Claro que no. La idea “genial” fue empezar a darles comida —alimentos complementarios— a los bebés desde tempranísima edad. Inclusive, se llegó a sugerir darles comida a los bebés desde los primeros días de nacidos. ¿Cuál es la única manera de darles “comida”? Sí, que esa comida sea líquida. Y ahí llegaron los cereales a la mamadera, y de ahí salieron las famosas papillas.

Las papillas no son una necesidad de los bebés, entonces. Surgen como una respuesta a una problemática de un sistema de trabajo orientado a la mayor

productividad, sin espacio para la extergestación ni para las necesidades básicas de la diada mamá-bebé.

Las papillas de cereales se volvieron un producto comercial sumamente exitoso. Góndolas y góndolas con diversas variedades, colores, ositos y, más novedosamente, frasquitos. Impensado alimentar a un bebé con otra cosa, al menos en un inicio. Es tan fuerte esta imposición cultural, que al día de hoy, muy internamente en mi corazón, me cuesta pensar en no darle a mi bebé esa mezcla de harinas y azúcar que tanto imaginé en mi infancia que les daría a mis hijos.

Si yo le indicara a una familia que mezcle harina de arroz, azúcar y harina de maíz, y le ponga agua, como primera comida para su bebé, me mirarían raro. Pero si les sugiriera que compren esa misma preparación, pero empaquetada y en venta en el supermercado con un osito azul, comprenderían perfectamente. Ese es el efecto de la publicidad en nosotros.

Entonces, ¿está “mal” dar papillas? Que los bebés comiencen a comer con papillas está tan establecido culturalmente que muchas sociedades científicas pediátricas lo incorporaron a sus recomendaciones. Estas recomendaciones van evolucionando y cambiando: hasta hace algunos años (1998), la Sociedad Argentina de Pediatría sugería iniciar la alimentación complementaria entre los 3-4 meses. Posteriormente, gracias a las diversas investigaciones, esta recomendación se modificó y hoy por hoy hablamos de la “norma de oro”. **Esta Norma de Oro es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por UNICEF y por las Sociedades Científicas en Argentina y el mundo: lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses y lactancia materna continuada hasta los 2 años o más.**

La Sociedad Argentina de Pediatría no se ha pronunciado formalmente aún acerca del método *Baby Led Weaning* (BLW, que ya veremos más adelante en este capítulo), pero la Asociación Española de Pediatría y la Agencia de Salud de Cataluña ya lo incluyen en sus recomendaciones de alimentación.

Más allá de eso, las sociedades científicas ya hace tiempo sugieren iniciar la alimentación complementaria con semisólidos, pero conservando su textura y evitando hacer un puré sin forma. La Organización Mundial de la Salud sugiere evitar alimentos aguados o muy blandos, que tienen menos densidad nutricional que alimentos más sólidos o espesos. Esta entidad plantea iniciar la alimentación complementaria con dichos alimentos espesos, e ir progresando paulatinamente la consistencia.

Existe una ventana crítica: si no progresamos la consistencia de las papillas a semisólidos y sólidos, generalmente por miedo al atragantamiento, no le estaremos permitiendo a nuestro bebé desarrollar los músculos de la masticación y de la deglución. Si no le permitimos “entrenar” estos músculos, perdemos un tiempo valioso de neuromaduración, y se predispone a dificultades en la alimentación.

No es raro encontrar niños de 5 o 6 años que no toleran ninguna textura que no sea procesada: al no progresar las texturas en el inicio de su alimentación complementaria, se perdió esa posibilidad de “aprender” a manejar el alimento.

En conclusión: los bebés no “necesitan” papillas, pero si de todos modos queremos iniciar la alimentación complementaria de esa manera, ¡no hay problema! Siempre y cuando respetemos la autorregulación de nuestros bebés y no olvidemos la importancia de progresar en las texturas.

#CososMarketineros: el chupete para frutas

Como bien dice el título, es una más de esas cosas que hace el mercado y nos quiere hacer creer que necesitamos. Y sí, para que no se sientan mal si lo tienen, yo casi lo compro cuando mi hijo mayor empezó a comer (cuando él gestionaba perfectamente gajos enteros de naranja desde el inicio... ¡Qué poco confiamos a veces en lo que pueden hacer nuestros hijos! ¿No?).

La idea de este dispositivo es meter trozos de fruta adentro de la red o bolsillo de silicona con agujeritos que trae, y que el niño de esa manera “coma fruta” y no se atragante. **Aun cuando la alimentación complementaria se inicie con papillas, es importante dejar explorar al niño e ir haciendo la transición a alimentos más sólidos.**

Es decir, no importa el método: eventualmente los chicos comerán pedazos enteros de alimentos y los podrán gestionar adecuadamente. Este chupete promueve todo lo contrario: la fruta siempre viene triturada y ni siquiera se extrae la mayor parte de la fibra. Además, es bastante difícil de limpiar correctamente, con lo que se acumulan residuos que pueden ser peligrosos para la salud.

Yo no recomiendo este #CosoMarketinero, porque es lo contrario a dejar explorar. Obviamente que es una sugerencia y que será la decisión de cada familia usarlo o no. Si ya lo tenemos, lo podemos usar como soporte para hacer heladitos de fruta o leche, por ejemplo.

La leche materna y los sabores

Se sabe que el líquido amniótico, probablemente, capta ciertos sabores de los alimentos que consume la madre, y son percibidos por el feto. Asimismo, sabemos que los sabores de los alimentos también pueden pasar a la leche materna. ¡Y esto es bueno! **Porque mientras el bebé mama, va recibiendo esa información sensorial que hace que, mientras más alimentos diversos haya consumido su mamá, más**

“reconoce” y probablemente acepte cuando inicie la alimentación complementaria.

Es otra de las ventajas de la leche materna por sobre la leche de fórmula: esta última tiene siempre el mismo sabor.

Baby Led Weaning (BLW), ¿algo nuevo? Alimentación autorregulada

En 2002, las recomendaciones de numerosas sociedades científicas para el inicio de la alimentación complementaria cambiaron, y la sugerencia empezó a ser iniciar la alimentación complementaria a partir de los 6 meses.

Un bebé de 6 meses ha adquirido habilidades neuromotoras más desarrolladas que uno de 4: puede tomar cosas con sus manos y llevarlas a la boca, perdió el reflejo de extrusión (más abajo lo explico), tiene el tronco más erguido o directamente se sienta, algunos ya se desplazan, ven mucho mejor y el mundo ya es mucho más interesante. En base a esto y a la epidemia de malnutrición mundial, familias y profesionales comenzaron a cuestionarse la alimentación basada en papillas y dirigida por el adulto.

¿Puede un bebé ser obligado a tomar el pecho si no lo desea? ¿Puede tomar leche en la mamadera si no tiene hambre? La respuesta es no. No abrirá la boca para tomar el pecho, o escupirá la mamadera, o rechazará con la lengua. **Los bebés se autorregulan naturalmente, sin que se lo enseñemos.**

¿Cómo comemos los adultos? ¿Nos autorregulamos? ¿O vaciamos el plato para no molestar a quien nos cocinó, aunque no tengamos hambre? ¿O terminamos la bolsa de papitas porque no podemos dejar de comerlas? ¿Eso es hambre? ¿Eso es placer? Probablemente no. Es un consumo de alimentos con muy poca conciencia y autopercepción. No sabemos cuándo tenemos hambre, porque nos regimos con horarios del trabajo o de otras actividades, y no con la percepción de nuestras necesidades.

Nos encontramos en un momento mundial de graves deficiencias a nivel alimentario. Existen áreas donde prima la desnutrición, pero, en gran medida, la alimentación de deficiente calidad ha afectado gravemente a la sociedad occidental generando una verdadera epidemia de malnutrición. Esto es muy visible a través del sobrepeso y la obesidad, pero también a través de las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión o la diabetes (y cada vez hay más niños con estas condiciones).

En respuesta a estas realidades e inquietudes, se plantea que el primer contacto con la alimentación complementaria sea basado en la autorregulación y en alimentos

reales. Y de eso se trata el *Baby Led Weaning* (BLW). *Baby Led Weaning* se traduce como “destete dirigido por el bebé”. Cabe explicar que la palabra en inglés *weaning* no significa “destete” por “dejar la teta”, sino por “incorporar otros alimentos aparte de la teta”. Plantea ofrecer alimentos de alta calidad nutricional y permitir que el bebé dirija la alimentación, decidiendo qué quiere comer y cuánta cantidad.

A mí no me gusta decir que el BLW es un “método”, porque no es nada nuevo. La alimentación complementaria en la antigüedad, antes de que Nestlé inventara la primera papilla comercializada, era de esta manera. No hemos descubierto la pólvora. Al revés: este método implica empezar a desestructurarse, a disfrutar, a percibir al bebé como persona y parte de la familia, y que el comer sea un momento de experimentos y disfrute.



El BLW plantea:

- * Sentar al bebé a la mesa con toda la familia, que no haya un tiempo “diferente” para que coma el bebé.
- * Ofrecer al bebé las mismas comidas que consume la familia, adaptadas a su desarrollo (ver más adelante).
- * Permitir que se alimente por sí solo, usando las manos o los cubiertos, según la edad.
- * Recordar que la leche materna o de fórmula es la base de la nutrición durante el primer año de edad y no “espaciar tomas” para que el bebé coma.

¿Todos los bebés pueden hacer BLW?

Se considera que todo bebé que cumpla las pautas madurativas propuestas para el inicio de la alimentación complementaria es apto para realizar BLW. Si el bebé tiene alguna condición de salud neurológica o motora, hay que evaluarlo.

¿Pero si no come “mucho”, va a estar bien nutrido?

Sí, porque hasta el año de vida los bebés son lactantes. La leche les provee gran parte de los nutrientes necesarios. Hay una brecha de nutrientes, sobre todo de hierro, que es preciso aportar con la alimentación complementaria. Por eso es importante ofrecer alimentos de alto valor nutricional, y no productos superfluos. La cantidad la decidirá el bebé.

BLW ¿vs.? papillas

¿Es *Baby Led Weaning* “comer en pedacitos sólidos”? Es la percepción más común de familias y profesionales de la salud que no se han interiorizado en el tema. La respuesta es NO, rotundamente no.

El BLW no apunta a ofrecer arbolitos de brócoli o gajitos de mandarina enteros: apunta a que el bebé inicie la alimentación complementaria en una forma respetuosa de sus tiempos y de sus ganas de comer, ofreciendo alimentos sanos y adaptados a su edad.

Se suele contraindicar el BLW por considerarlo riesgoso con relación al atragantamiento. ¿Lo es? No, si adaptamos los alimentos a cada etapa del bebé. Igual que lo haríamos con las papillas.

¿Es una “recomendación” hacer BLW? ¿Es “mejor”? La intención de hablar de diferentes métodos de inicio de la alimentación complementaria es simplemente dar información y que cada familia pueda decidir lo que es mejor para ella. Hay ciertos beneficios en estudio con respecto al BLW y su relación con la motricidad, el habla y la prevención de la obesidad infantil, pero están en revisión.

¿Puedo iniciar la alimentación complementaria con papillas, o en forma mixta, o hacer BLW y cada tanto dar un puré, si respeto la autorregulación? Ya hemos dicho que sí, porque aquí lo importante es esto último: permitir que el bebé experimente.

En ocasiones, hay familias que desean practicar BLW, pero sus bebés concurren al jardín o queda a cargo de cuidadores que no se animan a implementarlo (como abuelos ansiosos de hacer “avioncitos”). ¡La realidad de todas las familias no es la misma! Y las recomendaciones tienen que adaptarse a cada una. No hay problema, lo ideal es instruir a los cuidadores a respetar la exploración y las ganas del bebé. Con

eso asegurado, durante las comidas que compartamos no habrá inconvenientes de continuar con el método que hayamos elegido.

Baby Led Introduction to Solids (BLISS)

Dijimos que el BLW propone incorporar al bebé a la mesa familiar, y no preparar comidas especiales, sino adaptar las comidas que consume el resto para el bebé. El problema es que **si la familia no cambia sus hábitos poco saludables, el bebé estará en riesgo de no recibir los nutrientes adecuados, sobre todo el hierro.**

Esta fue una gran crítica al BLW, por lo que se reajustó el “método” (ya saben que no me gusta decirle así) de tal manera de tener un ayuda memoria para que las comidas sean siempre nutricionalmente significativas. A esa modificación se la llamó BLISS, *Baby Led Introduction to Solids*.

¿Qué propone el BLISS? Básicamente asegurarse de que cada comida que se le presente al niño (no, probablemente no la coma toda, hay que presentársela) tenga:

- **Un alimento rico en hierro (carnes, legumbres).**
- **Un alimento rico en energía (carbohidratos, grasas).**
- **Una fruta o verdura (adaptada a su desarrollo).**

¿Comerá el bebé toda esa comida? Alguno que otro sí, pero lo más probable es que deje gran parte. Seguimos confiando en su regulación.

Arrancando la alimentación complementaria

Pautas para empezar la alimentación complementaria (incluso si recibirán papillas)

El bebé puede permanecer sentado, con o sin ayuda

En este punto, habrá familias que practiquen estrictamente movimiento libre y deseen esperar que los bebés se sienten por sus propios medios, y familias que han colocado al bebé en la posición de sentado.

Con respecto al primer caso, los bebés no suelen llegar naturalmente a sentarse por sus propios medios a los 6 meses, ese proceso se suele extender aproximadamente hasta los 8-9 meses. **Los estudios indican que es aconsejable no demorar la alimentación complementaria mucho más allá de los 7 meses y medio, porque más tiempo podría hacer que faltaran ciertos nutrientes importantes, y que perdiéramos “ventanas de oportunidad” para el desarrollo de la deglución y la masticación.**

Entonces, ¿cómo hacer? Se puede sentar al bebé en la falda, apoyado contra el cuerpo del adulto, permitiéndole el sostén del tronco sin forzarlo, dejándolo libre para que utilice sus manos.

En el caso de bebés que hayan llegado a la posición de sentado por su cuenta o por intervención del adulto, es importante que sea estable y que no esté “atado” con correas a la sillita de comer para permanecer erguido.

El bebé tiene que poder usar sus manos para explorar y no para sostenerse

Evitar las correas que aprieten o atan el abdomen. Algunas sillitas tienen correas de seguridad, que están muy bien para evitar accidentes si cuidamos su regulación. Evitar sentarlos en lugares con respaldos reclinados, como el cochecito o el *bebesit*.

Llevarse algo a la boca es un complejo proceso que incluye el sostén cefálico y del tronco, la coordinación de ojo-mano-boca, la presión de la pinza hecha con la mano para tomar alimentos, el trayecto del alimento a la boca, el movimiento de la boca para recibirlo, el olor, el sabor, la temperatura, la textura... ¡es un gran desafío!

El bebé tiene que mostrar interés en los alimentos

A medida que el bebé va creciendo, el mundo es cada vez más interesante. Los mapadres lo observamos asombrados: de a poco, toca todo, tira todo, aprieta todo, hace ruiditos respondiéndonos.

El interés por lo que come el adulto no es menor. **Los bebés suelen estar interesados por el proceso de comer de sus mapadres mucho antes de estar listos para la alimentación complementaria.** Estiran las manitos, meten los dedos en el mate, agarran el costadito del vaso de agua. Esto no predice “cuánto” va a comer más adelante (y ya hemos dejado claro que el “cuánto” no nos preocupa mucho), sino que habla de un proceso madurativo esperable.

El bebé ha perdido el reflejo de extrusión

Para tomar la teta, los bebés cierran la boca con la lengua. La apoyan debajo del complejo areola-pezones y hacen movimientos con ella para exprimir la leche. Con la

mamadera pasa algo parecido, si bien la posición de la lengua es diferente.

Esto que hacen con la lengua es un reflejo creado por la naturaleza para permitir que el bebé se alimente, y se llama “reflejo de extrusión”. **Todo lo que le metamos en la boca a un bebé antes de que las vías nerviosas de este reflejo hayan madurado, hará que saque la lengua y lo empuje para afuera.** Es por eso que si le damos una cucharada de cereales a un bebé de 4 meses, es posible que los escupa: no es capaz de evitar ese reflejo.

Alrededor de los 6 meses, algunos bebés antes y otros después, pierden este reflejo. No todos: es por eso que a algunos bebés alimentados con papillas y cuchara “no les gusta nada”, “todo lo escupen” y “no comen nada”. Simplemente no están listos para comer.

¿Cómo sé si mi bebé tiene o no reflejo de extrusión? No hace falta hacer ningún test extraño. Si agarra cosas con sus manos y se las lleva a la boca, o si abre la boca ante la llegada de la cuchara, o si traga trocitos, probablemente ya lo haya perdido. De otra manera, es cuestión de esperar un poquito nomás.

“Desea... ¿le puedo dar?” Los adultos y el apuro

A los bebés les debemos parecer los seres más fabulosos del planeta. Como cuidadores adultos, los hacemos sentir bien al sonreírles, al acariciarlos, al saciar su hambre, al cambiarles los pañales. Todo lo que hacemos delante de ellos es fascinante, es un mundo de movimientos, colores, aromas, texturas y sensaciones.

La leche materna, o de fórmula si es necesario, cubre la mayor parte de las necesidades nutricionales durante el primer año de vida, por lo que la alimentación complementaria es eso: COMPLEMENTARIA. Un momento para descubrir y disfrutar.

Los bebés nos miran y quieren imitarnos, incluso en nuestra hora de comer. Eso no quiere decir que “tengan hambre” o que “deseen comida”. Quiere decir que somos su ejemplo y nos imitan. Inclusive algunos hacen movimientos al estilo “masticar”.

Sin embargo, los adultos somos nosotros y tenemos la responsabilidad de tomar decisiones sobre la salud de los chicos. **¿Le puede hacer mal iniciar la alimentación complementaria antes de los 6 meses? La respuesta es SÍ, puede ser nocivo a corto y largo plazo.**

Entre otras cuestiones:

- Aumentan las posibilidades de atragantamiento, no importa si hacemos BLW o papillas.
- Aumentan las posibilidades de gastroenteritis e infecciones respiratorias (por

inmadurez intestinal y por riesgo de aspiración).

- Puede interferir con la absorción de hierro y otros nutrientes.
- Se sustituyen cantidades de leche por alimentos menos nutritivos (100 g de puré de zapallo tienen MUCHÍSIMAS calorías y minerales menos que 100 ml de leche materna).
- Aumenta el riesgo de obesidad.
- Aumenta el riesgo de dermatitis atópica.
- Aumenta el riesgo de diabetes.
- Aumenta el riesgo de alergias alimentarias.
- Aumenta el riesgo de destete precoz.

Hace años, se iniciaba el dar de comer a los 3-4 meses (lo vimos al principio del capítulo). Esto se estudió y se llegó a la conclusión de que, por las cuestiones citadas, puede ser peligroso y la edad mínima hoy por hoy está planteada en 6 meses.

La leche materna o de fórmula cubre casi todos los requerimientos hasta el año. No hay apuro. Respetemos los tiempos de los niños y no queramos apurarlos por nuestra propia ansiedad.

La alimentación complementaria es complementaria

La alimentación en un inicio es COMPLEMENTARIA (qué repetitiva, Sabrina). Es decir, la leche, sea materna o de fórmula, seguirá siendo la primera fuente de nutrición para este bebé, y la comida, un momento de exploración. No importa si se quedó dormido y no cenó. **No hay tampoco que sacar o espaciar tomas de leche para “que tenga más hambre”. Progresivamente, si se lo permitimos, va a ir regulando las tomas de leche por su cuenta.** No va a tener “más hambre” por no tomar la teta o la fórmula, y le estaríamos quitando nutrientes esenciales que está incorporando mediante la leche.

Es posible que aplasten todo con la mano y se nieguen a abrir la boca. Que lo más cercano a comer sea arrojar la comida al piso y que la limpie la mascota.

¿Existe el “enseñar a comer”? Los bebés se alimentan desde su primera hora de

vida (idealmente) y nadie les explica cómo. Con la alimentación complementaria, idealmente debería pasar lo mismo. Nos esforzamos en que use plato, cuchara y babero cuando el niño está empeñado en destruir todo con sus manos... ¡como corresponde!

Dejar experimentar

Con el inicio de la alimentación complementaria, nos encontramos frecuentemente con estas frases:

“Tira todo al piso”.

“No come nada, solo juega”.

“Yo le cocino pero nomás lo aplasta y lo tira, y eso me frustra”.

“No le gusta nada”.

Cuando un bebé se sienta a la mesa, hay muchísimas expectativas familiares alrededor de lo que “tiene” que comer, tanto en cantidad como en qué alimentos.

Y es importante destacar que son eso: expectativas. Supuestos que tenemos los adultos y fuimos construyendo a través de nuestra vida acerca de lo que “tiene” que hacer un bebé.

Inicialmente, el bebé no se sienta a “COMER”. No sabe que esos elementos calman su hambre. Se sienta a JUGAR, a explorar, a tirar al piso a ver cómo cae, a embadurnarse, a llenarse el ojo con batata, a enojarse porque se le cae la banana, a toser para entrenar la vía aérea.

Es importante acompañar ese proceso y revisar como adultos por qué nos frustra. Nos da miedo no poder alimentar a nuestras crías. Y en realidad, nos enfrentamos a que nuestro bebé ha crecido, y que es capaz perfectamente de regular su propio alimento.

Recordemos que la leche, ya sea materna o de fórmula, es el alimento más importante durante el primer año de vida. **Si le presentamos además alimentos con alto valor nutricional, no importa la cantidad que coman; y esto aplica tanto a las familias que inician la alimentación complementaria con papillas como las que hacen BLW/BLISS o mixto.**

Dejar que se ensucien es más que importante. Si todo el tiempo les estamos limpiando las manos o la boca mientras comen, tendrán una percepción negativa sobre dicha actividad, y puede contribuir a crear dificultades en la alimentación.

La comida es un mundo de exploración y disfrute. Aprendamos con ellos.

El ambiente

Es aconsejable que el ambiente esté relajado, con la tele y otros dispositivos apagados, y el bebé de buen humor, sin mucha hambre. Explicarle que ahora vamos a comer, ponerle su “ropa de comer”, babero, pintorcito o lo que sea (puede no ser nada de eso y simplemente usar ropa gastadita, o lavar ropa, o dejarlos en pañal si el clima lo amerita y punto); sentarlo y limpiarle las manos con un trapo húmedo.

Explicarle. Tu bebé entiende. Tal vez no las palabras, pero sí entiende tu tono de voz y gestos. Decirle: “Ahora, Robertito, vamos a comer”, no está de más. **Cada familia decidirá qué es mejor para ella, pero no hay nada más lindo que poder compartir la mesa todos, y que no haya un momento “para que coma el bebé” y otro para que coma el resto.** La alimentación autorregulada permite esto: que el bebé sea parte de la mesa.

Evitar que se siente a la mesa con hambre también es un buen dato. El bebé no sabe que eso es comida, que, en algún momento, ese alimento va a saciar su hambre. Lo que le llena la pancita es la leche. Probablemente si sentamos a un bebé con hambre a la mesa, se ponga fastidioso y no tenga ganas de explorar.

¿Siempre hay que ofrecerle teta o mamadera antes de comer? No, la leche es a libre demanda, va a depender de sus ganas. No lo hagamos rígido: simplemente, tratemos de que no se siente “con hambre” a la mesa.

¿Qué alimentos sí?

No existen los alimentos “para bebés”. Existen los alimentos, que son para todo el mundo. Lo que podemos hacer es adaptarlos para bebés: un bebé de 1 año tiene otro manejo de los alimentos que el bebé que inicia la alimentación complementaria.

La idea es ofrecerle al bebé lo mismo que se come en la mesa familiar (exceptuando preparaciones con miel y otros ingredientes que detallaremos al final). Colocarle la comida al alcance de sus manitos y que experimente. Sin necesidad de cucharas térmicas, platos especiales u otras cuestiones.

Podemos ofrecer la mayor parte de los alimentos que consumimos diariamente:

- * TODAS las frutas (naranja, manzana, banana, mandarina, frutilla, pera, durazno, damasco, etc.). Si son de producción agroecológica y de estación, mucho mejor, pero de no serlo, no es un impedimento para no consumirlas, al igual que las verduras.

- * TODAS las verduras (palta, brócoli, zapallo, zapallito, papa, batata, zanahoria, tomate, cebolla, espárragos...), exceptuando verduras de hoja verde como acelga y espinaca.
- * Carne de vaca (excepto carne picada), pollo, cerdo, pescado, otras carnes.
- * Huevo, clara y yema.
- * Legumbres y cereales: quinoa, mijo, lentejas, garbanzos, trigo, avena, maíz, cebada, centeno... (todo lo que es pequeño y posible de irse a la vía aérea, ¡en preparaciones! Lo veremos más adelante).
- * Frutos secos: maní, nueces, almendras, girasol, castañas... (NUNCA ENTEROS. ¡En preparaciones!).
- * Harinas para preparaciones (trigo, trigo integral, avena, arroz, maíz, almendras, maní, algarroba, etc.). Hay miles de harinas además de la aburrida harina blanca (que tampoco está mal, ¡solo que es aburrida!).
- * Pastas que puedan gestionar (mostacholes, tirabuzones). Pastas rellenas solo si son caseras con ingredientes aptos.
- * Es aconsejable usar aceite (si es de oliva o coco, mejor), *ghee* (manteca clarificada) e incluso manteca (no margarina) para las preparaciones. Los bebés requieren grasas para el desarrollo del cerebro, así que las versiones “descremadas” de alimentos no deberían estar introducidas hasta al menos los 2 años.
- * Los “jugos vegetales” (“leche” de almendras, de coco, de maní...) se pueden utilizar en preparaciones. Recordemos que no son “leches”, la confusión viene porque son blancas, generalmente. No se puede comparar este alimento con la leche. Sería como comparar una mandarina y un filet de merluza: son cosas distintas.
- * Las sopas y caldos son una posibilidad, pero es preciso limitar su contenido de agua y estar atentos a su composición. Deben ser muy nutritivas (por ejemplo, el caldo de huesos) para evitar “llenar la panza de agua” y desplazar a otros alimentos nutritivos.
- * Para tomar, agua únicamente. Y la leche de siempre.

Calendario orientativo de incorporación de alimentos

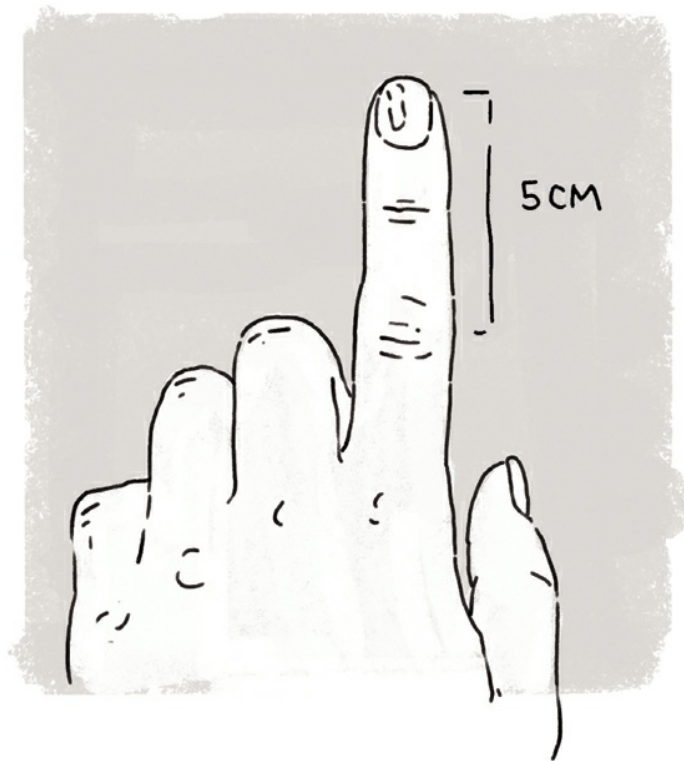
ALIMENTO	0-6 meses	6-12 meses	12-24 meses	> 2 años
Leche materna				
Fórmulas adaptadas (en caso de no estar con LM)				
Cereales, frutas, hortalizas, legumbres, huevo, carne, pollo, pescado, aceite de oliva				
Leche entera, yogur, queso tierno (pueden ofrecerse en pequeñas cantidades a partir de los 9 o 10 meses)				
Sólidos con riesgo de atragantamiento (frutos secos enteros, manzana o zanahoria cruda, etc.)				Por encima de los 3 años
Alimentos superfluos (azúcares, miel, chocolatada, galletitas, cereales con azúcar, facturas, embutidos)	Cuanto más tarde y en menor cantidad mejor (siempre a partir de los 12 meses)			

Modificada de "Recomendaciones para la alimentación en la primera infancia",
Agència de Salut Pública de Catalunya, 2016.

¿Cómo presentar?

Hay tres puntos a tener en cuenta:

El tamaño: pensemos que es algo que tiene que poder tomar el bebé con su mano inexperta aún. Evaluemos el largo: tiene que sobresalir del puñito cerrado del bebé, es decir, aproximadamente 5 cm de largo, o del largo del dedo índice de un adulto. O miremos el puñito de nuestro bebé y listo. También pensemos que no tiene que ser muy pesado, porque al principio no va a poder levantarlo. De a poco la mano se va desarrollando, y a medida que pasan los meses, los bebés van aprendiendo a hacer una pinza más fina entre el índice y el pulgar. Esto, en conjunto con el desarrollo de los movimientos masticatorios y la aparición de dientes, va a permitir presentar más adelante trozos más pequeños. Para empezar, reproduzco una excelente frase de la puericultora e investigadora en salud y alimentación Luisina Troncoso: “Mientras más pequeño el bebé, más grande el trozo que presentamos”.



La forma: todo lo que sea pequeño y redondo tiene posibilidades de irse por el camino incorrecto: en vez de ir al esófago, pasar a la vía aérea, con el consiguiente riesgo de asfixia. ¿Qué cosas son pequeñas y peligrosas? El maní, el girasol, los arándanos, las uvas, los tomates *cherry*, los garbanzos... Entonces, ¿no se pueden consumir estos alimentos? Claro que se puede, simplemente hay que adaptarlos.



La textura: este es el punto que amo compartir. La textura de los alimentos para iniciar BLW no es muy diferente a la de un puré: tiene que poder deshacerse si lo apretamos entre el índice y el pulgar. ¡El BLW no es mucho más que puré en barritas accesibles para manipular!

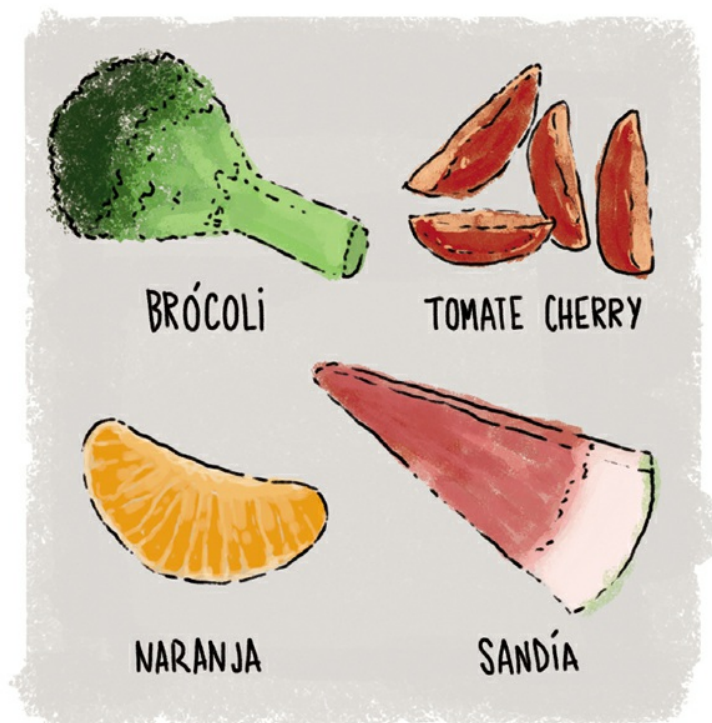


Comparto algunas opciones de formas de presentación de los alimentos para realizar BLW. No hay que seguirlas a rajatabla, hay que encontrar la forma que mejor nos sirva, y eso se hace a prueba, error y diversión. **A medida que los bebés vayan desarrollando la masticación y deglución, y vayan perfeccionando la pinza digital (durante el desarrollo motor de la mano), vamos a poder ir achicando el tamaño y aumentando la consistencia.** Se plantea que aproximadamente al año, un bebé puede recibir los alimentos con la misma textura que un adulto, aunque evitamos algunos de ellos por prevención (lo veremos en el siguiente apartado).

Sobre las frutas y verduras

¡Protagonistas plenos del plato! Mientras más coloridos, mejor. Priorizar que sean de estación. ¿Cómo sé que algo es de estación? En la verdulería hay mucho y barato. Consejo: comprar en cantidad. Si sobra, seguramente habrá alguna manera de hacer algo con eso y meterlo en el *freezer*, para el momento en que ya no esté en estación.

Las frutas y verduras que son “duras” no se recomiendan crudas hasta que no sean capaces de gestionarlas. Por ejemplo, la manzana o la zanahoria. Entonces, ¿no damos manzana? Por favor, que no nos falte la manzanita: podemos hacerla rallada, asada, en compota, en preparaciones...



Si la leche de vaca no se recomienda hasta el año de vida... ¿con qué cocino?

Podés cocinar con:

- Leche materna: mucha gente me pregunta si pierde sus propiedades. Sí, como todo alimento que se cocina, muchas características cambian. Pero sigue siendo excelente. El Banco de Leche Humana de Mendoza tiene hasta talleres de cocina con leche materna: hacen panqueques, *scones*, *muffins*, flanes...
- Leche de fórmula: puede usarse para cocinar, sin problemas.
- “Leches” vegetales: de coco, de almendras, de castañas de cajú...
- Agua.

¿Cómo presentar legumbres (arvejas, lentejas, garbanzos, porotos, habas...), dado que son redonditas y pequeñas?

- En forma de purés o pastas.
- En forma de harinas (en la dietética se venden harinas de lentejas o de arvejas, se pueden mezclar con huevo y hacer un *omelette* divertido).
- En forma de fideos, hay marcas de pastas hechas con dichas harinas.
- En forma de hamburguesitas, croquetas o *muffins*.
- En panificados, como la fainá (se realiza con harina de garbanzos).
- O simplemente, un poco pisadas después de la cocción para que pierdan esa forma.

¿Cómo incorporar cereales?

- En forma de harinas (trigo, maíz, avena, arroz, centeno, etc.).

- En forma de puré espeso, como la polenta, el mijo, la quinoa.
- En forma de barritas (barritas de polenta).
- En forma de preparaciones cremosas (arroz con leche, *porridge*).
- En bollitos o hamburguesitas (los bollitos de mijo son una gran opción y muy sencillos de realizar. Básicamente hay que cocinar mijo... y hacerlo bollitos).

¿Cómo presentar uvas, tomates *cherry* o arándanos?

- Al inicio de la alimentación complementaria, sin semillas y en preparaciones.
- Más adelante, cortados en 4 a lo largo para las uvas y tomates *cherry*, y a la mitad para los arándanos.

¿Cómo incorporar frutos secos (maní, almendras, castañas, castañas de cajú, avellanas, nueces...)?

Los frutos secos tienen grasas saludables y muchos minerales. No nos privemos de ellos: hay múltiples formas de presentarlos.

- Molidos o rallados.
- En harinas.
- En pastas (crema de maní, crema de girasol... no son más que los frutos secos procesados hasta lograr la consistencia cremosa). Podemos ofrecerlas untadas en otros alimentos o en cucharitas precargadas.

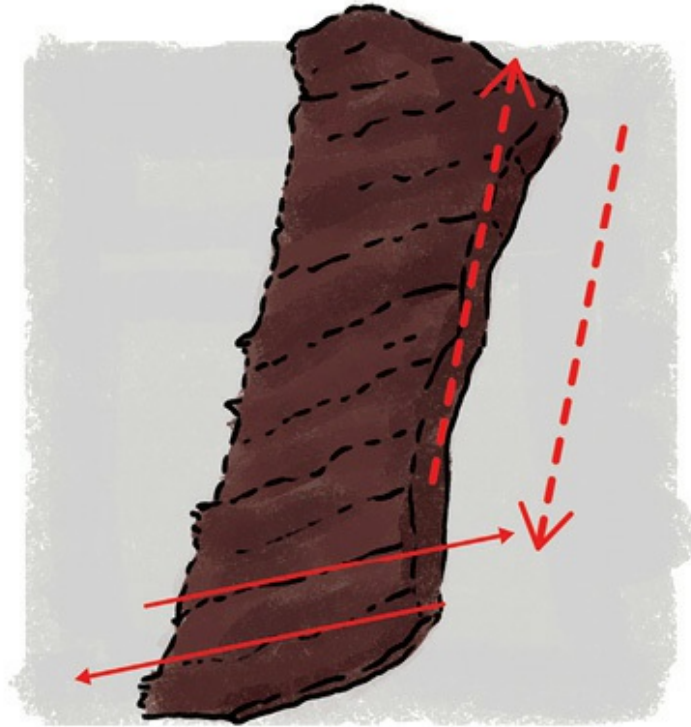
¿Cómo incorporar el huevo?

Siempre bien cocido, podemos ofrecerlo en trozos como en la foto, o podemos deshacerlo como puré, o podemos incorporarlo a preparaciones (tortillas, *omelettes*, *muffins*, hamburguesas de legumbres o cereales, flan...). Posteriormente desarrollaré el tema alergias.



¿Cómo ofrecer carne? ¡No tiene dientes!

Los bebés no necesitan dientes para empezar a comer. Van a deshacer todo (lo que tengan ganas) con sus encías. Para ayudarlos, la carne se corta en tiras en contra de sus vetas. Las vetas son las “rayitas” que tiene la carne. Cortamos de tal manera que las vetas queden una arriba de otra y no a lo largo, lo que le permite al bebé arrancar pedacitos más fácilmente con las encías. La carne, pollo, cerdo o la que elijamos tiene que cocinarse de tal manera que pueda deshacerse fácilmente y no quedar jugosa, sino absolutamente cocida.



Otra forma de presentar la carne es cocinarla, deshilacharla y hacerla en purés o croquetas caseras.

Recordemos que no se recomienda el uso de carne picada en niños, al menos hasta los 5 años de edad. Si necesitamos hacer una preparación con esta presentación de carne (por ejemplo, empanadas o pastel de papas), lo ideal es cocinarla completamente y luego procesarla.

¿Y el gluten?

Según la Guía de Práctica Clínica sobre Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Celíaca, desarrollada por el Ministerio de Salud en 2017, **no se retrasa la introducción del gluten en ninguna persona, tampoco en parientes de personas con celiaquía. Retrasar su introducción generaría mayor intolerancia**, y se sugiere presentar alimentos con trigo, avena, cebada y centeno a partir de los 6 meses y no más allá de los 7. Esta recomendación se encuentra en constante revisión.

¿Con qué empezar?

Los alimentos que vaya a recibir un bebé dependerán de la cultura de esa familia. No hay algo “mejor”, porque el bebé no conoce esos sabores ni texturas, y todo será

novedoso y digno de ser explorado. Pueden empezar con lo que deseen, mientras no sea peligroso para el bebé. ¿Tal vez un trocito de palta? ¿Un puré de papa? ¿Pera en compota? ¿Banana madurita?

Tengo un solo consejo para la primera comida: disfrútenla.

¿Qué alimentos no?

- **Miel de abejas hasta los 2 años** (bibliográficamente, se sugiere no ofrecer hasta el año por riesgo de botulismo. El extenderlo hasta los 2 años es una apreciación personal). En su composición, la miel puede contener esporas de *Clostridium botulinum*, una bacteria que causa botulismo. El botulismo es una enfermedad que se caracteriza por una “parálisis flácida”, es decir, todos los músculos, inclusive los respiratorios, se ponen “flojos”, causando primero dificultad para moverse y luego imposibilidad de respirar. Puede ser fatal. ¿Por qué los niños más grandes y adultos consumen miel y no tienen botulismo? Porque su intestino es más maduro que el de un bebé, y las esporas no se desarrollan, destruidas por los jugos gástricos. Cocinar con miel tampoco es seguro, dado que no estamos seguros de que alcanzamos la temperatura adecuada para eliminar las esporas.
- **Azúcar agregado** (ver “Los mil nombres del azúcar” más adelante).
- **Sal agregada.** El 75 % de la sal que consumimos viene de los productos ultraprocesados. Hasta el año de vida no se recomienda el consumo de sal, y posteriormente, no se recomiendan más de 2 g diarios en total.
- **Carne picada hasta mínimo los 5 años, por riesgo de síndrome urémico hemolítico.** Elegir un trozo y que lo pique delante de nosotros es lo mismo, y picarla cruda en casa también es lo mismo. No se recomienda. (Ver más información en el capítulo 13: “Mocos, tos, fiebre, chichones... y otros temas que nos preocupan”).
- **No se sugiere incorporar leche de vaca hasta el año de vida, luego puede consumir leche entera.** La Asociación Española de Pediatría habilita el consumo de algunos quesos y yogures sin agregados desde los 10 meses. Importante evaluar en la etiqueta que sean queso y yogur, y no “alimento a base de queso”, por ejemplo.
- **Alimentos que puedan aspirarse e ir fácilmente a la vía aérea (maní, tutuca,**

garrapiñada, pipas de girasol).

- **Manzana o zanahoria crudas.** Son duras y, por lo tanto, se puede romper el trozo, e ir peligrosamente para la vía aérea.
- **Las hojas verdes como la acelga y la espinaca cuentan con nitratos en su composición.** Estos nitratos en bebés menores de 1 año podrían causar metahemoglobinemia, una afección sanguínea que causa una coloración azulada en la piel. Los estudios que plantean esto son españoles, en bebés pequeños (menores de 3 meses). Dado que ya no le damos comida a bebés menores de 3 meses, habría que reevaluar esta recomendación. La acelga y la espinaca son de consumo muy popular en Argentina, y no hay casos de metahemoglobinemia descriptos en el país por estos vegetales. Se sugiere que no ocupen más de un 20 % del plato si deseamos ofrecerlas a bebés menores de 1 año.
- **No se recomienda el consumo de algas en la infancia por riesgo de intoxicación por el alto contenido de yodo que contienen.**
- **Productos ultraprocesados:**
 - Galletitas industriales y otros productos de baja calidad nutricional con grandes cantidades de azúcares como el jarabe de maíz de alta fructosa.
 - Postrecitos y yogures industrializados. Además de contener leche de vaca, si observamos sus etiquetas, tienen una alta cantidad de azúcares y otros aditivos.
 - Embutidos (salchichas, jamón, etc.), por su alto contenido de colorantes, conservantes, sal y otros aditivos.
 - Gaseosas, jugos industriales, jugos de soja y toda esa góndola del supermercado está terminantemente afuera de lo que debería consumir un niño (¡y un adulto también!).
 - Calditos de sobre o concentrados “de cuadradito”. Sopas o purés instantáneos.
- **Los jugos exprimidos tampoco se aconsejan.** Cuentan con el azúcar de la fruta pero no con la fibra, y con menos nutrientes que el trozo entero. Si los ofrecemos, que sea esporádico y como golosina.
- **Té de “yuyos”:** anís estrellado, paico, boldo, manzanilla, etc. No se recomienda en niños por alto riesgo de toxicidad. Se han observado hemorragias digestivas, broncoespasmos, convulsiones y otras manifestaciones graves por el consumo de estos preparados.
- **Las infusiones (té, café, mate) y el cacao tienen xantinas, compuestos que**

estimulan al sistema nervioso central y tienen cierto efecto diurético.

Interfieren en la absorción del hierro (por eso “tomarse un cafecito” después de la comida no es para nada beneficioso en ese sentido). Muchas familias consultan acerca de darles a probar mate, por una cuestión cultural, y sí podríamos hacerlo como un juego, pero no como una infusión. Lo sugerible es no fomentar el consumo de infusiones porque ocupan lugar en el estómago y tienen baja calidad nutricional, desplazando a otros alimentos. En invierno es muy común la pregunta acerca de “dar algo calentito”. Si vamos a ofrecerlas, hagámoslo en pequeñas cantidades y en conjunto con alimentos saludables.

- **Soja.** La soja contiene fitoestrógenos, que pueden actuar como un disruptor endocrino, es decir, en cantidades excesivas puede actuar sobre los receptores de algunas hormonas y producir cambios, por ejemplo, en los caracteres sexuales secundarios (aparición temprana de tejido mamario, entre otros). El problema no son los porotos de soja ni las barritas de tofu, es el altísimo contenido de soja utilizado para “estirar” productos ultraprocesados como las salchichas, hamburguesas, “patitas de pollo”, las famosas milanesas de soja... Si evitamos los ultraprocesados, podemos ofrecer preparaciones con tofu, si es orgánico mejor, o con brotes o porotos de soja sin problemas si son parte esporádica de la alimentación.
- **Alimentos enlatados, por el alto contenido de sodio que contienen, y por tener bisfenol A en el recubrimiento de la lata.**

Algunos cuidados más

- **Las semillas de las frutas y verduras**
 - Cuidado con las semillas duras, como las de los cítricos, pueden ser motivo de atragantamiento.
 - Las semillas de la banana no “caen pesadas”, no hace falta sacarlas (seguramente más de un lector se está desayunando con esto de que la banana tiene semillas). Se ven en la caca como “pelitos negros”, no tengan miedo, no son parásitos.
 - Las semillas del tomate son muy pequeñas y gelatinosas, no hay riesgo. No causan apendicitis (otra pregunta frecuente).
 - Las semillas externas de la frutilla también pueden ser consumidas sin problemas.
- **Las cáscaras**

- Si la fruta o verdura es orgánica o agroecológica, no recibió pesticidas, y se puede consumir la cáscara sin problemas. Generalmente esperamos a que tengan dientes para ofrecerla.
- Si no lo es, simplemente hay que pelarla. Los agroquímicos se concentran sobre todo en la cáscara.

¿Cuánto presentar?

“¿Cuán grande es la porción que debo darle? ¿Un plato? ¿Medio plato? ¿Cuánto debería comer para que esté ‘bien’?”. Antes, algunas preguntas: ¿alguna vez pudiste decidir en tu infancia cuánto ibas a comer? ¿O se la pasaron diciéndote “hasta terminar este plato no te levantas”, “sin comida no hay postre”, “te vas a dormir castigado sin comer”?

Estos conceptos, junto con los productos que acaparan todas las góndolas, han creado vínculos insanos con la comida, tales que sufrimos una enorme epidemia de obesidad y de trastornos de la alimentación que se cobran vidas todos los días.

La intención es que el bebé se autorregule y elija la cantidad que desea comer.

Que si un día se come una palta entera, un huevo y tres fideos, esté perfecto; y que si otro día decide solamente tomar teta y un bocadito de zapallo, también esté bien. Su cuerpo sabe cuántas calorías necesita.

La alimentación autorregulada consiste en dejar explorar y permitir decidir, no “qué vamos a comer”, dado que eso es patrimonio del adulto (quien es el responsable de seleccionar y presentar los alimentos buscando una buena nutrición), sino “cuánta hambre tengo hoy”.

¿Cuántas veces al día?

Como la idea es incorporar al bebé a la mesa, se puede ofrecerle todas las comidas. Ahora, tal vez prefieran empezar de a una vez por día, luego aumentar a dos... y así. No hay una regla. Importa que cada familia se sienta cómoda.

¿Y qué pasa si no come a la hora de la comida y me pide comida dos horas después? Antes que nada, no reemplazar esa hambre por productos de picoteo (galletitas, el gran drama), sino volverle a ofrecer lo que sobró de la comida o un equivalente. Se puede ofrecerle un arbolito de brócoli y un pedazo de pechuga de pollo a las cuatro de la tarde. No pasa nada. Va a ser más sano que darle una vainilla.

¿Cómo cocinar?

Podemos usar la mayor parte de las formas de cocción: al horno, a la plancha, al vapor, hervido... Mientras cuidemos la seguridad alimentaria, adelante con la experimentación. También podemos presentar frutas y verduras sin cocer: el objetivo de la cocción es: a) que tenga la textura adecuada, b) que sea rico. Pero si tenemos una banana madurita o una hermosa pera acuosa de estación que se deshace en la boca, adelante.

¿Qué es mejor? Cocinar al vapor es mejor que hervir: al hervir, los nutrientes se van al agua (que podemos usar para hacer caldo, por ejemplo). Cocinar los alimentos enteros también mejora la conservación de sus propiedades. Siempre que cocinamos un alimento, sus propiedades cambian: que no nos asuste esto. Salgamos un poco de la física y la ciencia, y disfrutemos el proceso. **Todo lo que hagamos en casa, no importa cómo lo hagamos, será más sano que consumir un producto de un paquete.**

Ya no sube tanto de peso

Un bebé nace con alrededor de 3 kilos. A los 6 meses, generalmente pesa el doble. Y a los 12 meses, pesa el triple. ¿Qué pasó? En los primeros 6 meses duplicó el peso de nacimiento, y luego empezó a crecer más lento. Nunca creceremos tan rápido como en ese primer semestre.

Es decir, **aumentar menos de peso a partir del inicio de la alimentación complementaria es absolutamente normal. Los bebés no van a crecer por lo que coman o no, van a crecer mayormente por la leche que tomen.**

Esto se pone más complejo el segundo año de vida: a veces crecen... ¡un kilo en todo el año! Y si es su curva de crecimiento, es absolutamente normal. **Un niño en percentil “bajo”, si creció todo el tiempo en esa curva, es un niño sano, y eso es importante de tener en cuenta. No son más sanos los bebés que crecen en el percentil 50 (mitad de tabla) que los que crecen en el percentil 3.**

¿Qué es un percentil? Así llamamos a los indicadores de talla, peso, perímetro de cabeza y otras cuestiones que buscan aportar una herramienta para evaluar el crecimiento según la edad. Son las famosas “curvas de crecimiento” que tenemos los pediatras en un librito en el consultorio. Estas curvas vienen de un estudio hecho por la Organización Mundial de la Salud, presentado en 2006, en el cual estudiaron a bebés de países muy distintos (Brasil, Omán, Estados Unidos, Ghana, India y Noruega), creciendo bajo condiciones óptimas (lactancia materna exclusiva, bebés

sanos a término, mamás no fumadoras y otros indicadores).

¿Sirve usar las curvas de crecimiento? Sí, son un indicador más de la salud de un niño. Podemos imaginar cada curva como el carril de la autopista. No importa por qué carril vaya cada niño, lo que nos importa es que no dé volantazos y se pase bruscamente de carril.

Estamos acostumbrados al “bebé rollizo = bebé sano”, entonces cuando los bebés no tienen rollitos, o cuando los niños comen menos, como sucede a partir del año, las familias se angustian mucho. Más si están poco acompañadas por los profesionales.

Hago una aclaración más: no existe la obesidad por lactancia materna. No hay ningún estudio que justifique intervenciones en la lactancia cuando un bebé alimentado con lactancia materna exclusiva y con un desarrollo madurativo saludable sube “mucho” de peso. La lactancia materna es un factor protector a largo plazo para la obesidad infantil.

Arcadas, toses y ahogos

Los bebés se atragantan y tosen con leche materna. Se atragantan y tosen con papillas. Se atragantan y tosen haciendo BLW. Es decir, aprender a alimentarse incluye tropiezos, al igual que aprender a caminar.

Se están haciendo estudios acerca de qué bebés se “ahogan” más, si aquellos que comen solo papillas o los que comen trocitos. **La mayoría de los estudios, que pueden consultar en la bibliografía de este capítulo, plantean que no hay mayor riesgo de atragantamiento practicando BLW que comiendo con cuchara.** Lo que sí se observó es que los mapadres de los bebés que practicaban BLW estaban más atentos y reaccionaban con menor ansiedad ante la tos.

El cuerpo responde rápidamente a un alimento que va a la vía aérea mediante la tos o la arcada. Esto es normal y natural, y no es necesario intervenir. Lo más probable es que el niño tosa una o dos veces, se ponga rojo, uno se asuste mucho, y a los diez segundos, gestione ese trocito y siga jugando como si nada.

¿Cuándo nos asustamos? Cuando no hay tos, no hay respiración ni sonido. Eso es un ahogo y puede ocurrir con cualquier tipo de alimentación.

¿Cómo prevenimos? No damos pedazos pequeños ni partículas que puedan ir fácil a la vía aérea (maní, pochoclo), y nunca dejamos a un bebé comiendo solo (ni siquiera si iniciamos la alimentación complementaria con papillas).

Siempre es útil hacer un curso de primeros auxilios donde nos enseñen la maniobra de Heimlich. Ojalá nunca la usemos, pero los niños son exploradores natos, y la primera exploración siempre es con la boca. Es más probable que se atragante con una piedrita que comió del jardín que con la comida.

El cuerpo de tu hijo es sabio y está listo para comer. Confía en él.

Maniobra de desobstrucción en lactantes (maniobra de Heimlich)

Hay que tener en cuenta a la hora de realizar las maniobras de desobstrucción el peso del niño. Por este motivo es muy importante utilizar las piernas como sostén cuando sujetamos al lactante y no hacerlo “en el aire”.

- 1. Observar la boca del bebé. Si el objeto se observa fácilmente y se puede extraer, hacerlo. Si está en el fondo de la garganta o no se visualiza, no intentar sacarlo por el riesgo de empujarlo más adentro en la vía aérea y empeorar la situación.**
- 2. Tomar al lactante con un brazo y colocarlo boca abajo.**
- 3. Sentarse y apoyarlo sobre la pierna del mismo lado, que estará levemente estirada y hacia abajo.**
- 4. El rostro debe ser tomado sosteniendo el mentón, con cuidado de no presionar los ojos ni el cuello.**
- 5. Realizar 5 golpes secos y moderadamente fuertes entre ambos omóplatos.**
- 6. Si no escupe el cuerpo extraño, girar al bebé boca arriba sobre el otro brazo y realizar presión torácica con dos dedos en el medio del tórax (sobre el esternón a la altura de las tetillas). Hacer 5 compresiones.**

Esta secuencia (5 golpes boca abajo, 5 compresiones boca arriba) se debe repetir hasta que se expulse el cuerpo extraño o que el bebé pierda la conciencia. De suceder esto, es necesario comenzar maniobras de RCP.

Es conveniente, como mencioné antes, realizar un curso de primeros auxilios inclusive antes de que nazca nuestro bebé. ¿Para qué? Para poder practicar con muñecos, por ejemplo, y tener incorporada la maniobra en caso de haber algún accidente.

(Agradezco a Patricio Cascallar, médico pediatra y emergentólogo (M. N. 141 513), por la colaboración en este apartado).





Alimentación complementaria en niños prematuros

La Organización Mundial de la Salud considera bebé prematuro a aquel nacido antes de la semana 37 de gestación. En estos bebés, para evaluar su desarrollo y crecimiento, nos guiamos por la EDAD CORREGIDA (la edad corregida es “corregir” la edad cronológica del bebé con la que tendría si hubiera nacido a las 40 semanas).

El inicio de la alimentación complementaria también debería ser, según las sociedades científicas, según la EDAD CORREGIDA. Es decir: a un bebé que nació de 32 semanas, le faltaron 8 semanas para la semana 40. Si tiene 6 meses, se considera como que tiene 8 semanas menos, es decir, que tiene: ¡4 meses de edad corregida! Y es muy posible que no haya alcanzado las pautas de neurodesarrollo adecuadas para iniciar la alimentación complementaria. Tenemos que ESPERAR a que las alcance o a que cumpla 6 meses de edad CORREGIDA.

¿Hay alguna restricción en la alimentación complementaria por haber sido prematuro? No. Si el bebé es sano y alcanzó las pautas adecuadas, se introducen todos los alimentos al igual que un bebé que nació a término.

¿Puede hacer BLW un bebé que fue prematuro? Por supuesto, si cumple las pautas

que mencionamos al principio del capítulo.

Todos los bebés prematuros DEBEN ser suplementados con hierro hasta el año de vida, y según su edad gestacional, peso y otras cuestiones, es posible que deban recibir por un tiempo otros suplementos nutricionales. Estos bebés que nacieron “antes” no recibieron muchos de los nutrientes de su mamá durante el último trimestre. ¡Es importante charlarlo con su pediatra!

El miedo a las grasas

Durante años se condenó a las grasas saturadas, contenidas en grasas animales —por ejemplo, carnes o huevo—, como las culpables de la enfermedad cardiovascular. Un estudio realizado en siete países planteaba precisamente esto: que por culpa de las grasas saturadas, la gente se infartaba. Las grasas fueron fuertemente condenadas y retiradas de la dieta diaria, y reemplazadas por las más “saludables” opciones de aceites vegetales.

Los aceites vegetales no son solo parte de la ensalada, sino que forman parte de la gran mayoría de los productos ultraprocesados. Y varios años después de hacerle mucho caso a ese estudio, descubrimos que no solo hay más infartos que antes, sino que la gente está más enferma. ¿Entonces? Se está estudiando que el consumo masivo de aceites vegetales industriales estaría relacionado con mayor inflamación de los tejidos y mayor probabilidad de riesgo cardiovascular.

Las grasas saturadas como las encontradas en la manteca, la carne o el aceite de coco, son grasas saludables si mantenemos una dieta variada, mayormente basada en vegetales y frutas como lo plantean las guías de alimentación después de numerosos estudios. Hay que perderle el miedo a las grasas, y no volverse loco comprando carne magra.

Los niños NECESITAN grasas saludables para el desarrollo cerebral, pero además, son ricas. Nada más oloroso que una cebollita sobre manteca. No escatimemos la materia grasa, y lo sabrosa que es.

Otras muy buenas fuentes de grasas saludables son los pescados, el huevo, los frutos secos, la palta, las semillas de chía, y el aceite de oliva, que mientras menos refinado se pueda conseguir, mejor.

Los mil nombres del azúcar

Hay azúcares intrínsecos en nuestros alimentos, por ejemplo, en las frutas y las verduras. No se ha encontrado que estos hagan daño a la salud. **El problema son los azúcares libres, añadidos a los comestibles. El azúcar libera diversas hormonas en el organismo que provocan un estallido cerebral de placer y de necesidad de consumir más y más.**

Todo esto está pensado y estudiado por la industria, por lo que hay diversos azúcares agregados a los alimentos, y está bueno saber los nombres para identificarlos: **jarabe de maíz de alta fructosa, maltodextrina, sacarosa, dextrosa, dextrina, panela, concentrado de frutas, sirope de agave, miel, jarabe de arce, azúcar de palma, azúcar de coco.**

Hoy por hoy, un niño de 8 años ya consumió más azúcar que su abuelo a los 80...

Jarabe de maíz de alta fructosa

El jarabe de maíz de alta fructosa es un endulzante industrial, producto de la manipulación del almidón de maíz. Es más barato y endulza más que el azúcar, por lo que es ampliamente utilizado en la industria alimentaria. Lo encontramos en casi todos los productos que consumimos día a día: gaseosas, jugos, yogures, pan, productos “*light*”... basta con leer la etiqueta y encontrar la sigla JMAF, o su sigla en inglés HFCS, High Fructose Corn Syrup.

¿Pero la fructosa no tiene que ver con las frutas? ¿Es mala? Este efecto de la fructosa no sería importante si los niveles consumidos son bajos, como la fructosa que está presente en las frutas. Sin embargo, si la consumimos en grandes cantidades y en forma sostenida, puede traer graves consecuencias para la salud.

La glucosa común y corriente se metaboliza en el organismo a través de una hormona llamada “insulina”, que produce el páncreas. Si consumo glucosa, el organismo la percibe, se produce un pico de insulina y las células se ponen a trabajar para usarla o guardarla. Asimismo, este proceso hace que se produzca leptina, una hormona que tiene que ver con la saciedad y nos dice que ya estamos llenos.

¿Y la fructosa? La fructosa genera menor elevación de la insulina que la glucosa, dado que su metabolismo es diferente. Esto generaría que se produzca menos leptina y una menor inhibición del apetito con el consiguiente aumento de la ingesta. Se observó también que los metabolitos de la fructosa generan grasa en vez de generar energía, fomentando la obesidad, el daño en los vasos sanguíneos y la acumulación de grasa en el hígado (esteatosis hepática no alcohólica). Asimismo está relacionada con la insulinoresistencia y la prevalencia de la diabetes tipo 2. Altera la microbiota intestinal y puede causar síntomas de malabsorción (como diarrea o constipación persistente).

Los niños son consumidores frecuentes y entusiastas de este tipo de productos, precisamente por las características endulzantes y adictivas del JMAF. En un cumpleaños infantil es muy difícil encontrar un solo producto libre de JMAF.

La Organización Mundial de la Salud sugiere no consumir azúcares libres antes de los 2 años de vida y luego limitarlos. No sugiere un mínimo, es decir, podríamos vivir sin azúcares libres. En un adulto, se sugiere no consumir más de 6 cucharadas pequeñas al día, menos de 30 g (las cucharadas que contiene un “agua saborizada”). Una gaseosa de 600 ml, ¡¡¡contiene 12 cucharadas de azúcar en su composición!!!

**La Organización Mundial de la Salud
recomienda disminuir el consumo
de estos alimentos a lo largo del día
según las diferentes edades**

2 a 3 años	Hasta 15 g de azúcares libres/día	3 cucharadas
4 a 10 años	Hasta 20 g de azúcares libres/día	4 cucharadas
11 a 15 años	Hasta 25 g de azúcares libres/día	5 cucharadas
Más de 15 años	Hasta 30 g de azúcares libres/día	6 cucharadas

¿Cuánto azúcar consumen en tu familia?

ALIMENTO	CANTIDAD DE AZÚCAR cucharadas tipo té
Vaso de gaseosa común (200 cc)	5 
Lata de gaseosa común (355 cc)	8 
Botellita de gaseosa (600 ml)	12 
Cajita de jugo comercial (200 ml)	5 
Agua saborizada (600 ml)	8 
Gomitas (5 unidades)	3 
Caramelos (6 unidades)	3 
Chupetín	3 
Chocolatín (100 ml)	2 
Alfajor simple	4 

Los cuadros están tomados de la infografía que subió a su web el Servicio de Nutrición del Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan.

“¿Y cómo endulzo las preparaciones para niños?”. Repregunto: ¿por qué hay que endulzar? A los seres humanos nos gusta el sabor dulce: probablemente porque así sea el líquido amniótico, o porque la leche materna es dulzona. Pero, después, lo ideal es buscar conocer el sabor de cada alimento, sin necesidad de azúcares agregados.

Si aún así queremos endulzar, una opción es utilizar pastas de frutas deshidratadas, como dátiles o pasas de uva. Se hidratan con agua unas horas, se descarta el agua sobrante, se procesan y se usa la pasta para endulzar. Podría decirles que una cucharada de esa pasta equivale a una cucharada de azúcar, pero no es cierto, porque depende de cuándo fue cosechada esa fruta, cuánto maduró, cuánto tiempo estuvo guardada... la magia de los alimentos reales es que nunca sale todo igual, y todo es un experimento constante.

¿Y los edulcorantes? Está estudiado que cambiar azúcares por edulcorantes no calóricos no necesariamente va de la mano de consumir menos calorías en todo el día, porque esas calorías se terminan buscando en otros alimentos. Además, algunos autores postulan que el consumo temprano de productos azucarados en bebés y niños pequeños podría alterar la autorregulación, y generan una profunda preferencia por sabores dulces. Es decir, son contraproducentes y no se recomiendan en la infancia.

Las legumbres y los cereales son amigos, y comida

Activar, remojar, fermentar, repetir

Las legumbres y los cereales son alimentos injustamente olvidados en la alimentación infantil y de toda la familia. Los encontramos en la parte de abajo de las góndolas, aburridos, en paquetes sin dibujitos. Nadie nos quiere vender un montón de garbanzos. ¿Por qué será?

Tal vez, porque **rinden muchísimo, son muy saciantes, tienen muchas proteínas y minerales, y no generan efectos adictivos. Y esto a la industria no le conviene, pero a nosotros y a nuestros hijos sí.**

Ya he contado algunas ideas acerca de cómo introducir legumbres y cereales en la alimentación complementaria. Ahora, hablemos de los antinutrientes. Los antinutrientes son compuestos que se encuentran en legumbres y cereales para proteger a la planta durante su desarrollo. Entre ellos están el ácido fítico, las saponinas, los polifenoles, y otros.

Este nombre tan dramático no quiere decir que sean sustancias tóxicas o hagan mal, quiere decir que, de no removerlas, probablemente nos perdamos algunas de las propiedades de estos alimentos, nos caigan pesados o nos den gases (inserte chistes acerca de porotos).

Todo el tiempo consumimos antinutrientes, por ejemplo, en las infusiones. ¿Entonces dejo de tomar mate? Para nada: muchos “antinutrientes” tienen funciones positivas para nuestro cuerpo, como actuar como antioxidantes o colaborar en el metabolismo de los azúcares. Todo se balancea.

¿Cómo puedo eliminar los antinutrientes de las legumbres y los cereales? **La manera de eliminar parte de los antinutrientes es el remojo y la fermentación. Nada más ni nada menos.**

* **Remojo (o “activación”).** Para evitar pensar mucho en las horas y evadir descargar insufribles tablitas de internet que indican cuántas horas se necesita remojar algo, dejar en remojo los cereales o legumbres antes de ir a dormir, y listo. Agua potable y tiempo (y también un chorrito de limón, si quieren). Para cocinarlos, se desecha esa agua y se cocinan en agua nueva.

* **Fermentación: un pasito más.** Se le puede agregar al agua un agente fermentador, como el kéfir, un probiótico. De esta manera se hace una especie de “predigestión” del alimento, y se eliminan muchos de los antinutrientes. Si me pongo a hablar de fermentación, hacemos otro libro, así que, tarea para el tiempo libre: chusmear sobre el tema.

Ahora, MOMENTO. Veo en la mente de mis lectores claras intenciones de nunca cocinar una legumbre por fiaca de hacer todo esto. Relax. Dijimos que los antinutrientes no hacen mal, simplemente, no dejan que absorbamos TODO lo bueno que tienen las legumbres y los cereales. Pero hay muchas de sus propiedades que vamos a aprovechar aunque no remojeamos ni fermentemos. No pasa nada: cocinen las lentejas aunque no estén remojadas. Seguirán siendo ricas y sanas.

La avena

Hace un tiempo que está de moda la avena, un cereal que se visualiza generalmente arrollado. ¿Qué significa esto? Al grano de avena cosechado lo “arrollan” máquinas y nos lo venden así. Nunca llegamos a ver el grano sin que esté chatito.

La avena viene arrollada, que es “la común”, y viene instantánea, que ya tiene un proceso de cocción previo. **Es preferible consumir la arrollada común y no la instantánea, y si es posible, remojarla antes de usar. Quedará una cremita, sí. Y probablemente, nos caiga mejor.** No se priven de buscar recetas de una preparación escocesa llamada *porridge*. No se van a arrepentir.

Refinado vs. integral

El grano de cereal se cosecha en el campo, luego se le saca el germen y el salvado (una especie de “envolturas”, pobre cereal, lo dejamos desnudo) y queda el almidón. Eso es refinar un cereal. Ese cereal, cuando se consume, se absorbe rápido, hace un pico veloz de azúcar en la sangre que así como sube, baja, y se vuelve a sentir hambre.

En cambio, un cereal o harina integral, como conserva estas capitas tan importantes, permanece más tiempo en el intestino, liberando sus azúcares más lentamente y generando mayor saciedad. Además, contiene mayor cantidad de fibra, la cual mejora el tránsito intestinal y ¿adivinen qué? A nuestras bacterias les gusta mucho.

Durante mucho tiempo se evitó sugerir comidas integrales a los niños porque, sí, tienen interferencia en la absorción de hierro. Sin embargo, en el marco de una dieta saludable y variada, son preferibles los cereales integrales a los refinados.

Los lácteos

No existe un alimento mágico que todo lo cubre. La leche tampoco lo es. **Existe una percepción errónea acerca de la necesidad absoluta de consumir lácteos de vaca, inclusive por encima de la leche materna.**

La leche de vaca es un alimento con una cantidad importante de calorías (0.57 cal/ml), proteínas de alto valor biológico y una gran fuente de calcio. Por otro lado, es muy pobre en hierro y dificulta el aprovechamiento del hierro de otros alimentos. También está demostrado que provoca microhemorragias intestinales, lo cual se agrega a todas estas condiciones que propician la anemia.

El consumo de lácteos de vaca (u otros mamíferos) no es imprescindible: se puede obtener el calcio de otros alimentos (por ejemplo: acelga, brócoli, repollo chino, *kale*, hojas verdes de nabo, higos secos, sardina, semillas de sésamo, almendras, porotos y muchos más), y más allá de eso, existen diversos factores que hacen que absorbamos ese calcio o no. Podemos tomar toda la leche del mundo, pero si tenemos una vida sedentaria, no hacemos actividad física, no tenemos suficiente vitamina D y nuestra alimentación no es completa... ese calcio pasará de largo.

Si se deciden consumir lácteos de vaca, se recomienda que se introduzcan después del año de vida, que sean enteros y que no superen los 500 ml en TOTAL, contando leche, yogures, quesos y otros preparados.

Una vaca no da la misma calidad de leche todos los días. La leche que nos venden en el supermercado pasó por muchos procesos para homogeneizarla, para que sea igual en todos los *sachets*. Existen mejores opciones de lácteos que los que están en la góndola del supermercado. Solemos encontrarlos generalmente en mercados orgánicos o dietéticas. Si tenemos alguna vez la oportunidad de probarlos, nos sorprenderá su cremosidad, su aroma, la nata que queda por encima cuando se cocinan (¿se acuerdan de la nata? ¿Hace cuánto no ven nata en la leche?). **Es importante que la leche siempre esté pasteurizada** para prevenir enfermedades.

Alimentación basada en galletitas Desayunos y meriendas

*Buen día, mi niño bello
La mañana recién comienza
Aprontamos los garbanzos,
con la masa madre una trenza.*

*Buen día, mi niño hermoso
Preparemos el desayuno
Cortemos las manzanitas*

del agua caliente soplemos el humo.

*Buen día, mi niño amado
buen día pancita llena,
que los pancitos te den un beso
y las cremas dulces te saquen penas.*

No es raro encontrar en “listitas” de inicio de alimentación complementaria galletitas y productos afines, con marca específica y todo. Yo se las di a mi hijo mayor, de hecho. En ese momento, nunca se me ocurrieron ciertas cosas que ahora sí tengo más claras: **todas las galletitas, inclusive las “de agua” o con cereales, o de marcas veganas, tienen azúcar. La inmensa mayoría.** Y la Organización Mundial de la Salud sugiere no darle azúcar agregado hasta al menos los 2 años.

Y no solo tienen azúcar: tienen varios tipos de azúcar, como el jarabe de maíz de alta fructosa del cual ya hablamos. Además, muchas de las más populares para el inicio de la alimentación complementaria son duras y fáciles de romper, con el riesgo de que un trozo vaya a la vía aérea. **Es más peligroso dar galletitas que cualquier fruta adaptada a la mano de un niño.**

Los bebés pueden comer miles de alimentos saludables, como ya vimos. Hay muchísimas opciones (y más baratas) por fuera de las clásicas galletitas, que fomentan el “picoteo” y la comida a destiempo. No responden al hambre, sino muchas veces al aburrimiento. Sin embargo, culturalmente son un elemento infaltable de nuestros desayunos y meriendas, y cuesta pensar en otras opciones.

Los desayunos y meriendas son una comida más. No tienen necesariamente que estar formadas por una infusión y un panificado. Hay un mundo de alimentos a incorporar. Dejo algunos ejemplos de desayunos y meriendas desde el inicio de la alimentación complementaria:

- **Frutas.**
- **Fainá sin sal.**
- **Bollitos de mijo.**
- **Pan casero untado con hummus, pasta de girasol, pasta de maní o guacamole.**
- **Brownie de porotos negros.**
- **Arroz con leche (usando leche materna, de fórmula o “leche” vegetal).**
- **Porridge (crema de avena).**
- **Muffins de calabaza (mezclamos calabaza, huevo y harina. Nada más que eso).**
- **Huevo bien cocido.**
- **Tortilla de papa.**
- **Tortilla de verdura.**

- **Croquetas de arroz.**
- **Trufas de quinoa o trigo burgol.**
- **Bastones de polenta.**
- **Tostadas de batata (que no son más que pedazos finos de batata al horno).**
- **Patitas de pollo caseras.**

La lista es interminable, el límite es la imaginación. ¿Pollo en el desayuno? Sí. Será una comida mucho más nutritiva que un té. Animémonos.

Tras la búsqueda del hierro

Argentina es un país con una enorme proporción de niños anémicos por falta de hierro, inclusive en los distritos con mayor accesibilidad a los alimentos. Ya hemos hablado de que el hierro es un factor imprescindible para el desarrollo neuromadurativo y para el sistema inmune, y de las diversas políticas públicas que se han incorporado para evitarlo (como la suplementación en grupos de riesgo).

El consumo de leche de vaca (leche de vaca, no leche de fórmula) antes del año no está sugerido por impedir la absorción de hierro y, además, causar microhemorragias a nivel intestinal, lo cual propicia la anemia.

¿Cómo incorporo hierro en la dieta diaria?

- * La leche materna tiene la mayor biodisponibilidad de hierro (es decir, es el hierro que más se absorbe).
- * En los alimentos, lo encontramos en:
 - Carnes: carnes rojas, pollo, pescado, cerdo, etc.
 - Huevos.
 - Frutos secos: sésamo, pistacho, girasol, almendras...
 - Legumbres: porotos, garbanzos, lentejas.
 - Hojas verdes: acelga, espinaca (no se recomiendan en grandes cantidades en niños por su contenido de nitritos).
 - Otros vegetales: brócoli, chaucha, coliflor, perejil, repollo.
 - Cereales: arroz, maíz, avena, quinoa.
 - En nuestro país, la harina de trigo está enriquecida con hierro.
- * El cuerpo absorbe más fácilmente el hierro de origen animal que el de origen

vegetal, porque químicamente es más sencillo de asimilar. Además, en su conformación cuenta con un componente que se denomina “factor cárnico”, que hace que el hierro de otros alimentos (por ejemplo, los de origen vegetal) se absorba mejor.

- * Es recomendable aportar los alimentos ricos en hierro en conjunto con alimentos que contengan ácido cítrico (siempre mejor la fruta entera, no el jugo), como naranja, mandarina, limón, pomelo, frutillas, ají, tomate.
- * El hierro se absorbe MENOS si consumimos grandes cantidades de **lácteos** (más de 500 ml después del año de vida de lácteos de vaca, no aplica para lactancia materna) o **infusiones** como el café, té, mate, jugos, gaseosas o los mismos lácteos cerca del consumo de estos alimentos, dado que interfieren a nivel intestinal con su absorción. Muchos niños consumen, posterior al año, grandes cantidades de lácteos en diversas presentaciones, como alimento principal. Yogures, leche, leche chocolatada, queso untado, queso rallado, postrecitos... De esa manera, el hierro tampoco tiene chance de ser absorbido correctamente. Muchos de estos productos industriales tienen hierro agregado, pero en la alimentación saludable tenemos que hablar de diversidad, de colores, de sabores, no de químicos agregados.

Alimentación vegetariana y vegana en la infancia

Cada familia tiene su cultura y sus hábitos alimentarios. Los consejos del/la pediatra y de los/las licenciados/as en Nutrición con relación a la alimentación tienen que ver con preservar la salud infantil y evitar enfermedades a corto y largo plazo, y deben tener en cuenta estas costumbres, respetarlas y adaptarse a las mismas de la mejor manera.

La alimentación vegetariana y vegana está estudiada, y es válida en pediatría. Dentro encontramos diversas variantes, según si se consumen o no lácteos, huevos y diversos productos de origen animal.

¿Se puede iniciar la alimentación complementaria siendo vegetariano/vegano? ¡Sí! ¿Se pueden cubrir todas las necesidades calóricas, proteicas, de vitaminas y minerales siendo vegetariano/vegano? ¡Sí! Pero es IMPORTANTÍSIMO un seguimiento controlado y adecuado con pediatra y nutricionista, en un equipo multidisciplinario.

¿Le cuento al pediatra? ¡Por supuesto! Es importante comunicarlo a los profesionales que nos acompañan en el camino de la salud. Estos irán controlando el

crecimiento y desarrollo para evitar cualquier carencia (como en cualquier niño, vegetariano o no, básicamente).

¿Y el hierro? Si bien el hierro de las carnes es el más sencillo de absorber para el cuerpo, una adecuada ingesta de cereales, legumbres, semillas y otros alimentos asociados al consumo de vitamina C, que favorece la absorción de hierro, puede evitar el riesgo de anemia. En otras ocasiones, será necesario suplementar con hierro.

Los suplementos (hierro, vitamina B12 en alimentaciones veganas, zinc, vitamina D) en CUALQUIER NIÑO deben ser evaluados INDIVIDUALMENTE y en EL CONSULTORIO. Como siempre planteamos, lo importante es empezar a comprender que es preciso alimentarnos con ALIMENTOS y no con PRODUCTOS, y evitar los ultraprocesados que, en cualquier tipo de alimentación, son dañinos para la salud.

Hablemos de alergias alimentarias

Durante muchos años se planteó incorporar los alimentos de a uno y retrasar algunos alimentos como el huevo, el pescado, los frutos secos y las frutillas por el riesgo de alergias. Actualmente ese concepto está en desuso. **Se pueden incorporar la mayoría de los alimentos que consumimos a diario al inicio de la alimentación complementaria sin riesgo**, con algunas excepciones detalladas al final. Cabe aclarar que estas recomendaciones son para la población en general, y que luego habrá que evaluar cada caso en particular.

Los frutos rojos, como las frutillas y cerezas, consumidos en gran cantidad, pueden causar un leve enrojecimiento o picazón alrededor de la boca, que no es una alergia, sino una respuesta a un componente de dichos frutos (la histamina). Sí, los frutos rojos se pueden introducir desde el inicio de la alimentación complementaria sin problemas.

En mucha bibliografía figura la sugerencia de ofrecer en tres comidas, no necesariamente consecutivas, un mismo alimento “nuevo”, a veces acompañado de otro que ya sabemos que tolera, para evaluar alergias e intolerancias. Se sugiere introducir alimentos nuevos por la mañana o el mediodía, para evaluar la respuesta.

¿Qué signos de alergia puede haber? Los signos son múltiples y a veces muy inespecíficos. Ronchas en la piel, vómitos, diarrea... a veces el único signo es que ese niño nunca toque ese alimento. **¿Cuándo consultar con urgencia? Cuando vemos dificultad respiratoria, porque podemos estar ante una anafilaxia (una reacción grave de todo el cuerpo hacia un alérgeno).** La proporción de la población que desarrollará anafilaxia es mínima, y no podemos prever qué alimento la

desencadenará (hay gente que es alérgica a la banana, por ejemplo).

Alergia a la proteína de leche de vaca (APLV)

¿Qué es? **Es la alergia más común en los primeros meses de vida.**

¿Es hereditario? ¿Es genético? ¿De dónde saca un niño una alergia a la proteína de la leche de vaca? Si bien los niños con familiares cercanos (padres, hermanos) alérgicos tienen una predisposición genética, la alimentación temprana con una fórmula láctea parecería ser uno de los factores más importantes.

Las leches de fórmula son leches de vaca modificadas para ser toleradas por el organismo de los bebés. Siempre intentan “parecerse” a la leche materna, pero esta es un tejido vivo que va cambiando su composición de acuerdo con las necesidades del niño. La leche materna tiene microorganismos saludables (probióticos), el alimento para esos microorganismos (prebióticos), tiene anticuerpos, grasas saludables, proteínas... todas sustancias que mantienen saludable la microbiota intestinal.

¿Hay niños que tomen pecho exclusivo y que tengan APLV? Sí, en un porcentaje mucho más bajo que los alimentados con fórmula. La proteína de la leche de vaca consumida por la mamá también pasa por la leche materna, por lo cual pueden estar expuestos de esa manera.

Suele confundirse esta condición con la INTOLERANCIA A LA LACTOSA, y no es lo mismo, ¡cuidado! La intolerancia a la lactosa es un conjunto de síntomas producidos por la dificultad en la metabolización del azúcar de la leche, la lactosa. Es raro en niños pequeños: la leche materna ya viene con la enzima para degradar la lactosa (se llama “lactasa”).

Puede suceder en niños alimentados con leche de fórmula. A medida que vamos creciendo, nuestro intestino va perdiendo la lactasa intestinal, y por eso, los adultos en su mayoría no somos muy tolerantes a la leche de vaca. También puede darse intolerancia a la lactosa después de una gastroenteritis, que ha dañado nuestras células intestinales. Pero NO es lo mismo, y diría, más aún, no tiene nada que ver con la alergia a la proteína de leche de vaca, y las leches deslactosadas no servirían para estos casos.

¿Cuáles son los síntomas de la APLV? Ahí viene la dificultad en su diagnóstico: tiene una gran variedad de expresiones clínicas. Diarrea con sangre, vómitos, mal progreso de peso, broncoespasmos, reflujo gastroesofágico, rinitis, dermatitis, constipación, reacciones en la piel... ¡Realmente son muchísimas!

¿Cómo se diagnostica? Otro problema. Podemos hacer pruebas de laboratorio, pero su valor para el diagnóstico es relativo. Pueden venir negativos, y el niño ser alérgico de todos modos. **Lo que se utiliza para el diagnóstico es la prueba de eliminación: si el niño tiene lactancia exclusiva, la mamá deja de comer lácteos y**

sus derivados por dos semanas, y se observa la evolución. Si el niño mejora, se reintroducen los lácteos a las cuatro semanas, y si vuelven los síntomas, se deriva al especialista. Si el niño se alimenta solo con fórmula, se prueba con leches hidrolizadas, de la misma manera, luego se hace la provocación (reintroducir los lácteos) y de allí se diagnostica.

¿Cuál es el tratamiento? Si el niño es amamantado, se suprimen los lácteos de la dieta materna y del niño cuando empiece a comer. TODOS los lácteos, inclusive los derivados, o los productos que declaren trazas. Si el niño toma fórmula, hay que usar fórmulas hidrolizadas, tanto para tomar como para cocinar.

NO se recomiendan las leches de otros animales (cabra, oveja) porque poseen proteínas similares a la leche de vaca y también pueden generar reacciones.

“Mi hijo tiene APLV, ¿la tendrá para siempre?”. No necesariamente. Puede revertir, por eso es importante el seguimiento por el pediatra en un equipo multidisciplinario.

La lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y, si es posible, hasta los 2 años o más, es la única medida recomendada para prevenir el desarrollo de alergias. La incorporación de alimentos sanos oportunamente, que mantengan la microbiota balanceada, puede colaborar para esta prevención.

Contaminación cruzada

Las familias de niños con APLV hacen un esfuerzo enorme para que no llegue ni una miguita que le genere daño al niño, y las mamás que amamantan también hacen la dieta de exclusión. Pero a veces, aunque vemos síntomas claros, la exclusión no funciona. ¿Por qué? Por un lado hay que revisar la dieta, pero por otro, hay que evaluar la contaminación cruzada, es decir, que haya proteínas de leche de vaca por ejemplo en los utensilios que usamos para comer o en la cocina.

Por lo tanto, algunos consejos:

- Separar la vajilla que va a usar ese niño/a y que no se mezcle con la otra. También recipientes plásticos de todo tipo.
- Usar una rejilla y una esponja diferentes a las que usamos para el resto de la familia, lo mismo que los repasadores.
- El horno y el microondas pueden estar contaminados. Aquí hay varias opciones: podemos envolver la comida del niño o de la mamá con papel *film* o de aluminio, con bolsas para horno (no de las que traen sabores), o podemos usar ollas que hornean exclusivamente para ellos, si tenemos la opción.

- Las licuadoras y minipimer son difíciles de limpiar y no se recomienda usarlas a menos que sean exclusivas.
- Mamaderas y chupetes deben ser reemplazados cuando se inicia la dieta.

Educar a los adultos

¡Qué difícil! Mucha gente del entorno no comprende realmente el esfuerzo y considera que “un poquito no hace nada”. Se escuchan frases como... “Dejaaaaalo comer un heladito, ¿qué le va a hacer?”. “Ah, sí, esto tenía crema, pero poquita, no creo que le haga nada”. “Le compré estas galletitas porque me pidió y me dio pena”. “Bueno, tranquila, ¡tampoco seas exagerada!”.

¿Cómo explicarle al entorno?

- * Si vamos a comer con otras personas, **HABLAR** con el resto de los comensales **ANTES** de la reunión. Con adultos y niños. Explicar claramente por qué se dan estas restricciones. Si es necesario, los pediatras podemos ayudar con alguna notita.
- * Remarcar los conceptos de **TRAZAS**, **DERIVADOS** y **CONTAMINACIÓN CRUZADA** (mucha gente ignora estas cuestiones).
- * Subrayar a los adultos que... ¡son adultos! Y que estamos cuidando la salud de un niño.
- * Si el menú no puede ser igual para todos (por temas de gustos y costos), evitar insistir que “Juan come distinto”. Integrar, incluir, dejar estas pequeñas cosas de lado... lo importante es la reunión.
- * Solicitar lavado de manos antes de tocar a un niño con alergias alimentarias. Casos severos de alergia a la proteína de leche de vaca, alergia al huevo o de celiaquía pueden provocar reacciones importantes solo al contacto (por ejemplo, un adulto que está comiendo galletitas que tienen trazas, aunque tal vez no lo sepa): no se lava las manos, alza a un bebé y le da besos ---> bebé con posterior diarrea con sangre...

La alergia a la proteína de leche de vaca suele ser reversible aunque un 1 % de los adultos la presentan toda la vida (recordemos que **NO** es lo mismo que la intolerancia

a la lactosa). Ánimo. Hay muchas familias en red trabajando y eso es un gran apoyo, y muchos profesionales estudiando para aprender más y poder acompañar correctamente.

Para tomar: el agua y sus no-amigos

Hemos visto que los bebés menores de 6 meses no requieren otro líquido u alimento que no sea leche, ya sea materna o de fórmula. **A partir de los 6 meses, el líquido a ofrecer es el agua potable, en pequeñas cantidades que puedan ser gestionadas por el bebé.** No hace falta comprar agua mineral de ningún estilo, mientras sea agua potable está bien. El filtro doméstico le da mejor sabor, generalmente.

En promedio, todos los niños de Argentina toman dos bebidas azucaradas por día. Bebidas llenas de calorías que no alimentan, con sustancias que les tiñen la piel (los “bigotes de jugo”) y quién sabe qué le hacen a los intestinos. O sin calorías, pero con toneladas de edulcorante que condicionan su paladar, y están llenas de cafeína, colorantes y otros estimulantes.

No hay algo “menos peor” en el mercado. Las sociedades científicas pediátricas insisten en que no se recomiendan los jugos, ni siquiera los exprimidos, en la alimentación de los niños. Ni jugo de naranja, ni jugo de soja, ni jugo en polvo dietético. Todas estas bebidas tienen una pobre calidad nutricional, tengan o no tengan azúcar, y desplazan el consumo de alimentos de mejor calidad.

Si un niño no quiere tomar agua es porque no tiene sed. Los niños dicen que tomar agua “no les gusta” cuando tienen el acceso a bebidas dulces de elaboración industrial, ofrecidas por adultos. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como adultos elegir qué les ofrecemos.

¿Y el jugo exprimido casero? Sin dudas, aun siendo mucho mejor que un jugo industrializado, tampoco es recomendable, pues es preferible ofrecer la fruta entera. Puede ser ofrecido a veces como una golosina o algo especial, pero que no sea, en lo posible, una conducta habitual.

Como siempre, no es cuestión de prohibir, sino de estar informados para poder elegir.

La mamadera

La mamadera, o biberón, tal como la conocemos, es un invento del siglo XIX. En un principio, se usaban vejigas de animales para la tetina. Claro que en esa época no se tenía muy claro el tema de la higiene... por lo que terminaba siendo una causa de muerte y enfermedad infantil.

La mamadera de hoy intenta ser lo más “parecida” posible al pecho materno (¡de hecho a veces en las cajas de las mamaderas hay mujeres amamantando!). Que el bajo flujo, que la forma de flor... etc.

Eventualmente, la mayor parte de los niños será alimentado alguna vez con mamadera, ya sea porque su mamá trabaja, o debe ausentarse unas horas, o porque por alguna razón no será amamantado.

¿Cuánto tiempo debería un niño alimentado con mamadera utilizarla? La respuesta es no más de un año. Hasta el año, los niños son lactantes. La leche es su fuente principal de nutrientes. Después del año, la lactancia materna sigue siendo nutritiva (sí, la leche de mamá SIEMPRE ALIMENTA), protectora inmunológica y lazo afectivo que contribuye al desarrollo neuronal.

En cambio, la leche de vaca, o las fórmulas de continuación (Bebé 3, Bebé 4, Bebé 38... etc.), estas últimas absolutamente innecesarias, son solo parte del esquema nutricional de un niño. No deberían ser la base de su alimentación, y la mamadera contribuye a que sí lo sean.

La mamadera no debe ser un lugar de ofrecimiento de agua, jugos, gaseosas, cereales ni nada que no sea leche hasta el año de vida.

La mamadera para dormir es uno de los mayores enemigos de la dentición: el goteo continuo de leche, aunque los dientes hayan sido higienizados antes del sueño, da lugar al desarrollo bacteriano y favorece el inicio de caries, por los azúcares de esa leche (la teta no tiene ese riesgo).

El quitarla bruscamente puede ser angustioso para el niño, por eso es importante, como adultos, estar conscientes de la información que manejamos, e **ir haciendo la transición entre mamadera a vasito gradualmente, a partir de los 6 meses, acompañando la maduración del niño.** También está bueno saber que no todos los bebés necesitarán usar mamadera, que no es algo “necesario”, sino un objeto que nos puede ayudar en algunos momentos, pero no es imprescindible.

Consejos para la transición de mamadera a vaso

- **Presentar vasito que sea liviano y fácil de manipular.** Hay muchos vasos en el mercado que son aparatosos y con múltiples chirimbolos: complican más de lo que ayudan. Más sencillo, mejor.
- **¿Con tapa o sin tapa?** Como quieran. Puede ser más sencillo tener un vasito con tapa en las primeras manipulaciones. Si es verano y es fácil que se seque la ropa, podemos ofrecer sin tapa y jugar con el agua.

- **¿Con sorbete o sin sorbete?** De nuevo, como quieran. Un bebé que utiliza mamadera y está en transición puede aceptar un vasito con sorbete más fácilmente.
- **Las tomas nocturnas suelen ser las más difíciles de cambiar.** Mejor empezar con una toma, por ejemplo, la del almuerzo, y en vez de ofrecerla en mamadera, ofrecerla en vaso.
- **Paciencia, mucha paciencia.** El proceso puede durar semanas, de hecho, es muy similar a un destete. Evitar los retos y la angustia. Tiempo al tiempo.

“No come nada”

¿No come nada?

“Come muy poco, es culpa de la teta”.

“Lo único que come es el postrecito, si se lo doy mientras mira la tele”.

Estas son las frases que día a día escuchamos en el consultorio. Son tan frecuentes que se han escrito libros acerca de las mismas.

¿Cuánto DEBE comer un niño? ¿Cuál es la porción adecuada? La respuesta es: LA QUE NECESITE. No sabemos cuánto toma un bebé que toma teta a demanda (lo cual pone nerviosos a muchos profesionales poco leídos acerca de lactancia). Toma lo que quiere, cuando quiere, en el tiempo que quiere.

Los adultos estamos “programados” de otra manera: nos ponemos horarios para comer y tenemos que “terminar el plato”. Esto viene de una larga tradición cultural, con frases como “hasta que no se termina el plato, no te levantas de la mesa” y “si no comés la comida, no hay postre” (¿el postre no es comida, entonces?).

Esta educación nos ha llevado a perder el control sobre nuestra saciedad: no sabemos cuándo o cuánto comemos por hambre o porque “hay que comer”. En un mundo con una epidemia de obesidad y sobrepeso, hay que cambiar estos paradigmas.

Los niños comen según el hambre que tienen. Ni más, ni menos. Obligarlos, crear premios y castigos, coaccionarlos a que coman “más” o presentarles solamente los alimentos que consumen fácilmente (generalmente ultraprocesados con sustancias que los hacen irresistibles, sabrosos y peligrosos para la salud) solo genera mayores problemas.

No importa si deciden como familia iniciar la alimentación complementaria con

papillas, BLW, método mixto... Lo importante es, desde el inicio, respetar las ganas y el tiempo de los chicos con relación a la comida.

La responsabilidad de las familias comienza y termina en ofrecer alimentos de calidad y otorgar el ejemplo con relación a los hábitos alimentarios (¡como si fuera poco!). Como ya vimos al inicio de este capítulo, la presencia de un nuevo bebé en casa es una gran oportunidad para mejorar la alimentación de todos.

Y... ¿qué come?

Una vez superado el inicio de la alimentación complementaria y la neofobia posterior, (ver más adelante) llegamos a la edad escolar y nos encontramos con niños que no comen “nada”...

El nutricionista español Julio Basulto ha resumido esta cuestión en un círculo muy acertado: los niños suelen desayunar (cuando desayunan) productos altísimos en azúcares, como chocolatadas, postrecitos lácteos, facturas y mermeladas. A media mañana, suelen consumir en el colegio otros productos industriales: panchos (sí, panchos a media mañana, todos los kioscos escolares los venden), alfajores, pizzetas, medialunas con jamón y queso...

Esto genera que, a la hora del almuerzo, no tengan hambre y no consuman comidas más completas nutricionalmente. En nuestro país tenemos que sumar también la gran cantidad de actividades extraescolares que hacen los chicos, lo cual genera que muchas veces el almuerzo sea en un kiosco, como algo “de paso”. El hambre llega de nuevo a la media tarde: merienda con galletitas y chocolatada, alfajores, más galletitas... tanto azúcar que por la noche de nuevo deja de ser atractiva la cena, y ya es otro día.

Sumado al cansancio de los padres después del trabajo, para que coman “algo”, se suele recurrir a las comidas que sí aceptan: generalmente ultraprocesados con multitud de sustancias diseñadas para que sean atractivas para los chicos: mucho *marketing* (¿quién no recuerda los perritos de esa propaganda de salchichas?), mucho sodio, muchos saborizantes, mucho jarabe de maíz de alta fructosa...

El círculo se perpetúa y nuestros chicos se enferman. **Argentina tiene un 36 % de sobrepeso y un 6 % de obesidad infantil, dos formas de malnutrición. ¿Cómo cambiamos esto? Aprendiendo a comer, de a poco, alimentos y no productos. Apagando la tele y las propagandas. Disminuyendo el consumo de azúcar y de ultraprocesados. Comiendo en familia. Y sobre todo, informándonos.**

“Sacale la teta para que coma más”

Para todos los profesionales que plantean que “sacando la teta”, “porque es agua”, un niño va a “comer más” (por qué queríamos que “coma más” si está sano, ¿no?), dejen esta información por aquí.

Dice la Asociación Española de Pediatría:

“A partir del primer año de lactancia, la cantidad de grasa en la leche aumenta con respecto a los primeros meses, resultando un alimento completo y nutritivo para un lactante mayor y de mayor calidad que la leche de fórmula o de vaca. Se ha visto que un bebé mayor de un año que toma pecho obtiene aproximadamente 1/3 de sus necesidades calóricas y proteicas diarias a través de la leche materna (a veces más, sobre todo durante períodos de enfermedad), además de una cantidad muy importante de vitaminas y minerales”.

La leche materna SIEMPRE es nutritiva. Además, cuenta con probióticos y prebióticos, que en cuanto la industria pueda meter en un frasco y vender, vamos a estar todos comprando como locos.

Ningún profesional de la salud puede “indicar” el destete (a menos que haya una situación de salud de gravedad que lo requiera). Es una decisión de mamá y bebé.

Si un niño está atravesando el proceso de neofobia y selectividad, sacarle la teta es solo sacar una de sus fuentes de nutrientes. ¡Por destetar no va a “comer más”!

“No come pero toma la leche”

Es habitual observar niños mayores de 1 año que ante la negativa de ingerir alimentos sólidos, se les ofrezca una mamadera de leche u otros postres lácteos como el yogur y similares. Todos estos productos cuentan con alto contenido de azúcar en el mejor de los casos, de jarabe de maíz de alta fructosa, y de colorantes y conservantes, además de que no podemos nunca asegurar cómo está conservada la cadena de frío.

La mayoría se promociona con “agregados” de vitaminas y otros suplementos. Lo racional sería que estos nutrientes sean incorporados a través de una dieta variada y equilibrada. **En nuestro medio, debido a este “reemplazo” de comida por leche, los niños superan ampliamente los requerimientos de calcio diario para su edad, prolongando esto mismo el uso de las mamaderas, la baja absorción de los nutrientes aportados por otros alimentos y los trastornos gastrointestinales.**

La intención no es demonizar ningún alimento. Simplemente informar, y saber que el “al menos me toma leche” tampoco es sano.

Neofobia alimentaria y selectividad

“Comía de todo... ¡y ahora solo come fideos!”

Rondando el año y medio de vida, muchos bebés adquieren emocionantes habilidades: caminar, hablar más claramente, correr, trepar... todo les da una perspectiva nueva del universo y comer ya no es tan divertido.

Bebés que comían “bien” (término que no me gusta, pues es ponerle un juicio de valor a la comida), de repente tiran todo, dejan de comer, se resisten a cosas nuevas y se bajan de la mesa para ir a correr por ahí. Esto se llama **NEOFobia ALIMENTARIA (rechazo a incorporar nuevos alimentos o a algunos ya incorporados), y es un comportamiento absolutamente normal, si bien suele asustar a las familias.**

Se plantea que la neofobia alimentaria es una conducta ancestral de los seres humanos omnívoros, en la que, recelosos de un posible daño por alimentos nuevos, apartamos lo que no nos parece que tenga buena pinta.

¿Y por qué? Podemos pensarlo como algo evolutivo. Al año de vida, los bebés suelen empezar a caminar. En la antigüedad, deambular los acercaba a plantas interesantes, que podían ser venenosas. Probablemente ese recelo a “probar algo nuevo” venga de ahí.

¿Y qué hacemos? ¿Se va a desnutrir? No. Los niños durante su primer año de vida triplican aproximadamente el peso del nacimiento. Esa velocidad nunca volverá a ocurrir (¿se imaginan triplicar nuestro peso en un año?). ¡La necesidad de nutrientes es diferente!

Generalmente, los chicos se inclinan por comer cosas que:

- * Se agarren con la mano y se puedan llevar por ahí (y terminar escondidas adentro de un sillón, por ejemplo).
- * No tengan mucho volumen.
- * Tengan muchas calorías en poquitos mordiscos.

Y allí aparecen los fideos, las papas, las patitas de pollo... las llamadas “*finger foods*”.

La neofobia y la selectividad pueden durar mucho tiempo, generalmente resolviéndose alrededor de los 6-7 años (y teniendo en cuenta que hay adultos muy selectivos, algunos por idiosincrasia y otros por haber sido ferozmente obligados de niños a comer ESE alcaucil que odiaban).

Cómo atravesar la neofobia alimentaria

- La primera información para quedarse tranquilos es que **TENEMOS QUE CONFIAR EN LA SACIEDAD** de los chicos. Si no quiere comer más, es porque no tiene más hambre. En una época regida por el aumento vertiginoso de la obesidad infantil, todas las guías profesionales actualizadas están de acuerdo en algo: **NO OBLIGAR A COMER**. La responsabilidad del adulto empieza y termina en presentar comida con alto valor nutricional, y no en insistir ante un plato lleno de brócoli.
- No desesperar. ¿Crece bien? ¿Corre, juega, es feliz? Ningún niño/a muere de hambre si tiene alimento a mano. Ningún niño/a crece si no ingiere el alimento necesario. Es decir, si está creciendo, es que le están alcanzando los nutrientes. ¿Puede haber déficit de algún nutriente? Sí, el déficit más común es el de hierro, pero no tiene que ver con la **CANTIDAD** que come un niño, sino con la **CALIDAD** que tienen sus alimentos.
- No desesperar (parte 2). El querer que “coma algo” nos lleva a correr al niño por la casa con el postrecito industrial, la patita de pollo o el fideo, lo único que acepta. No hay necesidad. Es nuestra responsabilidad ofrecer, si no lo acepta en este momento, será más tarde. Si no come nada del plato, se le ofrece después. Circunscribirnos a una comida sola porque “le gusta” es cerrar el juego a otras posibilidades nutricionalmente más saludables.
- No desesperar (parte 3). “Si no comés, no hay postre”, “te vas a dormir sin comer”, “con la comida no se juega”; estas frases solamente generan una sensación de premio-castigo. ¿El postre es mejor que el resto de la comida, ya que es un premio? ¿Hay comidas “buenas” y comidas “malas”? El nutricionista español Julio Basulto, en su libro *Se me hace bola*, explica que lo mejor es evitar el peso emocional en la comida. Si el niño/a

hace un berrinche (muy común de la edad) porque no le gustan las chauchas, nos quedamos tranquilos y podemos decirle: “Ah, mirá, a mí tampoco me gustaban las chauchas a tu edad”, y seguir comiendo. Sin mucho más drama.

- **Dar el ejemplo: si nosotros no comemos verduras porque no nos gustan, ¡no podemos pretender que el/la niño/a coma verduras!** Está bueno tratar de que todos comamos lo mismo, y aprovechar el inicio de la alimentación complementaria como un cambio de hábitos familiar. Lo más probable es que, de tanto ver el tomatito *cherry* en nuestro plato y decir que no le gusta, un día lo agarre y lo ponga en el suyo, y otro lo pruebe, y a la semana se enamore.
- **No comprar lo que no deseamos que coman.** Si las galletitas (sobre todo las galletitas...), los postrecitos, las golosinas y las papas fritas están a mano... ¿cómo no quererlas? ¿Cómo no consumirlas? El picoteo de lácteos y harinas es típico y lleva, posteriormente, a no desear almuerzo ni cena. Lo que no está en casa, no se come...
- **Los lácteos de vaca no reemplazan a la comida.** Ya hablamos del “no come pero al menos me toma la leche”. Grandes cantidades de lácteos al día generan carencias nutricionales, como también las generarían vivir a mandarinas.
- **Si el niño toma leche materna, destetar NO es una sugerencia.** La Organización Mundial de la Salud sugiere lactancia materna hasta mínimo 2 años, y luego el tiempo que el binomio decida. Destetar NO va a aumentar el apetito ni hacer que “coma mejor”. La leche materna siempre nutre.
- **Dejarlos que participen en la cocina.** Que le pierdan el miedo a los cuchillos, al fuego, a los condimentos (por supuesto, todo adaptado a la edad). Que entiendan que son capaces de producir su propio alimento y no depender de productos ni del *delivery*. Que se sientan orgullosos de lo que pueden hacer.
- **Que nos acompañen a comprar la comida.** Dar una vuelta por la verdulería, dejarlos elegir alguna fruta o verdura que les llame la atención. Tal vez ni nosotros sepamos qué es eso y tengamos que aprender formas nuevas de prepararlo. (Yo no conocí las paltas hasta que tuve 25 años).

- Dejar frutas y verduras “a mano”. Nadie se resiste a una bandeja de frutas cortadas sobre la mesa. ¡Algo van a agarrar!
- Permitirles ensuciarse, tocar texturas, pintar con comida. Sí, mucho para limpiar, pero tendremos niños con experiencias sensoriales felices que los acercan a los alimentos.
- Dijimos que comen poco, calórico y con la mano. ¿Qué podemos preparar saludable?
 - **Comida en tiras y fácil de llevar por el mundo:** tiras de carne o pollo, zanahorias *baby*, tomates *cherry*, huevos, trozos grandes de frutas. Todo adaptado a la edad para evitar el riesgo de asfixia.
 - **“Pastas” para mojar el pancito o estas “tiras”:** hummus (garbanzos cocidos y molidos), guacamole, pasta de lentejas, quesos vegetales o quesos untables si consumen lácteos (recordemos que hasta los 2 años se recomiendan lácteos enteros). Todo de alta densidad calórica.
 - **“Patitas” caseras, que no son más que milanesas pequeñas.** Las “patitas” industriales difícilmente estuvieron alguna vez cerca de un pollo.

Dar el ejemplo siempre es la clave. Si nosotros como adultos comemos sana y tranquilamente, y nuestros hijos ven eso, de a poco se incorporarán a nuestra alimentación. Paciencia y mucho amor. Esto también pasará.

“No come... ¿le podemos dar vitaminas? ¿O ‘algo’?”

Ante esta pregunta, usual en el consultorio pediátrico, es importante aclarar que **las vitaminas NO aumentan el apetito, por lo que NO están indicadas en niños que “comen poco”.**

Se debe también tener en cuenta que ciertas vitaminas (A, E, K, D) presentan toxicidad ante su ingesta excesiva. Los suplementos de vitamina C tampoco son necesarios, y no protegen de los resfríos y otras enfermedades, mucho menos si la dieta general es deficiente.

En ocasiones puntuales, como enfermedades crónicas, desnutrición o cierto tipo de alimentaciones, será necesario suplementar con vitaminas, siempre bajo supervisión de médicos/as y nutricionistas.

Los suplementos hipercalóricos para niños están de moda hoy en día y su publicidad puebla los consultorios pediátricos. Este concentrado es muy útil en niños cursando una patología que les impide alimentarse normalmente (por ejemplo, recibir

quimioterapia) o enfermedades crónicas, pero de ninguna manera debería indicarse como complemento de un niño sano que no come verduras, por ejemplo, como me han llegado casos al consultorio. Estos suplementos se promocionan como “un empujoncito de nutrientes mientras se aprende a comer BIEN”. Comer BIEN implica respetar nuestra hambre, reconocer nuestra saciedad e incorporar alimentos variados, no productos de la farmacia.

Las vitaminas y los complementos son lamentablemente de venta libre y es importante comprender que son una medicación y que solo un profesional puede indicarlos, EN LAS DOSIS ADECUADAS. **La mejor manera de garantizar un adecuado aporte de todas las vitaminas necesarias es una dieta variada.** Hemos visto que los niños se autorregulan a nivel alimentario, y que eso puede hacer que coman “poco” o selectivamente. Por eso es importante ofrecer, sin obligar, los grupos de alimentos en forma variada y constante, y como adultos, dar el ejemplo y empaparnos de información en pos de una niñez más sana.

Dificultades en la alimentación

No todo es neofobia. Los pediatras debemos estar atentos a pesquisar dificultades en el desarrollo, incluidas las relacionadas con la alimentación. Puede haber cuestiones relacionadas con los antecedentes de ese niño, como por ejemplo, ser prematuro o la utilización de sondas nasogástricas que hayan generado trastornos en la oralidad. También debemos estar atentos a los niños con desafíos sensoriales. Para explicar un poco esto, pedí colaboración a **María Fernanda Iroumé, terapeuta ocupacional (M. N. 3663), estimuladora temprana y consultora de porteo.**

“La integración sensorial es el proceso neurológico que organiza la sensación de nuestro propio cuerpo y del ambiente, y hace posible el uso del cuerpo en forma efectiva dentro del ambiente” (Dra. Jean Ayres, 1989), podemos referirnos entonces al procesamiento sensorial como la forma en que el sistema nervioso recibe mensajes y los transforma en una respuesta. El acto de alimentarse es uno de los desafíos sensoriales más complejos a los que un niño se enfrenta. La selectividad alimentaria es, por definición, la ingesta restringida a pocos alimentos y el rechazo a incorporar alimentos nuevos. Si bien es común que entre los 18 y 24 meses los niños muestren cierta selectividad alimentaria (algunos autores los llaman “picky eaters”), hay una franca diferencia con aquellos que presentan un trastorno sensorial. En estos casos, la comida familiar es un momento de mucha tensión, puede aparecer tos, arcadas o incluso vómito, solo logran

ingerir alimentos de una marca específica o respetando siempre los mismos pasos para su elaboración, suelen rechazar categorías completas de alimentos (por ejemplo: ningún alimento blando o ningún alimento crocante), a pesar de pasar por más de 10 exposiciones a un alimento no logran incluirlo en su dieta y muestran dificultad para explorar los alimentos (olerlos, tocarlos, etc.). Estos niños también suelen mostrar peso inferior a la edad”.

El pediatra es el responsable de evaluar estas condiciones, y si es necesario, buscar trabajar con un equipo multidisciplinario para acompañar el desarrollo del niño y a su familia.

El mundo real: la casita de Hansel y Gretel

Por fuera de casa, todo conspira para un mundo lleno de azúcar poco saludable. Ánimo, de a poco vamos tomando conciencia, y lo que es esporádico no es costumbre.

La escuela

Uno de los mayores temores de los mapadres que son muy conscientes de la alimentación de sus hijos son las comidas escolares y el kiosco de la escuela. Lamentablemente, los menús infantiles, tanto de establecimientos escolares públicos como privados, están diseñados para ser baratos y “simpáticos”. Muchas veces incluyen jugo, sándwiches, fiambre y galletitas.

Los kioscos escolares también se manejan con total impunidad, sin ninguna regulación, vendiendo productos con toneladas de azúcar e incluso, como ya mencioné, panchos en los recreos (como si un niño necesitara una salchicha a las 9 a.m....).

¿Qué hacemos con esto?

- * **Confiar en las decisiones de los chicos.** Los aritos de colores son sumamente tentadores, ni hablar. Pero podemos explicarles de qué están hechos, por qué no son tan saludables y por qué no los comemos en casa. ¿Los consumirán igual? Probablemente, pero con más información. Y eso es lo que importa.

- * **Asumir una responsabilidad social.** Unirnos con otros mapadres, involucrarnos en la importancia de una toma de conciencia. Podemos convocar a algún profesional de la salud que haga una charla escolar para explicar la importancia de la alimentación saludable.
- * **Animarse a plantear opciones.** A veces el límite lo ponemos nosotros creyendo que no se puede cambiar nada o que nadie va a querer participar.
- * **Sugerir cambios concretos.** De jugo de sobre a agua con rodajas de frutas, de galletitas a chipá, de yogur a frutas frescas.

Los cumpleaños

Los cumpleaños suelen ser ocasión de reencuentro de familiares y amigos. Y culturalmente, solemos celebrarlos sentándonos a la mesa o preparando un menú especial, diferente al de todos los días.

Los cumpleaños infantiles no son la excepción, solo que en ellos abunda mayormente la comida “de pie”: panchos, papitas, chizitos, palitos, caramelos de la piñata (a veces me pregunto por qué nunca pensamos que esas cosas pueden ser peligrosas, por su forma y tamaño, en niños pequeños), gaseosas, jugos y la infaltable bolsita de golosinas para llevarse de recuerdo.

¿Existen otras opciones ricas y sanas, evitando estos alimentos de bajo valor nutricional? ¡Claro que sí!



Podemos proponer opciones saludables y fáciles

- * **Pinchos de frutas.**
 - * **Platitos con tomates *cherry*.**
 - * **Aceitunas sin carozo y rodajas de choclo.**
 - * **Papas fritas caseras.**
 - * **Galletitas caseras y “pastas” (guacamole, hummus, mayonesa de zanahoria) para untarlas.**
 - * **Tiritas de *pizza*.**
 - * **Frutos secos, y/o pochoclos si ya son más grandes, y/o uvas, frutillas...**
-
- La bolsita puede contener galletitas caseras, algún juguete simple como plastilina, *stickers*... no es necesario que estén llenas de caramelos. La tradición es la bolsita, no su contenido. Mi amiga Cinthia, en el cumpleaños de su hijo Nahuel, puso lápices de colores y un burbujero en cada bolsita. Amo los burbujeros.
 - Juntar varios cumpleaños en uno solo (por ejemplo, festejar todos los cumpleaños del mes del jardín en un solo día).
 - Ofrecer agua como bebida, o a lo sumo, agua con rodajas de frutas o limonada casera.
 - Hay muchas opciones coloridas y, lo más lindo, podemos incluir a los niños en su

preparación. Lavar los tomatitos, elegir en la verdulería los limones para exprimir, sacarles las hojitas a las frutillas... Todo puede ser parte de su fiesta.

La comida y las enfermedades

Es muy común que, durante las enfermedades frecuentes de la infancia, los chicos no quieran comer. Les duele la garganta, tienen mocos, están cansados. No tienen ganas, y eso nos preocupa muchísimo. La solución es pensar cómo nos sentimos nosotros cuando nos enfermamos y ponernos en su lugar. Es feo ir a trabajar con los mocos colgando, ¿o no?

Si no tienen hambre, no pasa nada. Lo importante, como veremos en el último capítulo del libro, es mantener la hidratación. Ofrecer teta, leche de fórmula o agua, según la edad. El peso que pierda un niño sano durante una enfermedad aguda lo recuperará rápidamente.

En el caso de las diarreas, es muy común buscar seguir una dieta especial. Los estudios dicen claramente que no hace falta, si nuestra alimentación es saludable. **Es importante mantener la alimentación en forma normal mientras dure la diarrea porque acelera la normalización de la digestión y absorción de nutrientes, y favorece la hidratación.** Ofrecer pequeñas porciones de alimentos muy nutritivos varias veces al día. Y paciencia.

Reflexión final: soberanos de los alimentos

*Este compró un huevito.
Este lo cocinó.
Este le puso la sal.
Este lo peló.
Y este pícaro gordo.
Se lo comió, se lo comió, se lo comió.
(Copla popular infantil)*

Conozco adultos que nunca se han acercado a una hornalla. Sus mapadres no se los permitieron, por miedo a que se lastimen. Yo creo que eso los lastimó mucho más que la quemadura hipotética a la que se exponían.

Yo no sé cómo es un grano de avena, y tardé mucho en dejar de leer las calorías de todo lo que consumía. Porque pasaba eso: consumía, no comía.

Progresivamente, cuando mi hijo mayor empezó a comer, empecé a pensar más en qué le estaba ofreciendo. Empecé a leer, a investigar. A preguntarme por qué se prohibían las frutillas y se indicaba gelatina. A sacarme el prejuicio de que comer sano es caro y trabajoso.

A medida que más investigaba, más me sorprendía encontrar material científico que desmoronaba todo lo que había aprendido hasta el momento. Y empecé a divulgar, y a encontrarme con tres frases recurrentes entre mis lectores en las redes sociales.

La primera: “Entonces no se puede comer nada”, cuando hablo de empezar a dejar de lado los productos industriales e intentar consumir alimentos lo menos procesados y contaminados posibles. Ya vimos muchísimas opciones posibles y decenas de alimentos posibles desde el inicio de la alimentación complementaria. Hacer reaparecer legumbres y cereales, priorizar frutas y verduras, hacer ricas las carnes, usar grasas sabrosas...

La segunda: “Comer sano es muy caro y no todos tienen acceso”. Durante años creímos que los cereales infantiles y las leches de soja eran lo mejor del mundo. Me formé en un hospital público y vi el esfuerzo monumental de muchas familias por comprar un conocido postre lácteo azucarado para alimentar a sus hijos, creyendo que era lo más sano y lo mejor que podían darles. Una caja de cereal infantil sale lo mismo que una palta, medio kilo de damascos y un paquete de polenta. Y esto último tiene infinita mejor calidad alimentaria que lo anterior.

La tercera, que se ha vuelto viral en mi grupo de trabajo: “Le estás robando la infancia a los chicos prohibiéndoles las cosas ricas”. Y empecé a pensar en las cosas ricas y en la importancia del placer ligado a los alimentos. **¿Rica es solo la galletita que trae figuritas? Parte de “ser rico”, ¿no es el amor que le ponemos a aprender acerca de alimentación? ¿El tiempo que invertimos en cortar la banana para hacerla apta para un bebé?**

La importancia de que nuestros hijos sepan que pueden ser soberanos de su alimentación es clave. Que puedan involucrarse en la cocina, que, como dice la experta culinaria brasileira Bela Gil, no tengan miedo de involucrarse con el fuego y los cuchillos, sino respeto. Que puedan acompañarnos a elegir la fruta que más les guste en la verdulería. Que jueguen con la tierra y no se priven de cultivar una plantita de perejil que luego comerán, aunque sea en una maceta del balcón. Que esta generación, que se vaticina enferma por los productos que nos impone la industria, tenga las herramientas para decidir su futuro y su salud.

Para leer

PARA FAMILIAS

- González, C. *Mi niño no me come*, Editorial Planeta, Ciudad de México, 2014.
- Eilenber, K. y Gatti Wosner, S. *Yo amo comer*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2017.
- Kiako, N. *A cuatro manos*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2018.
- Barruti, S. *Mala leche*, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2018.
- Troncoso, L. *Los primeros 1000 días de tu hijo*, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2019.
- Kiako, N. *Antinutrientes, ¿y ahora qué hago?* Disponible en: <http://nataliakiako.com.ar/antinutrientes-y-ahora-que-hago/>
- Kiako, N. *Pequeño manual de remojo y fermentación*. Disponible en: <http://nataliakiako.com.ar/pequeno-manual-de-remojo-y-fermentacion/>
- Oyarzo Salazar, M. *Cocina Biomédica*, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2018.
- Llorca, J. y Gómez, M. *Sin dientes y a bocados*, Penguin Random House, 2018.
- Llorca, J. y Gómez, M. *En boca de todos*, Penguin Random House, 2019.
- Basulto, J. *Se me hace bola*, Penguin Random House, 2013.

PARA FAMILIAS Y PROFESIONALES

- Organización Panamericana de la Salud. *Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas*, 2016. Recuperado de: <http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/7698>
- Monteiro, C. A.; Cannon, G.; Levy, R.; Moubarac, J. C.; Jaime, P.; et ál. *NOVA. The star shines bright*, World Nutrition, 2016. Recuperado de: <https://worldnutritionjournal.org/index.php/wn/article/view/5>
- World Health Organization. (2015). *Guideline: sugars intake for adults and children*. Recuperado de: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/149782>
- Fidler Mis, N.; Braegger, C.; Bronsky, J.; Campoy, C.; Domellöf, M.; Embleton, N. D.; et ál. *Sugar in Infants, Children and Adolescents: A Position Paper of the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition*. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017, Dec; 65(6):681-96. DOI: 10.1097/MPG.0000000000001733.
- Vos, M. B.; Kaar, J. L.; Welsh, J. A.; Van Horn, L. V.; Feig, D .I.; Anderson, C. A. M.; et ál. *Added sugars and cardiovascular disease risk in children: a scientific statement from the American Heart Association*. Circulation. 2017, May 9; 135(19): e1017-e1034. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000439.

- Agencia de Salud Pública de Cataluña. *Preguntas más frecuentes: PMF. Recomendaciones para la alimentación en la primera infancia (de 0 a 3 años)*, 2017. Recuperado de: http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/alimentacio_saludable/Publicacions/castella/
- Organización Mundial de la Salud. Directrices: *Ingesta de sodio en adultos y niños*, 2013. Recuperado de: https://www.who.int/nutrition/publications/guidelines/sodium_intake/es/
- Gómez Fernández-Vegue, M. Asociación Española de Pediatría. *Recomendaciones para la alimentación complementaria*, 2018. Recuperado de: <https://www.aeped.es/comite-lactancia-materna/documentos/recomendaciones-aeped-sobre-alimentacion-complementaria>
- Ministerio de Salud de Argentina, *Nutrición del niño prematuro*, 2015.
- Programa Nacional de Actualización Pediátrica (PRONAP) 2014, Módulo 2, *Mitos en Alimentación Infantil*.
- Organización Panamericana de la Salud, *Plan de acción para la prevención de la obesidad en la niñez y la adolescencia*, 2014. Recuperado de: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11373:plan-of-action-prevention-obesity-children-adolescents&Itemid=4256&lang=es
- Setton, D. y Fernández, A. *Nutrición en Pediatría*, Editorial Panamericana, 2014.
- Ministerio de Salud de Brasil, Secretaría de Atención a la Salud Departamento de Atención Primaria. *Guía Alimentaria para la población brasileira*, 2015.
- Silva Ocampo, P. y Durán A., S. *Bebidas azucaradas, más que un simple refresco*. Rev. chil. nutr. vol.41, no.1, Santiago, Mar. 2014. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.4067/S0717-75182014000100013>
- Cabezas Zabala, C. C.; et ál. *Azúcares adicionados a los alimentos: efectos en la salud y regulación mundial. Revisión de la literatura*. Revista de la Facultad de Medicina (2016), 64(2):319. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v64n2.52143>
- R. Tojo Sierra, Comité de Nutrición de la Asociación Española de Pediatría. Asociación Española de Pediatría. *Consumo de zumos de frutas y bebidas en la infancia*. 2003. Recuperado de: <https://www.aeped.es/comite-nutricion/documentos/consumo-zumos-frutas-y-bebidas-refrescantes-por-ninos-y-adolescentes-en-espana-imp>
- American Academy of Pediatrics. *La American Academy of Pediatrics recomienda que los niños menores de 1 año de edad NO tomen jugo de fruta*. The Healthy Children en español. 2017. Recuperado de: <https://www.healthychildren.org/Spanish/news/Paginas/aap-recommends-no-fruit-juice-for-children-under-1-year.aspx>
- Ministerio de Salud de la República Argentina. *Disminuir el consumo de bebidas azucaradas para cuidar la salud*. 2017. Recuperado de:

<http://www.msal.gob.ar/ent/index.php/home/6-destacados-slide/425-disminuir-el-consumo-de-bebidas-azucaradas-para-cuidar-la-salud>

- Riveros, M. J.; Parada, A.; Pettinelli, P. *Consumo de fructosa y sus implicaciones para la salud; malabsorción de fructosa e hígado graso no alcohólico*. Nutr. Hosp. vol. 29 no.3, Madrid, mar. 2014. Recuperado de: <http://dx.doi.org/10.3305/NH.2014.29.3.7178>
- Kasangian, J. H. *Jarabe de maíz de alta fructosa y su relación con la obesidad*. Intramed. 2010. Recuperado de: <https://www.intramed.net/contenido.asp?contenidoID=67306>
- ¿Está la fructosa engordando a la gente? Medlineplus. 2013. Recuperado de: <https://www.intramed.net/contenido.asp?contenidoID=78714>
- Pellegrini, L. *Fructosa (JMAF), obesidad y diabetes*. Asociación Profesionales de Salud y Alimentos, 2018. Recuperado de: <http://apsal.org/fructosa-jmaf-obesidad-diabetes/>
- Havel, P. J. *Dietary Fructose: Implications for Dysregulation of Energy Homeostasis and Lipid/Carbohydrate Metabolism*. Nutrition Reviews, Volume 63, Number 5, May 2005, pp. 133-157. DOI: 10.1301/nr.2005.may.133-157.
- Fundación Interamericana del Corazón: <https://www.ficargentina.org/publicidad-de-alimentos-dirigida-a-ninos-y-ninas-en-la-argentina/>
- Fu, X.; Conlon, C. A.; Haszard, J. J.; Beck, K. L.; Von Hurst, P. R.; Taylor, R. W.; Heath, A. L. M. (2018). *Food fussiness and early feeding characteristics of infants following Baby-Led Weaning and traditional spoon-feeding in New Zealand: An internet survey*. Appetite, 130, 110–116. DOI:10.1016/j.appet.2018.07.033.
- Roviroso, A.; Zapata, M. E.; Gómez, P.; Gotthelfd, S.; Ferrante, D. *Alimentos y bebidas publicitados en canales infantiles de Argentina: frecuencia, duración y calidad nutricional*. Arch Argent Pediatr 2017; 115(1):28-34/28. Recuperado de: <https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2017/v115n1a06.pdf>
- Ministerio de Salud de la Nación. *La alimentación de los niños menores de dos años*. Resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud - ENNyS 2010. Buenos Aires. 2010. Recuperado de: <https://goo.gl/y52j3s>
- Laporta Báez, Y.; Goñi Zaballo, M.; Pérez Ferrer, A.; Palomero Rodríguez, M. A.; Suso, B.; García Fernández, J. Servicio de Anestesiología y Reanimación. Hospital Universitario La Paz. Madrid. España. *Metahemoglobinemia asociada a la ingesta de acelgas*. Anales de pediatría. Vol. 69. Núm. 2. páginas 103-245 (Agosto 2008). Recuperado de: <https://www.analesdepediatría.org/es-metahemoglobinemia-asociada-ingesta-acelgas-articulo-S1695403308720393>
- Sociedad Argentina de Pediatría, Comité de Nutrición. *Lineamientos para la Alimentación del Niño Menor de 2 Años*, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 2001. Recuperado de: <https://goo.gl/qiLaSp>
- Ministerio de Salud de la Nación. *Guías alimentarias para la población infantil*. Buenos Aires, 2006. Recuperado de: <https://goo.gl/cwMhB9>
- Orsi, M.; et ál. *Alergia a la proteína de la leche de vaca: Propuesta de Guía para*

- el manejo de los niños con alergia a la proteína de la leche de vaca*. Arch. Argent. Pediatr. 2009, vol. 107, n. 5, pp. 459-467. Recuperado de: <https://goo.gl/DLyrD2>
- Guzmán, M. A. *Alergia e intolerancia alimentaria*, Editorial Mediterráneo, 2015.
 - Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. *Principios de orientación para la alimentación complementaria del niño amamantado*. Asociación Española de Pediatría, 2003. Recuperado de: https://www.aeped.es/sites/default/files/1-orientacion_para_la_ac.pdf
 - Ierodiakonou, D.; García-Larsen, V.; Logan, A.; Groome, A.; Cunha, S.; Chivinge, J.; et ál. *Timing of allergenic food introduction to the infant diet and risk of allergic or autoimmune disease: a systematic review and meta-analysis*. JAMA. 2016, Sep 20; 316(11):1181-92. DOI: 10.1001/jama.2016.12623.
 - Cuadros-Mendoza, C. A.; Vichido-Luna, M. A.; Montijo Barrios, E.; Zárate-Mondragón, F.; Cadena-León, J.; Cervantes-Bustamante, R.; et ál. *Actualidades en alimentación complementaria*. Acta Pediatr Mex. 2017; 38(3):182-201. Recuperado de: www.scielo.org.mx/pdf/apm/v38n3/2395-8235-apm-38-03-0182.pdf
 - Ministerio de Salud de la Nación. *Situación de la Lactancia Materna en Argentina*. Buenos Aires. 2015. Recuperado de: <https://goo.gl/ro6RFP>
 - Dogan, E.; Yilmaz, G.; Caylan, N.; Turgut, M.; Gokcay, G.; Oguz, M. M. *Baby-led complementary feeding: Randomized controlled study*. Pediatr Int. 2018, Dec; 60(12):1073-1080. DOI: 10.1111/ped.13671.
 - Cameron, S. L. y Taylor, R. W. *Heath AL3 Development and pilot testing of Baby-Led Introduction to Solids - A version of Baby-Led Weaning modified to address concerns about iron deficiency, growth faltering and choking*. BMC Pediatr. 2015 Aug 26; 15:99. DOI: 10.1186/s12887-015-0422-8.
 - Brown, A. *No difference in self-reported frequency of choking between infants introduced to solid foods using a baby-led weaning or traditional spoon-feeding approach*. Journal of Human Nutrition and Dietetics. 2017. Recuperado de: <https://doi.org/10.1111/jhn.12528>
 - Rapley, G. *Baby-led weaning: transitioning to solid foods at the baby's own pace*. 2011. Community Pract 84, 20–23. Recuperado de: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21739856>
 - Daniels, L.; Taylor, R. W.; Williams, S. M.; Gibson, R. S.; Samman, S.; Wheeler, B. J.; Taylor, B. J.; Fleming, E. A.; Hartley, N. K.; Heath, A. M. *Modified Version of Baby-Led Weaning Does Not Result in Lower Zinc Intake or Status in Infants: A Randomized Controlled Trial*. J Acad Nutr Diet. 2018 Jun; 118(6):1006-1016.e1. DOI: 10.1016/j.jand.2018.02.005.
 - Daniels, L.; Heath, A. L.; Williams, S. M.; Cameron, S. L.; Fleming, E. A.; Taylor, B. J.; et ál. *Baby-Led Introduction to Solids (BLISS) study: a randomized controlled trial of a baby-led approach to complementary feeding*. BMC Pediatr. 2015 Nov 12; 15:179. DOI: 10.1186/s12887-015-0491-8.
 - Martínez Biarge, M. *Niños vegetarianos, ¿niños sanos?* AEPap (ed.). Curso de

Actualización Pediatría 2017. Madrid. Lúa Ediciones 3.0; 2017. p. 253-68.

Recuperado de: https://www.aepap.org/sites/default/files/pags._65-78_ninos_vegetarianos.pdf

- Redecillas, S.; Moráis, A.; Marques, I.; Moreno-Villares, J. M. (2018). *Guía de recomendaciones sobre las dietas vegetarianas en niños*. Anales de Pediatría. DOI:10.1016/j.anpedi.2018.09.012.
- Sociedad Argentina de Pediatría, Comité Nacional de Nutrición, *Obesidad: guías para su abordaje clínico*, 2015. Recuperado de: www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2016/v114n2a26.pdf

CURSOS QUE HICE Y QUE APORTARON A ESTE CAPÍTULO

(muchos de ellos son gratuitos y accesibles)

- Curso de Universitario de Posgrado en modalidad virtual en Obesidad en Edades Pediátricas, Universidad del Hospital Italiano de Buenos Aires, 2019.
- Curso: Pesquisa de trastornos de la deglución y la conducta alimentaria en lactantes y niños pequeños. Abordaje interdisciplinario. Hospital Garrahan, 2019.
- Curso a distancia de Medicina Ambulatoria Pediátrica, Hospital Garrahan, 2018-2019.
- Curso Básico de Lactancia Materna Tercera Edición, Secretaría de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Plataforma SUMAR, 2018.
- Curso Virtual de Actualización sobre Enfermedad Celíaca para Médicos y Bioquímicos, Secretaría de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Plataforma SUMAR, 2018.
- Curso de Universitario de Posgrado en modalidad virtual Actualización en Alergias Alimentarias, abordaje médico-nutricional, Universidad del Hospital Italiano de Buenos Aires, 2017.
- VI Curso Latinoamericano Virtual de Nutrición Infantil, Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, 2017.
- Alimentación saludable, Centro Cultural Ricardo Rojas, Universidad de Buenos Aires, 2017.
- Políticas efectivas de desarrollo infantil, Banco Interamericano de Desarrollo, 2017.
- Child Nutrition and Cooking, Stanford University, 2019.
- Complementary Feeding in Infancy, Early Nutrition eAcademy, 2019.
- Programa Nacional de Actualización Pediátrica, Sociedad Argentina de Pediatría (curso anual para pediatras).

El sueño



Yo no quiero que duermas como el mundo quiere que duermas.

A mí no me interesa lo que dicen los libros. Yo quiero ver tu sueño plácido, llena la panza de leche, flotando tal vez en el recuerdo de tu reciente mundo de agua.

Yo no quiero que duermas como otros lo han escrito. Quiero que te despiertes todas las veces que necesites un abrazo. Lo quiero porque entiendo que la naturaleza lo ha hecho así para asegurar tu vida. Quiero que me busques ansioso y quiero poder responder estando a tu

lado.

Yo no quiero que duermas como el mundo quiere que duermas, ni como el mundo necesita que duermas para que yo, tu madre, y él, tu padre, podamos trabajar más horas, ser más productivos, generarle más dinero a quién sabe quién.

Yo no quiero que tengas que adaptarte al ritmo del mundo, yo quiero que el mundo cambie su eje y le dé espacio a tu infancia.

Yo no quiero seguir hablando de “sueño cambiado” ni de “dejar llorar”. Quiero licencias de verdad. Quiero que todos sepan cómo se desarrolla un bebé naturalmente.

Quiero que las familias no tengan que llorar de agotamiento por tener un bebé que “no duerme” en casa y estar obligadas a rendir en el trabajo igual que antes. Quiero que se deje de patologizar tu infancia solo para perpetuar un sistema económico.

Yo quiero que duermas cuando estés cansado. Cuando te agotes de mirar el mundo con tus ojitos curiosos y necesites un rato para guardar la luz del sol en tu cabecita. Cuando el pecho de papá esté tan cómodo que amerite soñar.

Yo quiero que te sigas encendiendo en el medio de la noche, y que, juntos, la iluminemos.

Para dormir como un adulto... hay que ser un adulto

Antes de hablar de sueño infantil en mi consultorio —como de cualquier otro tema— empecé a documentarme. Este es un proceso que me resulta fascinante porque descubro cosas que no sabía, generalmente, y trato de leer en idiomas que desconozco, como el portugués o el francés (con resultados variables).

De los mocos, del andador y de los berrinches, hay mil opiniones en todas las ramas de la medicina (psicólogos, psicopedagogos, pediatras, médicos generalistas...). Y acerca del sueño infantil también, pero me encontré con que todas las opiniones y los trabajos, en el idioma que sea, empiezan con la palabra “trastornos” o se encuentran en la categoría “patología del sueño infantil”. Esta “patología” tiene diversos nombres en los DMS IV y V (manuales que usamos los médicos en general para “catalogar” —palabra horrenda— trastornos psiquiátricos). Despertares repetidos, terrores nocturnos, parasomnias. De todo. Cuando los leí, descubrí que yo tenía cinco o seis de esos “trastornos”, al parecer. Y tengo 30 años.

Reconozco que para este capítulo planificaba hacer una exposición grandilocuente acerca de las etapas del sueño infantil. Decidí que existen muy buenos libros especializados en el tema, como *Dormir sin lágrimas*, de Rosa Jové, del cual aprendí muchísimo. ¡Se los recomiendo!

Hay pocos niños que duerman toda la noche. Los bebés muy pequeños no tienen ritmo circadiano (ritmo sueño-vigilia), vienen de un suave y acuático ambiente uterino donde apenas, cada tanto, perciben un resplandor de luz. No hay día y noche, y pretender que se adapten a ello de golpe y porrazo solo porque empezaron a respirar solos es bastante optimista, por no decir utópico.

Los niños duermen cuando tienen sueño y están cansados, para procesar todo lo que han aprendido durante las horas de vigilia. Duermen lo que necesitan, ni más ni menos. Hasta que no se escolarizan, no tienen necesidad de seguir horarios rígidos, y pueden simplemente dejarse caer en un sillón o en los brazos de algún ser querido. Esto, lejos de ser patológico, creo que es lo que todos querríamos si la vida no estuviera repleta de obligaciones y trabajo.

¿Por qué queremos que los niños duerman toda la noche? Porque nosotros

trabajamos durante el día. Estamos cansados, tenemos que manejar o tomar cuatro colectivos diarios, necesitamos tomar decisiones, enfrentar responsabilidades, hacer guardia en el caso de muchos profesionales de la salud (como yo), tolerar que otro adulto nos maltrate (porque, lamentablemente, así solemos comportarnos como sociedad), sacarnos leche, comprar la comida, acompañar a la familia. No hay cuerpo que aguante sin dormir. Y sin embargo, no podemos “obligar” al niño a dormir, así como no podemos “obligarlo” a comer, ni a hacer pis, ni a aprender a sumar, ni a querernos.

Lo repito aquí como le he descripto en otras partes del libro: vivimos en una sociedad adultocéntrica. Traemos al bebé al mundo pero pedimos que no descalabre demasiado nuestro *statu quo* de adultos. No porque seamos malos mapadres, sino porque tenemos que seguir trabajando para darle al bebé “lo mejor”. Por eso, **patologizamos la infancia y, entre otras cosas que suceden en esa etapa, el sueño.**

Sí, existen bebés que duermen toda la noche. Preguntá en tu círculo cuántos son. Y a la gente que te diga que su hijo/a “duerme toda la noche”, preguntale qué es “toda la noche”. Tal vez te sorprendas cuando escuches que, en realidad, se despierta cuatro o cinco veces para tomar la teta.

Cuando hice la residencia de Pediatría, tuve noches interminables de trabajo donde el sueño no estaba en los planes. Dormirte en una guardia cuando hay trabajo es indigno, aunque alguna vez me quedé dormida hablando con una familia recién internada. Aún les sigo pidiendo disculpas en mis pensamientos, porque ser atendidos por una médica que llevaba más de 24 h despierta es una falta de respeto hacia ellos y hacia mí misma como persona (¿por qué permitimos que eso sea un trabajo “normal”?).

Pero más allá de esa etapa, yo duermo de forma entrecortada, pocas horas y la mayoría de los ruidos me despiertan. Juani se despertaba varias veces a la noche, yo lo traía a la teta y seguíamos durmiendo los dos. En un sentido estricto, podríamos haber dicho que “dormía poco”, pero según mi percepción, dormía toda la noche.

¿Cuántas horas tiene que dormir un bebé? ¿Y un niño de 2 años? ¿Cuántas siestas tiene que hacer? ¿Está bien si no se despierta en toda la noche? Las preguntas que suelo recibir de los mapadres son infinitas. Repito: nos han hecho patologizar la infancia... ¡pareciera que ya no hay niños sanos! Hace poco tiempo atrás tuve que hacer un certificado para un jardín de infantes donde sellaba con toda mi responsabilidad médica que no era patológico que un bebé se despertara y pidiera por su mamá. El bebito no tenía ninguna enfermedad psiquiátrica... solo quería a su mami.

Como dije antes, un niño duerme cuando está cansado. No se despierta nunca o se despierta diez veces para ver si estás a su lado. Se duerme con la teta, se duerme abrazado al perro, se duerme chupando la etiqueta de un muñeco de apego con forma de patito. Salta en la cama una hora antes de dormir, o escucha un cuento plácidamente y cierra los ojos. Te dice que no tiene sueño. Habla de monstruos debajo de la cama. Pide un vaso de agua. Todas esas situaciones son normales, sanas, y no

durarán para siempre.



¿Por qué se despierta un bebé tantas veces por la noche? ¿Por qué un bebé atravesando la angustia del octavo mes, que dormía seis horas seguidas, se empieza a despertar una vez por hora llorando? La respuesta es que necesitan ver que estamos al lado. Que no están solos. Que no hay depredadores porque está la presencia amorosa de alguno de sus seres amados. Lo necesitan, ellos no pueden saber que ya no vivimos al aire libre y que no va a venir un león a comerlos. Está programado en el cerebro de las crías, lo vemos en la naturaleza. ¿Por qué los patitos siguen, en fila impecable, a la pata? ¿Por qué el elefantito, que pesa toneladas, va a buscar a su mamá después de caerse jugando? (si no vieron ese video en YouTube, se los recomiendo, es genial). El adulto es la figura de apego, es refugio, es calma, es

todopoderoso. La noche da miedo, es oscura y no se ve bien (recordemos que los bebés no tienen la agudeza visual del adulto). Necesitan despertarse para asegurarse de que estemos allí.

¿Es agotador? Sí. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que apunta al rendimiento feroz en los trabajos, a la eficiencia y a dejar todo por la empresa. Y el respetar los tiempos fisiológicos de los niños y de los cuidadores de esos niños no está contemplado.

La medicina se basó muchos años en la diáda patología-tratamiento. Si los niños son enfermos psiquiátricos porque no duermen, ¡hay que buscar la cura! Sí, se probó con medicación en algún momento y no funcionó, o se intoxicaron demasiados niños (la mayoría de los fármacos para dormir son depresores del sistema nervioso central). Otra opción probada son los métodos de adiestramiento, que encima... ¡funcionan! A un pediatra llamado Richard Ferber —que seguramente fue poco abrazado en su vida— se le ocurrió describir esos métodos en un libro, así nació el “método Ferber”. Además, fundó el Centro Pediátrico para los Trastornos del Sueño en el Hospital Infantil de Boston. Su primer libro, que fue publicado en 1985, se llama *Solucione los problemas de sueño de su hijo*.

Trastornos.

Problemas.

Otra vez lo mismo.

Ferber no fue el primero. Antes de él, otros pediatras, como Spock y Valman, ya habían hecho libros con tablas y todo. Pero Ferber “la pegó”, tanto que seguimos hablando de él y sus discípulos (como Eduard Estivill, y hasta algún otro colega argentino que gusta de promover estos métodos).

El libro *Duérmete niño* de Estivill, que se sigue vendiendo en librerías y recomendándose entre profesionales y familias, básicamente plantea acostar al niño en su camita antes de que termine de dormirse y salir de la habitación. Lógicamente, una gran cantidad de niños llorarán. Ferber, Estivill y compañía, a través de una tabla preestablecida, plantean “dejar llorar” una determinada cantidad de minutos, e ir aumentándolos cada día, hasta que el niño no llore más y duerma toda la noche.

Últimamente también encontramos la moda de los *sleep coach* o “asesores de sueño”, personas sin formación en fisiología ni en salud infantil que, a partir de una suma de dinero en dólares, nos proponen solucionar todos nuestros problemas...

Como dije antes: funciona. **¿Por qué dejan de llorar los niños finalmente, después de muchos días? Porque se dan cuenta de que nadie concurrirá a consolarlos.** Que no importa cuánto lloren (recuerden que esto ocurre desde el nacimiento, es decir, los bebés no tienen otra herramienta más que el llanto para comunicar que algo les molesta, les da miedo, los angustia), nadie concurrirá, o si viene alguien, no los levantarán de la cuna (otra cosa que sugieren estos señores), sino

que les dirán algunas palabras y se irán de nuevo.

El niño llorará hasta que se “cansé”. Cansarse en este caso es desencadenar una cadena de hormonas y neurotransmisores que generan hasta vómitos (Ferber y Estivill inclusive lo avisan... Al parecer, el niño es un ser manipulador que vomita a propósito para hacernos trabajar más). **El estrés del llanto produce altas cantidades de cortisol y también puede inhibir la hormona de crecimiento.**

¿Qué dice la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) acerca del método “Duérmete, niño”? En sus recomendaciones para el sueño seguro del año 2017, no solo no adhiere al método “Duérmete, niño”, sino que tampoco desaconseja tajantemente el colecho.

Cito textual: “Si bien algunos niños permanecen calmos en sus cunas en los períodos en los cuales no se alimentan, otros lloran de manera inconsolable. Algunos mapadres adhieren, entonces, a la norma de la psicología conductista del *Duérmete, niño*, que propone un método de adiestramiento para enseñar a los niños a dormir solos, que incluye dejar al niño llorando en su cuna. Esta práctica genera una situación de estrés para la diada”.

¿Existen verdaderos trastornos de sueño? Sí. Existen las disomnias (trastornos en la cantidad, calidad y horarios del sueño, entre las que encontramos, por ejemplo, las apneas) y las parasomnias (pesadillas, terrores nocturnos, sonambulismo...). No suelen darse en bebés pequeños, tienen síntomas característicos y es patrimonio del pediatra pesquisarlos y trabajar multidisciplinariamente para que generen el menor impacto posible en el niño y su familia.

En conclusión: **el sueño es un proceso madurativo.** No esperamos que un bebé de 3 meses camine, tampoco podemos esperar que duerma toda la noche. Esta expectativa parte de cosas que “nos dicen” o que nosotros, como adultos, necesitamos.

¿Hasta cuándo se despertará a la noche? ¿Hasta cuándo “es normal”? Se podría decir que aproximadamente hacia los 6 años el sueño es más parecido al de un adulto. Ahora, les dejo esta inquietud: ¿todos los adultos dormimos igual?

Nadie debería irse a dormir llorando.

Nadie debería quedarse con el corazón arrugado, viendo llorar a un ser amado “por su bien”.

Nadie debería sufrir, nunca, la desesperación de la no respuesta a la angustia, la congoja del abandono, la frialdad de que te den la mano y no un abrazo, “para que no te tome el tiempo”.

Nadie debería sentirse solo y triste en la cuna que, paradójicamente, fue preparada con tanto amor.

Nadie debería ser bombardeado/a de opiniones ajenas (a veces) con buena voluntad pero también con mucha ignorancia, explicando que los bebés son seres manipuladores.

Nadie debería creer que un ser que se asombra de su propia mano y se fascina con una sonrisa, puede tener el poder de “tomar el tiempo”.

Nadie debería acostumbrarse a no contar con quien más ama en la vida para calmar su tristeza. Si tu pareja llorara a tu lado, ¿considerarías que es sano? ¿Que mañana va a llorar menos? ¿Que de a poco se va a ir acostumbrando hasta dejar de llorar y entender que no, que nunca va a contar con tu abrazo para paliar esa angustia?

¿Por qué nos parece lógico, entonces, dejar llorar a un bebé en su cuna hasta que se agoten sus fuerzas, y comprenda que no puede contar con nadie para consolarlo?

¿Qué podemos hacer para que duerman “mejor”?

Después de todo lo expuesto, creo que quedó bastante claro que no hay métodos mágicos para que un niño duerma toda la noche. Sin embargo, existen algunas medidas que pueden ayudar.

- Entorno que propicie el sueño: ambiente calmo, oscuro, fresco. Toda la familia bajando el nivel de actividad diario.
- Evitar en los chicos el consumo de azúcares y estimulantes durante la tarde y la noche (en lo posible, consumirlos poco en general).
- Establecer rutinas, no inflexibles, pero sí constantes. Por ejemplo: comida, baño, teta, sueño.
- Evaluar la temperatura de la habitación: no sobreabrigar. Los bebés suelen tener piecitos y manos un poco más fríos que el resto del cuerpo, sin estar pasando frío necesariamente.

- Apagar pantallas: TV, celulares (sí, también), *tablets*, computadoras.
- Evitar usar la cama como castigo.

Dormirse con la teta y mamar durante la noche (*breastsleeping*)

Parte de los sistemas de “adiestramiento” plantean que el niño debe ser acostado despierto en su cuna, y terminar de dormirse solo. Por supuesto, dormirse con la teta en la boca es considerado una especie de pecado capital.

La leche materna contiene triptófano, un precursor de la melatonina. La melatonina es una hormona que es producida por la glándula pineal, que está escondida colgando en la parte de atrás del cerebro, y tiene que ver con el sueño y el ritmo circadiano (de hecho, hay muchos productos para el insomnio que la contienen). Las células de la pineal fetal empiezan a producir melatonina en la semana 26, pero el bebé no tiene ritmo circadiano completo hasta los 5-6 meses.

La leche, al contener estas sustancias, genera una regulación del sueño infantil. Inclusive las leches de fórmula han incorporado este aminoácido en su composición. La diferencia es que en la leche materna, la concentración variará según las necesidades de ese niño, y en la fórmula, será igual para todos. **Las señales de que necesitan estar mamando para dormir dependen mucho de cada bebé, y también de si usa o no chupete: a veces lo que el bebé requiere solamente es la succión. En los electroencefalogramas de sueño de bebés tomando teta semidormidos se ve que... ¡están dormidos!**

Es importante recalcar que dormirse con la teta no quiere decir que nunca dormirás si no es prendido a ella. Mamar por la noche es natural, normal y para muchas mujeres, disfrutable. Dependerá, por supuesto, de las ganas y del placer de cada día. También es absolutamente normal sentir cansancio al amamantar por la noche. Muchas mamás, generalmente con bebés mayores a 1 año, se sienten agotadas y agobiadas ante la alta demanda, y desean llevar adelante un destete completo o al menos nocturno. Más que entendible y para acompañar: la lactancia nunca puede ser una obligación. No es imposible destetar solo por la noche, por ejemplo. Requiere paciencia y acompañamiento, y para ello estamos como profesionales.

Colecho seguro

El Grupo de Trabajo en Muerte Súbita e Inesperada del Lactante, en conjunto con la Subcomisión de Lactancia Materna de la Sociedad Argentina de Pediatría, en el año 2017 publicaron un documento llamado “Colecho en el hogar, lactancia materna y muerte súbita del lactante. Recomendaciones para los profesionales de la salud” (Arch Argent Pediatr 2017; 115 Supl 5: S105-S110).

Dicho documento cambiaba (para bien) la mirada acerca del colecho y de la información a brindar a las familias, a la vez que aclaraba un poco las recomendaciones. Durante años se desaconsejó el colecho tajantemente, con el argumento de que aumentaba el riesgo de muerte súbita. Dicha recomendación ignoraba el hecho de que, por más que nos pusiéramos en pediatras hegemónicos y lo “prohibiéramos”, el colecho iba a seguir sucediendo, dado que **los niños necesitan el contacto constante con sus cuidadores y que la lactancia a demanda requiere una presencia materna casi permanente. ¡Y porque lo disfrutamos, que no es un hecho menor!**

El colecho no solo no aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante, sino que es beneficioso para el establecimiento de la lactancia: **es un factor PROTECTOR para la muerte súbita**. Mantiene al niño seguro y confortable, se siente protegido y amado, estimula la sincronización de los despertares y la respiración mamá y bebé.

Ya lo dijimos antes: no “malcría”. No “se van a quedar para siempre en la cama”. No les va a causar un daño psicológico. Esos son mitos del sistema de trabajo postindustrial, que busca a un niño independiente y autosuficiente para que sus mapadres puedan volver pronto a trabajar, ignorando sus necesidades y su fisiología.

¿Hay riesgos? Sí. Pero **el riesgo no es inherente al colecho, sino a las circunstancias en las que ocurre**. Por eso, no podemos dejar de advertir a las familias de estos potenciales riesgos ni tampoco negar sus beneficios. Cada familia debe elegir con libertad y conocimiento, por lo cual es imprescindible dar información completa y acompañar como pediatras en la decisión.

La Sociedad Argentina de Pediatría y la Asociación Española de Pediatría no recomiendan el colecho en sí, sino que plantean que **el lugar más seguro para dormir para un bebé es una cuna al lado de la cama de los mapadres, y la cohabitación por lo menos los primeros 6 meses de vida**, ya que hasta esa edad ocurre el mayor riesgo de síndrome de muerte súbita, si bien hay reportes hasta el año.

Desde hace un tiempo existen en el mercado, cada vez más amplio, cunas colecho. ¿Qué es esto? Cunas a las que les “falta” un lateral y se pegan a la cama de los mapadres, como una extensión de la misma. Suelen ser muy cómodas, porque evitan levantarse una y otra vez durante la noche. Lo importante de estas cunas es que estén bien pegadas a la cama grande, sin dejar espacios entre ambas, para evitar caídas o que queden atrapados. Algunos modelos tienen unos ganchos que se colocan debajo

de los colchones con este fin.

Otra opción, más barata (o si ya tenemos una cuna común), es simplemente quitarle un lateral y pegarla a nuestra cama, bien unida a la misma. Y una tercera opción, que es mucho más común de lo que pensamos... ¿es eliminar las camas y poner todos los colchones en el piso! Esta última opción es muy útil para los bebés movedizos con historial de tirarse “de palomita” desde las alturas, dormidos o despiertos.

Las muertes en situación de colecho se asocian a los factores de riesgo para muerte súbita y asfixia:

- Madre o padre fumador (¡esta es la más importante!).
- Madre que fumó en el embarazo.
- Niño prematuro o con restricción del crecimiento intrauterino en sus primeros meses, dado que por su pequeño tamaño tiene más riesgo de sufrir aplastamiento.
- Colecho con múltiples personas.
- Mapadres consumidores de sustancias que afecten el humor y el sueño (por ejemplo, el alcohol o ciertas drogas), o mapadres con alguna patología que altere los despertares (por ejemplo, apneas de sueño y algunos casos de obesidad mórbida); todo esto también por riesgo de asfixia.
- Colchón muy blando o de agua, muchas almohadas o mantas mullidas, presencia de peluches, niditos y otros objetos.

En estos casos, **SOBRE TODO** cuando los dos o alguno de los mapadres FUMA (no importa si es afuera de la casa), consume alguna medicación o sustancia que genera más sueño, o tiene alteraciones de la conciencia, o tiene alguna patología que le genera un sueño muy profundo, es preciso desaconsejar el colecho y se intenta buscar otras maneras de generar el contacto corporal tan importante para el neurodesarrollo físico y emocional del niño.

Como dije antes, estas son recomendaciones, y cada familia deberá tomar sus propias decisiones y nosotros acompañar. **En el caso de que deseen colechar, es importante aportar pautas de colecho seguro**, a saber:

- * Que no haya acolchados, almohadas mullidas o niditos alrededor del niño.

- * Siempre del lado de la mamá, como en “abrazo”. No se recomienda en los primeros meses que duerma entre los mapadres.
- * Que no haya posibilidad de caerse de la cama (siempre es mejor arrimar la cama a la pared o poner la cuna del otro lado).
- * En épocas frías, no sobreabrigar y mucho cuidado con tapar la cara del bebé con las mantas.
- * El bebé siempre boca arriba (eventualmente se pondrá frente al pecho de la mamá, mirando a la teta).
- * Evaluar los peligros de que el bebé quede atrapado entre el colchón y la pared, o quede boca abajo en algún hueco del colchón, para minimizar el riesgo de asfixia.
- * No se recomienda colechar en un sillón o sofá.

La premisa es elegir lo que mejor se adapte a nuestras familias y a nuestros niños. ¡Hay bebés que duermen toda la noche en su cuna porque les encanta! Mi hijo mayor, por ejemplo, que era un ser adaptable a cualquier circunstancia, le gustaba colechar abrazado a nosotros parte de la noche, pero a veces quería irse a su cuna. Me acuerdo un día que me desperté porque se estaba quejando. No entendía qué le pasaba, así que lo dejé en su cunita colecho y fui corriendo al baño. Cuando volví, ¡estaba plácidamente dormido!

Otros colechan hasta los 3 años, otros duermen tres noches en su cama y cuatro en la nuestra. Algunas mapadres prefieren no colechar y otros lo desean muchísimo. Todo es por amor y está bien mientras se tomen los recaudos necesarios. Acompañémonos y vivamos una crianza respetuosa y feliz.

Cuando alguien fuma en casa

Creo que nadie estaría en desacuerdo con que el cigarrillo causa daños en la salud. Ni siquiera el fumador más empedernido. Hace muchos años se plantea que el cigarrillo está relacionado con varios tipos de cáncer (pulmón, mama, boca...), enfermedades pulmonares, enfermedades gastrointestinales y, como dijimos antes, con el síndrome de muerte súbita del lactante (SMDL). También está estudiado que la exposición al cigarrillo de cualquier forma (fumadora activa, pasiva o de “tercera mano”, es decir, expuesta no al humo, sino a las sustancias que deja el humo en el ambiente) de una embarazada puede causar daños al bebé a corto o a largo plazo.

Los mapadres que fuman suelen ser conscientes de la peligrosidad del cigarrillo en los

niños y toman medidas con el fin de evitar su exposición directa, como fumar afuera, en la ventana, en el trabajo... El cigarrillo no es un hábito, sino una adicción, y su manejo no es sencillo.

Dijimos en la sección anterior que ante alguno o ambos mapadres fumadores, se desaconseja el colecho. ¿Por qué? Porque la exposición al cigarrillo es el principal factor de riesgo para el síndrome de muerte súbita del lactante.

¿Qué es el síndrome de muerte súbita del lactante?

Dice la Sociedad Argentina de Pediatría: “El SMSL se refiere a la muerte durante el sueño de un lactante aparentemente sano, sin otra causa demostrable. En nuestro país, hablamos de muerte súbita e inesperada del lactante, ya que no se realizan ni autopsia por un patólogo pediatra ni estudio de la escena de la muerte que permitan llegar a un diagnóstico de certeza. Adquiere relevancia, entonces, poder distinguir las muertes por asfixia, que serían evitables”.

¿Qué tiene que ver el fumar con la muerte súbita del lactante? Por un lado, el humo y las sustancias del cigarrillo causan irritación de las vías respiratorias, lo cual puede llevar a enfermedades que bloquean las mismas. Por otro, la exposición a la nicotina del humo altera la respuesta a la hipoxia en los lactantes. ¿Qué significa esto? Uno de los estímulos que utiliza nuestro cerebro para “acordarse” de respirar es precisamente censar que baja el nivel de oxígeno y sube el nivel de dióxido de carbono en sangre. El cerebro de esos bebés expuestos a la nicotina tiene menos sensibilidad a este estímulo, y más chance de “olvidarse” de respirar y hacer una apnea (pausa respiratoria), que lleve al SMSL. Es por esto también que no se recomienda el colecho si la mamá fue fumadora durante el embarazo: ese pequeño cerebro ya está programado de esa manera y el riesgo es grande.

“Pero en casa solo fumamos afuera, y antes de agarrarlo nos lavamos las manos”. Las toxinas del cigarrillo continúan suspendidas en la ropa, el cabello, la barba, el sudor. Lo mismo si fumamos al lado de la ventana o la abrimos para que se vaya el humo. El riesgo estará.

“Fumo y amamanto, ¿dejo de amamantar?”. Se estudió esto y, si bien hay sustancias del cigarrillo que atraviesan la leche materna, se vio que de cualquier manera recibir dicha leche protegía más a los bebés de enfermedades que recibir fórmula.

“¿Y fumar marihuana?”. La marihuana, entre sus efectos, provoca disminución de reflejos y somnolencia. También pasa a leche materna, y puede producir aletargamiento y apneas en los bebés. No se recomienda el consumo de ninguna sustancia con estas características si se desea realizar colecho.

“Quiero dejar de fumar”. Esta sería la mejor opción, y la más sana para los niños y la familia en general. Existen muchos centros de cesación tabáquica y los podés consultar en: <http://www.msal.gob.ar/tabaco/index.php/informacion-para-ciudadanos/donde-recurrir-para-dejar-de-fumar>

“Me dijeron que el chupete previene el SMSL, ¿es verdad?”. Es verdad que hay estudios que plantean dicho beneficio del chupete. Debido a esto, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud cambiaron en 2019, y se nos plantea a los profesionales la importancia de no “prohibirlo”, sino de ofrecerlo explicando sus riesgos. Lo importante es introducirlo después de haberse establecido correctamente la lactancia, si decidimos amamantar, pues antes puede interferir con el correcto desarrollo de la misma, y no usarlo mucho más allá del año, para evitar deformaciones de la cavidad oral. Pero no es NECESARIO que un niño use chupete, ni insistir si el bebé lo escupe o no lo quiere, ¡es importante tenerlo claro!

Pautas para un sueño seguro

Es popular el uso de elementos en la cuna como el nidito, las chichoneras, las almohadas, los juguetes... Los “negocios de cosas para bebés” nos presentan hermosísimas fotos de gurrumines durmiendo con un elefante de peluche alrededor. ¿Quién se podría resistir?

Sin embargo, ninguno de estos elementos es recomendable. **Las normas para un sueño seguro estipulan una cuna libre de objetos, donde el bebé se acueste boca arriba, sin almohadas, preferentemente tocando con los piecitos el borde inferior de la cuna.** Se recomienda taparlo por debajo de las axilas y no sobreabundar de frazadas, mantas y cosas que se pueda llevar a la carita. No existe una recomendación puntual acerca de las bolsitas de dormir, o los “burritos”, pero si deseamos usarlos, es importante dejar las manitos libres y cerrarlos por debajo de las axilas.

¿Por qué no sugerimos estos elementos? ¡El nidito es superlindo! Sí, no hay duda, pero ningún elemento en la cuna de un bebé es seguro. Un nidito también puede moverse y asfixiarlo. Tampoco se sugiere el nido en la cama de los mapadres si

decidimos hacer colecho.

“Mi bebé estuvo en Neo y ahí le ponían nidito”. Sí, en las internaciones en Neonatología se suele usar el nido para contener a los bebés mientras no pueden estar a upa. Son situaciones puntuales y tienen que ver con disminuir su estrés. Además, en las internaciones, los bebés están 24 horas monitorizados en sus parámetros vitales, lo cual es muy diferente a estar en casa.

“Quiero usar el nido igual”. **Si deseamos, de cualquier forma, usar el nido, la recomendación es usarlo con la parte en forma de “u” alrededor de los pies del bebé, tocándolos, y por debajo de la sábana de abajo de la cuna, cosa que no se pueda mover. Pero reitero: no está recomendado, puede ser peligroso.**

¿Y la chichonera? Tampoco es necesaria. Si un bebé pequeñito se desplaza hasta uno de los laterales de la cuna, no tiene que haber nada que pueda presionar contra su carita y eventualmente asfixiarlo. El riesgo de un “chichón” es muchísimo menor al riesgo de sofocación.



Sí tenemos que tener en cuenta qué cuna adquirimos. En Argentina no hay regulación para las cunas —ni para andadores, portabebés y otros artículos por el estilo— y la pequeña regulación para las butacas para el auto en la ciudad de Buenos Aires es bastante reciente. Es decir, cada fabricante puede vender lo que más le guste. Por eso es importante, como mapadres, estar informados.

La Sociedad Argentina de Pediatría, en su “Consenso para el Mobiliario Infantil

Seguro”, sugiere **cunas resistentes, sin aristas, astillas, clavos o tornillos sobresalidos que puedan dañar al bebé. También hay que evaluar la pintura o barniz y asegurarse de que no contengan sustancias tóxicas.** Para evitar que la cabeza pase entre los barrotes y quede atrapada, o que el bebé pueda caerse al piso, el espacio entre estos tiene que ser entre 4,5 a 6 cm. ¡Con menos de 4,5 cm existe riesgo de manos o deditos atrapados! El colchoncito debe ser firme, sin fundas plásticas.

Recomendaciones para el sueño seguro del bebé

- Siempre boca arriba, en su cuna.
- Brazos por arriba de la sábana.
- Sin almohada ni juguetes.
- Lactancia materna.
- Ambiente libre de humo.

¿Puedo no usar cuna? Sí, por supuesto, tanto como si la familia desea hacer colecho seguro como si desea usar directamente las camas del tipo Montessori, que van en el piso y no poseen barrotes, o directamente un colchón en el suelo. Estas camitas claramente reducen el riesgo de caídas y permiten el libre movimiento del bebé.



¿Por qué sugerimos que el bebé duerma boca arriba, si muchos de nosotros

dormimos boca abajo? Dormir boca abajo está popularmente difundido y ha sido difícil cambiar esta costumbre. Ya contamos que los bebés pueden tener algún tipo de reflujo (pasaje del contenido del estómago al esófago o incluso a la boca y al exterior), y este puede ser tanto fisiológico como patológico. Se estudió que, teniendo reflujo y estando boca abajo, la leche puede pasar del esófago a la vía aérea por una cuestión de gravedad, sin permitir al bebé defender la vía aérea mediante la tos o la arcada. Esto mismo pasa si el bebé duerme de costado. En cambio, estando boca arriba, esa leche vuelve al esófago, manteniendo la vía aérea sin riesgo.

¿Es recomendable usar dispositivos que mantengan al bebé durmiendo de costado o boca arriba? Dormir de costado tampoco está recomendado porque es posible que el bebé pase de esa manera a dormir boca abajo. Los posicionadores de costado no evitan esto, y sí evitan girar boca arriba. Es importante que los mapadres sepan que son inútiles todos los dispositivos cuyo objetivo es mantener al bebé en una posición determinada. El hecho de estar a la venta no garantiza que sean seguros ni recomendables.

¿Y si lo acuesto boca arriba y solo se da vuelta boca abajo? Generalmente, esta habilidad la logran bebés mayores con mejor tono muscular, aproximadamente entre los 4 y 6 meses. **Si el bebé se da vuelta solito, mientras se haya dormido boca arriba, no es necesario ponerlo así de nuevo.**

“Descolectar”

“¿Hasta cuándo hacer colecho?” es una pregunta común, cuya respuesta la tiene solo la familia en cuestión. Podemos esperar que los niños decidan dormir solos, si no nos molesta colechar. La niñez no es eterna y eventualmente esto sucederá. Pero si la cama nos quedó chica, estamos agotados de las patadas (y, sí) y nuestro deseo es que cada uno duerma en su cama o su cuarto, aquí van algunas sugerencias.

- Como todo, anticipar lo que vamos a hacer y el motivo. Explicarle por qué vamos a iniciar este proceso.
- Permitirle elegir algo para su cuarto: sábanas, acolchado, alguna decoración que le guste. Algunas lindas opciones: brindarle una pared para dibujar, o pintar con pintura para pizarrón una pared y, juntos, escribir frases lindas que acompañen por la noche.
- Buscar un muñequito de apego, o almohadita, o algo que lo haga sentir seguro y lo

acompañe. Puede ayudar mojarlo con un poco de leche de mamá, si es un bebé amamantado. Un cuento también puede ser útil.

- Comprender que es un proceso y puede llevar un tiempo largo. Puede volver a nuestra cama a la noche: esto no es un retroceso, está buscando compañía. Podemos permitirlo o volver a llevarlo a su camita y volver a hacer el ritual del sueño.
- Como dijimos antes, establecer una rutina, bajar las luces de toda la casa, evitar alimentos con mucha azúcar...
- Responder siempre a sus llamados, que no se sientan solitos ni abandonados.
- Cada familia encontrará la forma, sin que existan “reglas” específicas para nadie. Así como no se puede sugerir una edad para el destete, tampoco se puede sugerir una para el “descolecto”.

Mitos sobre el sueño infantil

“Si no aprende a dormir en su cama, nunca se va a ir de la cama de los padres y, además, le puede producir un daño psicológico”.

El colecho es una decisión familiar en la cual los profesionales no tenemos voz ni voto, más allá de las sugerencias con respecto a su seguridad. Cuando el niño se sienta listo y seguro para irse a dormir a otra cama u otra habitación, lo hará. No están descriptos trastornos psicológicos con relación a esta práctica, como sí lo están con relación al sentimiento de abandono al “dejarlos llorar”.

“Es importantísimo que el bebé duerma solo y en otra habitación para recuperar la pareja”.

De nuevo, nos metemos en la vida privada de una pareja. Si hay deseo, la pareja encontrará lugares fuera de la cama familiar para consensuarlo. La mapaternidad es un camino de novedades y los inconvenientes a la adaptación de los nuevos integrantes no tienen que ver con compartir la cama o la habitación con los niños, mucho menos si ambos (mapadres) disfrutan de esta práctica.

“No tiene que tomar la teta a la noche a partir de los 6/8/9/12 meses (elijá la edad que desee)”.

Las tomas nocturnas son las que estimulan el pico de prolactina, hormona que estimula al pecho materno a producir leche. La Organización Mundial de la Salud promueve la lactancia materna hasta los 2 años al menos. Las tomas nocturnas aportan consuelo, seguridad y van de la mano de la fisiología. Y no, no producen caries, como sí sucede cuando los bebés se quedan dormidos con el biberón en la boca.

“Para criar respetuosamente tengo que hacer colecho y dar la teta a la noche. De otra manera, mi hijo/a no sentirá mi presencia. Pero estoy muy cansada y no lo disfruto”

La crianza respetuosa no tiene su centro en el niño ni en el adulto. Se respetan las necesidades de ambos. No tiene sentido adoptar una práctica que va en contra de nuestra cultura, nuestros deseos y nuestro placer. Hay bebés que duermen en otra habitación desde muy pequeños, con mapadres amorosos que concurren ante sus necesidades, y se sienten amados y acompañados. Hay niños que no gustan de hacer colecho. Existe la “agitación por amamantamiento” en la que la mamá siente rechazo por dar el pecho, generalmente producto del agotamiento y de lactancias sostenidas en el tiempo, y desea destetar solo de noche, o destetar completamente. Hay madres que no desean amamantar. Estar atentos a nuestros sentimientos es vital, no hacer las cosas porque “hay que hacerlas”. Hay muchas formas de disfrutar y de amar, y no tienen que ver con determinada práctica ni con otra. Cada familia y cada día da mamá-bebé es un mundo.

Para leer

PARA FAMILIAS

- Jové, Rosa (2006). *Dormir sin lágrimas*. Editorial El Ateneo, 2014

PARA PROFESIONALES

- Comité Nacional de Prevención de Lesiones de la Sociedad Argentina de Pediatría (2016). *Consenso sobre mobiliario infantil seguro*. Arch Argent Pediatr, 2016; 114(2):182-188/182. Recuperado de: <https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2016/v114n2a27.pdf>
- Subcomisión de Lactancia Materna y Grupo de Trabajo de Muerte Súbita e Inesperada del Lactante, Sociedad Argentina de Pediatría (2017). *Colecho en el hogar, lactancia materna y muerte súbita del lactante*. Recomendaciones para los profesionales de la salud. Arch Argent Pediatr 2017; 115 Supl 5:S105-S110. DOI: <http://dx.doi.org/10.5546/aap.2017.S105>
- Díaz Gómez, N. M.; Izquierdo Macián, I.; San Feliciano Martín, L. Comité de Lactancia Materna de la AEP, Grupo de Trabajo para el Estudio de la Muerte Súbita Infantil de la AEP (2014). *Colecho, síndrome de muerte súbita del lactante y Lactancia Materna. Recomendaciones actuales de consenso*. Disponible en: <https://www.aeped.es/.../coleccion-síndrome-muerte-súbita-lacta...>
- McKenna, J. J.; Ball, H. L.; Gettler, L. T. (2007). *Mother–Infant Cosleeping, Breastfeeding and Sudden Infant Death Syndrome: What Biological Anthropology Has Discovered About Normal Infant Sleep and Pediatric Sleep Medicine*. DOI:10.1002/ajpa.20736
- Pin Arboledas, G. y Lluch Roselló, A. (2011). *El sueño en el primer año de vida: ¿cómo lo enfocamos?*. Pediatría Atención Primaria, 13 (Supl. 20), 101-111. Recuperado el 22 de febrero de 2019, de: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1139-76322011000400011&lng=es&tlng=es
- Simon, C. D.; Adam, E. K.; McKinney, C. O.; Krohn, J. B.; Shalowitz, M. U. (2016). *Breastfeeding, Bed-Sharing, and Maternal Cortisol*. Clin Pediatr (Phila). 2016 May; 55(5):470-8. DOI: 10.1177/0009922815601981. Epub 2015 Sep 1.
- Mosko, S.; Richard, C.; McKenna, J.; Drummond, S.; Mukai, D. (1997). *Maternal proximity and infant CO2 environment during bedsharing and possible implications for SIDS research*. Am J Phys Anthropol. 1997 Jul; 103(3):315-28. DOI:10.1002/(SICI)1096-8644(199707)103:3<315::AID-AJPA2>3.0.CO;2-P
- Camerota, M.; Tully, K. P.; Grimes, M.; Gueron-Sela, N.; Propper, C. B. *Assessment of infant sleep: how well do multiple methods compare? Sleep*. (2018). Oct 1;41(10). DOI: 10.1093/sleep/zsy146.

- Aurore Côté, A. C. Sids Argentina. *Síndrome de muerte súbita del lactante - Bienvenida*. Recuperado el 22 febrero de 2019, de:
https://www.sids.org.ar/sueno_seguro.htm

El movimiento y el cuerpo



“Los bebés necesitan leche, sí. Pero aún más ser amados y recibir caricias”.

Shantala. Arte tradicional de masaje para bebés, de Frédérick Leboyer.

La construcción de la corporalidad

El recién nacido habita el cuerpo de la madre. No tiene conciencia de su propia corporalidad, porque su aparato psíquico está en construcción. De a poco, en ese diálogo corporal con sus figuras de apego, va comprendiendo, día a día y mes a mes, que es una persona independiente.

El bebé no se conoce, no comprende el espejo, no reconoce sus segmentos corporales. Su visión es limitada y se va desarrollando de a poquito. ¿Entonces cómo se construye esa corporalidad? En un primer momento, a partir de una exploración minuciosa del entorno con la mirada algo errante, con los sobresaltos, con los reflejos de abrazo (también llamados “reflejo de Moro”, los típicos sobresaltos con bracitos extendidos de un bebé pequeño) que no puede controlar. Unas semanas después, las manos aparecen en el paisaje y van al único lugar donde pueden ser exploradas: la boca.

Es absolutamente normal que un bebé se chupe las manitos, primero una, luego la otra, después ambas a la vez llevándolas a la línea media del cuerpo. Se banean con fruición, se despiertan a la madrugada para explorarse, se provocan arcadas. Preocupan a las familias, y las abuelas dicen que “seguro está por cortar un diente”. Es cierto que hay bebés que tienen erupción dentaria temprana, pero la mayoría comenzará la dentición luego de los 6 meses, y chuparse las manitos no tiene nada que ver con esto. Las familias consultan angustiadas, y no faltará quien les diga que le saquen la mano de la boca para evitar acostumbrarlo o porque “se le va a deformar el paladar”, o que les pongan un chupete para que no use la mano.

El chupete puede ser útil, pero no debería serlo para evitar que se exploren las manitos: los bebés necesitan esa succión, ese lamerse, esa construcción mental de su propio cuerpo a través de la boca. Después de las manos, se encontrarán los pies. Y, de a poco, irán tomando conciencia de todo su cuerpo, hasta finalmente comprender —cada uno a su propio tiempo— quién es ese bebé tan simpático que los saluda desde el espejo.

Movimiento libre

El desarrollo infantil, para la pediatría, tiene hitos: sostén cefálico, sedestación (sentarse), bipedestación, marcha... Los pediatras usamos estas cuestiones para “medir” el desarrollo del niño, pesquisar si algo anda mal o si hay algún tipo de retraso en cuatro áreas: motor grueso, motor fino, lenguaje y comportamiento psicosocial.

Hay tablas de edades e hitos. Durante muchos años, nos guiamos a rajatabla por esas cuestiones aprendidas, sin cuestionarlas mucho. Cuando recibíamos un bebé recién nacido en el consultorio, le sugeríamos a las familias ponerlo boca abajo para ir “fortaleciendo” los músculos de la espalda y así lograr el control cefálico más rápidamente. Si un bebé no se sentaba a los 6 meses, le aconsejábamos a la familia sentarlo con almohadones y mostrarle cosas para que “vaya agarrando”. Si al año no entraba caminando al consultorio, lo tomábamos de la manito y le mostrábamos a la familia cómo “ayudarlo”. ¿Qué pasaría si no forzábamos posturas en los niños (siempre hablando de niños sanos) y los dejáramos desarrollarse “por su cuenta”? ¡Tal vez no aprenderían a caminar nunca!

¿Eso cambió? No. Sigue habiendo tablas y gente que no cree que los niños puedan hacer cosas solos. **El paradigma del bebé como sujeto, como persona a respetar, continúa siendo bastante novedoso.**

Emmi Pikler fue una pediatra húngara formada en Viena, quien se instaló en Budapest en los 30. En 1946 asumió la dirección del Instituto Lóczy, una casa cuna para niños que por diversas situaciones (orfandad, tuberculosis de sus padres) requerían cuidados institucionales. La Dra. Pikler concibió una nueva forma de ver el niño pequeño. **Postuló que el bebé es un ser autónomo, capaz de desarrollarse sin nadie que “le enseñe”, ya que las diferentes fases del desarrollo motor se van dando a medida que el bebé está preparado, sin la intervención del adulto.** ¿Esto significa que el adulto no participa? Para nada. El adulto es necesario para aportar apoyo emocional, entusiasmo y cariño.

La Dra. Pikler comprobó sus teorías evaluando a los bebés del Instituto Lóczy. Los niños entraban a la institución alrededor de las 2 semanas de vida y egresaban al año, aproximadamente. En Lóczy se formó a las cuidadoras y los colaboradores para seguir **una rutina de “movimiento libre”**, bajo las siguientes premisas:

- Ropa cómoda.
- Superficie estable (que no se hundiera bajo el peso del niño, por ejemplo).
- No intervención del adulto con relación a las posturas. El bebé se colocaba en decúbito dorsal (acostado de espaldas) y no se lo forzaba a otras posiciones.
- Espacio seguro y amplio para explorar y desplazarse.

La pediatra llegó a la conclusión de que, dentro del patrón motor, los niños

alcanzaban todas las posturas sin necesidad de que se interviniera en el desarrollo de las mismas. Es decir, sin obligar a un bebé a sentarse, a pararse o a caminar de la mano; aguardando y respetando su tiempo, se sentará, se parará y caminará solo. Estos postulados, y su desarrollo, los plasmó en su libro *Moverse en libertad*.

Las investigaciones de la Dra. Pikler llevan a “novedades” para los encargados de pesquisar el desarrollo infantil, es decir, para los pediatras. **Un niño que realiza movimiento libre probablemente se siente por sus propios medios más “tarde”,** ya que primero alcanzará la posición de arrastre y después la de gateo, existiendo muchas posturas intermedias. Esto es normal, pero nos obliga a repensar ciertas cuestiones, por ejemplo, el inicio de la alimentación complementaria.

Y por otra parte, el movimiento libre, ¿es lo mejor? ¿No debo intervenir en nada? ¿Lo dejo en el piso y ya? **Lo que se plantea con el movimiento libre es el reconocimiento de la autonomía y la competencia de cada niño, pero también la compañía amorosa del adulto.** El niño no es “depositado” en el suelo, sino que se lo acompaña, se le habla, se le canta, se le cuenta cuentos. Nos podemos acostar a su lado para ver el mundo desde sus ojos. El disfrute es mutuo.

¿Y si no decido practicar movimiento libre? También es válido, cada familia tiene su cultura y sus decisiones. **Se sugiere, de cualquier manera, no forzar posturas: no hacer “rebotar” al bebé parado, no “sentarlo” atado a la sillita o rodeado de almohadones.** Paciencia, no hay apuro. Las alcanzará cuando sea capaz de hacerlo. Lo importante es disfrutar juntos, y sobre todo, jugar.

¿Qué otras cosas podemos hacer para acompañarlos?

- **Medidas anticipatorias:** explicarle al bebé lo que realizaremos con él/ella antes de desplazarlo, cambiarlo, sacarle la ropa. Pero... ¿el bebé entiende? Tal vez no comprenda las palabras como tales, pero prestará atención y será agradable para él/ella escuchar una voz tranquila antes del cambio de pañales. También es disfrutable explicarle cada cosa que le hacemos: “Ahora te voy a sacar una media... ¡ahora la otra!”.
- **Responder a sus sonidos,** a su llanto, a sus llamados, manteniendo contacto visual.
- **Mantener sus manos y pies despejados** para la exploración.
- **Esperar sus tiempos:** no forzar posturas a las cuales no ha llegado por su cuenta. A menos que haya señales de alarma en el desarrollo, no hay ningún apuro.

- **No comparar con otros bebés.**
- **Piso, mucho piso, y compañía en el mismo.** Jugar en la cama está buenísimo por períodos cortos, pero las superficies que se hunden ante el peso dan una percepción errónea del cuerpo y es preferible jugar en superficies firmes.
- **Descubrir el mundo de nuevo.** Ver cada hojita seca como una novedad. Probar el pasto con los pies descalzos, si es suavcito o pinchudo. Bucear en la arena o en la plastilina. Animarse a ensuciarse, embadurnarse, a las texturas, los aromas, los sabores. No importa que sea nuestro primer o cuarto hijo/a, el mundo toma otros colores y otras sensaciones cuando, de nuevo, nos animamos a sumergirnos en él.

Señales de alarma

- **Cada niño es diferente.** Su familia y su médico/a de cabecera lo conocen y podrá evaluar si alguna de estas señales está presente, y la intervención diagnóstica y terapéutica a realizar si la requiere.
- **No fija la mirada en las figuras de apego (mamá, papá...).**
- **No responde a los ruidos fuertes ni a su nombre.**
- **No muestra interés en comunicarse.**
- **Juega persistentemente durante largos períodos con un mismo objeto (por ejemplo, la ruedita de un auto).**
- **No imita gestos ni responde a sonrisas o al habla.**
- **Pierde pautas ya adquiridas.**
- **La presencia de estos signos no significa *per se* que exista una patología, simplemente son una señal de que debemos consultar con el pediatra.**

¿Y la “estimulación temprana”?

La estimulación temprana es una intervención terapéutica orientada a niños que requieren cuidados especiales por alguna situación patológica (prematurez, internación prolongada, retraso del desarrollo, etc.). **Su indicación debe ser evaluada por profesionales que pesquisen señales de alarma en el desarrollo**, para trabajar en forma multidisciplinaria. La estimulación temprana no está reñida con el

movimiento libre: se trata de propiciar este movimiento exploratorio, dar un apoyo y un espacio a ese niño y a su familia para el mejor desarrollo posible, siempre a través del juego. Las maneras de lograr esto dependerán del profesional a cargo. Lo correcto sería hablar de “atención temprana del desarrollo infantil”, con una mirada centrada en el niño, su entorno y sus necesidades.

Los pies descalzos

“¿Se va a enfermar!”.

“Dígale, doctora, que ahora está engripada por andar descalza por la casa”.

“Odia los zapatos. ¿Necesitará un traumatólogo?”.

- * **Los pies descalzos son aliados para el neurodesarrollo infantil.** Permiten que el niño sienta texturas y temperaturas distintas según el suelo que pise (pasto, cerámica, madera), haciendo que ciertas zonas del cerebro trabajen procesando dicha información, que de otra manera no recibirían.
- * **Mejora el desarrollo de la musculatura del pie y ayuda a prevenir el pie plano.** Los niños tienen un pie plano fisiológico hasta los 4 años, y de hecho, en ausencia de síntomas, la mayoría de los autores coinciden en que el pie plano es una variante del pie de forma normal a lo largo de la vida.
- * **Permiten experimentar la propiocepción (la percepción del propio cuerpo) y mejorar la estabilidad y la coordinación en la marcha.**

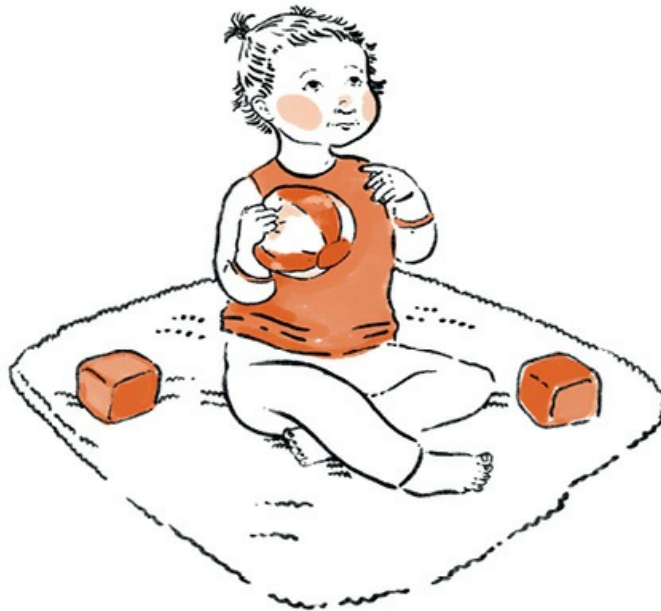
Pero...

- * ¿No se enferman? No, **el frío no enferma. Enferman los virus y las bacterias.** Si no estamos expuestos a ellos, el frío no tiene nada que ver.
- * Entonces, ¿por qué nos enfermamos más en invierno? Porque para protegernos del frío, **nos amontonamos en ambientes poco ventilados**, y basta con que una persona sea portadora de un virus o una bacteria en sus secreciones —aunque no parezca enferma— para correr riesgo de contagiarse, ya que basta con unas gotitas de saliva que vayan por el aire.



- * “Se le ponen los piecitos muy fríos...” es una frase común. **Los bebés regulan la temperatura corporal también a través de los pies. No notan los pies fríos.** A los adultos nos gustan las medias, porque nos movemos menos, estamos más tiempo sentados y somos más aburridos... pero preguntale a tu hijo más grandecito si prefiere estar con medias o descalzo. Creo que tenemos la respuesta.
- * ¿Y en la calle? En las ciudades, al transitar por la calle estamos expuestos a multitud de elementos que pueden lastimar. **Lo ideal es colocar un calzado ergonómico (adaptado a la fisiología), blando, que se adapte al piecito del deambulador.** Si el bebé no camina, ni se va a parar en alguna superficie peligrosa, puede ir tranquilamente descalzo y feliz.
- * ¿Y qué hago con todos los zapatitos lindos que tengo? Usarlos para fiestas, disfraces, eventos. La cuestión no es no usarlos nunca más, sino permitir el libre desarrollo el mayor tiempo posible.

* ¿Y cuándo necesita un niño usar zapatos? Cuando nuestras imposiciones culturales lo requieran, por ejemplo, al inicio del jardín. Pero **el pie no necesita estar adentro de un zapato para crecer sano**, así como nuestra mano no necesita estar adentro de un guante.



“Sostenedores de bebés”

¿Dónde es el mejor lugar para que un bebé pase el día? La primera respuesta es: UPA. Los brazos, el contacto, el olor de la persona que lo ama es el motor que lleva a las relaciones de apego seguro y confianza con el universo.

Pero los bebés crecen y necesitan explorar. ¿Dónde los ponemos? El mercado está lleno de elementos “sostenedores de bebés”. Mecedoras, cochecitos, hamacas, sillitas, gimnasios, cosos. ¿Los bebés los necesitan? Para nada. Los necesitamos los adultos para hacer cosas, por ejemplo, ir a buscar algo sin riesgo de que se caiga, o ponerlo en el corralito porque estamos cocinando y nos da miedo que se queme en la cocina. **Ese uso no es incorrecto, es circunstancial...** Además, ¡las madres y los padres también vamos al baño! El problema es cuando el bebé está en un lugar (por ejemplo, el cochecito) que limita sus movimientos y no le permite explorar durante muchas horas, situación que se agrava si lo exponemos a pantallas.

El mejor lugar para un bebé es EL PISO. Con una manta, colchoneta, piso de goma, lo que fuere, y algún que otro juguete. En el piso puede explorar el espacio,

probar posturas, mirar y experimentar con su cuerpo, sin riesgo de caerse. ¡También le da espacio para aburrirse, por supuesto! Muchas veces, los bebés se fastidian de estar en la misma posición. Hay bebés que gustan de estar mucho tiempo en el piso y otros, unos pocos minutos.

Dijimos que al bebé no se lo puede dejar solo en el piso, sino que es un momento para compartir con su cuidador. Acostarnos a su lado, cantarle y hablarle, harán de ese espacio algo placentero.

Y hablando de andadores...

La Asociación Americana de Pediatría, la Asociación Española de Pediatría, la Liga Europea para la Seguridad Infantil, la Sociedad Canadiense de Pediatría y nuestra más local Sociedad Argentina de Pediatría (junto a otras sociedades latinoamericanas) **no recomiendan el andador y, asimismo, desaconsejan su uso**. Más aún, en Canadá, esta recomendación viene desde 1989 y se ha prohibido la comercialización de este producto en 2004.

La mayor parte de las sociedades científicas coinciden en que el andador es un objeto que no contribuye al desarrollo motor del bebé, que genera una postura que tiende a la caminata en puntas de pie y la sobrecarga del peso sobre la pelvis, evita que el niño pueda explorar el entorno libremente e incluso impide que pueda observar sus miembros inferiores. También se ha visto que desalienta el desarrollo del gateo, el cual si bien no todos los bebés lo llegan a practicar, favorece el desarrollo de la mano y la interconexión de los hemisferios cerebrales. Pero en lo que todas están de acuerdo es en que **los andadores son un enorme factor de riesgo para los accidentes**.

Los andadores son responsables de diversas lesiones. La mayoría de los accidentes graves relacionados con su uso se deben a caídas por las escaleras. Otros mecanismos de lesión son vuelcos o desplomes, dedos atrapados y acceso a peligros, como las puertas del horno, los objetos calientes o pesados y las sustancias tóxicas.

Sí, hay niños que usan andador y que caminan tempranamente. Otros que no sufren ningún accidente. Generaciones “sanas” que han usado andador. Estas situaciones puntuales no pueden ser condicionantes de la sugerencia pediátrica, debido a la enorme cantidad de evidencia que demuestra que es un artículo a evitar.

¿Por qué se siguen vendiendo andadores? Primero, porque se siguen comprando como simpáticos artículos para el bebé. Segundo, porque no existe en Argentina regulación alguna para el mobiliario infantil, más que una propuesta del 2015 en la que el INTI trabajaría con la SAP para al menos estandarizar las cunas.

Un regalo para un bebé no tiene por qué ser algo que ya está demostrado que pone en peligro su integridad física. Hay miles de formas de expresar amor, y una de ellas, es cuidar su salud. ¡Por menos andadores y más upa!

Los niños y las pantallas

Una duda común en las consultas y los grupos de mapaternidad es qué “dibujitos conviene ponerle al bebé” o cuáles son los más “educativos”. La respuesta es y será: ninguno.

Vivimos en un mundo de pantallas, abstraerse es imposible. Pero una cosa es usarlas ocasionalmente, por ejemplo para distraerlos mientras vamos al baño o durante un viaje largo en auto. **Otra cosa es pensar que las pantallas son saludables y estimulan al bebé, algo que no es en absoluto real.**

Cuando un bebé es colocado frente a una pantalla (televisión, celular, *tablet*) es probable que se “embobe” frente a ella y se quede callado, con todo su cuerpo quieto. La luz brillante y los sonidos atraparán su atención, ya que es probable que su visión no esté del todo desarrollada como para lograr ver realmente los dibujos.

Un bebé expuesto a una pantalla no tiene respuesta. El aparato no le responde, nunca será lo mismo que una cara cercana que le sonría y le hable. No moverá la cabeza, no estirará los bracitos. Todo lo que observará será símbolos en un continuo sin fin, y sin posibilidad de analizarlos uno por uno. Hay una diferencia enorme entre ver una imagen de una pelota y ver una pelota en tres dimensiones, tocarla, ver la respuesta de la misma cuando rueda, palpar su textura, enojarse porque se escapa. La estimulación neuronal es francamente diferente.

Los principales circuitos neuromadurativos se generan en los 2 primeros años de vida, por lo que es un período crítico. La Sociedad Argentina de Pediatría sugiere no exponer a niños menores de esa edad a pantallas, salvo que sean comunicaciones con familiares. Inclusive se desaconseja la tele “de fondo”, pues se han comprobado sus efectos negativos sobre el desarrollo del lenguaje.

Posterior a los 2 años, no se recomienda más de una hora de exposición diaria, con supervisión adulta y con programas interactivos que inciten al niño a participar. De los 6 años en adelante, es importante establecer límites coherentes sobre el tiempo y que no interfieran con otras cuestiones como la alimentación, el sueño, la actividad física...

Como señalé más arriba, vivimos en un mundo de pantallas. Nos traen muchas satisfacciones, nos permiten informarnos, aprender y estar en contacto con seres queridos. **No las demonicemos, pero entendamos que no son el estímulo adecuado y que son hasta nocivas para los niños pequeños.** Jugar con las cacerolas, los cubos, el pasto, los cuentos, las mascotas, y sobre todo, el jugar, bailar y cantar con la familia siempre serán los mejores estímulos para un niño/a.

Porteo ergonómico, seguro y respetuoso

El bebé humano, naciendo aún “a término”, es prematuro. No puede ir solo a ningún lado, no puede buscar su alimento, requiere de una figura de apego de quién subsistir. Ha estado 9 meses en el útero, pero aún le falta “cocción”. **Este proceso de maduración externa, como ya charlamos en otros capítulos, se denomina “exterogestación”,** y dura alrededor de 9 meses más como mínimo.

Durante ese tiempo, el estar a upa, en contacto con seres amados, es primordial. Ayuda al bebé a regularse, lo hace sentirse seguro percibir la vibración de la voz y los movimientos faciales de quien lo carga. Desarrolla su sentido del equilibrio y del movimiento.

Para poder sostener esta necesidad de los bebés, muchas culturas han practicado, desde siempre, el “porteo”. **Portear es la manera de llevar a los bebés con portabebés, que son dispositivos pensados para ello.** El portabebés debería ser un elemento que permita estar cómodo al bebé y a la persona que portea, por lo cual, debe ser ergonómico, seguro y respetuoso. **Debe acompañar el desarrollo óseo y neuromuscular del bebé, y no forzar posturas.** No debería tampoco lastimar a la persona que lleva al bebé y, al contrario, tendría que proveerle comodidad.

En Occidente, hace varias décadas se han deformado los portabebés ergonómicos clásicos, para crear y vender las llamadas mochilas “canguro”, que suelen ser rígidas y no adaptables al cuerpo, donde el bebé queda “colgado” de la entrepierna, en una posición poco amable para su fisiología y que no colabora para el desarrollo de su columna ni de su cadera. Asimismo, suelen ser de materiales sintéticos poco respirables, y tener tirantes que lastiman los hombros y la espalda de la persona que portea por mala distribución del peso. En las cajas dice “ergonómico”, aunque eso no quiere decir que lo sean.

¿Cómo elegir el portabebés que mejor nos sirva como familia? **Podés buscar una asesoría de porteo con una consultora especializada,** quien te puede mostrar portabebés y cómo se usan, y luego, a partir de allí, decidir cuál vas a adquirir. Es un excelente regalo para un recién nacido. **Animarse a cambiar lo que “siempre fue así” es un paso enorme. Cuestionar los mandatos de la industria también. Y poder elegir informados, lo mejor.**

Portabebés ergonómicos vs. no ergonómicos

La **ergonomía** es “la disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de los trabajadores que se verán

involucrados”.

Este concepto, que explicado así parece algo obtuso, cuando lo trasladamos a los portabebés significa que **es preciso que elijamos uno que se adapte a nuestro cuerpo y al del bebé en cuestión, respetando sus tiempos y los nuestros, sin lastimarnos, forzar posturas, ni hacernos sentir incómodos.**

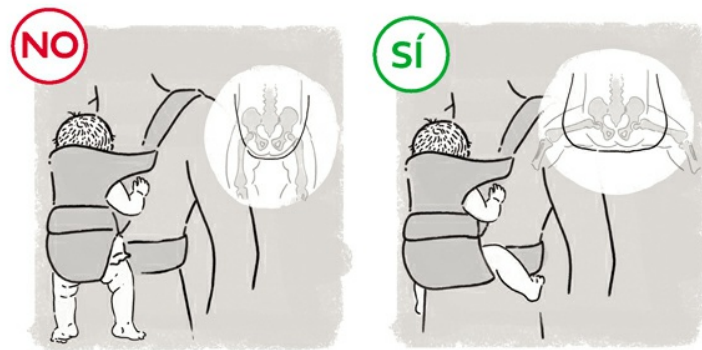
En el mercado hay muchísimos portabebés. La mayor parte de la población adulta pasó meses transportada en mochilas “canguro”, como las llamamos. Estas mochilitas tienen varias cosas buenas: mantienen al bebé pegadito a la persona que lo lleva y son muy útiles para viajar en transporte público (en donde es una tarea titánica circular con un cochecito) o simplemente para caminar.

¿Qué tienen de criticable estas mochilas? También varias cosas, veamos:

- 1. Suelen estar hechas de materiales poco amables con el bebé y la persona que lo lleva.** Telas sintéticas, acolchonadas y poco respirables son la norma.
- 2. No se adaptan al cuerpo del binomio.** Generalmente vemos bebés, sobre todo si son muy pequeños, “perdidos” adentro de las mochilas, tiras incómodas que lastiman los hombros del adulto y sobrecarga sobre su espalda.
- 3. No mantienen una postura que acompañe el desarrollo del niño.** Dijimos que en un primer momento, el bebé tiene un tono flexor, está todo “abolladito”, como cuando estaba en el útero. Esto va cambiando a medida que se va desarrollando, primero levanta la cabeza, gatea, se sienta y camina, y todo eso va modificando las curvaturas de la espalda. Ningún portabebés del tipo “colgona” respeta esta evolución. Suelen tener un panel rígido que busca mantener la espalda recta a cualquier edad, cuando nuestra espalda... ¡nunca es recta!
- 4. Llevan todo el peso del cuerpo a los genitales del niño.** Esto lo podemos ver con la forma de la parte inferior: suelen tener forma “de calzón”. Todo el peso del bebé recae en sus genitales, las piernitas quedan colgando a los costados. Pensemos en la postura natural que adoptamos niños y adultos cuando los sostenemos a upa: los niños suelen abrir las piernitas y colocar una a cada lado del adulto, ¿no es cierto? Ya sea sobre el frente, a la cadera o haciendo caballito sobre la espalda. No hay ningún portabebés del tipo mochila canguro que mantenga esa postura, y si bien en este momento la industria busca imitar a los portabebés ergonómicos, no llega a lograrlo (aún). Mantener el peso sobre los genitales no es un tema menor. Se ha reportado un caso de un bebé que perdió un testículo por falta de riego sanguíneo, al mantener mucho tiempo adoptada una postura de este tipo.

5. **No ofrecen un correcto cuidado de las vías aéreas.** Al estar “perdido” adentro de la mochila, el bebé —sobre todos los más pequeños, sin sostén cefálico— puede adoptar posturas incorrectas que lleven al bloqueo de la vía aérea. Si vamos a usarlos, hay que tener muchísimo cuidado.

6. **Usar un portabebés ergonómico de forma incorrecta, o a una edad que no es adecuada, puede resultar en una postura no ergonómica, insegura o poco respetuosa para el desarrollo del niño y la postura del adulto.** A continuación, detallaré algunos portabebés “ergonómicos”, pero como dije, depende de su uso.



Tipos de portabebés ergonómicos, si los utilizamos correctamente

- **Fular:** el fular es **una tela larga, rectangular y sin costuras, que puede ser elástico, rígido o semirrígido**, de acuerdo con su elasticidad. Dentro de los fulares rígidos encontramos diversos materiales, entre ellos, los tejidos (más caros pero más duraderos), los de telas sintéticas o de algodón, y mezclas. Los fulares elásticos son útiles para los primeros meses del bebé, pero posteriormente, por el mismo peso del bebé que crece, pasa a “rebotar” y deja de ser ergonómico, dado que es incómodo tanto para el niño como para el adulto. También existen fulares “prearmados”: son una especie de remera con tiras que no es necesario anudar, y una tira horizontal para cubrir la espalda del bebé y generar mejor basculación de la pelvis. Estos últimos van por talle de la persona que portea, por lo que a veces no coincide con todos los adultos que van a portear. También, al ser elásticos, solo son útiles por unos meses. **Los fulares rígidos, sobre todo los tejidos, son los más versátiles.** Pueden soportar mucho peso, ¡inclusive se usan para portear niños de 4-5 años! Podemos llevar niños al frente, a la cadera, en la espalda y realizar *bellywrapping*... (¿y esto? Se los cuento más adelante). Aprender a usar un fular requiere un tiempo, dado que hay que aprender a hacer “nudos” y esto puede desanimar a las familias, pero es un portabebés sumamente adaptable a la ergonomía y fisiología de cada día. Vale la pena intentarlo.



- Bandolera: este portabebés consta de un rectángulo de tela con anillas — generalmente de metal— cosidas en un extremo, las cuales se colocan a la altura de un hombro, quedando la tela sobre la cadera contralateral. Es muy útil para llevar bebés a la cadera y que puedan “chusmear el mundo”, teniendo de cualquier manera nuestro rostro cerca para mirarlos, y ayudarlos a interpretar lo que están experimentando. También sirve para llevar niños al frente y en la espalda. Suelen ser de tela rígida o tejida. Es importante constatar que las anillas sean de un material seguro, sin rispideces ni soldaduras, de una sola pieza y con certificación. Las anillas de plástico generalmente son inseguras porque se pueden romper. **La bandolera también es un portabebés muy versátil (de hecho, personalmente es mi favorito)**, que bien utilizado, sirve para *bellywrapping*, recién nacidos, bebés que levantan la cabeza, bebés que se sientan, hermanos mayores... en fin. Otro hermoso elemento que nos acompaña en la crianza.
- Portabebés de panel (mochilas ergonómicas, **mei tai**, **onbuhimos**): los portabebés que menciono constan de un panel de tela y tiras que van atadas sobre los hombros del adulto. Algunos se parecen más a las típicas mochilas canguro (mochila ergonómica) y otros como los *mei tai* (cuyo nombre correcto es *meh dai* o *bei dai*) son más artesanales (básicamente, son un cuadrado de tela con 4 tiras cosidas que hay que anudar). **Estos portabebés se recomiendan recién cuando el bebé se**

sienta. ¿Cuando llega a sentarse solo o cuando permanece sentado?, podría ser la pregunta siguiente. Depende de lo que siga la familia: si hace movimiento libre, es preferible esperar a que llegue solo a la posición de sentado. De otra manera, desde que se mantiene erguido son aptos para su uso. **¿Por qué cuando los bebés recién se sientan? Porque no ofrecen el sostén punto por punto de la columna que sí logramos con los fulares o las bandoleras.** ¿Pero logran una posición ergonómica? Sí, si están bien utilizados. Mantienen la forma de “M” con las rodillas por encima de la pelvis, pero se adaptan a la curvatura de la espalda que tiene un niño que se sienta, que es diferente a la de un niño que no lo hace.



Si de algo se ha apropiado el mercado argentino para bebés actual, es de las mochilas ergonómicas. Existe la idea entre las familias de que son más sencillas de utilizar, más rápidas y más seguras. En realidad, también requieren una curva de aprendizaje para su correcta colocación, y no todas las que se venden son ergonómicas o de materiales adecuados. También se promocionan mochilas ergonómicas “evolutivas” que se pueden utilizar desde el nacimiento. ¿Existen? Sí, pero las que realmente acompañan todo el desarrollo neuromuscular de un niño suelen ser importadas y de alto costo, y son muy pocas.

En la Argentina no hay regulación para la venta y el uso de portabebés ni de otros accesorios. La calidad de las telas utilizadas para la confección de los portabebés va a depender únicamente del fabricante. En Europa, esto sí se encuentra

regulado, tanto los tipos de tela como los colorantes, las fibras, los empaques y los productos que se utilizan para lavar y planchar. Por eso, estos portabebés suelen ser mucho más caros, pero de excelente calidad.

Displasia de cadera y portabebés

Mucho se dice acerca de la relación entre estas cuestiones. Hemos hablado de la displasia de cadera cuando nos referimos a los exámenes complementarios en el recién nacido y en sus primeros meses. También vimos que, dentro de los tratamientos, existe el llamado “arnés de Pavlik”, que, utilizado durante varios meses, puede resolver dicha patología y evitar el tratamiento quirúrgico.

Si miramos la postura en la que acompañamos a un bebé cuando lo portamos ergonómicamente, es similar a la que se adopta utilizando el arnés de Pavlik. ¿Puede el porteo ergonómico reemplazar este tratamiento? La respuesta es no. El arnés ortopédico tiene indicaciones precisas, y el porteo puede acompañar y colaborar en el proceso de resolución de la displasia de cadera, pero no lo reemplaza.

¿La mochila colgona hace mal a la cadera? ¿Puede provocar displasia? No existe evidencia científica aún que pueda afirmar eso. La displasia de cadera tiene bases genéticas y ambientales. Sin embargo, el Instituto Internacional de Displasia de Cadera (International Hip Dysplasia Institute) sugiere el uso de portabebés del tipo ergonómico, y no aquellos donde el peso del niño cuelga sobre la pelvis.

En niñas/os en tratamiento por displasia de cadera, sugiero informar al traumatólogo y al pediatra tratante sobre el deseo de portear o, si ya lo estamos haciendo, sobre el portabebés que utilizamos. El profesional tiene la responsabilidad de, si desconoce de qué le estamos hablando, averiguar e informarse acerca de esto, y acompañarnos en nuestras decisiones como familia.



¿Qué significa “bascular”?

Bascular (con “b”, no tiene que ver con los vasos sanguíneos) es un movimiento que se refiere a llevar la sínfisis pubiana hacia anterior y las crestas ilíacas hacia posterior. Esto genera que la cadera del bebé, al ser porteado, quede por debajo de las rodillas, adoptando una forma de “M”. Dicha forma es beneficiosa e higiénica para el desarrollo de la cadera, la cual, como la mayoría de las articulaciones, es inmadura y se va consolidando durante la infancia.

¿Qué es el *bellywrapping*?

Durante mi primer embarazo, Juani estaba posicionado de tal manera que sus piecitos me pateaban insistentemente las costillas izquierdas. Por momentos, el dolor era tan intenso que me dejaba sin aliento. Mi compañero me decía que a veces me quejaba dormida. Se lo comenté a mi obstetra y me dijo que a veces se hacen pequeños desgarros musculares muy dolorosos en los músculos intercostales y abdominales. Me sugirió una faja que se coloca debajo de la panza para sostener el peso y aliviar un poco el tironeo. Funcionó, a pesar de que al ser de tela sintética, me irritaba la piel y me daba bastante calor y prurito. En noviembre de 2017, a poco tiempo de fallecer Juani y absolutamente alejada por propia decisión y por mi propio dolor de las cuestiones de maternidad, porteo y demases, me animé, no sin vacilar, a concurrir a las Primeras Jornadas Rioplatenses de Porteo Ergonómico, organizadas por la Escuela de Porteo Crianza en Brazos, la primera de Argentina. Allí conocí a Mariel Bonnefon, una psicóloga y asesora de porteo uruguaya, quien, con su hijita en un

trapo naranja atado hábilmente a su espalda, nos contó qué era el *bellywrapping*. Lisandro, mi segundo hijo, no tuvo la costumbre de patearme las costillas (¡a pesar de ser un bebé que se movía un montón!), pero cuando pasaba muchas horas parada trabajando, había un cuadradito muscular abdominal que me dolía horrores, y el bellywrapping con bandolera me ayudó muchísimo a mejorarlo.

Ahora, vamos a la teoría:

- El *bellywrapping* es la técnica de envolver el cuerpo con un fular o una bandolera para aliviar las molestias del embarazo. En algunas ocasiones, por la técnica, se parece a las “fajas” que se usan por debajo de la panza para aliviar el peso, como conté antes.



- **¿Qué molestias podemos aliviar?** Dolor en la cintura pélvica, dolor en la sínfisis púbica, dolores costales, sensación de pesadez, dolores puntuales en alguna parte del abdomen, hernias umbilicales, várices vulvares.
- **¿Hay que estar envuelta todo el tiempo? La respuesta es no.** Son períodos cortos, y tiene que ser cómodo y personalizado para cada mujer y bebé. Nunca debe limitar los movimientos de ninguno de los dos. No “cura”, sino que brinda un alivio temporal.

- **También es una manera de darle un significado simbólico a nuestro portabebés, que ya está envolviendo amorosamente al bebé que espera.** Para el Día de la Madre, por ejemplo, mi compañero me regaló un hermoso fular tejido que fui domando de a poquito entre abrazos y *bellywrapping* para que cuando naciera, ya estuviera suavcito.
- **¿Cómo puedo hacer *bellywrapping* sin lastimarme? Podés buscar una consultora o consultor de porteo ergonómico,** quien te asesorará y, además, te podrá ayudar a elegir un portabebés que sea adecuado para toda la familia. Algo que yo aprendí de esa charla de Mariel, por ejemplo, es que en el *bellywrapping* con bandolera, la anilla se coloca encima del punto doloroso, haciendo una leve presión. Una vez atendí en mi consultorio toda la tarde con la bandolera atada a la panza, porque me dolía justo abajo del esternón. ¡Y funcionó!

Movimiento y cuerpo: mitos vs. realidad

“Si no le enseñamos, no va a aprender nunca”.

Todo bebé sano es capaz de alcanzar un desarrollo motor por sí mismo, sin necesidad de “estimulación” ni ayuda externa. ¡Disfrutemos su exploración del universo sin apuros ni ansiedades de adulto!

“Porteo con mi bebé mirando para adelante porque si no, se aburre”. “Porteo en posición cuna porque es más fisiológico”.

Muchas mochilas “canguro” dan la posibilidad de llevar al bebé mirando hacia adelante. Dentro del porteo ergonómico y respetuoso, desaconsejamos esa postura. El bebé explora teniendo a su cuidador/a a su lado, compartiendo los hallazgos. Un signo del desarrollo es el descubrir algo y mirar inmediatamente la cara de su mamá, buscando la interpretación del adulto de ese suceso. A esto lo llamamos “atención conjunta” y es clave en el desarrollo del niño. El mirar al frente sin posibilidad de girarse ni de mirar el rostro de quien lo porta impide este trabajo de a dos. Asimismo, puede ser hiperestimulante para el bebé, expuesto a situaciones y personas de las que no puede escapar debido a una posición forzada. Con relación a la ergonomía, la posición de la columna nunca se sujeta correctamente, ya que está adosada al frente del adulto, y puede ser incómodo para ambos. ¿Qué hacemos si nuestro bebé quiere chusmear todo? ¡Podemos portear a la cadera! De esa manera puede mirarnos y mirar a su alrededor. Portear en la espalda también es una posibilidad para niños más grandecitos y adultos más hábiles con el porteo.

La posición cuna es controvertida, porque tiene que estar muy bien realizada para no ser peligrosa y se corre riesgo de asfixia. En general no se recomienda, pero si

deseamos utilizarla, es necesario que el bebé esté “panza con panza” con la persona que lo portea, con muchísimo cuidado de no obstruir las vías respiratorias.

“Porteo para poder tener ‘manos libres’”

Mucho se dice del porteo como medio para tener las “manos libres”. Yo también lo pensé en un inicio y creí que mi bebé podría ser amamantado dentro del portabebés mientras yo seguía mi vida como si nada. Error. Descubrí que si bien el porteo es un aliado para usar las dos manos, sobre todo si tenemos más de un hijo que atender, cada cosa en la crianza merece su tiempo. Amamantar no es algo sencillo, y siempre requiere mucha energía y mucha atención, más allá de que con los meses, mamá y bebé se ponen más cancheros. Se puede usar el portabebés como apoyabrazos y amamantar adentro del mismo, pero no es una “sugerencia” o un “beneficio”, simplemente es una opción.

“Hay que tener mucho cuidado con ‘verticalizar’ al bebé”

Dentro del pensamiento pikleriano, se plantea mucho el hecho de “no verticalizar” a los niños, porque sería una postura forzada. Se promueve cargarlos únicamente de manera “cuna”, hasta que alcancen la posición vertical por sí mismos. En esta cuestión, adhiero al pensamiento de Nils Bergman, médico sueco y especialista en neurociencia perinatal, creador del “método canguro”: el lugar de un bebé pequeño no es el suelo, sino el cuerpo de su madre (o cuidador principal). Si no intervenimos en un bebé recién nacido sano, él mismo será capaz de reptar sobre el cuerpo de su madre hasta llegar a su pecho, incluso encontrándose su madre reclinada, en posición vertical. En un bebé recién nacido cargado correctamente en posición vertical, su espalda se redondea, dejando espacio entre las vértebras y apoyando en el pecho del adulto, sin posibilidad de sobrecargar ninguna articulación. A medida que ese bebé se vaya desarrollando, por sí mismo adoptará otras posturas. Desde mi punto de vista, la postura “vertical” no es incompatible con el movimiento libre, y, de esa manera, un porteo seguro, ergonómico y respetuoso es absolutamente compatible con dicha posición.

“Necesita zapatos para que la articulación del pie le crezca firme”.

No necesitamos un molde para que el cuerpo crezca correctamente. La naturaleza nos hizo con todas nuestras partes en su lugar: ¡los recipientes no son más que creaciones culturales!

Sistemas de retención infantil

(huevitos, sillitas, adaptadores para el auto)

Si bien todos alguna vez escuchamos hablar de las sillitas o huevitos para el auto, muchas veces no consideramos la real importancia de los mismos en la prevención de accidentes.

Los bebés y niños deben ir en un sistema de retención infantil hasta por lo menos los 12 años o hasta que alcancen 1.50 metros de altura (sí, ¡ya sé que hay adultos que no miden mucho más que eso! Pero la composición corporal de un adulto es muy diferente a la de un niño).

¿Cómo elegir la sillita adecuada?

- Los sistemas de retención infantil deben tener certificación. Cada sistema debe estar homologado para garantizar que el producto cumpla con las normas de seguridad que protegen al niño. Las homologaciones admitidas son: IRAM 3680-1 y 3680-2 (Argentina), FMVSS213 (Estados Unidos), UNECER44/04 (Unión Europea), AS/NZS 1754 (Australia y Nueva Zelanda), INMETRONBR 14.400.
- Deben tener FECHA DE VENCIMIENTO, y luego de eso, no se pueden usar. Y no deberían utilizarse más de 6 años.
- Si esa sillita estuvo involucrada en un accidente, NO SE DEBE VOLVER A USAR (importante al comprar sillitas usadas).
- Por lo menos hasta los 2 años, el niño debería ir mirando HACIA ATRÁS (contramarcha). Cuando uno va a comprar una butaca (¡me pasó a mí!), muchos vendedores intentan convencerte de lo contrario (para lograr la venta), por eso es importante tenerlo claro.



- Para los chicos más grandes, la indicación es usar una butaca o *booster* con o sin respaldo, que tiene la finalidad de elevar el cuerpo y permitir que el cinturón se ajuste cruzando sobre el medio de la clavícula y que calce en la cadera baja (sobre los huesos), y no por la cintura ni sobre el abdomen blando.
- Hay diversos anclajes de la sillita al auto (sistema tradicional, ISOFIX y LATCH). Los tres son igualmente efectivos cuando están bien utilizados, pero debemos observar si el sistema que vamos a comprar es compatible con nuestro vehículo.
- “¿Por qué a contramarcha dos años? ¡Se aburre y llora!”. El ir a contramarcha reduce el impacto de la colisión considerablemente, dado que se absorbe repartido en diversos puntos del cuerpo. Esto causa daños menores en el “rebote” del cerebro dentro del cráneo, los impactos vertebrales y articulaciones. La edad (1, 2 o 4 años, según cada sociedad científica) varía según diversas investigaciones. **La Sociedad Argentina de Pediatría sugiere hasta los 2 años, y la Asociación Americana de Pediatría plantea hasta los 4 años.**
- Es aconsejable explicarle al niño, desde muy bebito, por qué debe ir en la silla. Si hay que alimentarlo o abrazarlo, lo mejor es detener el auto y realizarlo de esa manera. El llanto puede ser desesperante, pero estamos cuidando su vida y su salud en base a nuestro amor. Aquí no hay negociación posible. Llevar a un niño de 20 kg sujetado solo por los brazos de otra persona y sufrir una colisión a 50 km por

hora equivale a una caída desde un tercer piso, con una probabilidad casi nula de sobrevivir.

- Debe usarse todo el tiempo, incluso en recorridos cortos, que es cuando los controles se relajan y existen más posibilidades de sufrir colisiones con lesionados.

Uso del huevito y asfixia postural

Vamos a focalizarnos en el huevito, el sistema de retención infantil que se utiliza para los bebés más pequeños, dado que en los últimos tiempos, debido a desgraciados accidentes, se habla mucho de los peligros de su mal uso.

Este tipo de butaca es la forma más segura de llevar a los bebés en el auto, bien ajustada y a contramarcha. Sin embargo, hay que tomar algunas precauciones. En bebés pequeños, sobre todo los que aún no tienen control cefálico, el huevito puede generar una forma de “C” pronunciada en el cuerpo, lo cual llevaría a que el mentón se acerque mucho al pecho. La consecuencia de esto es el bloqueo de la vía respiratoria, con la consiguiente asfixia (“asfixia postural”). Esto también puede suceder utilizando un portabebés no ergonómico o colocando mal cualquier tipo de portabebés.

¿Cómo podemos evitarlo?

- * Observar al bebé regularmente mientras viajamos. A veces es conveniente que uno de los mapadres viaje atrás con el bebé.
- * Cada hora y media detener el vehículo, atender al bebé y moverlo de posición, incluso en bebés con control cefálico.
- * Tratar de no utilizar el huevito en casa como lugar de sueño o de “pasar el día”.
- * No se recomienda el uso de accesorios por fuera de los incorporados por el fabricante (por ejemplo, no recomendamos el uso de almohaditas alrededor de la cabeza o de vinchas en la frente) porque pueden empeorar las lesiones ante una colisión.
- * No hay que tener miedo, solo precaución.

Para leer

PARA FAMILIAS

- Grieco, A. y Zampaloni, S. *Crianza para principiantes*, Editorial Grijalbo, Buenos Aires, 2018.
- González, C. *Bésame mucho*, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2018.
- Car Safety Seats: *A Guide for Families 2019*. Copyright © 2019 American Academy of Pediatrics.

PARA PROFESIONALES

- *Consenso sobre mobiliario infantil seguro*. Versión abreviada. Arch. argent. pediatr., Buenos Aires, v. 114, n. 2, p. 2-3, abr. 2016. Recuperado de: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752016000200027&lng=es&nrm=iso>. Consultado el: 10 marzo 2019. DOI: <http://dx.doi.org/10.5546/aap.2016.18>.
- Delgado, V. y Contreras, S. *Desarrollo Psicomotor (Primeros Años)*, Editorial Mediterráneo, Santiago de Chile, 2016
- *Baby Walkers: What You Need to Know* (2008). American Academy of Pediatrics.
- Goldfarb, G. Programa Nacional de Actualización Pediátrica (PRONAP) 2016, Módulo 3, Capítulo 4: *Bebés, niños, adolescentes y pantallas*, pág. 123 a 144, Sociedad Argentina de Pediatría.
- Schulz, N., Laskowski, P. y Eliet, V. (2018). *Módulos de formación en porteo ergonómico*. Crianza en Brazos Escuela de Porteo.
- López Acuña, E. S. y Salmerón Ruiz, M. A. (2014). *El porteo ergonómico*. Pediatría Integral 2014; XVIII (10): 774-780. Recuperado de: <https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2014-12/el-porteo-ergonomico/>
- Gentil García, I. (2007). *Podología preventiva: niños descalzos igual a niños más inteligentes*. Revista Internacional de Ciencias Vol. 1, Núm. 1, 2007, 27-34. Recuperado de: <https://revistas.ucm.es/index.php/RICP/article/view/19520>

“Su hijo es valiente”



Si un niño:
Es ruidoso
Explora todo
Está pegoteado de cosas misteriosas
Tiene mocos
Hace berrinches
Toca todo

Come poco (o mucho)
Se despierta a la noche
Quiere mucha upa
¡Excelente! Lo más probable es que sea un niño sano

(y que nosotros, los adultos, seamos quienes tengamos que revisar nuestras expectativas y deseos).

Mi camino en la crianza respetuosa

El primer libro de “crianza” que leí en mi vida fue *Bésame mucho*, del pediatra español Carlos González. Bendita fue mi suerte. Lo leí apasionadamente, en los pequeños momentos que me permitía mi hijito mayor. Leí parada en el colectivo, escuchando las canciones infantiles que me aprendía para cantarle. Leí en la sala de espera de sus controles médicos, mientras él dormía sobre mi pecho. No podía creerlo, estaba anonadada. Fue una especie de epifanía, un sacudón de oxitocina. Llevaba años trabajando con niños, y en ese momento me di cuenta de que sabía muy poco de ellos. Que me estaba perdiendo gran parte de los colores vibrantes de mi trabajo. **Que todo lo que hacía con mi hijo, desde la pura intuición, estaba bien: no porque me lo decía un libro, sino porque lo hacía desde el amor y disfrutando la aventura de mi maternidad.**

“Su hijo es valiente”, “Su hijo es generoso”, “Su hijo es sincero”, dice Carlos... y sí. Mi hijo mayor fue valiente, generoso, sincero... Y su hermano también lo es. Mis pacientes también lo son. Y la crianza sigue siendo una aventura, llena de belleza en el caos, de deseo y de amor.

El biencriar

Los hijos nos sorprenden. Todo el tiempo. En situaciones en las que juramos no caer nunca.

¿Les suena el: “Yo nunca voy a hacer colecho”, “A los dos meses como mucho vuelvo al trabajo, no me aguantaría estar en casa”, “Mi hija nunca haría un berrinche en público” o “Yo nunca le voy a hablar como ‘bebé’?”.

Y luego:

“¿Quién es ese bebé tan lindo? ¿Taaaan, taaan lindo? ¿Lindo de mamá? ¿Dónde está ese bebé? Acá taaa”.

La forma en la que le hablamos a nuestros bebés, tiene nombre: se llama “maternés”. El maternés es el dialecto dulce en el que todas las madres les hablan a sus bebés en el mundo. El tono musical, agudo, el repetir muchas veces las sílabas, el remarcar cada letra, el usar diminutivos... es parte de la introducción del bebé al mundo social del lenguaje, cuyas palabras ya vienen resonando desde la panza. Está probado que los bebés pequeñitos responden mejor a esta forma de hablarles, y prefieren los tonos agudos y dulces.

No importa en qué idioma hablemos: el maternés es un lenguaje universal.

Nos sorprende porque no importa cuántos hijos hayamos tenido antes, o cuánto hayamos leído de crianza: esta persona nueva vino para traer algo nuevo al mundo. ¿Cómo acompañarla?

De a poco nos hermanamos con otras familias. De a poco empezamos a comprender la infancia y su magia. De a poco nos convertimos en mapadres, cansados, ojerosos, felices porque nuestro bebé comió el primer pedacito de banana.

Convertirse en mapadres también es acceder al universo de las opiniones ajenas, todas muy preocupadas por evitar que el bebé “se malcrie”. ¿Malcriar es llevarlo en brazos cuando llora? ¿Malcriar es apoyar nuestra mejilla sobre la de ellos, sentir su piel suavcita, olerlos, escuchar su corazón? ¿Por qué es tan difícil comprender que, en una mapaternidad deseada, todas estas cosas también son producto del deseo? Que más allá de que ellos necesitan nuestros brazos... ¡disfrutamos abrazarlos!

Malcriar no es levantar al bebé de la cuna para achucharlo, malcriar es emplear la violencia. Malcriar es “el chirlo a tiempo”, la tirada de oreja, la violencia psicológica (“no servís para nada”, “nadie te va a querer”, “si seguís portándote mal, me voy y te dejo solo”), el descuido y el abandono.

Las consecuencias de la violencia son muchas. Es muy complejo para un niño comprender por qué la persona que debería protegerlo y cuidarlo lo lastima física o psicológicamente. Crece creyendo que merece ese trato, y probablemente se relacionará de esa manera en su accionar cotidiano.

Muchos mapadres que ejercen violencia sobre sus hijos no consideran que están siendo violentos. No saben otra forma de relacionarse. La frustración y la impaciencia hacen que no encuentren las palabras para expresarse y terminen desbordándose. **Tal vez lo que no nos parecía violento en una época, ahora sí nos lo parece, y eso da pie a reflexionar. Poner en palabras esos sentimientos de desborde.** No con culpas y angustias, sino buscando ayuda, en ocasiones hasta profesional.

Nosotros somos su lugar seguro, el único que conocen. Y no, no es sencillo estar en ese lugar, no es sencillo tomar decisiones, no es sencillo ser adultos y animarnos a observar en forma crítica nuestra propia crianza y el niño o niña que fuimos. Biencriar no es un conjunto de reglas que hay que seguir puntiliosamente, sino, con simpleza, es criar a partir del respeto y del amor.

Bebés y niños de “alta demanda”

Nadie tiene la “posta” de la mapaternidad. Nadie. Estamos relativamente solos acompañando el crecimiento y desarrollo de pequeñas personas que por un lado nos necesitan, y por otro, cuando son más grandecitos, también necesitan hacer cosas solos, decir “yo” y “mío”, hacer berrinches, no comer, tirarse al piso en lugares públicos.

En una sociedad adultocentrista, donde las licencias de maternidad muchas veces obligan a volver a trabajar a los 45 días de nacido el bebé, donde a nadie le importa si no hay lactario, donde miramos mal al niño que hace un berrinche en el subte, caemos en términos y etiquetas que describen... niños sanos.

No existe ninguna teoría pediátrica ni psicológica que avale hablar de “niños de alta demanda”. Sí podemos hablar de niños con diferentes temperamentos, inclusive entre hermanos (¡inclusive entre gemelos!), y también de las diversas herramientas que tenemos como adultos para responder a esos temperamentos.

Un niño sano “demanda” 24 horas, exige atención, explora todo como un terremoto, rompe cosas sin querer, se ensucia la ropa nueva, llora a los gritos porque no lo dejamos tomar agua del inodoro, se angustia profundamente porque vamos cinco minutos al baño, SIEMPRE tiene mocos, come tierra, revolea las verduras, y podría estar todo el día enunciando otros “amenos” momentos de la mapaternidad.

Eso no habla de “alta demanda”. Habla de un niño sano, tal vez diferente al hermano o al vecino que es “más tranquilo”; así como yo, que estoy escribiendo, soy diferente a vos, que estás leyendo (y a nadie se le ocurriría compararnos porque somos adultos).

Esto no quita que ser mapadre puede resultar agobiante, angustiante y agotador. En la sociedad del trabajo y de vivir a mil, a nadie le importa que tengamos un minidinosaurio en casa exigiendo atención si tenemos que entregar tal o cual papel importantísimo para mañana.

¿Qué podemos hacer? Creo que siempre lo mejor es compartir estas experiencias, acompañarse, hacer la famosa TRIBU de la cual ya hablamos, ya sea en forma personal o virtual. Saber que no estamos solos, que llorar de cansancio es válido, que siempre hacemos lo mejor que podemos, que nuestro hijo no es el único que no se

calma en la butaca del auto, que hoy no es siempre, y que esto, sí, esto también, también pasará. ¡Y habrá nuevos desafíos!

Oda a la butaca del auto

***Que terrible la butaca del auto.
Le agradezco.
Infinito, le agradezco
Que cuide tu vida
Que proteja tu cuerpo
Que, si algo nos lastima,
Sean menos posibles tus heridas.***

***Le agradezco que
Me dé más días de abrazarte dormido
Más noches de bebé calentito
Más tardes de risas y baba.***

***Pero qué terrible
El llanto extremo.
La tos
Las arcadas
Lágrimas, mocos, gritos.***

***Canté todas las canciones
Conté todos los cuentos
Agité chiches, llaves
Vimos todos los videos de Magdalena Fleitas
(acá sí vale el celu, vale todo).***

***Qué terrible ser el adulto responsable.
El saber que no puedo sacarte de ahí porque podrías lastimarte.
El apelar a mi conciencia, a mi razón, y no a las ganas de sacarte de ahí y darte la teta.
El comprender que la butaca no se negocia
Y que es parte de mi amor.***

***Le agradezco, le agradezco a la butaca
Que a pesar de tus lágrimas***

*Y de mi cansancio
Llegamos a casa
A abrazarnos.*

Angustia del octavo mes

Hemos visto anteriormente que por más que nazcan a término, los bebés continúan siendo prematuros varios meses más. Necesitan contacto, contención, upa, atención permanente y, sobre todo, la presencia de una figura de apego que le ayude a comprender el mundo. La famosa “exterogestación”, en suma.

El bebé, hasta cierta edad, no sabe que él y su mamá son personas diferentes. Tampoco entiende que las cosas no desaparecen del universo cuando desaparecen de su vista. A los 8 meses aproximadamente (pues hay bebés que lo experimentan antes y otros después), estos conceptos empiezan a aparecer... y causan sorpresa y angustia.

De repente, un bebé apacible, que dormía muchas horas a la noche, se despierta cada una hora llorando desconsolado. O una beba que se “quedaba con todos” no deja que la aúpe nadie más que su mamá. O el tratar de ir al baño se vuelve una tragedia griega con gritos de verdadera angustia. O de repente, un bebé que toma teta se pone en “modo ternero” (¡toma sin parar!) y no entendemos qué pasa.



Para el bebé, quien está empezando a procesar que es UNA PERSONA DIFERENTE, que nos alejemos de su campo visual es compatible con que desaparezcamos para siempre. Aún no entiende la permanencia del objeto: si no lo ve, no existe.

Es una época difícil para muchas familias, porque no comprenden qué está pasando. ¡Si hasta ayer se quedaba con la abuela y se reía todo el día! La angustia del octavo mes es algo **ABSOLUTAMENTE NORMAL** y que **TIENE QUE SUCEDER**. Inclusive sucede en bebés que no lo expresan tan floridamente. **Es parte de la constitución del aparato psíquico de un niño sano.**

¿Cómo podemos acompañar?

- **Medidas anticipatorias.** Sí, los bebés entienden. Entienden todo. Está bueno explicarles que vamos a hacer pis al baño, que nos vamos a trabajar unas horas y se van a quedar al cuidado de la niñera pero a las seis de la tarde estamos de vuelta, que papá va a comprar pero vuelve. “Esconderse” para salir por la puerta y “tratar de que el bebé no se dé cuenta porque sufre”, solo los confunde. Es preferible contarles realmente lo que va a suceder.
- **Jugar al “¿dónde está?”.** Los bebés a esa edad empiezan a disfrutar mucho los juegos de “esconderse y aparecer”, y generalmente tienen la coordinación motriz para imitar y hacerlo ellos por su cuenta. Participar de estos juegos les ayuda a entender que, a pesar de que una cara “desapareció” detrás del trapito, ¡sigue estando en el mundo!
- **Jugar a esconder chiches abajo de una tela,** y que los descubra.
- **Permitirle “revolear” cosas y ver hasta dónde llegan, qué ruido hacen, y devolvérselas,** mostrándole que se han caído de su sillita alta, por ejemplo, pero no del mundo (acá es cuando los adultos ejercemos toda nuestra habilidad de hacer sentadillas).
- **Podemos usar objetos de apego/transición.** Algún juguete o algún trapito que los acompañe y les aporte seguridad y calma.
- **El porteo ergonómico puede ser una excelente ayuda** en este momento de mucha demanda de brazos y contacto.

- **Explicarle al resto de la gente que es un proceso normal y sano (qué difícil...).**
- **Mucha upa, paciencia y comprensión.** Sepamos que es una etapa NECESARIA. No “dejarlo llorar” ni decir que es “caprichoso/a”. No es algo que el bebé pueda controlar, está descubriendo el mundo.

Lo repito muchas veces porque me parece importante: ESTO TAMBIÉN PASARÁ (como pasó la primera noche, como pasaron los cólicos...). **Mientras más información tengamos, más herramientas podemos construir para atravesar la crianza.**

Los adultos y el apuro

Que cuándo va a caminar. “¿Por qué no la ayudás un poco?”.
Que cuándo va a comer todo el plato. “¿Será que toma mucha teta?”.
Que cuándo va a dejar los pañales. “Eso es porque es muy apegado”.

Los adultos siempre queremos más y más. Y rápido. Si empezamos a estudiar, soñamos con que se termine pronto. Si abrimos una red social, queremos muchos seguidores. Y que no tarden. Disfrutar los procesos nos cuesta. Y mucho. Pero la infancia tiene sus ritmos y sus colores, y caminar una cuadra puede ser una eternidad, porque se investiga cada hojita y se festeja cada auto que sale de un garaje.

Cada niño tiene sus tiempos. Buscar “estimularlo” para que haga algo más “rápido”... ¿a quién beneficia? Ese bebé “necesita” aprender más rápido... ¿o tal vez tenemos que revisar nuestras expectativas? Si es un niño sano y feliz, ¿importan los tiempos? Inclusive si por alguna condición de salud se requiere algún tipo de intervención, o se manejan tiempos distintos a los de otros chicos... ¿cuál es el objetivo de comparar todo el tiempo?

Brindemos para no haya apuros. Para que no haya comparaciones. Por tomar las oportunidades que nos dan los chicos para repensar la propia infancia y abrazarnos. Por ser más sabios y aprender a acompañar.

Los adultos y el cansancio

Hoy no puedo más.

Estuve muchas horas en el trabajo. Me dijeron que estoy rindiendo menos por dormir poco y si realmente necesito tanto tiempo para sacarme leche. Luego, en casa, respondí muchos mails. Recordé retirar el acolchado del lavadero. Entregué textos que tenía atrasados. Puse a lavar la ropita del bebé. Limpié el pis del perro. Me acordé de que tengo un curso por la mitad y el examen es mañana. Anoche dormí muy poco porque ayer pusimos vacunas y hubo fiebre. Y el cansancio ahí, invadiéndolo todo.

Cansancio, hartazgo. En casa hay gritos y llantos. Prendo la tele y se calman. Dejo la tele prendida, con culpa porque no tendría que ponerles pantallas. Descongelé comida, con culpa porque no estoy cocinando fresco ni sano. Me contengo de gritar al tercer garbanzo que vuela en medio de un berrinche, pero, uff, como gritaría.

¿Esto significa que no amo a mis hijos? ¿Que soy una mala madre? Yo cuido todo el día, ¿y a mí quién me cuida? Miles de cuentas de Instagram diciéndome qué hacer, haciéndome sentir horrible. La culpa, siempre la culpa. Y la noche empieza otra vez.

No. Todo eso no es ser mala madre. Al revés. Es ser la madre que podemos ser en un sistema absurdo, de múltiples imposiciones sobre la maternidad y sin ninguna facilidad hacia la misma. **En un mundo donde se nos exige trabajar como si no criáramos y criar como si no trabajáramos.** Este último texto no está escrito en femenino de casualidad, porque si bien hay todo tipo de familias y padres cumpliendo su rol en la crianza, **las miradas ajenas aún suelen posarse en la madre para las críticas. Hay mucho que cambiar.**

Somos las madres que podemos ser, con nuestras luces y sombras. Y reconocer que, ciertos días, todo nos sobrepasa es importante, porque es lo que hace que podamos decirlo y que no quede doliendo, y es mostrarles a nuestros hijos que somos falibles. **La crianza respetuosa también es eso: validar las emociones y necesidades de todos los miembros de ese vínculo.**

En esos días, aflojar en lo que se pueda. Si no quiere vestirse, que ande en culito por la casa. Si no se secaron los pañales de tela, no sucede nada con que un día use descartables. Si los platos quedaron sin lavar, qué pena. Somos humanos. Lo único importante es que nos amamos, que todos estamos aprendiendo a la par y que habrá días mejores. En serio.

Berrinches

Los berrinches son manifestaciones de enojo, frustración o confusión que pueden expresar los niños desde los 18 meses hasta los 4 años (aproximadamente). Lo más importante de esta cuestión es comprender, como adultos, que si bien los berrinches nos desconciertan y nos frustran a nosotros también muchas veces, **son normales, sanos y parte del desarrollo de un niño.**

El berrinche es una respuesta (para nosotros, adultos, “exagerada”) a algo que el niño no entiende, lo frustra o lo hace sentir mal. Así como el recién nacido se comunica a través del llanto y aún no tiene otras herramientas, los niños de esas edades no pueden expresar todavía qué les pasa exactamente.

El berrinche puede ser solo llanto o puede incluir tirarse en el suelo, patalear e incluso lastimarse o querer lastimar a otros.

¿Qué podemos hacer nosotros?

- **Primero, respirar hondo y entender que es un proceso, y es normal.** No somos malos papadres, y el niño no es malcriado, manipulador o llorón por hacer un berrinche. Es como pedirle a un bebé de días que no llore por hambre, o mantener la calma ante el tercer colectivo que nos pasa de largo cuando llevamos una hora y media en la parada (¿ven que los adultos también haríamos berrinches si pudiéramos?).
- **Llevar al niño a un lugar donde no tenga posibilidad de lastimarse y pueda descargarse el tiempo que necesite.**
- **Ponerse a su altura, decirle: “Sé que estás enojado/a, cuando quieras hablar, acá estoy”.** Mostrarle que no estamos enojados, aunque el berrinche haya sido por un límite necesario que pusimos, y que estaremos ahí para el consuelo.
- **No “buscar venganza” cuando el berrinche finalice.** Frases del estilo: “Ah, ahora sí querés jugar, ¿no? Qué vergüenza, todo ese llanto” o “Ahí viene la señorita, siempre haciendo lo que se le antoja”, lo único que hacen es minar la confianza del niño y hacerlo sentir avergonzado.



- **Dar opciones.** Supongamos que el berrinche se da porque no lo dejamos tomar un objeto que es peligroso, como es lógico. Lo que podemos hacer es darle a elegir entre otros dos objetos, para distraerlo de aquel que no puede tocar. Por ejemplo: “El cuchillo te puede lastimar, así que mejor llevate esta cuchara o esta tapa de olla”.
- **Negociar es fundamental.** ¿Cuánto es capricho nuestro y cuánto del niño? Si negociamos la cosa que no implica riesgos (por ejemplo, ¿cuál es el problema de que use la taza rosa en vez de la verde?), entonces cuando decimos “no”, es tan ocasional que apenas genera una molestia.
- **“Hace berrinches en lugares públicos”.** Típico. El problema no es del niño en cuestión, sino de nuestra sociedad adultocéntrica, donde observamos con horror a un gurrumin de 2 años tirado en el piso enojado porque no le gusta ponerse los zapatos, y con más horror, susurros audibles y hasta dedos señalando a la “mala madre” que se muere de vergüenza. ¿Qué pasaría si todos entiendiéramos que el berrinche es algo normal? ¿Que lo anormal sería que un niño no tuviera berrinches? ¿Que estar fuera de casa es una experiencia muy intensa para un niño, un mundo avasallante y nuevo que requiere ríos de paciencia?

La violencia no es aceptable de ninguna manera. Los golpes, los insultos, las descalificaciones y las faltas de respeto (sí, el niño es una persona y también

requiere respeto) solo le enseñan que esa es la manera de comportarse ante una frustración. “Un chirlo a tiempo” solo nos ha enseñado que no podemos contarles a quienes más amamos, nuestros mapadres, que estamos enojados, frustrados o confundidos.

Ser mapadre no es fácil. Nadie nos dijo que íbamos a tener que apelar a nuestras más profundas herramientas psicológicas, boyando en nuestra propia historia y nuestra propia infancia (qué miedo, ¿no?). Nadie nos dijo que íbamos a recibir ideas de extraños aconsejándonos golpear a nuestros hijos. Nadie nos dijo tampoco que ese bebé dulce de hace unos meses, que le hacía caritas al pediatra, se va a empezar a retorcer en la balanza al grito pelado de “NO QUIEROOO”. Y sobre todo, nadie nos dice que todo eso es esperable, y hasta normal.

Vos sos un buen mapadre. Tu hijo no es malo, no es manipulador, no quiere “tomarte el tiempo”, solo quiere decirte algo y aún no sabe cómo. Si le mostramos cómo manejamos nuestras propias frustraciones y enojos, aprenderá, de a poco, de nuestro ejemplo.

Tiempo. Hoy no es siempre.

Caprichos

(Escrito y prestado por **Mariana Nieva**,
doula y consultora de porteo ergonómico).

Hace un rato pasó algo que me dejó pensando, como casi todo lo que vivo con él desde que soy mamá.

Nos levantamos y le pregunté si quería desayunar jugo. “UO”, dijo. Así que me dispuse a exprimir una naranja. La pasé a su vaso de aprendizaje, como todos los días.

“No”, dijo.

Lo ignoré y cerré el vaso.

“No”, repitió.

“Juan, ¿qué pasa con el vaso?”.

“No, ma, NO”. Y me dio la botella con piquito que le compré por la calle ayer, que habíamos salido y me olvidé el vaso para el agua. Esa en la que tomó agua ayer todo el día.

“No, Juan. El desayuno se toma en el vasito azul”.

“No, mamá”, y desenroscaba el vaso.

“Juan, el desayuno se toma en el vaso azul”.

Y Juan no quería. ¿Cómo es que con sus casi 2 años no se da cuenta de que el desayuno se toma en el vaso azul? ¿Que la botella con pico es para emergencias en la calle? ¿Cómo no entiende que aunque sirva para tomar, no es PARA el desayuno?

Ahora, ¿quién está en medio de un capricho?

Yo, la adulta, exigiendo que tome en un vaso que él no quiere (¿cuál es el problema si el vaso es azul o rojo, tiene pico o es una botella? Para el caso es lo mismo).

Y bueno. Le pedí disculpas, le pasé el jugo a la botella y desayunamos en el piso. Algún día se quedará quieto y vamos a desayunar en la mesa.

Control de esfínteres: “dejar” los pañales

Adquirir control de esfínteres no es tarea sencilla. Los nervios y neuronas que trabajan con las sensaciones y control motor de las zonas involucradas tardan un tiempo importante, que varía de niño a niño, en desarrollarse. **Recién a los 18 meses, este proceso se empieza a consolidar lentamente.** Así como no esperamos que un bebé de 3 meses camine, no podemos esperar que uno de 15 meses deje el pañal solo porque se lo pedimos o porque tiene que ingresar a una institución.

Durante años, se planteó que a los niños había que enseñarles cosas: a sentarse, a caminar, a comer, a dormir. Ahora sabemos (tal como vimos en otros capítulos) que si les permitimos desarrollarse libremente y acompañamos con amor ese proceso, todos los niños sin ninguna condición subyacente lograrán estos hitos solos.

Veamos, entonces. Para poder llegar a “dejar” el pañal, el niño tiene que haber logrado evolutivamente:

- 1. Darse cuenta de que hizo pis o caca en el pañal.**
- 2. Darse cuenta de que está haciendo pis o caca.**
- 3. Percibir que tiene ganas de hacerlo.**
- 4. Llegar a contener y avisar que desea ir al baño.**

Todo esto es progresivo y reviste un importante nivel de complejidad neuronal. Es importante también que el niño sea capaz de expresarse y contar lo que le pasa. **En general, este proceso se inicia, principalmente, entre los 2 y 3 años, donde predominan el “yo”, “mío”, “no” y “puedo solo”, todas pautas importantes que**

llevan al reconocimiento del propio cuerpo y a determinar límites.

A algunos niños les genera mucha angustia “perder” parte de su cuerpo cuando evacúan. La presión del pañal puede hacerlos sentir que la caca y el pis siguen siendo parte de su cuerpo. Esto es normal y debemos acompañarlos tranquilos como mapadres.

¿Cómo acompañar?

- Reconocer los signos de que este proceso se está iniciando, y respetar que es el niño quien decide sobre su propio cuerpo.
- Enseñarle palabras que describan las partes del cuerpo y los procesos de evacuación.
- Mostrarle la culturalidad en la que vivimos con respecto a esos procesos (en la sociedad occidental usamos inodoros, por ejemplo, pero esto no es así en todo el mundo).
- Ofrecerle elegir elementos que los ayuden a usar el baño (pelelas, banquitos, adaptadores).
- Evitar juicios de valor: castigos o felicitaciones desmedidas.
- Tomar los “accidentes” como algo natural. Invitarlo a ayudarnos a limpiar.
- No tener miedo de “volver” a los pañales, si es preciso. No es un retroceso ni un error. Podemos preguntarle si prefiere volver a usar pañal, y si su respuesta es positiva, respetarla.
- Ponerle ropa cómoda, que acompañe sus movimientos, y sea fácil de sacar y poner.
- No usar el verano como momento en el que “hay” que sacar los pañales. Tal vez el niño no esté aún listo.
- Que el niño ingrese al jardín no implica la obligación de dejar los pañales previamente. No existe ninguna disposición o ley que pueda forzar a un niño a hacer algo para lo que evolutivamente no está preparado. Es totalmente cierto que

muchos jardines no cuentan ni con personal ni con el lugar adecuado para cambiar los pañales durante la jornada, pero no podemos obligar a los niños a responder a políticas poco respetuosas de salud y educación infantil, sino adaptar esas políticas para el acompañamiento de la infancia.

- No apurarse, no comparar. Se demostró que los niños que fueron forzados a iniciar “entrenamiento” para dejar los pañales antes de que estén listos, luego tardan más en completar el proceso, además de sentir frustración y angustia por no “lograr” algo que la familia espera.
- Los juegos de trasvasar, tanto elementos sólidos (piedritas, fideos o arena) como líquidos, hablan de un inicio del proceso. Trasvasar da sensación de control, de poder decidir hasta dónde sale el chorro y qué cantidad retener. Podemos acompañarlos y fomentar estos juegos.
- Jugar con arena, masa, plastilina o *slime* también aporta información al cerebro a través de la mano, intuyendo texturas, temperaturas, formas y resistencias. Todo esto aporta a la sensación de “entender” el propio cuerpo y al control de esfínteres.

¿Hasta cuándo es “normal” el proceso de control de esfínteres? Generalmente, primero se logra el control diurno, y luego, el nocturno; y primero del pis y después de la caca. Recién se considera enuresis (persistencia de micciones incontroladas) después de los 6 años. **El control completo de la vejiga es variable y no mojar la cama es la última etapa del aprendizaje**, habiendo un porcentaje de adultos (1 %) que siempre lo hará, sin ninguna patología orgánica puntual.

Escolaridad

Volver al trabajo remunerado.

A veces porque lo deseamos

A veces porque no queda otra y hay que pagar la luz.

Casi siempre duele.

Hay un abrazo infinito para decir “Chau, en un ratito vuelvo” y dejarlos en brazos de papás, abuelas, niñeras, maestras.

Se descongelan leches, se preparan mochilitas, se toman colectivos.

Se prepara con amor a esos seres imposibles de chupete y uniforme...

*Y las horas pasan
Esperando el reencuentro.
Con suerte, en un trabajo elegido y amado.
Y muchas otras veces, en uno necesario para sobrevivir.*

*Las horas pasan
Hasta llegar y caer en esos bracitos tibios
Las boquitas ansiosas
El olor a bebé.
Y ahí, en esos amores plenos, las horas dejan de pasar.*

Una consulta común es solicitar la recomendación de una “edad” específica para que los bebés y niños comiencen el jardín de infantes. Muchas familias tienen miedo de que si no mandan a los chicos al jardín, no sabrán socializar.

El jardín maternal o el jardín de infantes es una decisión familiar. A veces no habrá otra opción, porque la familia tiene que trabajar y no hay otros cuidadores. Otras, es una elección por una cuestión de requerir tiempos para otros hermanitos o diversos proyectos. Y otras, porque hay niños que están muy felices de interactuar con otros niños, y sus familias consideran que en el jardín la pasan muy bien, gastan energía, aman a sus maestras, cantan mucho y vuelven contentos (y está fantástico).

No podemos dejar de decir que ir al jardín lleva aparejado el traer mocos continuamente a casa. **Nunca fue ni nunca será de otra manera: juntar niños chiquitos es sinónimo de mocos. Sabemos que durante esos años los chicos tendrán más de 8 infecciones respiratorias altas (resfrío, gripe, otitis) por año: es normal y sano. Paciencia.**

El jardín de infantes solo es obligatorio desde los 4 años en algunos distritos y desde los 5 en otros. Esto es debido a que los niños hasta esa edad no juegan entre ellos. ¿Cómo? Sí, **hasta los 4 años aproximadamente vemos lo que se llama “juego paralelo”, es decir, pueden jugar en la misma habitación pero en general no jugarán entre ellos.** Posterior a los 4 años, ya podemos observar diversas interacciones sociales de juego en grupo. **No, no les podemos pedir que compartan: sus juguetes u objetos son de ellos, son enormes e importantes aún, y hay que respetarlos.** ¿Acaso ustedes compartirían su celular? Lo dudo.

Los niños no necesitan ir al jardín para socializar: socializan todo el tiempo con los miembros de su familia. No van a tener problemas con la adaptación al mundo por no haber ido al jardín hasta los años obligatorios. Reitero: el jardín de infantes es decisión familiar, ya sea por trabajo o porque consideran que es lo mejor para sus hijos.

Muchas veces somos los adultos los que necesitamos socializar. Y esto es muy bueno, porque les mostramos a los chicos que el mundo va más allá del núcleo

familiar. A veces el jardín de infantes también cumple esa función: encontramos amigas y amigos dentro de los mapadres que nos tocó conocer en ese grupo.

La elección del jardín de infantes, cuando se puede elegir, no suele ser sencilla. Personalmente, haría hincapié en **una escuela con la que pueda interactuar la familia, donde se acompañen los procesos sin obligar, por ejemplo, el control de esfínteres, o la adaptación. Donde puedan ser flexibles y abiertos al diálogo. Y donde, no menos importante, se contemple al establecimiento como parte de la salud de los niños:** que se destaque la importancia de completar el carnet de vacunas y de mantener una alimentación saludable.

Quiero cerrar este apartado agradeciéndoles a las y los docentes, quienes, con mucho amor y vocación, cuidan a esos niños durante su estadía en el jardín, y los abrazan con cariño y respeto. Ojalá se reconociera más seguido su trabajo y fuera realmente valorado, social y económicamente. Gracias.

Todo tipo de familias

*(...) Familia es
papá y mamá,
o dos papás,
o dos mamás.
Abuelos, tíos,
primos y amigos.
Es el amor lo que importa acá.*

(Fragmento de canción popular creada por Erica Labelle, en el marco del proyecto “Conocemos nuestros derechos”, junto con la Sala Lila, Jardín N° 901 de Olavarría, y su maestra Marita Fanesi, 2018).

“Las familias de ahora no son como las de antes”, dicen personas que probablemente nunca hayan buceado en genealogías documentadas en libros de historia. Muchas culturas tienen rasgos impositores que tienen que ver con dogmas religiosos, como decir en la actualidad que las familias son únicamente formadas por el típico grupo varón-mujer-niños.

La humanidad, en su fluir, se ha burlado de esto a través de los siglos. **No son una novedad las parejas homosexuales, las familias monomarentales y monoparentales, las familias ensambladas, las familias poliamorosas, las familias**

donde crían abuelos o tíos, e infinita cantidad de otras formas de ser familia. Lo que sí cambió es que la globalización y la presencia de las redes sociales posiblemente nos acercan a ver muchas realidades que anteriormente no conocíamos, pero que existen desde que el mundo es mundo.

También el sistema ha evolucionado, lentamente, en reconocer los derechos de las personas. En 1981 se retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud (ya era hora), y en 2010, después de muchos años de lucha, en Argentina se sancionó la Ley de Matrimonio Igualitario, que reconoce el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional.

Queda mucho por recorrer a nivel sociedad para evitar las miradas raras y los comentarios por lo bajo cuando una familia sale de la “norma” de lo que es una “familia moderna tipo”. Recuerdo mi libro de lectura de primer grado. En un cuadradito, había dibujadas una mujer y una niña. Había que escribir “mamá y nena”. A su lado, un cuadradito con el dibujo de un varón y un niño. Poco tiempo antes se habían separado mis padres, mi padre no estaba presente en mi vida y vacilé muchísimo en escribir “papá y nene”. Si no lo escribía, probablemente la maestra me pusiera una carita fea por no hacer la tarea. Se hablaba poco de los divorcios en esa época, y los libros de texto dejaban muy claro lo que consideraban “familia”. Hoy, de a poco, eso está cambiando, y lo celebro profundamente.

El camino a la adopción

El sistema de adopción argentino es complejo por una infinita diversidad de razones, entre ellas, además de las trabas judiciales del sistema, porque **la gran mayoría de los adoptantes se anotan para recibir niños de entre 0 y 3 años (80 % de los inscriptos), mientras que menos del 10 % de los niños que esperan tienen 1 año o menos.** Puede adoptar un matrimonio (ya sea hetero u homosexual), una pareja en unión convivencial o una única persona, soltera, viuda o divorciada.

Cuando la búsqueda de familia entre los inscriptos en la Red Federal de Registros da un resultado negativo, los juzgados incluso pueden hacer una convocatoria pública, donde en los medios oficiales de la nación se publica y se cuenta acerca de los niños, ampliándose así la búsqueda de familias.

La adopción busca permitir a niñas, niños y adolescentes tener una familia que les brinde afecto y cubra sus necesidades materiales cuando no puede hacerlo la familia de origen. Es decir, busca la mejor familia para cada niño, cumplir con sus derechos, y no otorgar un “niño a la carta”, según lo que soliciten los postulantes.

Como todos los procesos de familia, la adopción no tiene por qué ser un acto romántico y perfecto: es probable que haya expectativas, sinsabores, momentos de acostumbamiento y momentos de zozobra. Pero con acompañamiento

profesional, entendiendo los tiempos que requerimos todos, grandes y chicos, los vínculos florecen. Los niños vienen con una historia, que ahora también es nuestra historia, es la historia de nuestra nueva familia y de nuestro amor.

Separarse para sumar

La separación de una pareja es un momento de crisis, incluso cuando se da en buenos términos. Las estructuras que hasta ese momento enmarcaban a esa familia cambian, puede haber mudanzas, cambios de rutina, nuevos horarios. Los niños también van a atravesar este proceso, por más que intentemos protegerlos y evitarles información, es importante tenerlos en cuenta, explicarles lo que estamos viviendo, inclusive explicarles nuestros sentimientos y las razones de la separación.

La separación no es necesariamente un proceso traumático, lo traumático son las formas, los silencios y el no considerar que el niño es partícipe del proceso, o usarlo como una moneda de cambio. La separación inclusive puede aportar felicidad y libertad a todos los miembros de ese ensamble que no estaba funcionando de esa determinada manera, y ahora busca otras formas de relacionarse.

Lamentablemente, muchas veces las historias no son tan armoniosas. En este apartado, con el permiso de la familia, contaré una anécdota. Hace un tiempo acompañé a una mamá quien, en medio de una separación compleja, me pidió hacer una nota médica a los abogados y al juez, dado que todos opinaban que su niña de 1 año tendría que ser destetada para pasar las vacaciones con el papá. Que si no lo hacía, era solamente para perjudicar la relación con el padre, porque esa leche ya era “agua” y le estaba causando un daño psicológico. Todo esto dicho con la lengua muy floja por gente que no tiene ninguna formación en salud.

Hice una nota muy clara explicando las recomendaciones de la OMS y aportando mis datos por si requerían más información. La firmé y la sellé. Es probable que esa nota haya terminado en un cesto de basura o perdida dentro de un archivo.

Cada separación tiene sus razones, pero cuando hay niños de por medio, lo más importante es su bienestar. ¡Parte de lograrlo es reconocer sus necesidades y deseos! Y, por ejemplo, la lactancia no solo es nutrición, sino que es un lugar seguro y de consuelo, que es precisamente lo que necesita un niño en esos momentos.

Como mapadres, es importante velar por el interés superior de nuestros hijos. **El horario de visitas debería ser flexible, frecuente y responder a las necesidades del menor, por supuesto, propicio para desarrollar un vínculo sano y hermoso con ambos mapadres y el resto de la familia.** En la vida de un niño pasan muchas cosas: descubrimientos, mocos, tarea, actos escolares... Tal vez un niño que va a dormir con su papá varias noches por semana sin problemas, durante una semana no desee ir y desee estar con su mamá porque hay algo que lo angustia. **La flexibilidad ante las**

diversas situaciones es vital.

Si los progenitores se ponen de acuerdo, excelente, pero si existe una lucha alrededor de, por ejemplo, llevarse de vacaciones a un niño o niña que amamanta — como en la anécdota que acabo de mencionar— tanto los profesionales de la salud que acompañan a la familia como la justicia deben trabajar en conjunto para evitar daños en el cuerpo y la psiquis de esa pequeña persona que no pidió estar en ese conflicto.

Las peleas de adultos son de adultos. Hablemos como tales y no usemos a los chicos como objetos para premios y castigos. **Evitemos los contrapuntos que no suman:** hay niños que tienen dos pediatras, uno con la mamá y otro con el papá, porque estos no pueden ponerse de acuerdo con un solo profesional. ¿Se imaginan lo agotador que puede llegar a ser eso para un chico?

Y aquí hablé puntualmente de lactancia, pero hay miles de otras situaciones dentro de las separaciones donde se visibiliza esta vulneración de los derechos de los niños. Siempre su bienestar TIENE que ir primero, sin excepción.

La lectura

Los libros son refugio, calor, voz de mamá, papá o cualquiera que quiera a ese niño que escucha, haciendo de lobo feroz para que se ría mucho. Son horas de sosiego, de espera tranquila, de sonidos que van y vienen entre las orejitas y el mundo. Son amor encuadrado, son los versos más tristes, son los minutos vueltos papel.

Leerle a un niño, incluso desde recién nacido (¡o antes!), es envolverlo en un mundo de sensaciones musicales y placenteras. Aunque no comprenda las palabras, escuchará tu voz y te sabrá cerca, se sentirá atendido y escuchado, e invertirá toda su pequeña atención y fascinación ante esta maravilla melódica que le estás poniendo adelante.

Los niños que estuvieron más expuestos al lenguaje cuando eran pequeños tienen mayor vocabulario, evidenciando que el lenguaje está claramente relacionado con el habla y la lectura. Al leerles cuentos a los bebés, los cargamos sobre nuestra falda, en brazos o en un portabebés, así que también les enviamos señales tranquilas a través del tacto, influyendo en los trayectos neuronales en formación.

Pero **¿qué libros leerle a un bebé? ¡Cualquiera!** Hay libros pequeños con imágenes grandes y pocas palabras, aptos para ser arrugados, sobados y masticados: esos no son claramente para leer, sino para ser disfrutados en el gozo de la destrucción. Para leer, reitero, cualquier libro que nos guste está bien. Las poesías son de gran gusto de los bebés, por su musicalidad; los cuentitos cortos antes de dormir son muchas veces aliados. No le tengamos miedo a los libros “de más grandes”, que arrugue un par de hojitas no es tan grave. No nos privemos de esta experiencia feliz.

Dejo algunas opciones que quiero mucho. Ojalá las disfruten.

- * *Versos tradicionales para cebollitas*, de María Elena Walsh.
- * *El libro que canta*, de Yolanda Reyes.
- * *Esto que brilla en el aire*, de Cecilia Pisos.
- * *Discurso del oso*, de Julio Cortázar.
- * *El conejito soñado*, de Malika Doray.
- * *El menino*, de Isol Misenta.
- * *Arroz con leche*, de Natalí Tentori.

Poemita para Liso

***Bailamos un montón
Bailamos vos y yo
Bailamos, pirujito
De mi corazón.***

***Bailamos con las noches
Repletas de luna oscura
Bailamos abajo del cielo
Lleno de cuentos dorados
Bailamos abrazados,
entretejidos, amados.***

***Bailamos con los dinosaurios amarillos,
En nuestro amor siempre brillantes.
Bailamos con las palabras sueltas
Porque las palabras dicen,
Pero también abrazan, sanan y consuelan.***

Para leer

- González, C. *Bésame Mucho*, Editorial Planeta, Buenos Aires, 2012.
- Grieco, S. y Zampaloni, S. *Crianza para principiantes*, Editorial Grijalbo, Buenos Aires, 2018.
- Jové, R. *La crianza feliz*, Editorial La esfera de los libros, Madrid, 2009.
- Raschkovan, I. *Infancias Respetadas*, Editorial Aique, Buenos Aires, 2019.
- UNICEF. *Crianza sin violencia: Guía práctica para evitar gritos, chirlos y estereotipos*. 2017.
- Vázquez, V. y González, M. *Ensambladas: todo tipo de familias*, Editorial Albatros, Buenos Aires, 2019.
- Argentina.gob.ar. *Quiero adoptar*. Recuperado de: [https: /
/www.argentina.gob.ar/justiciacerca/quiero-adoptar](https://www.argentina.gob.ar/justiciacerca/quiero-adoptar)

Mocos, tos, fiebre, chichones... y otros temas que nos preocupan



Viene el monstruo del invierno
entre nubecitas frías viene marchando.
Aterrador, misterioso, coqueto
camina con los mocos colgando.

Viene el monstruo del invierno
guardias, pediatras, pañuelos
mamá escuchando preocupada
el murmullo de la tos a la noche
apoyando, suave,

la mano tibia en la cabecita afiebrada.

Viene el monstruo del invierno
¿dejarás a mi niño, bicho malvado?
Señora, perdóneme usted
Yo también estoy muy cansado.
¿Tiene por ahí un tecito?
¿O un caldo de pollito mojado?

Mamá sentó al monstruo en la mesa
pan con manteca puso en su mano
le abrigó las orejas con lana
le colgó el sobretodo mojado.
Señor monstruo, ¿está mejor?
Gracias, ya estoy curado.
El sol de la primavera me espera,
por este año he terminado.

Los pies descalzos y las enfermedades

En algún momento de la humanidad, se relacionó el estar descalzo con enfermarse, sobre todo para patologías de la vía aérea. **Desmitifiquemos este asunto: ponerse medias y zapatos es una cuestión cultural.** En Nueva Zelanda, por ejemplo, los niños van descalzos al colegio. Esto no es embanderar los pies descalzos y exigir a las familias que arrojen los zapatitos a la basura, sino al revés, tranquilizarlas: cuando Juanita se saque sola los zapatos y corra descalza por la cerámica fría, simplemente va a ser feliz y vivir una experiencia sensorial. **No se va a enfermar ni sus mocos serán por eso.**

Los pies descalzos:

- No dan gripe.
- No dan cólicos.
- No dan diarrea.
- No empeoran los mocos.

Los pies descalzos:

- Sirven para que los chicos exploren el entorno.
- Estimulan áreas importantes de desarrollo cerebral.
- Permiten la autopercepción del cuerpo.
- Los chicos disfrutan de estar descalzos, dato no menor.



Las medias se ponen cuando cada familia quiera —porque esto no es una imposición, simplemente son datos para dejarnos tranquilos— o cuando hace frío como para poner guantes.

Fiebre

La fiebre, que se define como aumento de la temperatura corporal (38°C o más), es un proceso natural del cuerpo ante estímulos nocivos.

No es una enfermedad en sí, es un mecanismo de respuesta y de defensa. Por eso, no es peligrosa ni grave por sí misma. Lo que tenemos que buscar, entonces, es la causa de esa fiebre, y muchas veces en la infancia tiene que ver con infecciones virales benignas.

Ante un niño con fiebre, antes que nada, es preciso mantener la tranquilidad. **¿Siempre tenemos que bajar la fiebre con medicamentos? No, no es necesario. Lo que tratamos no es la fiebre, sino el malestar que causa:** dolor de cabeza, fatiga, malestar general, pérdida del apetito. Si el niño está jugando contento, no es necesario

darle antitérmicos. Sí, lo repito: no es necesario. Al final del capítulo hablaremos de los antitérmicos.

Los baños pueden servir, siempre con agua tibia. Bañar con agua fría solo genera incomodidad, que es lo que deseamos evitar. Hay que respetar que probablemente el niño/a no tenga ganas de comer. Esto es normal, solo tenemos que estar atentos a que tome líquido (agua, teta) y que haga pis normalmente.

¿Fiebre alta es sinónimo de enfermedad grave? No necesariamente. Por ejemplo, la enfermedad pie-mano-boca, muy frecuente en niños que van al jardín de infantes, es producida por un virus que se va solo y puede dar fiebre muy alta varios días.

La fiebre puede producir convulsiones febriles en un número de niños predispuestos (¡no en todos los niños!) entre los 6 meses y los 6 años. No tiene que ver con la “cantidad” de fiebre, dado que pueden suceder con fiebre baja. Son feas, muy feas, pero no causan daño neurológico y no siempre se repiten. Hay que charlarlo con el pediatra.

Los termómetros de mercurio están en desuso, debido a la toxicidad que generan en el medio ambiente, y en Argentina se dejaron de comercializar en 2019. **Se recomiendan los termómetros digitales.**

Los motivos de consulta en una guardia son:

- Bebé menor de 3 meses, y más aún menor de 1 mes, con fiebre.
- Mal estado general.
- Manchas en la piel del tipo petequias: son manchas pequeñas, como pecas, que no desaparecen cuando las apretamos.
- Bebé que rechaza alimentarse (teta, fórmula) o niño que rechaza líquidos.
- Niño con alguna patología de base (cardiopatía, enfermedad reumatológica...).
- Dificultad respiratoria, caca con sangre, niño que no hace pis.
- Cambios en la conciencia y en la conducta (mayor irritabilidad sostenida, pérdida de conciencia...).

Al niño en buen estado general, con fiebre, podemos verlo en el consultorio.

¡A no asustarnos! Recordemos que un niño SANO puede tener, aproximadamente, ¡de 8 a 12 infecciones respiratorias altas (catarros, por ejemplo) por año de causa viral y benigna! ¡También es parte de la infancia!

Lo importante es estar bien informados, mantener la calma y conocer las pautas de alarma para poder consultar. Y por supuesto... muchos mimos, upa y paciencia.

Enfermedades de la vía aérea

Mocos

Los niños tienen mocos. Muchos. (Los adultos también, pero sabemos sonarnos la nariz). **El moco es una reacción natural de nuestro cuerpo a diversos estímulos.** Es una barrera de defensa. ¡Qué bueno que exista!

El moco mantiene hidratada la vía aérea, protege la vía digestiva, nos protege de las bacterias. Pero... cuando nos enfermamos y tenemos mocos de más, ¡pueden ser muy molestos! Vamos con algunas dudas sobre el tema:

- **¿El aire frío produce mocos?** Algo así. La vía aérea puede producir más moco ante el aire frío o el cambio de temperatura abrupto entre el interior y el exterior (por ejemplo, aires acondicionados). Eso no es “estar enfermo”, simplemente es un mecanismo de adaptación, normal y sano.
- **¿La noche produce mocos? ¿Por qué tantos bebés sanos se despiertan haciendo ruido de chanchito?** Porque de noche nos movemos menos y las secreciones no se drenan tan fácilmente. Los bebés tienen la vía aérea pequeña y esto se escucha como un “chanchito”, que desaparece a las pocas horas de estar despierto.
- **¿Los mocos son peligrosos?** A los bebés muy pequeños les cuesta mucho manejar las secreciones si son producidas por un virus o por bacterias, y puede ser necesaria la internación para aspiración y para vigilar que se alimenten e hidraten correctamente.
- **¿Hay que usar siempre el sacamocos?** No, el uso continuo del sacamocos irrita la vía aérea y produce... ¡más moco! Sirve mucho usarlo cuando los niños están muy molestos, pero no toooodo el tiempo.
- **¿El moco verde es más grave? ¿Es bacteriano?** No, es la evolución natural del moco, no importa su causa.
- **¿Es grave que mi hijo tenga mocos todo el invierno?** Los niños sanos, reitero, tienen un promedio de 8 a 12 infecciones respiratorias altas por año. Así que sí, puede ser normal.
- **¿Si no saco el moco, se le va al cerebro?** No, eso no puede suceder, tranqui.
- **¿Y le puede dar sinusitis si “sorbe” con la nariz?** No, el “sorber” los mocos solo

lleva a que se los traguen, pasen al estómago y se vayan con la caca. Sin mucho drama.

La mejor manera para prevenir infecciones respiratorias es una buena alimentación, ambientes libres de humo de cigarrillo, vacunas completas, lavado de manos y mucho, mucho aire libre.

Tos

La tos es un reflejo que protege la vía aérea. Cuando algo la irrita, se produce la tos. Por eso es tan frecuente que los niños tosan cuando empiezan con la alimentación complementaria: están protegiendo su vía aérea.

La tos es un mecanismo excelente. Sí, así como lo leen. **La tos es algo bueno, sano, esperable y deseable, aun cuando asuste y nos haga pasar noches enteras viéndolos toser. Es “la escoba que barre los pulmones”, e impide que se acumulen secreciones.**

En pediatría, la tos aguda que moviliza mocos no debería ser inhibida, pues expondríamos a los niños a infecciones más graves. Si “cortáramos la tos”, habría mayor obstrucción de la vía aérea, menor oxigenación y mayor riesgo de otitis y neumonía. **Los jarabes para la tos, mucolíticos, antihistamínicos o descongestivos nasales no están indicados en la mayoría de los cuadros de tos en pediatría,** pues no se probó que tuvieran ningún efecto positivo y sí pueden tener efectos adversos.

La tos simplemente es un signo de un proceso. Puede haber tos por resfrío, por gripe, por broncoespasmos, por neumonía, por coqueluche. No lo sabremos hasta revisar al niño. No sirve mandarle al pediatra un audio de WhatsApp con la tos, aún no podemos auscultar electrónicamente. Hay que ver al paciente.

La tos se define como “crónica” recién cuando supera las cuatro semanas. ¿Por qué? Porque si un niño tuvo un proceso infeccioso en la vía aérea, primero tiene que cumplir su ciclo la infección, y luego, esas células se tienen que reparar. Puede continuar la tos varias semanas más después de curado el proceso. A la tos crónica es preciso estudiarla por el pediatra de cabecera.

¿Qué cosas son efectivas cuando hay tos?

- **Mantener la hidratación,** ofreciendo líquidos abundantes y teta.
- **Solo si los mocos son difíciles de eliminar, realizar lavados nasales con solución salina** (el famoso *spray* nasal, o gotitas de solución fisiológica + sacamocos). No es necesario realizar esto en forma constante, de otra manera, la

irritación de la vía aérea causará más moco.

- **Mantener el confort del niño** (bajar la fiebre, dejarlo descansar, no insistirle en comer si no lo desea).
- **En mayores de 2 años, se puede administrar miel**, que se estudió que mejora las molestias por la tos. En menores de 2 años, no se recomienda la miel por riesgo de botulismo.
- **Ventilar los ambientes, respirar aire puro. Evitar humo de cigarrillo.**
- **Mantener la higiene de manos.**

Y sobre todo, tener en cuenta que el 90 % de los catarros en pediatría son por causa viral, y hay que esperar que el virus cumpla su ciclo. No podemos apurarlo de ninguna manera. Paciencia, mimos... ¡y a pasar el invierno!

Faringitis

La faringitis (o anginas) es la inflamación de la faringe, un tubo que conecta la cavidad bucal y las fosas nasales con la laringe, la cual se continúa con la tráquea, bronquios y demás divisiones que forman los pulmones. Es parte de la vía aérea superior.

La faringe se puede inflamar por varias razones, pero es muy común la causa infecciosa. De esas infecciones, dependiendo de la edad, **el 75 % en pediatría son de causa VIRAL** y el resto, bacteriana.

Las manifestaciones de la faringitis son de lo más variadas, y van desde eritema (color rojo de la garganta), hasta las famosas “placas” blanquecinas (exudados), pasando por vesículas, úlceras y más. Esto ocurre porque hay muchos agentes que causan faringitis, y cada uno de estos microorganismos puede causar inclusive cosas distintas. Puede acompañarse de dolor de garganta, dolor al tragar, dolor de cabeza, fiebre... Es por esto que **la presencia de “placas” no siempre habla de infección bacteriana, y por lo tanto, ¡no siempre requiere antibióticos!**

¿Y cómo sabemos si la infección es viral o bacteriana? Por un lado, los pediatras nos guiamos por la edad del paciente y su estado clínico. Por el otro, tenemos los métodos de laboratorio: el test rápido y el cultivo. Ambos métodos buscan la presencia del *Streptococcus pyogenes*, que si se encuentra allí, es necesario matar con antibióticos para prevenir complicaciones como la fiebre reumática o la

glomerulonefritis postestreptocócica (una afección grave de los riñones), más que para “curar” la faringitis.

El hisopado es precisamente una técnica donde con un hisopo largo se raspa suavemente el fondo de la garganta, entre las amígdalas. Luego, la muestra pasa por dos procesos:

- El test rápido: lo tenemos listo en un ratito. Detecta partes de la bacteria, así que si es positivo, es muy probable que el *S. pyogenes* ande rondando y hay que medicarlo.
- El cultivo: se “siembra” la muestra y tarda algunos días, pues tiene que crecer la bacteria. Es importante retirar el resultado.

Si no tenemos el test rápido disponible, podemos esperar el resultado del cultivo para iniciar el tratamiento antibiótico. Si alguno de estos métodos es positivo, se prescriben antibióticos en DOSIS, POSOLOGÍA Y DURACIÓN ADECUADAS para cada paciente y edad. Si son negativos, se suele interpretar como causa viral y NO SIRVEN los antibióticos. Hay que esperar que el virus cumpla su ciclo.

Por eso es importante NO automedicarse. Si tengo un virus y tomo un antibiótico, no solo no voy a curarme el virus, sino que voy a hacer más resistentes a otras bacterias, desequilibrando mis bacterias “buenas”, es decir, la flora normal de mi cuerpo. El uso de antibióticos, como cualquier medicación, tampoco está exento de efectos adversos, y si no es el adecuado, puede ser tóxico.

Para prescribir antibióticos para una faringitis, por lo tanto, es necesario realizar el hisopado de fauces previamente. Esto está consensuado por muchas sociedades científicas, entre ellas, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Asociación Española de Pediatría.

Si la faringitis realmente es de causa estreptocócica, a las 24 horas de iniciado el antibiótico, deja de contagiar (y el niño puede volver a la escuela, si los síntomas están controlados). Es imprescindible cumplir correctamente la cantidad de días de antibiótico.

Otitis

Existen varios tipos de otitis, palabra que define a la inflamación del oído. La otitis externa es la que se asocia mayormente a verano y piletas. En este apartado, me referiré a la otitis media aguda, generalmente de causa infecciosa.

La otitis media aguda es la inflamación del oído medio. En el oído medio se encuentra el famoso tímpano, los huesecillos y el recubrimiento de caja timpánica y mastoides (una estructura del cráneo). El oído medio tiene comunicación directa con

la faringe por un tubito que se llama trompa de Eustaquio. Este tubito, en los chicos, es más corto y más ancho que en los adultos, por lo que es más sensible a infecciones. Por lo tanto, **si un niño tiene un resfrío o una gripe, puede predisponer a una infección del oído medio.**

¿Quiénes tienen más riesgo de tener otitis media aguda? Los niños que usan chupete, los que están expuestos al humo de cigarrillo, los que van a guardería o jardines maternos, los que toman mamadera acostados (recordemos que la boca está conectada al oído) y los que se alimentan desfavorablemente. **La lactancia materna es un factor protector.**

¿Cómo diagnosticamos una otitis media aguda? Tiene manifestaciones muy variables: a veces hay fiebre, y otras, solo dolor. A veces los bebés simplemente se toquetean o refriegan la oreja. Otras directamente vemos salir pus de la oreja: en esos casos, el tímpano se ha perforado (no se asusten, se autorrepara, a menos que el proceso se vuelva crónico). El diagnóstico lo hacemos mirando el oído con un aparato que se llama “otoscopio”, que tiene una luz y una lupa. Generalmente, los mapadres nos tienen que ayudar porque a nadie le gusta mucho que le toquen el oído, menos si hay dolor. Es importante contarles a los chicos qué les vamos a hacer y darles herramientas para que tengan menos miedo.

El tratamiento tiene que ver por un lado con mejorar el dolor, y luego se evaluará la necesidad o no de antibiótico, según la edad y los síntomas del niño. No todas las otitis son por bacterias, muchas son por virus. Es preciso evaluar caso por caso.

Bronquiolitis

La bronquiolitis es una enfermedad VIRAL, muy común en la época invernal en menores de 2 años de edad. Es producida por varios tipos de virus (virus sincicial respiratorio, adenovirus, influenza, parainfluenza...). La mayor parte de las veces no sabremos qué virus la produjo, porque eso no cambia el tratamiento.

Estos virus se contagian por gotitas de secreciones en el aire. Mientras más cerrados y con más gente estén los ambientes, es mayor el riesgo de contagiarse.

La bronquiolitis puede iniciar con un catarro común y luego progresar a dificultad respiratoria. El diagnóstico lo tiene que hacer un médico, escuchando los pulmones. No hacen falta radiografías ni estudios.

Como es viral, no sirven los antibióticos. Para su tratamiento se suelen usar broncodilatadores como el salbutamol, aunque cada vez lo utilizamos menos porque se está estudiando que no se observa gran mejoría con su uso en esta patología.

Como todo virus... hay que esperar que se vaya solo. A veces se requiere ayudar con un poco de oxígeno, en un ámbito hospitalario. La tos posbronquiolitis suele durar varias semanas.

Es importante que ante síntomas de dificultad respiratoria, vayamos a la guardia.

- Respira muy rápido.
- Se le hunde la panza y/o las costillas al respirar.
- Le cuesta alimentarse, hablar o jugar.
- No puede tomar líquidos.
- Mal estado general.

Lavarse las manos, no concurrir a lugares cerrados con muchas personas, ventilar los ambientes, no exponerse a humo de cigarrillo, la lactancia materna, la alimentación saludable y mantener el calendario de vacunas completo son ítems que nos pueden ayudar a prevenir esta enfermedad.

El vapor y las nebulizaciones

El nebulizador es un instrumento que permite llevar partículas de medicación a la vía aérea para que actúen directamente en ese lugar. Tiene que estar bien conservado e higienizado para no contaminar la medicación.

¿En qué caso sirve usarlo? Cuando se usan fármacos como el budesonide (tos por laringitis), salbutamol (broncoespasmos) o en otras patologías, indicados por un médico. Es decir, sirve para vehiculizar medicación. Para esto, el ideal es el nebulizador a pistón, no el ultrasónico. Sí, el ultrasónico es más lindo, lo sabemos, pero no tiene gran utilidad.

¿Es útil si la tos es por un resfrío común? No. A veces nos sentimos mejor realizando las nebulizaciones con solución fisiológica, y no causa daño hacerlas, pero no cambia la cantidad de días de tos ni de malestar.

¿Sirve el vapor? El vapor solo sirve si las secreciones no son fluidas. Hidrata levemente el moco y lo hace más sencillo de aspirar o de sonarse. Si los mocos ya son flojos, no cambiará nada. Tampoco generará un perjuicio, así que si deseamos realizarlo, adelante.

¿Qué hacer con un niño enfermo?

En invierno hay más enfermedades respiratorias. ¿Por los pies descalzos? No, hay más enfermedades porque **en invierno las condiciones ambientales son buenas para el desarrollo de virus y bacterias, porque el aire frío puede producir más moco donde estos se asienten y porque nos amuchamos en lugares cerrados y mal ventilados.**

Aquí van algunas pautas para atravesar los procesos de enfermedad:

- **Primero de todo, dejar al niño DESCANSAR.** Cuando el cuerpo tiene que luchar contra algo, necesita tranquilidad. Claro que, para un niño, descansar no tiene por qué ser estar acostado. No hay nada más sano que un niño jugando. Permitir el juego y el movimiento también es importante para la salud.
- **Los chicos pueden estar “pachuchos” y cansados, y esto también es normal.** Pensemos en cómo nos sentimos nosotros, los adultos, cuando tenemos fiebre. Puede que de noche duerman mal, y que prefieran dormir durante el día de ratitos cortos.
- **Un niño enfermo puede no querer comer y es absolutamente normal.** Lo importante es mantener la hidratación con líquidos, sobre todo agua si es mayor de 6 meses, y teta si toma. En niños mayores podemos ofrecer caldos naturales, por ejemplo, como el caldo de huesos, que tienen gran contenido nutritivo.
- **Las infusiones de “yuyos” (anís estrellado, paico, eucalipto, menta) no son recomendables.**
- **La miel en NIÑOS MAYORES DE 2 AÑOS puede ser buena para la tos,** como ya mencionamos en apartados anteriores.
- **Cuando tenga hambre, es importante ofrecer porciones pequeñas de alimentos saludables:** frutas, verduras, cereales, legumbres, carnes, pastas de frutos secos.
- **Ventilar los ambientes y permitir el aire fresco es superimportante.** Incluso podemos salir al exterior y jugar afuera si se sienten bien para ello. Evitar los ambientes con humo de cigarrillo.

- **Los ungüentos y *sprays* con eucalipto o alcanfor tampoco se recomiendan**, porque pueden causar hiperreactividad bronquial (broncoespasmos) y más secreciones, empeorando el cuadro.
- **Si tiene fiebre, se pueden usar los antitérmicos que indicó el pediatra, en la dosis indicada.** Es importante NO medicar por nuestra cuenta, mucho menos con antibióticos, ni con jarabes para el catarro (NO se usan en niños).
- **Si algo nos llama la atención, consultar al pediatra de cabecera** (al pediatra que lo/la conoce, no por redes sociales) para ver si, en contexto con ese niño/a, corresponde ir a la guardia o hacer una visita al consultorio.

Golpes en la cabeza

Las caídas, los porrazos y los chichones son comunes en la niñez. Ante golpes en la cabeza, se suele correr a una guardia en la búsqueda de la realización de radiografías. La realidad es que **las radiografías de cráneo tienen escasa utilidad y se realizan ante indicaciones muy puntuales.**

Un niño que tuvo un golpe en la cabeza leve, sin factores de riesgo, sin ninguna anormalidad en la clínica, será observado en la guardia unas horas y luego en casa, dando pautas de alarma, sin necesidad de radiografías ni de otro examen.

Un niño que nos llama la atención y creemos que puede tener alguna consecuencia cerebral de su golpe, no requiere radiografías, sino estudios más complejos como una tomografía computada.

¿Cuándo se debe concurrir a la guardia?

- **Cuando el niño perdió la conciencia luego del golpe**, la haya recuperado o no.
- **Cuando el niño no está “como siempre”** (no juega, está continuamente irritable, no se alimenta).
- **Cuando presenta algún signo neurológico específico** (convulsiones, debilidad de alguna parte del cuerpo).
- **Cuando presenta vómitos.**

- **Cuando presenta algún signo de fractura** (hundimiento de alguna parte del cráneo, por ejemplo, o un “chichón” que abarca gran parte del cuero cabelludo).
- **Cuando el golpe estuvo asociado a caída desde algún elemento, altura o estructura**, como el andador (algo MUY COMÚN) o una escalera. Si no pasó nada de esto, el niño está jugando y con ganas probablemente de golpearse de nuevo, las conductas a seguir son:
- * **Observación en casa las siguientes 24-48 h.** Si aparece alguno de los signos anteriores, concurrir al médico.
- * **Frío en el chichón**, si es que lo hay. Si hay dolor, algún analgésico. No manteca, ni azufre, ni pomadas con medicación, ni ninguna otra cosa. Frío (hielo envuelto en un paño, por ejemplo) solamente.
- * **El niño puede dormir.** Una cosa es perder la conciencia después del golpe, eso requiere una consulta. Otra cosa es que, entre el llanto, el miedo y nuestro propio estrés, el niño se duerma como lo hace habitualmente. Si es así, dejarlo descansar.
- * **Hay un mito que dice que los golpes en la frente son “los peores”. ¡El hueso frontal es el más fuerte del cuerpo!** Se podría decir que en ausencia de otros síntomas, es el que menos nos preocupa.

Habrán golpes. Aunque los envolvamos en gomaespuma, los niños siempre van a encontrar la forma de pegarse un porrazo. Saber qué hacer para mantener la calma es importante, y prevenir los accidentes graves, también.

Diarrea y vómitos

Gastroenteritis aguda

La gastroenteritis aguda es una enfermedad que incluye vómitos y diarrea. La diarrea es el aumento en el número de deposiciones y/o una disminución de la consistencia de las mismas. **Cuando se asocian la diarrea y los vómitos, los niños se encuentran en alto riesgo de deshidratación**, porque pierden líquido y no lo pueden reponer.

Las gastroenteritis agudas pueden ser virales o bacterianas, pueden incluir fiebre varios días, dolor abdominal y diarrea hasta 10 días aproximadamente. **Lo importante es mantener a los chicos hidratados, con agua, teta o sales de rehidratación oral (sales OMS) si las indica el médico.** Las mismas contienen sodio, potasio, glucosa, cloro y bicarbonato; estudiadas por años para lograr la medida precisa. Si no las necesitamos, el agua (o la teta, si son chiquitos) basta para prevenir la deshidratación en la mayoría de los casos.

Continuar con la lactancia durante la diarrea, hidratarse con agua o sales de ser necesario, dar agua a sorbitos y no de golpe, incorporar pequeñas porciones de comida lo antes posible (si hay ganas), muchísima higiene de manos y mucho descanso, son algunas de las indicaciones para mejorar estos cuadros, los cuales de ser necesario, requerirán evaluación médica e indicaciones individuales. **Se sugiere no dar antiespasmódicos, ni gotas para “el dolor de panza”, ni infusiones como el té.** Estas últimas pueden ser peligrosas para los niños, pues muchas de ellas son tóxicas en la infancia (paico, anís estrellado, manzanilla).

¿Cuándo consultar?

- **Caca con sangre o pus.**
- **Niño o bebé que no hace pis.**
- **Niño o bebé que vomita todo lo que toma o no ingiere líquido.**
- **Ojos hundidos o lengua seca.**
- **En bebés menores de 3 meses, la diarrea siempre es motivo de consulta.**

Las gaseosas transparentes con sabor a limón están popularmente reconocidas como parte de una dieta “de enfermedad”. **Ante diarrea, vómitos, fiebre... gaseosa batida. Es importante conocer que esto es un mito.** Las gaseosas contienen azúcar, jarabe de maíz de alta fructosa, ácido fosfórico, colorantes, y no aportan nada a un cuadro viral gastrointestinal (como lo son la mayoría de las diarreas agudas en la infancia).

Estas gaseosas cuentan con sodio en su composición (ninguna con potasio, por ejemplo), pero en proporciones no adecuadas para la reposición de estos electrolitos. Las bebidas deportivas tienen más electrolitos (sodio, potasio) que las gaseosas, pero de cualquier manera, sus ingredientes principales son el azúcar, el jarabe de maíz de alta fructosa y colorantes. **Estos componentes pueden aumentar el dolor de panza y la diarrea por el alto contenido azucarado.**

Esta misma azúcar “de golpe” nos puede hacer sentir un poco mejor cuando

estamos mucho tiempo en ayunas, pero el efecto es corto y posteriormente nos sentiremos peor o con más síntomas. **Cuando estamos enfermos, no hay nada mejor que el agua potable.**

Si requerimos rehidratarnos por indicación médica, existen las sales de rehidratación oral (SRO), aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, las cuales tienen los minerales que requerimos en esos momentos y deben ser preparadas en una forma cuidadosa, tal como lo indica el envase (1 litro de agua de la canilla potable, no agua mineral, + 1 sobre de sales de rehidratación oral).

Ninguna bebida del mercado reemplaza las sales de rehidratación oral si es que las precisamos. ¡Derribemos mitos! Es parte del trabajo del *marketing* y de la industria alimentaria también que asociemos estos productos con la enfermedad, el placer y el alivio. Cambiar estos conceptos tan arraigados lleva tiempo y mucha información. ¡Pero podemos!

Si el niño no tolera ningún líquido, ni siquiera las sales, y continúa con vómito y/o diarrea, tenemos que concurrir a un centro de salud para que le repongan líquidos, ya sea con una sondita que se coloca en la nariz y va al estómago, o por vía endovenosa.

¿Cómo prevenir la gastroenteritis aguda?

- **Lavarse cuidadosamente las manos para manipular alimentos.**
- **No guardar leche sobrante en las mamaderas.**
- **Hervir el agua antes de reconstituir leche en polvo.**
- **Utilizar tablas diferentes para cortar la carne y las verduras.**
- **Lavar bien las frutas y verduras.**
- **Mantener los alimentos refrigerados y no utilizarlos luego de la fecha de vencimiento, si la tienen.**
- **Lavarse las manos, en general.**

Síndrome urémico hemolítico

El síndrome urémico hemolítico (SUH) es una microangiopatía trombótica. ¿Qué significa esto? Que es **una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos pequeños**

haciendo que las plaquetas se pegoteen y creen pequeñas obstrucciones. Estas obstrucciones generan que la sangre no circule correctamente y que a los tejidos les falte oxígeno y mueran.

Uno de los órganos que más vasos sanguíneos pequeños tiene es el riñón, porque es el responsable de filtrar la sangre. Por lo tanto, es uno de los órganos que más sufre en un caso de SUH. Sin embargo, pueden afectarse otros órganos como el cerebro, el páncreas, la visión...

El síndrome urémico hemolítico se presenta en mayor frecuencia en niños menores de 5 años y se adquiere al consumir agua o alimentos contaminados con una bacteria llamada *Escherichia coli*, sobre todo la carne picada y mal cocida. También puede contraerse por los lácteos no pasteurizados, las manos contaminadas, la contaminación cruzada (al usar la misma superficie o utensilios para lo crudo y lo cocido), el agua no potable y el baño en aguas contaminadas.

Generalmente, el cuadro empieza con diarrea con sangre o con dolor abdominal. Los niños pueden empezar a hacer poco o nada de pis, mostrar mucha irritabilidad o somnolencia, presentar convulsiones, ponerse pálidos y otros síntomas.

El SUH no tiene tratamiento, hay que esperar que la enfermedad haga todo su ciclo e ir paliando los síntomas. Cuando fallan los riñones, se suele hacer algo que se llama “diálisis”, que “limpia” la sangre, como si fueran los riñones. No es para nada feliz. **En Argentina, por los métodos para faenar utilizados, somos tristemente campeones mundiales en SUH.**

¿Cómo prevenir?

- Cocinar bien las carnes hasta que no queden rosadas ni jugosas por dentro, ya que la bacteria que causa la enfermedad muere por acción del calor —cocción— a más de 72 °C. Se recomienda tener especial cuidado con la carne picada y no se recomienda su consumo antes de los 5 años de edad.
- ¿Y si la pican delante de mí, un carnicero conocido? Es lo mismo, la bacteria está en la superficie de la carne y al picarla, se mezcla y la bacteria queda por dentro.
- ¿Y si la pico en casa? Ídem.
- ¿Y si la cocino bien? La cocción de una hamburguesa, por ejemplo, es heterogénea, y no sabemos si en todos los sectores se cocinó correctamente.
- Por último, ¿para qué arriesgarse? La carne picada no es un alimento indispensable...

- Consumir y ofrecer únicamente lácteos pasteurizados.
- Para beber, cocinar o lavar los alimentos, usar solo agua potable. Si existen dudas, agregar 2 gotas de lavandina apta para alimentos por litro media hora antes de usarla.
- Lavarse siempre las manos antes de cocinar.
- Usar diferentes superficies para picar y distintos utensilios de cocina para los alimentos crudos y cocidos, a fin de impedir la contaminación cruzada. Evitar las mesadas y las tablas de madera.
- Mantener la cadena de frío de los alimentos.

Intoxicaciones

En cualquier hogar podemos encontrar multitud de productos potencialmente tóxicos para los niños. Productos para la limpieza en envases de colores, medicamentos con formas llamativas, cebos para roedores, tabletas antimosquitos... e incluso, algún familiar que nos avisa que le dio un “tecito” para los cólicos a un bebé pequeño.

¿Qué hacemos cuando nos damos cuenta de que un niño ingirió una sustancia que puede ser peligrosa?

- Primero, mantener la calma. NO PROVOCAR EL VÓMITO NI ADMINISTRAR LECHE. Tampoco aportar líquidos ni alimentos antes de consultar al médico.
- Si se encuentra al niño con algún producto de limpieza volcado sobre su ropa, retirar la misma y lavar la piel con abundante agua.
- Si el niño está en buen estado general, comunicarse rápidamente con los Centros de Toxicología, los cuales funcionan las 24 horas. De otra manera, si observamos síntomas (náuseas y vómitos, dolor abdominal, mal estado general, lesiones en piel y mucosas, dificultad respiratoria, etc.), concurrir a la guardia rápidamente.

- Identificar la sustancia consumida y, en lo posible, la cantidad de la misma. Preferentemente, llevar los envases a la consulta médica.

¡El mejor antídoto para las intoxicaciones es la PREVENCIÓN!

TELÉFONOS DE CONSULTA LAS 24 HORAS

(se encuentran en la etiqueta de todos los productos de limpieza)

Hospital Nacional Alejandro Posadas: 0-800-333-0160.

Centro de toxicología Hospital Posadas: 011-4658-7777 y 011-4654-6648.

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 0-800-444-8694.

Centro de toxicología Hospital de Niños R. Gutiérrez: 011-4962-6666.

Hospital General de Agudos J. A. Fernández: 4808-2606/2646/2604/2121.

Centro de toxicología Hospital Fernández: 011-4808-2655.

Hospital Pedro de Elizalde: 4363-2100 al 2200.

Centro de Toxicología Hospital Elizalde: 011-4300-2115.

Hospital de Pediatría Sor María Ludovica (La Plata): 0-800-222-9911.

Quemaduras y cortes

¿Qué hacer ante un corte? Presionar para parar la hemorragia (no realizar torniquetes). Si esta no cede, o el corte fue producido por un material oxidado o muy sucio, concurrir inmediatamente a un centro médico. Si el corte o raspadura es menor, lavar con agua y jabón, y mantener limpio. Siempre constatar que se tengan todas las vacunas al día, para evitar el riesgo de tétanos.

¿Qué hacer ante una quemadura? Las quemaduras, inclusive las solares, pueden ser muy graves en los niños. Siempre la prevención es el mejor remedio. Cuando se

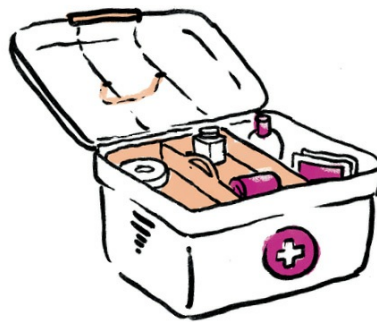
produce una quemadura, hay que alejarse de la fuente, mantener la zona limpia, no colocar ninguna pomada ni medicamento, y concurrir a un centro médico.

El botiquín en casa

Un buen botiquín debe ser muy sencillo y contener únicamente lo necesario. Debe estar lejos del alcance de los niños, bien cerrado.

¿Qué tiene que tener un botiquín hogareño?

- Varios paquetes de gasas.
- Uno o dos paquetes de vendas.
- Apósitos autoadhesivos (las curitas, se entiende).
- Un termómetro digital.
- Solución fisiológica en monodosis.
- Una tijera.
- Un antiséptico: iodopovidona, clorhexidina.
- Un antitérmico-analgésico: paracetamol, ibuprofeno... ¡consultar al pediatra!
- La medicación habitual de las personas que viven en ese hogar.



No guardar antibióticos a medio terminar: al finalizar el tratamiento, el resto se tira. Tampoco guardar gotas oftálmicas, dado que las bacterias y hongos proliferan en su interior. El envase de cada medicamento dice dónde guardarlo (heladera, lugar fresco y seco, etc.). Si tenemos dudas, podemos consultar a un farmacéutico.

¿Cuándo ir a la guardia?

Primero, hay que detenerse a pensar que **la guardia es para situaciones de riesgo de vida**. No es para certificados, recetas, aptos físicos ni para charlas de alimentación complementaria.

Segundo, **la atención en una guardia es por prioridad**. Las patologías más graves se atenderán primero, no importa el orden de llegada. Por ejemplo, un bebé de 1 mes con fiebre es mucho más urgente que una fiebre en un niño de 1 año que está jugando.

Signos y síntomas que ameritan ir a la guardia:

- **Dificultad para respirar:** “agitación”, niños que respiran muy rápido y con cansancio, se le hunde la panza o las costillas al respirar, cambios de coloración.
- **Dificultad para hidratarse:** bebés que rechazan el pecho o la mamadera, niños que no toman líquido o vomitan todo. Nos preocupa EL LÍQUIDO, cuando están enfermos, es normal que coman poco.
- **Fiebre (38° o más) en bebés menores de 3 meses o fiebre en niños mayores en mal estado general.** No es una cuestión de 48 horas: hay que mirar CÓMO ESTÁN los chicos, y si amerita guardia o consulta con pediatra.
- **Caca o pis con sangre.**
- **Bebé o niño que no hace pis.**
- **Fiebre + petequias** (manchitas en la piel que no desaparecen cuando las presionamos).
- **Traumatismos con pérdida de conciencia, signos de alarma** (ver “Golpes en la cabeza”), o mucho dolor.
- **Dolor que no cede.**
- **Convulsiones.**
- **Mal estado general.** Esto es superimportante: los chicos cuando se sienten mal, no

están igual que siempre. Pero es diferente un niño con fiebre que juega cuando se siente mejor de uno que no responde, está muy dormido o aletargado. En esos casos, mejor consultar.

Para otras cuestiones (por ejemplo, por certificados de alta que muchos trabajos exigen para reincorporarse), tenemos la consulta por consultorio de demanda espontánea, (muchos hospitales públicos y obras sociales cuentan con ese servicio); en algunos servicios médicos, los médicos a domicilio; y por supuesto, el consultorio del pediatra de cabecera.

Ir a la guardia por lunares, por ejemplo (¡me pasó atender cosas así...!), **sobrecarga el tiempo de espera de otro niño que necesita ser atendido pronto, y expone a niños con enfermedades benignas a otras enfermedades en la sala de espera.** No es raro ir a consultar por un resfrío y volverse con conjuntivitis y gastroenteritis.

El cuidado en salud es una responsabilidad social. Se entiende perfectamente la angustia de que nuestro hijo esté enfermo, y a ningún pediatra le molesta atender a un niño, ni hablemos si lo requiere urgentemente. Pero seamos coherentes en el uso de los servicios de guardia, para que si algún día nos toca a nosotros ser parte de la urgencia (ojalá que no), podamos tener la prioridad que el caso requiere.

Medicaciones frecuentes

El salbutamol

Hace un tiempo me comentaron que, a veces, con la mejor intención, se recomienda entre familias y amigos el salbutamol para paliar la tos o los mocos. Veamos por qué es importantísimo no automedicarse.

Los bronquios son las estructuras en las que se va dividiendo la vía aérea después de la tráquea. Estos se dividen también en estructuras más chiquitas que se llaman “bronquiolos”, que se siguen dividiendo hasta formar los alveolos.

En la bronquiolitis, el asma y otros síndromes broncoobstructivos, estas estructuras se inflaman, se contraen y se achican, haciendo más “finito” el espacio por donde entra y sale el aire. Esto genera dificultad para respirar y los distintos ruidos que auscultamos los médicos, y que a veces, ¡hasta se escuchan sin estetoscopio!

El salbutamol es un agente BRONCODILATADOR. Ayuda a que los bronquios se abran para que el aire circule mejor. NO cura la enfermedad (viral en las

bronquiolitis) que los está lastimando. NO mejora los mocos ni descongestiona. NO calma la tos si no tiene el broncoespasmo como causa. **Si no hay broncoespasmo, el salbutamol NO SIRVE. Y más aún: las últimas investigaciones dicen que para la bronquiolitis sirve bastante poco y se está dejando de usar para esta patología.**

El salbutamol viene en aerosol (*puff*), gotas para nebulizar y jarabe (muy poco usado). DEBE SER PRESCRIPTO POR UN MÉDICO, en la dosis adecuada para el niño y en la presentación correcta.

Como toda medicación, tiene efectos adversos. En ocasiones podemos ver taquicardia (latidos muy rápidos del corazón) en los niños que lo utilizan, pero también es necesario definir si dicha taquicardia no es producida por la dificultad respiratoria.

Es aconsejable lavarse los dientes después de cada serie de *puff* para prevenir la aparición de gingivitis, caries y otras patologías bucales. Asimismo, cuando los niños hacen tratamientos preventivos (por ejemplo, con budesonide o fluticasona), se sugiere que se laven los dientes después de cada *puff*.

Siempre que se sospeche dificultad respiratoria (niño “agitado”, que habla entrecortado, respiración muy rápida, hundimiento de costillas, cambios de color) hay que acudir al pediatra para que lo revise.

Los antibióticos

Los antibióticos son un invento fantástico, que ha permitido salvar muchas vidas y evitar muchas secuelas de muchas enfermedades. **Los antibióticos actúan sobre BACTERIAS. Si la enfermedad no está producida por bacterias, el antibiótico NO SIRVE.**

En pediatría calculamos la dosis según el peso, la edad, la patología que necesitamos tratar, los intervalos entre dosis y cómo viene concentrado. Por ejemplo, en infecciones de piel e infecciones urinarias, a veces usamos el mismo antibiótico pero en diferentes dosis.

Por eso, lo que le sirve a un niño, no le sirve a otro. ¡No hay que comparar!

Una vez iniciado el tratamiento, **hay que hacerlo completo, los días que nos indicaron. Si lo dejamos antes, las bacterias se vuelven más resistentes y hay que usar antibióticos más fuertes... ¡y no queremos eso!** Es preocupante la venta indiscriminada de antibióticos y la automedicación.

Los antibióticos actúan también sobre las bacterias sanas de la microbiota intestinal. Recordemos que la microbiota cumple muchísimas funciones como la producción de vitaminas, de neurotransmisores y de protección contra otros gérmenes que pueden enfermar. Entonces, es importante utilizarlos SOLAMENTE cuando amerita. **La mayor parte de las infecciones de vía aérea superior en pediatría son**

por VIRUS, a los que no podemos apurar con nada, sino que solo nos queda esperar que cumplan un ciclo.

Seamos responsables con el uso de medicamentos, aún más en niños.

Los antitérmicos

Los antitérmicos son medicamentos que bajan la fiebre. En pediatría, los más usados son el paracetamol y el ibuprofeno. También tienen efecto analgésico y antiinflamatorio.

Los antitérmicos no dejan de ser medicamentos y de tener efectos adversos. No debemos guiarnos por la dosis que dice en la caja (me consta que muchos la traen “por edad”), sino consultar al pediatra dado que se calcula por peso.

No esperemos que la fiebre baje “del todo”, ni mucho más de un grado una hora después de administrado. Recordemos que **la idea no es ganarle al termómetro, sino mejorar el malestar. No se recomienda alternar medicamentos sin consultar al pediatra (una dosis de paracetamol, otra de ibuprofeno...) por riesgo de mayor toxicidad.** En Argentina, una de las principales causas de insuficiencia renal, después del síndrome urémico hemolítico, ¡es la nefrotoxicidad por ibuprofeno!

Pocas situaciones más estresantes y angustiantes que nuestros hijos enfermos. Los primeros mocos, la primera fiebre y el primer porrazo son un sinfín de sensaciones catastróficas. “¿Por qué no inventan una vacuna para TODO?”. “¿Por qué no hay nada que elimine los mocos?”. “Estoy harto de que me digan que es viral”. “¿Le pongo un casco para que no se golpee la cabeza?” (esto es real: se venden cascos para los niños que empiezan a gatear y caminar, yo los llamo #CososMarketineros). Todas estas son frases que resuenan mucho en los primeros años.

Algunas enfermedades y situaciones vertiginosas también son parte de la infancia, y atravesarlas con paciencia y hasta con humor será una aventura para grandes y chicos, digna de ser vivida. De a poco. Hoy no es siempre.

Para leer

PARA FAMILIAS

- Sociedad Argentina de Pediatría - Comunidad SAP. *Diarrea aguda*. Recuperado: [http:// comunidad.sap.org.ar/index. php/2015/08/10/diarrea-aguda/](http://comunidad.sap.org.ar/index.php/2015/08/10/diarrea-aguda/) ·
- Asociación Española de Pediatría. En familia. Golpes en la cabeza, ¿qué nos debe preocupar? Recuperado de: [https:// enfamilia.aeped.es/temas-salud/ golpes-en-cabeza-que-nos-debe-preocupar](https://enfamilia.aeped.es/temas-salud/golpes-en-cabeza-que-nos-debe-preocupar) ·
- Argentina.gob.ar. Síndrome Urémico Hemolítico. Recuperado de: [https:// www.argentina.gob.ar/salud/glosario/ sindrome-uremico-hemolitico](https://www.argentina.gob.ar/salud/glosario/sindrome-uremico-hemolitico)

PARA PROFESIONALES

- *El niño con problemas de la vía aérea superior*, Series de Pediatría Garrahan, Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires, 2018. ·
- *Manejo del traumatismo craneal pediátrico*, Asociación Española de Pediatría, 2008. ·
- Manual de emergencias y cuidados críticos en pediatría, Sociedad Argentina de Pediatría, 2013. ·
- Huartamendia, R.; Nappa, A.; Queirolo, R. (2012). *Problemas de salud bucal relacionados al uso de medicamentos por vía inhalatoria en trastornos respiratorios*. Odontoestomatología, 14(20), 4-16. Recuperado de: http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-93392012000200002&lng=en&tlng=es

AGRADECIMIENTOS

A Lisandro y Juan Martín, soles de mi vida.

A Patricio, el mejor padre y el mejor compañero que me dio el amor.

A Nadia Salazar, Martín Schneider, Matías Duca, Mariano Lafranconi, Axel Perossa, Rocío Navarro, Belén Cazorla, Estefanía Rodríguez, Elián Colombo, Luciana Truffini, Cinthia Callegari, Melisa Cascallar, Cecilia Pintos, Delia Nicoletti, Matías Grande y muchos otros que forman parte de la familia que nos abrazó, nos ayudó a sobrevivir a la tristeza y nos acompaña en el amor y la felicidad.

A Verónica Gatto Bellora, gracias a quien me recibí, a pesar de todo, de pediatra.

A Susana Faggio y a Jorge Duca, por su presencia constante y amorosa.

A Clara Baffa, Violeta Vázquez, Mariana Nieva y María Fernanda Iroumé que me prestaron textos, vivencias y miradas nuevas.

A Soledad Barruti y Natalia Kiako, compañeras, tribu y mujeres de pura pasión.

A las escuelas Crianza en Brazos y Panza y Crianza Escuela de Puericultura, por enseñarme tanto y permitirme también enseñar.

Especiales y repetidas gracias a Delia, Nadia, Martín y Cinthia que cuidaron con amor a Lisandro durante las largas jornadas de escritura.

A Godzilla, nuestro perrito chiquito color marrón, compañero fiel y el verdadero influencer de la familia.

Al equipo editorial que acompañó a este libro

A todos mis pacientitos que, día a día, me regalan volver a ver la vida a través de ojos de niño.



¿Te gustó este libro? Te recomendamos...

